

CATÁLOGO POSOLÓGICO PEDIÁTRICO

Esquemas terapêuticos por indicação

498 medicamentos

Uma monografia por página

Emergência • Terapia intensiva • Ambulatório

DOSE • VIA • INTERVALO • DURAÇÃO
FAIXAS ETÁRIAS • LIMITES • FONTES

Preparado para consulta por médicos,
pediatras e intensivistas.

Como consultar

EDIÇÃO DE CONSULTA PROFISSIONAL • 13/09/2026

Organização. Cada medicamento ocupa uma página. As indicações do documento-base são mantidas na própria ficha para rastreabilidade; os esquemas operacionais distinguem população, via e contexto. O número de cada medicamento preserva o identificador original. O índice permite localizar o nome genérico. Fichas extensas usam A3 para preservar a legibilidade; para impressão, usar o tamanho original da página.

Leitura da dose. mg/kg/dose significa a quantidade em cada administração. mg/kg/dia significa o total de 24 horas, dividido nas tomadas informadas. Doses de associações devem seguir o componente explicitado. Não intercambiar base e sal nem concentração do frasco e concentração final da infusão.

Alternativas. Esquemas apresentados como alternativas não devem ser somados. Intervalos, duração, idades e máximos pertencem ao esquema citado. Um teto de uma indicação ou faixa etária não deve ser transferido para outra.

Duração. Infecções exigem a duração definida para o foco e a evolução. Terapias crônicas, imunossupressores e infusões tituláveis não recebem número fictício de dias; a ficha descreve continuidade, titulação ou critério de suspensão quando a fonte o permite.

Cores e referências. Azul identifica referências e observações off-label. Vermelho destaca restrições ou lacunas. Cada esquema remete às fontes da própria página, com links clicáveis. Apoio internacional não equivale a aprovação regulatória brasileira.

Aplicação clínica. Peso, idade cronológica/gestacional, função renal/hepática, alergias, comorbidades e apresentação disponível precisam ser confrontados com o esquema antes da prescrição. Em neonatos e lactentes, exigir faixa etária explicitamente sustentada na fonte; “crianças” não autoriza extrapolação automática. Recalcular e conferir a dose individual em mg ou mL.

Alta vigilância. Em insulinas, eletrólitos concentrados, anticoagulantes, opioides, sedativos e vasoativos, realizar dupla checagem humana de peso, unidade, concentração final, via e programação da bomba.

Cálculos e checagem reversa

EDIÇÃO DE CONSULTA PROFISSIONAL • 13/09/2026

Dose por tomada: dose total (mg/dose) = dose ponderal (mg/kg/dose) × peso (kg). Aplicar o teto por dose da indicação quando houver.

Dose diária: total diário (mg/dia) = dose ponderal (mg/kg/dia) × peso (kg). Se há N tomadas iguais/dia: mg/dose = mg/dia ÷ N. Intervalos de 6, 8 e 12 horas correspondem a 4, 3 e 2 tomadas/dia, respectivamente.

Volume por dose: mL/dose = dose total (mg/dose) ÷ concentração da solução administrada (mg/mL). Checagem reversa: mL/dose × mg/mL ÷ peso = mg/kg/dose.

Infusão em mcg/kg/min: mL/h = dose (mcg/kg/min) × peso (kg) × 60 ÷ concentração FINAL (mcg/mL). Checagem reversa: mL/h × mcg/mL ÷ (60 × kg) = mcg/kg/min.

Infusão em mg/kg/h ou UI/kg/h: mL/h = dose × peso ÷ concentração FINAL na mesma unidade por mL. Checagem reversa: mL/h × concentração ÷ peso = dose por kg por hora.

Infusão intermitente: mL/h = volume FINAL (mL) × 60 ÷ tempo em minutos. A quantidade total do fármaco deve ser mantida no volume final; “completar para 50 mL” difere de “adicionar 50 mL”.

Equivalências: 1 mg = 1.000 mcg; 1 g = 1.000 mg; 1 UI = 1.000 mUI. Conversões de mg para mEq/mmol dependem da substância e da composição da apresentação; não usar um fator universal.

Superfície corporal: quando a fonte prescreve mg/m², usar a superfície corporal validada para o paciente; não converter por um peso fictício. Limites por m² e máximos absolutos devem ser aplicados como descritos na fonte.

Escopo e revisão editorial

EDIÇÃO DE CONSULTA PROFISSIONAL • 13/09/2026

Documento-base. Foram extraídas 498 monografias de 61 páginas. Dois métodos independentes de extração confirmaram a correspondência de nomes, indicações e apresentações. O texto-base não é uma bula oficial nem certifica todas as indicações pediátricas.

Pesquisa documental. As referências de cada ficha identificam as fontes usadas para os esquemas. Priorizam-se reguladores, fabricantes, sociedades médicas e hospitais públicos especializados. A pesquisa é uma revisão dirigida; não constitui busca sistemática capaz de garantir todas as posologias já publicadas.

Cobertura da edição-base. 498 medicamentos e 1.263 linhas de indicação/esquema: 992 com suporte, 262 restrições e 9 lacunas de validação. Esses números descrevem a edição recebida; indicação documental não autoriza tratamento sem respaldo pediátrico.

Revisão 1 - fidelidade e cobertura. Conferência dos identificadores e do texto original, correspondência das indicações com as linhas da ficha, ausência de medicamentos omitidos ou duplicados.

Revisão 2 - suporte clínico. Conferência de fontes, população, indicação e via nos registros de pesquisa; revisão focal adicional das situações de alto risco. As revisões foram assistidas por inteligência artificial; não houve validação clínica humana independente.

Revisão 3 - unidades e cálculos. Verificação dimensional das fórmulas, conversões direta e reversa e busca de ambiguidades entre dose diária, dose individual, sal/base e concentração final.

Revisão 4 - limites e coerência. Conferência dos registros de idade, intervalo, duração, máximos, restrições e off-label, com correção das divergências documentadas.

Revisão 5 - arquivo final. Extração do PDF gerado para confirmar preservação do conteúdo, uma página por medicamento, referências, limites de página e inspeção visual de páginas representativas e de maior densidade.

Limite da entrega. Revisões reduzem risco, mas não garantem ausência absoluta de erros. Lacunas identificadas na ficha impedem tratar aquele trecho como posologia validada. A seleção e a prescrição permanecem decisões do profissional assistente.

Atualização corretiva - 13/09/2026. Leitura crítica das 498 fichas e conferência externa dirigida aos achados prioritários. Corrigidos enquadramento de doses, marcos de duração, limites, precauções, terminologia e referências nas fichas assinaladas. Acrescentada a indicação alternativa do soro antiaracnídico no escorpionismo. O texto histórico do PDF-base recebe indicação explícita quando sua redação foi corrigida.

Conferidas as unidades e conversões das alterações, com cálculo independente e reverso quando aplicável. As nove lacunas explicitamente não validadas da edição-base permanecem identificadas; esta revisão não certifica todas as afirmações nem confirma a disponibilidade brasileira de cada apresentação.

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Abatacepte [463] · 475	Amicacina [29] · 41
Acebrofilina [1] · 13	Amilorida + Hidroclorotiazida [30] · 42
Acetato de Cálcio [496] · 508	Aminofilina [31] · 43
Acetazolamida [2] · 14	Amiodarona [32] · 44
Acetilcisteína [3] · 15	Amitriptilina [33] · 45
Aciclovir [4] · 16	Amlodipino [34] · 46
Ácido Acetilsalicílico (AAS) [5] · 17	Amoxicilina [35] · 47
Ácido Aminocaproico [6] · 18	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio [36] · 48
Ácido Ascórbico (Vitamina C) [7] · 19	Amoxicilina + Sulbactam [37] · 49
Ácido Fólico (Vitamina B9) [8] · 20	Ampicilina [39] · 51
Ácido Folínico (Folinato de Cálcio) [9] · 21	Ampicilina + Sulbactam [38] · 50
Ácido Fusídico [10] · 22	Anfotericina B [40] · 52
Ácido Mefenâmico [11] · 23	Anidulafungina [41] · 53
Ácido Nalidíxico [12] · 24	Aripiprazol [42] · 54
Ácido Tranexâmico [13] · 25	Atenolol [43] · 55
Ácido Ursodesoxicólico [14] · 26	Atomoxetina [475] · 487
Ácido Valproico / Valproato de Sódio / Divalproato de Sódio [15] · 27	Atracúrio [44] · 56
Adalimumabe [464] · 476	Atropina [45] · 57
Adenosina [16] · 28	Azatioprina [46] · 58
Adrenalina (Epinefrina) [17] · 29	Azelastina [47] · 59
Agalsidase Beta [18] · 30	Azitromicina [48] · 60
Albendazol [19] · 31	Aztreonam [49] · 61
Albumina Humana [467] · 479	Azul de Metileno (Cloreto de Metiltionínio) [484] · 496
Alendronato de Sódio [20] · 32	Baclofeno [50] · 62
Alfa-Dornase (Dornase Alfa) [21] · 33	Baloxavir Marboxil [494] · 506
Alglucosidase Alfa [22] · 34	Bamifilina [51] · 63
Alopurinol [23] · 35	Beclometasona [52] · 64
Alprazolam [24] · 36	Benralizumabe [458] · 470
Alprostadil (Prostaglandina E1) [25] · 37	Benzidamina [53] · 65
Alteplase [26] · 38	Benzilpenicilina Benzatina [54] · 66
Amantadina [27] · 39	Benzilpenicilina Potássica (Cristalina) [55] · 67
Ambroxol [28] · 40	Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina Potássica [56] · 68

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Benznidazol [57] · 69	Carmelose Sódica [88] · 100
Benzoato de Benzila [58] · 70	Carvão Vegetal Ativado [89] · 101
Beractanto [59] · 71	Carvedilol [90] · 102
Betametasona [60] · 72	Caspofungina [91] · 103
Bicarbonato de Sódio [61] · 73	Cefaclor [92] · 104
Bilastina [62] · 74	Cefadroxila [93] · 105
Bimatoprost [63] · 75	Cefalexina [94] · 106
Biperideno [64] · 76	Cefalotina Sódica [95] · 107
Bisacodil [65] · 77	Cefazolina Sódica [96] · 108
Bosentana [66] · 78	Cefepima [97] · 109
Brimonidina [67] · 79	Cefotaxima Sódica [98] · 110
Brometo de Ipratrópio [68] · 80	Cefoxitina Sódica [99] · 111
Brometo de Pancurônio [69] · 81	Ceftarolina Fosamila [100] · 112
Brometo de Rocurônio [70] · 82	Ceftazidima [101] · 113
Brometo de Tiotrópio [71] · 83	Ceftazidima + Avibactam [102] · 114
Brometo de Vecurônio [72] · 84	Ceftolozana + Tazobactam [103] · 115
Bromexina [73] · 85	Ceftriaxona Sódica [104] · 116
Bromoprida [74] · 86	Cefuroxima (Axetila / Sódica) [105] · 117
Budesonida [75] · 87	Celecoxibe [106] · 118
Bupivacaína [76] · 88	Cetirizina [108] · 120
Buprenorfina [77] · 89	Cetoconazol [109] · 121
Bupropiona [78] · 90	Cetoprofeno (Base / Lisinato) [110] · 122
Cafeína (Citrato de Cafeína) [79] · 91	Cetotifeno [111] · 123
Calcipotriol [80] · 92	Ciclesonida [486] · 498
Calcitonina Sintética de Salmão [81] · 93	Ciclopirox Olamina [112] · 124
Calcitriol [82] · 94	Ciclosporina [113] · 125
Canabidiol (CBD) [83] · 95	Cimetidina [114] · 126
Captopril [84] · 96	Cinchocaína + Policresuleno [115] · 127
Carbamazepina [85] · 97	Ciproheptadina + Cobamamida [116] · 128
Carbocisteína [86] · 98	Ciprofloxacino [117] · 129
Carbonato de Cálcio [87] · 99	Cisatracúrio [118] · 130
Carboximaltose Férrica [483] · 495	Citrato de Potássio [119] · 131

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Claritromicina [120] · 132	Deltametrina [150] · 162
Clindamicina [121] · 133	Desloratadina [151] · 163
Clioquinol + Hidrocortisona [122] · 134	Desmopressina [152] · 164
Clobazam [123] · 135	Desonida [153] · 165
Clobetasol [124] · 136	Desvenlafaxina [447] · 459
Clomipramina [125] · 137	Dexametasona [154] · 166
Clonazepam [126] · 138	Dexclorfeniramina [155] · 167
Clonidina [127] · 139	Dexmedetomidina [156] · 168
Cloperastina [128] · 140	Dexpantenol [157] · 169
Clopidogrel [129] · 141	Diazepam [158] · 170
Cloranfenicol [497] · 509	Diazóxido [159] · 171
Cloreto de Cálcio 10% [476] · 488	Diclofenaco (Potássico / Sódico / Resinato) [160] · 172
Cloreto de Potássio [130] · 142	Difenidramina [161] · 173
Cloreto de Sódio [131] · 143	Digoxina [162] · 174
Cloroquina [132] · 144	Diltiazem [163] · 175
Clorpromazina [133] · 145	Dimenidrinato [164] · 176
Clotrimazol [134] · 146	Dimenidrinato + Piridoxina [165] · 177
Codeína [135] · 147	Dipirona Sódica (Metamizol) [166] · 178
Colagenase [136] · 148	Dobutamina [167] · 179
Colchicina [137] · 149	Domperidona [168] · 180
Colecalciferol (Vitamina D3) [138] · 150	Donepezila [454] · 466
Colestiramina [139] · 151	Dopamina [169] · 181
Colistimetato de Sódio (Colistina) [140] · 152	Doxazosina [170] · 182
Complexo Protrombínico Concentrado [141] · 153	Doxiciclina [171] · 183
Concentrado de Fibrinogênio [142] · 154	Dropropizina [172] · 184
Crioprecipitado [143] · 155	Duloxetina [446] · 458
Cromoglicato Dissódico [144] · 156	Dupilumabe [456] · 468
Dantroleno Sódio [145] · 157	Ebastina [173] · 185
Daptomicina [146] · 158	Eculizumabe [174] · 186
Deferasirox [147] · 159	Eltrombopague [469] · 481
Deferoxamina [148] · 160	Emicizumabe [470] · 482
Deflazacorte [149] · 161	Emulsão Lipídica 20% [175] · 187

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Enalapril [176] · 188	Filgrastim (G-CSF) [201] · 213
Enoxaparina Sódica [177] · 189	Fitomenadiona (Vitamina K1) [202] · 214
Enzimas Pancreáticas (Pancrelipase) [178] · 190	Flucitosina [203] · 215
Epinastina [179] · 191	Fluconazol [204] · 216
Epoetina Alfa (Eritropoietina) [493] · 505	Fludrocortisona [205] · 217
Eritromicina [180] · 192	Flumazenil [206] · 218
Ertapenem Sódico [181] · 193	Fluoxetina [207] · 219
Escetamina [107] · 119	Fluticasona (Furoato / Propionato) [208] · 220
Escitalopram [182] · 194	Fomepizol [209] · 221
Escopolamina (Butilbrometo de Escopolamina) [183] · 195	Formoterol [210] · 222
Esmolol [184] · 196	Fosfato de Potássio Injetável [477] · 489
Esomeprazol [185] · 197	Fosfomicina Trometamol [211] · 223
Espiramicina [186] · 198	Furosemida [212] · 224
Espironolactona [187] · 199	Gabapentina [213] · 225
Etambutol [188] · 200	Galsulfase [214] · 226
Etanercepte [465] · 477	Ganciclovir [215] · 227
Etomidato [189] · 201	Gentamicina [216] · 228
Etossuximida [190] · 202	Glicerina (Glicerol) [217] · 229
Famotidina [191] · 203	Glicopirrônio (Brometo) [461] · 473
Fator IX da Coagulação Humana [491] · 503	Glicose [218] · 230
Fator VIIa Recombinante [192] · 204	Glucagon [219] · 231
Fator VIII + Fator de von Willebrand [472] · 484	Gluconato de Cálcio 10% [220] · 232
Fator XIII da Coagulação Humana [471] · 483	Gramicidina + Triancinolona + Neomicina + Nistatina [221] · 233
Fenilefrina [193] · 205	Granisetrona [222] · 234
Fenitoína Sódica [194] · 206	Griseofulvina [495] · 507
Fenobarbital [195] · 207	Haloperidol [223] · 235
Fenoterol [196] · 208	Hedera Helix [224] · 236
Fenoximetilpenicilina Potássica (Penicilina V) [473] · 485	Heparina Não Fracionada [225] · 237
Fentanila [197] · 209	Hidralazina [226] · 238
Ferro Aminoácido Quelato (Glicinato Férrico) [198] · 210	Hidroclorotiazida [227] · 239
Ferro Polimaltosado [199] · 211	Hidrocortisona [228] · 240
Fexofenadina [200] · 212	Hidroxicloroquina [229] · 241

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Hidróxido de Alumínio [230] · 242	Isoniazida [258] · 270
Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio (+ Simeticona) [231] · 243	Isossorbida (Dinitrato / Mononitrato) [259] · 271
Hidróxido Férrico em Sacarose (Sacarato Férrico) [232] · 244	Itraconazol [260] · 272
Hidroxiquinolina + Trolamina [233] · 245	Ivermectina [261] · 273
Hidroxizina [234] · 246	L-Ornitina L-Aspartato [262] · 274
Hidroxocobalamina (Vitamina B12) [235] · 247	Lacosamida [263] · 275
Ibuprofeno [236] · 248	Lactulose [264] · 276
Idarucizumabe [237] · 249	Lamotrigina [265] · 277
Idursulfase [238] · 250	Lansoprazol [266] · 278
Iloprosta [239] · 251	Laronidase [267] · 279
Imiglucerase [240] · 252	Levetiracetam [268] · 280
Imipenem + Cilastatina [241] · 253	Levocetirizina [269] · 281
Imipramina [242] · 254	Levodopa + Benserazida / Carbidopa [270] · 282
Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B [243] · 255	Levodropropizina [271] · 283
Imunoglobulina Humana Antirrábica [244] · 256	Levofloxacino [272] · 284
Imunoglobulina Humana Antitetânica [245] · 257	Levomepromazina [273] · 285
Imunoglobulina Humana Antivaricela-Zóster (VZIG) [492] · 504	Levosimendana [274] · 286
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) [246] · 258	Levotiroxina Sódica [275] · 287
Indacaterol [460] · 472	Lidocaína [276] · 288
Indometacina [247] · 259	Linezolida [277] · 289
Infliximabe [478] · 490	Lisdexanfetamina [278] · 290
Insulina Asparte [248] · 260	Lítio (Carbonato) [279] · 291
Insulina Degludeca [249] · 261	Loperamida [280] · 292
Insulina Detemir [490] · 502	Loratadina [281] · 293
Insulina Glargina [250] · 262	Lorazepam [282] · 294
Insulina Glulisina [251] · 263	Losartana Potássica [283] · 295
Insulina Lispro [252] · 264	Macrogol 3350 / 4000 (PEG) [284] · 296
Insulina NPH (Humana) [253] · 265	Manitol [285] · 297
Insulina Regular (Humana) [254] · 266	Mebendazol [286] · 298
Iodeto de Potássio [255] · 267	Mebeverina [287] · 299
Isavuconazol (Sulfato de Isavuconazônio) [256] · 268	Meloxicam [288] · 300
Isoflurano [257] · 269	Memantina [452] · 464

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Mepolizumabe [457] · 469	Nimesulida [317] · 329
Meropenem [289] · 301	Nirsevimabe [474] · 486
Mesalazina [290] · 302	Nistatina [318] · 330
Metadona [291] · 303	Nistatina + Óxido de Zinco [319] · 331
Metformina [292] · 304	Nitazoxanida [320] · 332
Metilergometrina [293] · 305	Nitrofurantoína [321] · 333
Metilfenidato [294] · 306	Nitroglicerina [322] · 334
Metilprednisolona [295] · 307	Nitroprussiato de Sódio [323] · 335
Metoclopramida [296] · 308	Noradrenalina (Norepinefrina) [324] · 336
Metoprolol (Tartarato / Succinato) [297] · 309	Nortriptilina [325] · 337
Metotrexato (Uso Imunossupressor) [480] · 492	Octreotida [326] · 338
Metronidazol / Benzoilmetronidazol [298] · 310	Olanzapina [327] · 339
Micafungina [299] · 311	Óleo Mineral (Petrolato Líquido) [328] · 340
Micofenolato de Mofetila / Sódio [479] · 491	Olopatadina [329] · 341
Miconazol [300] · 312	Omalizumabe [330] · 342
Midazolam [301] · 313	Omeprazol [331] · 343
Mikania Glomerata (Guaco) [302] · 314	Ondansetrona [332] · 344
Milrinona [303] · 315	Oseltamivir [333] · 345
Minociclina [304] · 316	Oxacilina Sódica [334] · 346
Mirtazapina [451] · 463	Oxcarbazepina [335] · 347
Misoprostol [305] · 317	Oxiconazol [336] · 348
Mometasona [306] · 318	Oxigênio Medicinal [337] · 349
Montelukaste de Sódio [307] · 319	Oxitocina [338] · 350
Morfina [308] · 320	Palivizumabe [339] · 351
Moxifloxacino [309] · 321	Pantoprazol [340] · 352
Mupirocina [310] · 322	Paracetamol (Acetaminofeno) [341] · 353
Naloxona [311] · 323	Penicilamina [342] · 354
Naproxeno (Sódico) [312] · 324	Perampanel [498] · 510
Neomicina [313] · 325	Permetrina [343] · 355
Neomicina + Bacitracina [314] · 326	Petidina (Meperidina) [344] · 356
Neostigmina [315] · 327	Picossulfato de Sódio [345] · 357
Nifedipino [316] · 328	Pilocarpina [346] · 358

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Pimecrolimo [347] · 359	Risperidona [378] · 390
Piperacilina + Tazobactam [348] · 360	Rivastigmina [453] · 465
Pirazinamida [349] · 361	Roflumilaste [459] · 471
Piridostigmina [350] · 362	Romiplostim [468] · 480
Piridoxina (Vitamina B6) [351] · 363	Ropivacaína [482] · 494
Pirimetamina [352] · 364	Rufinamida [379] · 391
Pirvínio (Pamoato) [353] · 365	Rupatadina [487] · 499
Plasma Fresco Congelado [354] · 366	Saccharomyces Boulardii [365] · 377
Poliestirenosulfonato de Cálcio [355] · 367	Sais de Reidratação Oral (SRO) [380] · 392
Polimixina B [356] · 368	Salbutamol [381] · 393
Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína [357] · 369	Salmeterol [382] · 394
Poractanto Alfa [358] · 370	Secnidazol [383] · 395
Posaconazol [359] · 371	Secuquinumabe [466] · 478
Pralidoxima [485] · 497	Sertralina [384] · 396
Praziquantel [360] · 372	Sevoflurano [385] · 397
Prednisolona [361] · 373	Sildenafil [386] · 398
Prednisona [362] · 374	Simeticona (Dimeticona) [387] · 399
Pregabalina [363] · 375	Sinvastatina [388] · 400
Primidona [364] · 376	Solução de Ringer com Lactato [389] · 401
Prometazina [366] · 378	Somatropina (Hormônio do Crescimento) [390] · 402
Propafenona [488] · 500	Soro Antiaracnídico [391] · 403
Propiltiouracila [367] · 379	Soro Antibotrópico (Pentavalente) [392] · 404
Propofol [368] · 380	Soro Antibotulínico AB Bivalente [393] · 405
Propranolol [369] · 381	Soro Anticrotático [394] · 406
Protamina [370] · 382	Soro Antidiftérico [395] · 407
Quetiapina [371] · 383	Soro Antielapídico (Bivalente) [396] · 408
Racecadotril [372] · 384	Soro Antiescorpiônico [397] · 409
Rasburicase [373] · 385	Soro Antitetânico [398] · 410
Remifentanila [374] · 386	Soro Polieletrólítico Balanceado [399] · 411
Retinol (Vitamina A) [375] · 387	Sotalol [489] · 501
Ribavirina [376] · 388	Succinilcolina [400] · 412
Rifampicina [377] · 389	Sucralfato [401] · 413

Índice de medicamentos

NOME GENÉRICO • NÚMERO DA FICHA • PÁGINA

Sufentanila [402] · 414	Tramadol [433] · 445
Sugamadex [403] · 415	Trazodona [449] · 461
Sulfadiazina [404] · 416	Triancinolona Acetonida [434] · 446
Sulfadiazina de Prata [405] · 417	Trimebutina [435] · 447
Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-Trimoxazol) [406] · 418	Umeclidínio (Brometo) [462] · 474
Sulfassalazina [407] · 419	Ureia [436] · 448
Sulfato de Magnésio [408] · 420	Valaciclovir [437] · 449
Sulfato Ferroso [410] · 422	Valganciclovir [438] · 450
Tacrolimo [411] · 423	Vancomicina [439] · 451
Tadalafila [412] · 424	Varfarina Sódica [440] · 452
Teicoplanina [413] · 425	Vasopressina [441] · 453
Tenecteplase [414] · 426	Venlafaxina [450] · 462
Teofilina [415] · 427	Verapamil [442] · 454
Terbinafina [416] · 428	Vigabatrina [443] · 455
Terbutalina [417] · 429	Vitamina A + D (Associação) [444] · 456
Terlipressina [418] · 430	Voriconazol [445] · 457
Tetraciclina [419] · 431	Vortioxetina [448] · 460
Tezepelumabe [455] · 467	Zinco (Sulfato) [409] · 421
Tiabendazol [420] · 432	
Tiamazol (Metimazol) [421] · 433	
Tiamina (Vitamina B1) [422] · 434	
Ticagrelor [423] · 435	
Tigeciclina [424] · 436	
Timolol [425] · 437	
Tinidazol [426] · 438	
Tioconazol [427] · 439	
Tiopental [428] · 440	
Tobramicina [429] · 441	
Tocilizumabe [430] · 442	
Tocoferol (Vitamina E) [431] · 443	
Topiramato [432] · 444	
Toxina Botulínica Tipo A [481] · 493	

1. Acebrofilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bronquite, traqueobronquite e hipersecreção/broncoespasmo associados a asma, broncopneumonia, bronquiectasias, pneumoconioses, rinofaringite, laringotraqueíte e enfisema	VO: 2 a <3 anos: 1 mg/kg/dose a cada 12 h (=2 mg/kg/dia). 3 a <6 anos: 25 mg a cada 12 h. 6-12 anos: 50 mg a cada 12 h. >12 anos: 100 mg a cada 12 h. A bula não estabelece duração específica por doença; reavaliar necessidade após a melhora da hipersecreção. [S1]
≥2 anos	Adjuvante sintomático; não substitui tratamento etiológico ou broncodilatador de resgate.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <2 anos, insuficiência renal/hepática grave e doença cardiovascular grave; cautela com outras xantinas e arritmias.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)
Bronquite e traqueobronquite com hipersecreção, broncoespasmo (adjuvante, a partir de 2 anos); hipersecreção e broncoespasmo associados a asma, broncopneumonia, bronquiectasias, pneumoconioses, rinofaringite, laringotraqueíte e enfisema (adjuvante sintomático conforme bula).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Geolab - acebrofilina, bula profissional (geolab.com.br)

2. Acetazolamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Glaucoma de ângulo aberto, secundário, congênito/juvenil e crise de fechamento angular - adjuvante Pediatria, oftalmologia	VO 10-20 mg/kg/dia divididos em 2-4 tomadas; titular à pressão intraocular. Crise angular: ponte até intervenção definitiva, não tratamento isolado. Uso crônico somente se benefício superar acidose/intolerância. [S1]
Epilepsia, incluindo ausências e crises mioclônicas - adjuvante Crianças	VO 8-30 mg/kg/dia em doses divididas; máximo 750 mg/dia. Manter conforme controle das crises, com reavaliação por tolerância e perda de efeito. [S2]
Mal de altitude - prevenção Crianças	VO 1,25 mg/kg/dose a cada 12 h, máximo 125 mg/dose; iniciar 1 dia antes da subida e manter 2 dias na altitude-alvo, ou mais enquanto continuar subindo. [S3]
Mal de altitude - tratamento Crianças	VO 2,5 mg/kg/dose a cada 12 h, máximo 250 mg/dose, até melhora e estabilização da altitude. Quadro grave exige descida e oxigênio imediatamente. [S3]
Hipertensão intracraniana idiopática Pediatria	VO iniciar sem ultrapassar 8 mg/kg/dose a cada 8 h, pelo peso ideal; aumentar lentamente conforme papiledema/campos visuais e tolerância. O protocolo utiliza progressão até 250 mg a cada 8 h, podendo tentar 375-500 mg a cada 8 h em crianças maiores tolerantes. Tratamento por meses, ajustado à remissão visual. [S4] Não aplicar a escala fixa de comprimidos a crianças pequenas.
Alcalose metabólica Pediatria hospitalizada	VO 5 mg/kg/dose a cada 6-8 h; uso curto, com gasometria e eletrólitos orientando suspensão após correção. [S5]
Edema cardíaco ou medicamentoso - diurese adjuvante selecionada Pediatria hospitalizada	Manual CHKD: EV/VO 5 mg/kg/dose a cada 6-12 h por 24 h; reavaliar balanço, bicarbonato/K e resposta antes de prolongar. [S6] Off-label; manual histórico lista regime para diurese, sem estratificar causa cardíaca/medicamentosa. Não é esquema crônico validado para todo edema.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em acidose hiperclorêmica, hiponatremia/hipocalemia importantes e disfunção renal/hepática grave. Monitorar bicarbonato, K, creatinina e litíase.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)
Glaucoma congênito ou secundário, epilepsias refratárias com crises de ausência ou mioclônicas (adjuvante); prevenção e tratamento do mal agudo da altitude; edema da insuficiência cardíaca e edema induzido por medicamentos (adjuvante), glaucoma de ângulo aberto e redução pré-operatória da pressão no glaucoma agudo de ângulo fechado; hipertensão intracraniana idiopática, alcalose metabólica refratária (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] American Academy of Ophthalmology - glaucoma medications (aao.org)
[S2] Acetazolamide - SmPC (medicines.org.uk)
[S3] CDC Yellow Book - high altitude illness (cdc.gov)
[S4] Alder Hey - hipertensão intracraniana idiopática pediátrica 2024 (alderhey.nhs.uk)
[S5] CHEO - Acetazolamide (outreach.cheo.on.ca)
[S6] CHKD - Pediatric Medication Handbook 2016, cópia institucional (pemsources.org)

3. Acetilcisteína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intoxicação por paracetamol - esquema EV de 3 bolsas ≥5 kg, FDA 2025	EV 150 mg/kg em 1 h, depois 50 mg/kg em 4 h e 100 mg/kg em 16 h: total 300 mg/kg/21 h. SG 5% como diluente: 5-20 kg, volumes de diluente 3 / 7 / 14 mL/kg, respectivamente; 21-40 kg, 100/250/500 mL; 41-99 kg, 200/500/1.000 mL. ≥100 kg: calcular por 100 kg. Ajustar volume ao estado hídrico e concentração permitida. [S1] Ao final, reavaliar paracetamol, ALT/AST, INR e quadro clínico antes de suspender.
Intoxicação por paracetamol - esquema EV de 2 bolsas Pediatria em toxicologia	PCH: EV 200 mg/kg em 4 h, depois 100 mg/kg em 16 h: total 300 mg/kg/20 h. Usar volume pediátrico individualizado; não aplicar bolsas adultas ao lactente. Intoxicação maciça pode exigir segunda bolsa 200 mg/kg por 16 h, após orientação toxicológica. [S1, S2] FDA 2025 rotula 2 bolsas somente ≥41 kg; centros pediátricos usam protocolo próprio em menores.
Intoxicação por paracetamol - via oral Pediatria, toxicologia	VO 140 mg/kg de ataque, seguido 70 mg/kg/dose a cada 4 h por 1-3 dias na bula brasileira; duração final orientada pela toxicologia/laboratório. [S3] Não atrasar início por ultrapassar 10 h da ingestão.
Hipersecreção: bronquite aguda/crônica, enfisema, pneumonia e atelectasia >2 anos	VO: 2-4 anos 100 mg 2-3 vezes/dia; >4 anos 100 mg 3-4 vezes/dia. Referência ponderal 9-15 mg/kg/dia. Agudas: 5-10 dias; crônicas: manutenção reavaliada. Bula permite até dobrar doses sob prescrição. [S3] Adjuvante sintomático; não substitui tratamento da causa.
Complicações pulmonares da fibrose cística >2 anos	VO 200 mg a cada 8 h; até 400 mg a cada 8 h somente com especialista conforme bula. Duração por resposta, frequentemente prolongada. [S3] Não equivale a alfa-dornase; benefício deve ser reavaliado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar hipersensibilidade, broncoespasmo e sobrecarga hídrica/hiponatremia. Conferir indicação: doses do antídoto são muito superiores às de mucolítico; não intercambiar.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)

Intoxicação por paracetamol (antídoto oral ou IV); secreções respiratórias espessas (mucolítico, a partir de 2 anos); mucólise como adjuvante na bronquite aguda ou crônica e exacerbações, enfisema, pneumonia, atelectasia e complicações pulmonares da fibrose cística.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Acetadote 2025 (accessdata.fda.gov)

[S2] PCH - Acetylcysteine (pch.health.wa.gov.au)

[S3] Zambon - Fluimucil, bula profissional (databaseprodotti.zambon.com)

4. Aciclovir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Herpes neonatal, cutâneo/ocular/oral, encefalite e disseminação Neonatos	EV 20 mg/kg/dose 8/8 h: doença limitada à pele/olhos/boca 14 dias; SNC/disseminada ≥21 dias. SNC: repetir PCR líquórico antes de suspender; continuar se positivo. [S2]
Encefalite herpética e HSV disseminado após período neonatal ≥4 semanas	PCH: <12 anos 20 mg/kg/dose EV 8/8 h; ≥12 anos 10 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 750 mg/dose, 14-21 dias. NIH: 10 mg/kg/dose (até 15 mg/kg <12 anos) 8/8 h por 21 dias. [S1, S2] Faixas de diretrizes distintas: selecionar integralmente um regime.
HSV mucocutâneo; gengivoestomatite herpética grave Crianças	NIH: grave EV 5-10 mg/kg/dose 8/8 h; transição VO após regressão, até cicatrização. VO 20 mg/kg/dose, máximo 400 mg, 4 vezes/dia por 7-10 dias; recorrência labial 5 dias. [S2]
Gengivoestomatite - alternativa oral precoce ≥4 semanas	VO 10 mg/kg/dose, máximo 400 mg, 5 vezes/dia por 7 dias; benefício maior se iniciado ≤72 h. [S3]
Varicela selecionada e zóster não complicado ≥4 semanas	VO 20 mg/kg/dose, máximo 800 mg, 5 vezes/dia por 7 dias. [S1]
Varicela grave/imunodeprimido; zóster disseminado ou oftálmico invasivo ≥4 semanas	EV: <12 anos 20 mg/kg/dose; ≥12 anos 10 mg/kg/dose; máximo 750 mg, 8/8 h. Após melhora, VO 20 mg/kg/dose, máximo 800 mg, 5 vezes/dia; total 7-14 dias. [S1]
Supressão de recorrências ≥3 meses; após HSV neonatal	Após HSV neonatal: VO 300 mg/m²/dose 8/8 h por 6 meses (NIH); PCH contempla 12 meses. Recorrência frequente: VO 10 mg/kg/dose 12/12 h, até 20 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 400 mg/dose; reavaliar aos 6 meses. [S1, S2]
Profilaxia em imunodeprimidos ≥4 semanas	EV 5 mg/kg/dose, máximo 750 mg, 8/8 h OU VO 30 mg/kg/dose 2-3 vezes/dia, máximo 1.600 mg/dia, durante risco. Pós-exposição varicela: VO 20 mg/kg/dose, máximo 800 mg, 4 vezes/dia por 5-7 dias, começando 7-10 dias após exposição. [S1]
Ceratite herpética ≥3 meses	Pomada oftálmica 3%: faixa 1 cm 5 vezes/dia; até 14 dias ou 3 dias após cicatrização, o que ocorrer primeiro; oftalmologia. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES EV: diluir em SF 0,9% a 5 mg/mL e infundir 1 h. Hidratação, função renal e neurotoxicidade. Ajustar intervalo/dose se eGFR <50. Não injetar em bolus.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)
Infecções por herpes simples, encefalite herpética, herpes neonatal ou disseminado, gengivoestomatite herpética grave, varicela em situações selecionadas e imunodeprimidos, herpes-zóster, supressão de recorrências, profilaxia em imunodeprimidos; ceratite por herpes simples.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Aciclovir ChAMP (health.wa.gov.au)
[S2] NIH - HSV pediátrico (clinicalinfo.hiv.gov)
[S3] PCH - Herpes stomatitis (pch.health.wa.gov.au)

5. Ácido Acetilsalicílico (AAS)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Artrite da febre reumática aguda Crianças/adolescentes, reumatologia	VO 80-100 mg/kg/dia divididos em 4 tomadas por 2 semanas; havendo melhora, reduzir para 60 mg/kg/dia dividido em 4 tomadas e manter por 4 semanas. Ajustar pela resposta e toxicidade. [S1] SBP prefere AINEs com melhor perfil de segurança; teto absoluto deve ser definido pelo serviço conforme peso e salicilemia.
Kawasaki - fase inflamatória Crianças	VO 30-50 mg/kg/dia divididos em 4 tomadas; alternativa tradicional 80-100 mg/kg/dia em 4 tomadas. Reduzir à dose antiagregante após 48-72 h sem febre. [S2] Não demonstrada vantagem coronária da dose alta.
Kawasaki - antiagregação Crianças	VO 3-5 mg/kg 1 vez/dia, usualmente até 6-8 semanas do início, se coronárias normais; manter mais tempo quando persistir aneurisma conforme cardiologia. [S2]
Dor e febre População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não usar como antitérmico/analgésico pediátrico de rotina; não se fornece um esquema de automedicação nesta indicação documental. [S1] Evitar particularmente em virose pelo risco de síndrome de Reye.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sangramento, rim, salicilismo e síndrome de Reye. Em influenza/varicela durante antiagregação por Kawasaki, reavaliar o AAS e discutir substituição com cardiologia; não suspender automaticamente em qualquer virose. Ibuprofeno pode reduzir sua ação plaquetária. [S3]

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)
Artrite da febre reumática aguda; dor e febre (respeitar restrições; não usar como antitérmico pediátrico de rotina); doença de Kawasaki: fase inflamatória e antiagregação plaquetária (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] SBP - Febre reumática: diagnóstico, tratamento e profilaxia (sbp.com.br)
[S2] AHA - Kawasaki disease 2024 (ahajournals.org)

[S3] Canadian Paediatric Society - Kawasaki disease, 2026

6. Ácido Aminocaproico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorragias por hip erfibrinólise/trombol íticos; prevenção/controle perioperatório; discrasias sanguínea s/hemofilias; hemoptise; sangramento uterino	VO 100-200 mg/kg/dia, divididos em 3-4 administrações (a cada 8 ou 6 h). Manter enquanto necessário para estabilização da hemostasia; a bula não fixa dias ou teto absoluto pediátrico. [S1] Faixa da bula brasileira. Sangramento maciço não deve ser tratado apenas por VO.
Crianças	
Sangramento renal	Não usar indiscriminadamente: hematúria do trato urinário superior pode causar obstrução por coágulos. Somente após localizar a origem e ponderar benefício/risco. [S1]
Crianças	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indicação documental preservada; não há esquema seguro universal para essa descrição.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar dose na insuficiência renal; monitorar trombose, função renal e CPK em tratamento prolongado. Não utilizar em coagulação intravascular ativa sem controlar a causa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)
Hemorragias por hiperfibrinólise ou trombolíticos, prevenção/controle de sangramento perioperatório, discrasias sanguíneas e hemofilias, hemoptise, sangramento renal e uterino.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Zydus - Ipsilon, bula profissional brasileira (cópia do documento) (uploads.consultaremedios.com.br)

7. Ácido Ascórbico (Vitamina C)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência de vitamina C e escorbuto Lactentes/crianças/adol escentes	VO 100-300 mg/dia em doses divididas por 1 semana, depois 100 mg/dia por 1-3 meses, até reposição e correção dietética. Se via oral inviável, esquema EV rotulado citado: 5-<12 meses 50 mg/dia; 1-<11 anos 100 mg/dia; ≥11 anos 200 mg/dia por 7 dias. [S1] Escolher VO sempre que possível; investigação não deve atrasar tratamento diante de forte suspeita.
Suplementação em prematuros e nutrição parenteral Prematuros/lactentes ≤12 meses; crianças maiores	Na NP: 15-25 mg/kg/dia até 12 meses; após 12 meses 80 mg/dia. Somar todas as fontes vitamínicas da NP e fornecer durante sua necessidade. [S2] Prematuridade isolada não justifica megadose se dieta já é suficiente.
Apoio à absorção do ferro Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Corrigir deficiência de vitamina C conforme esquema acima e assegurar ingestão alimentar adequada. Não existe dose farmacológica universal de vitamina C necessária para toda prescrição de ferro. [S1] Não substituir dose de ferro nem investigar anemia apenas pela resposta ao suplemento.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cautela em insuficiência renal/litíase por oxalato e deficiência de G6PD com doses altas EV; evitar megadoses.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)

Deficiência de vitamina C e escorbuto, suplementação em prematuros ou nutrição parenteral, apoio à absorção de ferro.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Royal Children's Hospital - estudo e proposta clínica para escorbuto pediátrico (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S2] ESPGHAN/ESPEN - vitaminas em nutrição parenteral pediátrica (espen.org)

8. Ácido Fólico (Vitamina B9)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anemia megaloblástica por deficiência de folato 1-18 anos	VO 5 mg/dia por 4 meses; manutenção 5 mg a cada 1-7 dias conforme persistência da causa. [S1]
Suplementação nas anemias hemolíticas crônicas: falciforme, esferocitose, talassemia 1-18 anos	VO: 1-12 anos, 2,5-5 mg/dia; 12-18 anos, 5-10 mg/dia na monografia consultada. Manter enquanto houver necessidade hematológica e reavaliar dieta/hemograma. [S1]
Prematuridade Recém-nascidos	Suplementação enteral 50 mcg/kg/dia; faixa de ingestão recomendada 35-100 mcg/kg/dia. Descontar folato já fornecido por fortificante/fórmula. Deficiência neonatal: 100 mcg/dia, sem dividir pelo peso. [S2] Dose neonatal não equivale ao esquema de crianças maiores.
Redução da toxicidade de metotrexato semanal em baixa dose Crianças com artrite idiopática juvenil	VO 1 mg/dia, omitindo o dia da dose semanal de MTX; manter enquanto usar MTX e reavaliar tolerância/hemograma. [S3] Não substitui folinato no resgate de superdose de MTX.
Prevenção de defeitos do tubo neural no período periconcepcional Adolescentes com possibilidade de gestação	Risco habitual: VO 0,4 mg/dia, iniciar antes da concepção e manter até 12 semanas. Alto risco: 5 mg/dia no mesmo período. [S1] Indicação materna; não administrar esse esquema ao recém-nascido.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Excluir deficiência de vitamina B12 antes de tratar anemia isoladamente; folato pode corrigir o hemograma e permitir progressão da lesão neurológica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 7)

Anemia megaloblástica por deficiência de folato, suplementação nas anemias hemolíticas crônicas (falciforme, esferocitose, talassemia) e prematuridade, redução da toxicidade do metotrexato; prevenção de defeitos do tubo neural no período periconcepcional.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Folic acid oral solution - SmPC (medicines.org.uk)

[S2] ANMF - Folic acid neonatal (anmfonline.org)

[S3] MARAJIA - consenso de metotrexato em artrite idiopática juvenil (doi.org)

9. Ácido Folínico (Folinato de Cálcio)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Resgate de metotrexato em alta dose Crianças em oncologia	Exemplo de regime rotulado após MTX 12-15 g/m ² : iniciar folinato 15 mg (aproximadamente 10 mg/m ²) VO/IM/EV a cada 6 h, 24 h após início do MTX, por 10 doses; prolongar se MTX ≥ 0,05 micromol/L. Não usar essa escala em protocolos oncológicos diferentes sem ajustar à dose/nível do MTX. [S1]
Superdose de MTX ou eliminação retardada Crianças em oncologia	Iniciar imediatamente 10 mg/m ² VO/IM/EV a cada 6 h até MTX < 0,01 micromol/L. Se creatinina aumentar ≥ 50% em 24 h ou MTX > 5 micromol/L em 24 h ou > 0,9 em 48 h: 100 mg/m ² EV a cada 3 h até MTX < 0,01. [S1] Resgate deve acompanhar hidratação, alcalinização e eventual glucarpidase.
Toxicidade hematológica da pirimetamina - toxoplasmose congênita Neonatos/lactentes	VO 10 mg três vezes/semana durante a pirimetamina; aumentar conforme neutropenia sob infectologia. [S2]
Anemia megaloblástica por deficiência de folato quando VO não é possível Pediatria	IM/EV até 1 mg/dia; manter até recuperação hematológica e reposição possível pela via oral. [S1] Excluir deficiência de B12 antes de tratar isoladamente.
Mielotoxicidade por trimetoprima Crianças, toxicidade documentada	Após suspender trimetoprima: folinato VO 3-10 mg/dia até normalização do hemograma. [S3] Não associar rotineiramente ao TMP-SMX na pneumocistose; confirmar toxicidade e selecionar dose dentro da faixa pelo hemograma.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES NUNCA intratecal. Doses altas devem ser EV; não exceder 160 mg/min de folinato cálcico. Acompanhar níveis de MTX, função renal, hemograma e pH urinário.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)

Resgate após metotrexato, prevenção ou tratamento da toxicidade hematológica da pirimetamina na toxoplasmose congênita e da trimetoprima; anemia megaloblástica quando a reposição oral é inadequada.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Leucovorin calcium injection (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] ANMF - Folinic acid (anmfonline.org)

[S3] Hospira - Calcium Folate 15 mg, SmPC 2024 (medicines.org.uk)

10. Ácido Fusídico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções bacterianas cutâneas localizadas: impetigo, foliculite, paroníquia, eritrasma, eczema e feridas infectadas	Aplicar fina camada de ácido fusídico 2% na lesão 3-4 vezes/dia; curso usual de 7 dias. Lesões cobertas podem exigir menor frequência. [S1, S2]
Crianças e adolescentes	A extensão/profundidade pode exigir antibiótico sistêmico; evitar cursos repetidos por resistência.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar contato ocular; suspender se irritação ou sensibilização. Não misturar com corticosteroide sem indicação própria.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Infecções bacterianas cutâneas localizadas; impetigo, foliculite, paroníquia, eritrasma, eczema e feridas infectadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] Fusidic acid 20 mg/g - SmPC (medicines.org.uk)
- [S2] NHS - modo e duração de uso do ácido fusídico (nhs.uk)

11. Ácido Mefenâmico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor inflamatória leve/moderada e odontológica	VO 500 mg a cada 8 h (=1.500 mg/dia), pelo menor tempo necessário ao controle da dor. [S1]
>14 anos	Bula brasileira do comprimido 500 mg; não fracionar comprimido não autorizado.
Dismenorreia primária	VO 500 mg a cada 8 h, iniciar no começo da dor menstrual e manter durante o período sintomático. [S1]
>14 anos	Não transformar em uso crônico diário.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <14 anos, dengue suspeita, úlcera/sangramento digestivo e insuficiência renal/hepática/cardíaca grave. Evitar outros AINEs e desidratação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)

Dor inflamatória leve a moderada, dor odontológica, dismenorreia primária (bula restrita acima de 14 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Pfizer - Ponstan, bula profissional brasileira (cópia do documento) (onepharma.com.br)

12. Ácido Nalidíxico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
ITU por Gram-negativos sensíveis - esquema histórico	Bula FDA 2007: VO 55 mg/kg/dia divididos a cada 6 h; se uso prolongado após fase inicial,33 mg/kg/dia em 4 tomadas. Bula não fixa duração pediátrica por foco; não apresentar como primeira escolha atual. [S1]
>3 meses RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Fonte histórica não comprova disponibilidade/registro atual, nem suscetibilidade local.
Infecção intestinal por Gram-negativo sensível	A bula oficial aberta limita indicação à ITU; não respalda esquema intestinal pediátrico atual. Escolher tratamento por agente identificado e diretriz vigente. [S1]
Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não extrapolar dose urinária para enteroinfecção.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <3 meses, história de convulsões e porfiria. Risco de convulsão, hipertensão intracraniana, neuropatia e lesão tendínea; ajustar à função renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Infecções urinárias e intestinais por bactérias Gram-negativas sensíveis (contraindicado abaixo de 3 meses e em histórico de convulsões).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FDA/Sanofi - NegGram/nalidixic acid, bula histórica 2007 (accessdata.fda.gov)

13. Ácido Tranexâmico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorragia traumática ≥4 semanas	EV: ataque 15 mg/kg (máximo 1 g), precocemente e idealmente até 3 h do trauma; depois até 2 mg/kg/h por 8 h, com continuidade condicionada à persistência do sangramento. Infundir ataque lentamente, sem ultrapassar 100 mg/min. [S1]
Prevenção de sangramento cirúrgico ≥4 semanas	Cirurgia não cardíaca: ataque EV 10-30 mg/kg (máximo 1 g), depois 5-10 mg/kg/h durante cirurgia. Circulação extracorpórea: ataque 10-100 mg/kg (máximo 1 g) em 1 h, depois 10 mg/kg/h durante cirurgia. [S1] Faixa alta exclusiva de cirurgia cardíaca; risco de convulsões.
Sangramentos mucosos na hemofilia/doença de von Willebrand ≥4 semanas	VO 15-25 mg/kg/dose (máximo 1,5 g) 2-3 vezes/dia OU EV 10 mg/kg/dose (máximo 1 g) 2-3 vezes/dia. Após procedimento dentário: até 8 dias. [S1]
Angioedema hereditário - profilaxia ≥4 semanas	VO 15-25 mg/kg/dose, máximo 1,5 g/dose, 2-3 vezes/dia; uso contínuo se selecionado, reavaliado por resposta. [S1] Alternativa de eficácia limitada; não trata adequadamente uma crise laríngea.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar na insuficiência renal; evitar na trombose ativa e hematúria alta com risco de obstrução. Monitorar convulsões. Nunca intratecal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)

Hemorragia traumática, prevenção e controle de sangramento cirúrgico, sangramentos mucosos na hemofilia ou doença de von Willebrand (adjuvante); angioedema hereditário.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Tranexamic Acid (pch.health.wa.gov.au)

14. Ácido Ursodesoxicólico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Colestase neonatal Neonatos	VO/sonda 10-15 mg/kg/dose 12/12 h (=20-30 mg/kg/dia); manter até resposta clínica/bioquímica, reavaliando bilirrubinas. [S1]
Colestase associada à nutrição parenteral Todas as idades pediátricas	VO 10 mg/kg/dose 8/8 h; duração guiada por retomada enteral e normalização da GGT/colestase. [S2] Off-label; não substitui ajuste da nutrição parenteral.
Atresia biliar após Kasai Lactentes/crianças, hepatologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime descrito no manejo pós-Kasai: VO 20 mg/kg/dia para colestase/prurido; fracionamento deve ser individualizado. Estudo 2025 observou benefício com ≤10 mg/kg/dia no primeiro ano; não definiu regime prescritivo universal. [S3, S4] Off-label; não manter altas doses automaticamente por anos: evidência de benefício tardio é limitada e obstrução completa contraindica.
Doença hepatobiliar da fibrose cística 6-18 anos; menores somente especialista	VO 10-15 mg/kg/dose 12/12 h OU 20-30 mg/kg/dia divididos em 3 tomadas; contínuo se resposta/tolerância. [S2] A indicação e dose não provam prevenção de progressão em todos os fenótipos.
Colangite esclerosante primária Crianças/adolescentes	VO 15-20 mg/kg/dia, teste de 6 meses; manter somente se melhora relevante de GGT/sintomas. [S5] ESPGHAN não demonstra prevenção da progressão. Não usar doses 28-30 mg/kg/dia automaticamente.
Lama/cálculos biliares - casos sintomáticos selecionados Crianças/adolescentes; cautela especial em lactentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Estudo pediátrico: VO 8-10 mg/kg/DIA; avaliar clinicamente e por ultrassom a cada 3 meses, teste até 6 meses. Fonte geral NHS permite dose diária única ou dividida 12/12 h; estudo pediátrico não publica fracionamento próprio. [S2, S7, S8] Off-label, benefício inconsistente. Estudo 2024 em lactentes desaconselha uso rotineiro, sobretudo assintomáticos; complicação/obstrução exige abordagem própria.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar bilirrubina direta/GGT/transaminases, fezes e diarreia. Contraindicado em obstrução completa e colangite/colecistite aguda sem controle da causa; separar de colestiramina/antiácidos com alumínio.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Colestase neonatal ou associada à nutrição parenteral, atresia biliar após Kasai, doença hepatobiliar da fibrose cística, colangite esclerosante primária; lama e cálculos biliares (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ANMF - Ursodeoxycholic acid 2024 (anmfonline.org)
[S2] NHS Cheshire/Merseyside - Ursodeoxycholic acid prescribing support (cheshireandmerseysideformulary.nhs.uk)
[S3] Hadzic - Medical management of failing Kasai (doi.org)
[S4] Estudo 2025 - dose/duração de UDCA pós-Kasai (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
[S5] ESPGHAN - PSC pediátrica 2024 (doi.org)
[S6] BNFC - Ursodeoxycholic acid (bnfc.nice.org.uk)
[S7] Estudo pediátrico 2020 - colelitíase e UDCA (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
[S8] Estudo 2024 - colelitíase em lactentes (doi.org)

15. Ácido Valproico / Valproato de Sódio / Divalproato de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Epilepsia: crises focais complexas e generalizadas, incluindo ausências e mioclonias Crianças/adolescentes; risco particularmente alto <2 anos	VO iniciar 10-15 mg/kg/dia; ausências:15 mg/kg/dia. Dividir em 2-3 tomadas, especialmente se total >250 mg/dia. Aumentar 5-10 mg/kg/dia a cada semana conforme resposta; máximo 60 mg/kg/dia. Uso contínuo; retirada gradual após decisão neurológica. [S1] Focais: bula consultada estabelece uso ≥10 anos; crianças menores e algumas síndromes exigem neurologia/off-label.
Status epiléptico convulsivo persistente Preferencialmente >2 anos; segunda linha hospitalar	EV 40 mg/kg, máximo 3 g, em 3-5 min, dose de ataque única; decidir manutenção após cessação. [S2] Uso off-label; evitar se doença mitocondrial/metabólica suspeita.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em doença hepática significativa, alterações POLG e defeitos do ciclo da ureia. Hemograma/plaquetas, transaminases e amônia se encefalopatia; níveis usuais 50-100 mcg/mL. Alto risco fetal e interação com carbapenêmicos/lamotrigina.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Epilepsias generalizadas, crises de ausência e mioclônicas; crises focais complexas; estado de mal epiléptico refratário a benzodiazepínicos (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Valproic acid, março 2026 (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] Queensland Children - status epilepticus (childrens.health.qld.gov.au)

16. Adenosina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
TSV regular por reentrada nodal/atrioventricular, inclusive WPW ortodrômico	EV/IO 0,1 mg/kg, máximo 6 mg, em bolus muito rápido; se falha, segunda dose 0,2 mg/kg, máximo 12 mg. Administrar pelo acesso proximal em 1-2 s, seguido imediatamente de flush SF 0,9%. Tratamento da crise; não manutenção. [S1, S2]
Lactentes/crianças	Se instabilidade, cardioversão sincronizada não deve ser atrasada. Não usar em fibrilação atrial pré-excitada ou taquicardia irregular/polimórfica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG contínuo e material de reanimação. Transplante cardíaco/dipiridamol exigem redução; xantinas antagonizam efeito. Cautela em broncoespasmo ativo e bloqueio AV sem marcapasso.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Taquicardia supraventricular regular por reentrada nodal ou atrioventricular, inclusive Wolff-Parkinson-White; reversão de TSV em crianças (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AHA - PALS Tachyarrhythmia With a Pulse 2025 (cpr.heart.org)
[S2] PCH - Adenosine (pch.health.wa.gov.au)

17. Adrenalina (Epinefrina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anafilaxia Crianças e adolescentes	IM: 0,01 mg/kg/dose (=10 mcg/kg/dose), máximo 0,5 mg; repetir a cada 5 min se necessário. Solução 1 mg/mL: 0,01 mL/kg, máximo 0,5 mL, na face anterolateral da coxa. [S1]
Anafilaxia refratária >4 semanas	EV contínua: iniciar 0,1 mcg/kg/min e titular à perfusão, pressão e efeitos adversos. Prosseguir até estabilidade e desmamar. [S1] Após adrenalina IM repetida e reposição volêmica apropriada; não administrar a ampola 1 mg/mL em bolus EV. Preparo periférico de baixa concentração PCH:6 mg em volume final 1000 mL de SF 0,9% (6 mcg/mL);1 mL/kg/h fornece 0,1 mcg/kg/min, considerando carga hídrica.
Parada cardiorrespiratória Crianças e adolescentes; reanimação neonatal possui algoritmo próprio	EV/IO: 0,01 mg/kg/dose, máximo 1 mg, a cada 3-5 min durante RCP. Usar 0,1 mg/mL: 0,1 mL/kg/dose. [S1] A monografia PCH usa ciclos de 4 min, dentro da faixa 3-5 min.
Choque distributivo ou cardiogênico refratário Nascimento-18 anos	EV contínua: iniciar 0,05-0,1 mcg/kg/min, titular à resposta hemodinâmica. A fonte não define teto universal. mL/h = dose (mcg/kg/min) × peso (kg) × 60 ÷ concentração final (mcg/mL). [S1] Preparo PCH via central:>10 kg,3 mg em SF 0,9% q.s.p.50 mL=60 mcg/mL. ≤10 kg fora da UTIN:500 mcg q.s.p.30 mL=16,67 mcg/mL aproximadamente; usar concentração exata 500/30 na programação. Nunca usar a concentração por kg neonatal como mcg/mL absoluto.
Crupe moderado/grave com estridor em repouso >4 semanas	Nebulizar 0,5 mg/kg/dose, máximo 5 mg, da solução 1 mg/mL; completar até 5 mL com SF 0,9% se necessário. Repetir após 15 min se persistência grave. [S1] Off-label; observar recorrência após efeito transitório.
Crise asmática grave refratária Crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A monografia contempla adrenalina nebulizada 0,5 mg/kg, máximo 5 mg. Não é esquema de rotina para asma; selecionar apenas resgate especializado ou anafilaxia concomitante. [S1] Não substituir salbutamol; evidência e diretrizes de asma não sustentam uso universal.
Reanimação neonatal e choque neonatal Neonatos	RCP neonatal: EV 0,01-0,03 mg/kg/dose (=0,1-0,3 mL/kg da solução 0,1 mg/mL), repetir 3-5 min se indicado. Enquanto obtém acesso: endotraqueal 0,05-0,1 mg/kg/dose (=0,5-1 mL/kg da solução 0,1 mg/mL). Choque: EV contínua 0,05-1 mcg/kg/min, titulada. [S2] Via endotraqueal tem absorção menos previsível; preferir acesso vascular. BIC neonatal:0,3 mg/kg em SG 5% (preferido) ou SF 0,9% q.s.p.50 mL=6 mcg/kg/mL;1 mL/h fornece 0,1 mcg/kg/min. Trata-se de preparo individualizado pelo peso, não de 6 mcg/mL fixos.
Anafilaxia refratária com parada iminente - resgate EV excepcional >4 semanas, equipe de ressuscitação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	EV 1 mcg/kg/dose em 1 minuto, máximo 50 mcg, titular à resposta. Diluição PCH:10 mcg/kg, máximo 500 mcg, em SF 0,9% q.s.p.10 mL; administrar 1 mL desse preparo para a dose inicial. [S1] Somente se IM repetida/volume falharam e parada iminente; infusão contínua é preferível ao bolus, com ECG/PA/oximetria contínuos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, PA, perfusão, lactato e potássio; inspecionar acesso periférico. Não misturar com bicarbonato. Conferir mg versus mcg e concentração 1 versus 0,1 mg/mL.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 8)
Anafilaxia e anafilaxia refratária, parada cardiorrespiratória, choque distributivo ou cardiogênico refratário; crise asmática grave refratária; crupe moderado/grave com estridor em repouso (nebulização, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] [PCH - Adrenaline \(Epinephrine\)](#) (pch.health.wa.gov.au)
[S2] [NeoMedQ - Adrenaline neonatal](#) (health.qld.gov.au)

18. Agalsidase Beta

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Fabry ≥2 anos pela bula FDA 2024; fonte original cita ≥8 anos	EV: 1 mg/kg a cada 14 dias, reposição contínua. Iniciar ≤0,25 mg/min (=15 mg/h); peso <30 kg: manter esse teto. Em ≥30 kg, aumentar gradualmente somente após tolerância demonstrada; não acelerar por conta própria. [S1, S2] Diferença regulatória: faixa ≥2 anos verificada em bula FDA; não comprova autorização brasileira nessa idade.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar reações infusionais, anafilaxia e anticorpos; sem ajuste renal; dados hepáticos limitados. Não misturar com outros medicamentos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Doença de Fabry (reposição enzimática, a partir de 8 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sanofi - agalsidase beta, SmPC (medicines.org.uk)

[S2] Sanofi - Fabrazyme FDA 2024 (products.sanofi.us)

19. Albendazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Ascaridíase e ancilostomíase ≥2 anos	VO 400 mg em dose única. [S1]
Oxiuríase ≥2 anos	VO 400 mg em dose única; repetir após 14 dias para erradicar vermes recém-eclodidos. [S1, S5] Associar higiene e manejo dos contatos.
Tricuríase ≥2 anos	Bula brasileira: VO 400 mg em dose única. Alternativa CDC: 400 mg 1 vez/dia por 3 dias, com maior duração para essa espécie. [S1, S2]
Giardíase 2-12 anos	VO 400 mg 1 vez/dia por 5 dias. [S1]
Larva migrans cutânea ≥2 anos	VO 400 mg 1 vez/dia por 1-3 dias. [S1]
Estrongiloidíase, teníase e himenolepíase ≥2 anos	Bula: VO 400 mg/dia por 3 dias; himenolepíase comprovada: repetir ciclo em 10-21 dias. [S1] Ivermectina é preferível na estrongiloidíase; excluir neurocisticercose quando houver sinais neurológicos.
Neurocisticercose Crianças, avaliação especializada	1-2 cistos parenquimatosos viáveis: VO 15 mg/kg/dia em 2 tomadas, máximo 1.200 mg/dia, por 10-14 dias (IDSA). CDC descreve 15 dias. Adequar ao número/localização/viabilidade; com >2 cistos, avaliar associação. [S3, S6] Off-label no catálogo original. Não tratar lesões calcificadas com antiparasitário; controlar edema e crises.
Toxocaríase visceral Crianças e adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquema CDC: VO 400 mg a cada 12 h por 5 dias. [S4] Off-label; a fonte usa mesma dose em adultos/crianças, mas não define idade mínima; crianças pequenas requerem individualização especializada. Duração ótima indefinida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cursos sistêmicos/prolongados: hemograma e transaminases. Evitar gestação. Neurocisticercose: avaliar fundo de olho, hipertensão intracraniana e corticosteroide antes do antiparasitário.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)

Ascaridíase, oxiuríase, ancilostomíase, tricuríase, giardíase (2-12 anos), larva migrans cutânea, estrongiloidíase, teníase, himenolepíase; neurocisticercose e toxocaríase (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Prati-Donaduzzi - albendazol, bula profissional (bulas.pratidonaduzzi.com.br)

[S2] CDC - Soil-transmitted helminths (cdc.gov)

[S3] CDC - Cysticercosis (cdc.gov)

[S4] CDC - Toxocariasis (cdc.gov)

[S5] CDC - Pinworm clinical overview (cdc.gov)

[S6] IDSA/ASTMH - Neurocisticercose, recomendação 13 (dose e teto por fenótipo)

Revisão corretiva de 13/09/2026: alterações e novas referências conferidas nesta ficha.

20. Alendronato de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Osteogênese imperfeita 4-18 anos, tratamento especializado	Regime estudado: VO 5 mg/dia se <40 kg ou 10 mg/dia se ≥40 kg, por até 2 anos no ensaio. Não converter automaticamente para comprimido de 70 mg semanal. [S1] Off-label; melhora da densidade óssea não demonstrou redução significativa de fraturas no ensaio.
Osteoporose pós-menopausa, osteoporose induzida por glicocorticoides e doença de Paget Indicações adultas do documento original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Pós-menopausa e Paget adulto não possuem esquema pediátrico transponível. Osteoporose pediátrica por glicocorticoide exige avaliação óssea especializada e não usa automaticamente o esquema adulto. [S1] Preservadas como indicações documentais, sem dose adulta apresentada como pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Administrar em jejum com água, manter sentado/em pé ≥30 min; corrigir hipocalcemia/vitamina D, avaliar função renal e doença esofágica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Osteoporose pós-menopausa e induzida por glicocorticoides, doença de Paget (uso majoritário adulto; uso pediátrico especializado em osteogênese imperfeita, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - avaliação pediátrica do alendronato em osteogênese imperfeita (accessdata.fda.gov)

21. Alfa-Dornase (Dornase Alfa)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Fibrose cística com secreções viscosas	Inalar por nebulizador 2,5 mg 1 vez/dia; tratamento contínuo, com reavaliação funcional e das exacerbações. [S1]
Crianças e adolescentes	Não extrapolar 2 vezes/dia de pacientes >21 anos para crianças; <5 anos requer avaliação especializada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não diluir nem misturar na câmara com outros fármacos. Usar nebulizador compatível; monitorar disfonia e broncoespasmo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Fibrose cística com secreções respiratórias viscosas para melhora da função pulmonar.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Roche - dornase alfa, SmPC (medicines.org.uk)

22. Alglucosidase Alfa

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Pompe infantil ou tardia	EV 20 mg/kg a cada 14 dias, continuamente. Iniciar 1 mg/kg/h e aumentar 2 mg/kg/h a cada 30 min até máximo 7 mg/kg/h, se tolerado; concluir a dose total. [S1]
Todas as idades pediátricas	Esquemas intensificados existem em centros especializados, mas não são intercambiáveis automaticamente com o esquema de bula.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar anafilaxia, função cardiorrespiratória, sobrecarga hídrica e anticorpos; avaliar status CRIM e eventual imunomodulação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Doença de Pompe de início infantil ou tardio (reposição enzimática de primeira linha).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] Sanofi - alglucosidase alfa, SmPC \(medicines.org.uk\)](#)

23. Alopurinol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hiperuricemia associada à lise tumoral; síndrome de Lesch-Nyhan e outros erros inatos; nefropatia por ácido úrico	VO 10-20 mg/kg/dia, máximo 400 mg/dia; pode fracionar se intolerância gastrointestinal. Ajustar à uricemia. Lise tumoral: manter durante o período de risco; erros inatos: tratamento contínuo. [S1] Não reduz rapidamente ácido úrico já elevado; lise estabelecida com alto risco renal pode exigir rasburicase.
<15 anos	
Hiperuricemia da quimioterapia/lise tumoral - alternativa FDA	VO 100 mg/m²/dose a cada 8-12 h, máximo 800 mg/dia. Bula também cita alternativa ponderal 10 mg/kg/dia; não somar métodos. Iniciar 24-48 h antes da quimioterapia e suspender quando risco desaparecer, usualmente 2-3 dias após início, prolongando se lise persistente. [S2]
Pediatria, incluindo adolescentes	SC <0,5 m²: preferir formulação que permita dose exata; dose por superfície não é igualdade matemática com dose ponderal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reduzir na insuficiência renal; hidratar, acompanhar urato e função renal. Suspender diante de rash. Azatioprina/6-mercaptopurina exigem redução substancial se associação for inevitável.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Hiperuricemia associada à lise tumoral, erros inatos do metabolismo (síndrome de Lesch-Nyhan), nefropatia por ácido úrico.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Allopurinol - SmPC (medicines.org.uk)
[S2] DailyMed - Allopurinol, pediatric cancer dosing (dailymed.nlm.nih.gov)

24. Alprazolam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtornos de ansiedade e pânico	Não há dose pediátrica estabelecida na bula oficial consultada. Não extrapolar a dose adulta nem oferecer faixa ponderal como validada. [S1]
<18 anos	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Uso off-label excepcional requer psiquiatria pediátrica; a indicação documental não comprova benefício pediátrico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dependência, abstinência/convulsões e depressão respiratória, particularmente com opioides/álcool; evitar retirada abrupta e inibidores potentes de CYP 3A.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Transtornos de ansiedade e pânico (uso predominantemente adulto; uso pediátrico restrito e especializado, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Pfizer - alprazolam, informação de prescrição (labeling.pfizer.com)

25. Alprostadil (Prostaglandina E1)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção da permeabilidade do canal arterial em cardiopatia ducto-dependente	EV contínua: iniciar 0,05-0,1 mcg/kg/min; após resposta, reduzir sequencialmente para 0,05, 0,025 e 0,01 mcg/kg/min, mantendo a menor dose eficaz até intervenção. Falha de resposta: bula admite até 0,4 mcg/kg/min, sem benefício habitual de doses altas. mL/h = dose x peso x60/concentração final (mcg/mL). [S1]
Neonatos/lactentes	A apresentação brasileira de 20 mcg não equivale à ampola 500 mcg da fonte; conferir produto e veículo antes do preparo.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Apneia frequente, hipotensão, febre e rubor: monitorização cardiorrespiratória contínua e suporte ventilatório imediatamente disponível. Nunca bolus.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)
Manutenção da permeabilidade do canal arterial em lactentes com cardiopatia congênita e fluxo pulmonar dependente do canal arterial, até intervenção cirúrgica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed/Pfizer - Prostín VR Pediatric, revisão abril 2026 (dailymed.nlm.nih.gov)

26. Alteplase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Desobstrução trombótica de cateter venoso central Todas as idades	Instilar 1 mg/mL: <30 kg, volume de 110% do lúmen, máximo 2 mg/2 mL; ≥30 kg, 2 mg/2 mL. Avaliar após 30 min; se necessário, manter até 120 min. Persistindo obstrução, repetir a mesma dose uma vez e reavaliar nos mesmos tempos. Após recuperar patência, aspirar fármaco/coágulo. [S2] Não infundir o conteúdo trombolítico do lúmen na circulação; excluir obstrução mecânica.
Embolia pulmonar maciça com risco vital Crianças e adolescentes selecionados	Trombólise sistêmica: EV 0,1-0,6 mg/kg/h, usual 0,5 mg/kg/h por 6 h, máximo 100 mg/dia; alternativas de baixa dose 0,01-0,06 mg/kg/h, usual 0,02-0,03 mg/kg/h (máximo 2 mg/h), por 12-70 h em indicações selecionadas. [S1] Off-label; alto risco hemorrágico, decisão hematologia/UTI.
AVC isquêmico Crianças selecionadas em centro de AVC pediátrico RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime estudado: total 0,9 mg/kg EV (máximo 90 mg): 10% em 1 min e 90% em 60 min. [S1] Não é indicação pediátrica generalizada; exige seleção por imagem, janela e equipe especializada. Fonte limita ao protocolo de estudo.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Excluir hemorragia ativa/intracraniana, coagulopatia importante, cirurgia/trauma recente e hipertensão descontrolada. Monitorar neurologia, Hb, plaquetas e fibrinogênio.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 9)

Trombólise em embolia pulmonar maciça ou AVC isquêmico (uso adulto); desobstrução trombótica de cateter venoso central (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Alteplase (pch.health.wa.gov.au)

[S2] Genentech - Cathflo Activase: dose intralúmen e tempos de permanência

27. Amantadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reações extrapiramidais induzidas por fármacos - parkinsonismo Crianças/adolescentes selecionados; consenso não estratifica peso/idade	CAMESA: VO iniciar 50 mg/dia; aumentar semanalmente até 50 mg 2-3 vezes/dia. Reavaliar semanalmente e reduzir quando o agente causal puder ser ajustado. [S1] Off-label, consenso 2011; não extrapolar para lactentes. Priorizar revisão do antipsicótico.
Distonia medicamentosa Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Amantadina não possui regime pediátrico de resgate estabelecido para distonia aguda. A tabela CAMESA a reserva ao parkinsonismo; distonia aguda requer agente anticolinérgico apropriado. [S1] Indicação original preservada, mas não generalizada a qualquer síndrome extrapiramidal.
Reabilitação após TCE grave com alteração de consciência 6-18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ensaio piloto: VO 4 mg/kg/DIA, máximo 300 mg/dia, por 7 dias; depois 6 mg/kg/DIA, máximo 400 mg/dia, por 14 dias; duração 3 semanas. [S2, S3] Off-label; fontes abertas não confirmam o intervalo do ensaio. Dose diária de pesquisa não é prescrição operacional completa; não extrapolar o teto 400 mg para todo TCE pediátrico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar na insuficiência renal; monitorar confusão, alucinações, convulsões e hipotensão. Retirada gradual após uso prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)

Reações extrapiramidais induzidas por fármacos; distonias e reabilitação após traumatismo cranioencefálico grave na criança (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CAMESA - tabela de tratamento de efeitos extrapiramidais (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S2] McMahon et al. - amantadina em lesão cerebral adquirida pediátrica (doi.org)

[S3] Pediatric Brain Injury Consortium - amantadine prescribing patterns 2022 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

28. Ambroxol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doenças broncopulmonares agudas/crônicas com secreção viscosa	VO, como cloridrato de ambroxol: <2 anos, 7,5 mg a cada 12 h somente sob prescrição; 2-5 anos, 7,5 mg a cada 8 h; 6-12 anos, 15 mg a cada 8 h; >12 anos, 30 mg a cada 8 h. Alternativa ponderal da bula: 0,5 mg/kg/dose 3 vezes/dia. Regime inicial até 14 dias, reavaliar persistência. [S1]
Pediatria	Mucolítico adjuvante; não é terapia específica para pneumonia/asma.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Interromper se lesão de pele/mucosa, reação alérgica ou broncoespasmo; cautela na insuficiência renal e incapacidade de eliminar secreções.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)
Doenças broncopulmonares agudas e crônicas associadas a secreções mucóides viscosas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Prati-Donaduzzi - ambroxol, bula profissional (bulas.pratidonaduzzi.com.br)

29. Amicacina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-negativos: sepse, ITU complicada, infecções osteoarticulares e pulmonares ≥4 semanas	Regime PCH EV/IM: 20 mg/kg/dose 1 vez/dia, máximo 1,5 g. Paciente crítico/fibrose cística/queimadura grave: 30 mg/kg/dose 1 vez/dia, máximo 1,5 g, com monitorização farmacocinética. EV: concentração final ≤10 mg/mL em SF 0,9%/SG 5%; infundir em 30-60 min (lactentes: 1-2 h). Reavaliar descalonamento em 48-72 h. [S1, S3] Para sepse/infecção pulmonar/ITU tratadas com amicacina, bula geral usa 7-10 dias; reavaliar necessidade antes de ultrapassar 10 dias. Infecção osteoarticular requer tratamento total maior e transição para agente adequado, não amicacina prolongada automática.
Sepse neonatal por Gram-negativo sensível Neonatos, por idade pós-menstrual (IPM) e pós-natal (IPN)	EV/IM: IPM ≤29 semanas: IPN 0-7 dias 14 mg/kg a cada 48 h;8-28 dias 12 mg/kg a cada 36 h;≥29 dias 12 mg/kg a cada 24 h. IPM 30-34 semanas: IPN 0-7 dias 12 mg/kg a cada 36 h;≥8 dias 12 mg/kg a cada 24 h. IPM ≥35 semanas:12 mg/kg a cada 24 h. EV 5 mg/mL em 20-30 min. Duração não equivale ao intervalo: reavaliar culturas e foco em 48 h; infecção confirmada exige curso dirigido. [S2] Aumentar intervalo 12 h em hipotermia terapêutica/indometacina/ibuprofeno. Se tratamento >48 h, medir pico 24-35 mg/L e vale <5 mg/L; vale ≥5: suspender próxima dose até avaliação.
Micobactérias não tuberculosas ≥4 semanas	EV/IM 15 mg/kg/dose 1 vez/dia, máximo 1,5 g, em associação. M. abscessus na fibrose cística: fase intensiva EV 3-12 semanas; tratamento combinado total 12 meses após conversão cultural, com fase de continuação própria. [S1, S4] Off-label; alternativa intermitente em adolescentes apenas com infectologia.
Sepse, ITU e infecções pulmonares - esquema fracionado de bula Crianças/lactentes além do período neonatal	EV/IM 15 mg/kg/DIA:7,5 mg/kg/dose 12/12 h OU 5 mg/kg/dose 8/8 h; máximo 1,5 g/dia. Curso usual 7-10 dias, abreviar/trocar conforme culturas. [S3] Alternativa ao esquema diário PCH; não somar doses ou misturar tetos entre protocolos.
Infecção osteoarticular por Gram-negativo sensível - componente inicial ≥4 semanas	Usar esquema EV/IM 20 mg/kg/dose 24/24 h, máximo 1,5 g, com níveis séricos. Duração total do tratamento: osteomielite 4-6 semanas; artrite séptica 2-3 semanas em cursos usuais, com drenagem e transição a outro agente sensível. [S1, S5] Durações são do tratamento completo, não recomendação de manter amicacina durante todas as semanas.
ITU baixa por E. coli ESBL sem alternativa oral - regime estudado 2-18 anos, função renal normal RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	IM 15 mg/kg 1 vez/dia; estudo utilizou 3-7 dias, mediana 6 dias. [S6] Não extrapolar curso curto para pielonefrite, sepse ou complicação anatômica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Creatinina, diurese, audição e níveis séricos; no PCH vale <5 mg/L. Intervalos orientativos: eGFR 40-59:36 h;20-39:48 h; <20: redosar somente após nível. Evitar nefro/ototóxicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)
Infecções graves por Gram-negativos suscetíveis (sepse neonatal, sepse, infecções urinárias complicadas, osteoarticulares, pulmonares); infecções por micobactérias não tuberculosas (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] PCH - Amikacin (pch.health.wa.gov.au)
- [S2] ANMF - Amikacin 2024 neonatal (seslhd.health.nsw.gov.au)
- [S3] DailyMed - Amikacin sulfate label (dailymed.nlm.nih.gov)
- [S4] CFF/ECFS - Nontuberculous mycobacteria (cff.org)
- [S5] Stanford Children’s - durations of pediatric infections (stanfordchildrens.org)
- [S6] Polat - amikacin for ESBL lower UTI in children (doi.org)

30. Amilorida + Hidroclorotiazida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão e edema com necessidade de poupar potássio	A associação fixa amilorida/hidroclorotiazida não tem esquema pediátrico estabelecido na bula consultada; não há razão segura para transpor número de comprimidos de adulto. [S1]
<18 anos	Se necessários, os componentes podem ser prescritos separadamente com doses pediátricas individuais por especialista.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada em hipercalemia, insuficiência renal significativa e associação com outros poupadores de K; monitorar K, Na, creatinina e PA.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)
Hipertensão arterial e edema cardíaco (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label para preservação de potássio).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Co-amilozide - SmPC (medicines.org.uk)

31. Aminofilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crise asmática grave refratária - ataque ≥1 mês	EV:1-<12 meses 5 mg/kg;1-18 anos 5-10 mg/kg, máximo 500 mg, em 30 min e sem exceder 25 mg/min. Omitir ataque ou medir teofilina se uso nas últimas 24 h. [S1]
Crise asmática grave - manutenção ≥6 semanas	EV contínua:6 semanas-<6 meses 0,5 mg/kg/h;6-<12 meses 0,7;1-<9 anos 0,9-1,1;9-<12 anos 0,7;12-18 anos 0,5-0,7 mg/kg/h. Alternativa EV a cada 6 h:3;4;6;5;3-4 mg/kg/dose, respectivamente (máximo 500 mg/dose nas faixas ≥1 ano). Manter apenas enquanto broncoespasmo grave exigir, titulando por níveis. [S1] Diluir a1 mg/mL em SF 0,9%/SG 5%; doses de manutenção intermitentes em 20 min.
Apneia da prematuridade - alternativa à cafeína Neonatos	Ataque EV/VO 6 mg/kg; manutenção inicial 2,5-3,75 mg/kg/dose a cada 12 h. EV em 20-30 min; ajustar intervalo e dose por níveis e maturação. Manter até resolução sustentada das apneias. [S2] Dose expressa em aminofilina; contém aproximadamente 80% de teofilina.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Janela terapêutica estreita: ECG, K, glicemia e teofilinemia; alvo asma 5-15 mcg/mL, concentrações maiores só com especialista. Reduzir em hepatopatia, febre persistente/choque. Náusea, taquicardia e convulsões sugerem toxicidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)
Crise asmática grave refratária (resgate especializado em UTI); apneia primária da prematuridade como alternativa à cafeína (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] PCH - Aminophylline (pch.health.wa.gov.au)
[S2] PedMed/BC Children - aminophylline neonatal 2024 (pedmed.org)

32. Amiodarona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
PCR por FV/TV sem pulso refratária Lactentes/crianças; algoritmo pediátrico	EV/IO 5 mg/kg em bolus: primeira dose máximo 300 mg; doses subsequentes máximo 150 mg cada; até 3 doses no total durante PCR. Preparo PCH ≤ 30 kg: 150 mg em SG 5% q.s.p. 30 mL = 5 mg/mL; retirar apenas a dose calculada. > 30 kg, dose > 150 mg: diluir a dose em 10-20 mL de SG 5%. [S2] Não usar teto cumulativo 900 mg da monografia antiga como regime PALS 2025.
Taquiarritmias ventriculares ou supraventriculares graves com pulso ≥ 4 semanas	Ataque EV 5 mg/kg (máximo 300 mg), em 20-120 min; repetir 1-5 mg/kg se necessário, até ataque acumulado 15 mg/kg/dia ou 900 mg/dia. BIC: iniciar 5 mcg/kg/min, faixa 5-15 mcg/kg/min, máximo 1.200 mg/dia. Desmamar quando estável. [S1, S3] Cardioversão não deve ser adiada quando houver instabilidade; administração rápida com pulso pode provocar hipotensão. Preparo CHEO: 50 mg (1 mL a 50 mg/mL) + 49 mL SG 5% = 50 mL finais, 1 mg/mL = 1000 mcg/mL. BIC em $\text{mL/h} = \text{dose (mcg/kg/min)} \times \text{peso (kg)} \times 60 \div 1000$. Infusão > 1 h: filtro 0,22 micra; acesso central preferido.
Taquiarritmias graves - transição e manutenção oral ≥ 4 semanas-18 anos, cardiologia	VO ≥ 4 semanas-12 anos: 5 mg/kg/dose, máximo 200 mg, 12/12 h por 7-10 dias; depois 5 mg/kg, máximo 200 mg, 1 vez/dia. > 12 anos: 200 mg 8/8 h por 7 dias; depois 200 mg 12/12 h por 7 dias; depois 200 mg 1 vez/dia. Manutenção contínua na menor dose eficaz. [S1] Carga oral pode ser dispensada após > 2 semanas de terapia EV; sobreposição EV/VO somente conforme cardiologia. Solução injetável não deve ser administrada por via oral.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG/QTc e PA contínuos, K/Mg, transaminases e tireoide em uso prolongado. Diluir SOMENTE em SG 5%; SF 0,9% apenas para flush, não como diluente; formulações podem conter álcool benzílico. Evitar associação empírica com procainamida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)

Parada cardiorrespiratória por FV/TV sem pulso refratária à desfibrilação, taquiarritmias ventriculares e supraventriculares graves.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Amiodarone (pch.health.wa.gov.au)

[S2] AHA - PALS Cardiac Arrest Algorithm 2025 (cpr.heart.org)

[S3] CHEO - Amiodarone, revisão junho 2026 (outreach.cheo.on.ca)

33. Amitriptilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Enurese noturna refratária ≥6 anos	VO:6-10 anos 10-20 mg à noite; ≥11 anos 25-50 mg à noite, 1-1,5 h antes de deitar. Máximo 3 meses por curso antes de reavaliar; retirar gradualmente. [S1] ECG basal; selecionar após alternativas apropriadas.
Dor neuropática 2-17 anos	VO:2-11 anos iniciar 0,2-0,5 mg/kg à noite, máximo inicial 10 mg; aumentar gradualmente; teto BNFC 1 mg/kg/dose a cada 12 h somente com especialista. 12-17 anos iniciar 10 mg à noite, titular até 75 mg à noite. Contínuo conforme benefício, com reavaliação funcional. [S2] Off-label; não confundir mcg e mg.
Profilaxia de enxaqueca ≥8 anos	VO 0,25-0,5 mg/kg 1 vez/dia à noite; aumentar 0,25 mg/kg/dia a cada 2 semanas, até 1 mg/kg/dia ou 100 mg/dia, o menor. Teste adequado 2-3 meses. [S3, S4] Off-label; evidência de eficácia isolada é limitada e CHAMP não superou placebo. Associar medidas comportamentais/CBT quando indicado.
Profilaxia de enxaqueca - esquema estudado CHAMP 8-17 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO total 1 mg/kg/dia dividido 12/12 h como alvo; titulação a cada 2 semanas durante 8 semanas, manutenção 16 semanas e retirada 2 semanas. [S4] Regime de ensaio, não prova superioridade ao placebo; efeitos adversos mais frequentes. Não somar aos esquemas noturnos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de QT/arritmia, sedação, retenção urinária, constipação e comportamento suicida; contraindicado com IMAO e cardiopatia de condução. Evitar retirada abrupta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)

Enurese noturna monossintomática refratária (com causas orgânicas excluídas); profilaxia de enxaqueca e dor neuropática crônica (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Amitriptyline - SmPC (medicines.org.uk)

[S2] NICE BNFC - amitriptyline (bnfc.nice.org.uk)

[S3] Prisma Health Children's - Pediatric headache guideline (prismahealthchildrens.org)

[S4] CHAMP - ensaio de prevenção da migração pediátrica (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

34. Amlodipino

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial essencial 6-17 anos	VO iniciar 2,5 mg 1 vez/dia; aumentar para 5 mg/dia se meta pressórica não atingida após 4 semanas. Tratamento contínuo; titular pela PA e tolerância. [S1] Bula consultada não estabelece dose >5 mg/dia nem esquema <6 anos; outras diretrizes pediátricas podem empregar doses ponderais off-label.
Hipertensão arterial - titulação hospitalar alternativa Crianças/adolescentes, nefrologia	VO iniciar 0,1 mg/kg 1 vez/dia, máximo inicial 2,5 mg; titular a cada 3-5 dias, teto 0,3 mg/kg/dia ou 10 mg/dia, o menor. Contínuo, ajustar à PA. [S2] Doses >5 mg/dia extrapolam a faixa pediátrica da bula consultada; diretriz hospitalar.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, edema e taquicardia; iniciar baixo e titular devagar em hepatopatia; sem ajuste renal habitual. Não usar para crise hipertensiva aguda.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)
Hipertensão arterial essencial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label consolidado).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Amlodipine - SmPC (medicines.org.uk)
[S2] Children’s Mercy - antihypertensive dosing (childrensmercy.org)

35. Amoxicilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Otite média aguda ≥6 meses	VO 45 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose. Duração:<2 anos ou quadro grave 10 dias;2-5 anos 7 dias;>5 anos 5 dias. [S1]
Rinossinusite bacteriana não grave Pediatria	VO 45 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose, por 10 dias. [S2]
Faringoamigdalite estreptocócica Crianças/adolescentes	VO 50 mg/kg 1 vez/dia, máximo 1 g/dia, por 10 dias. Alternativa:25 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 500 mg/dose, por 10 dias. [S3, S6] Confirmar etiologia estreptocócica.
Pneumonia comunitária típica não complicada ≥3 meses, ambulatorial	VO 45 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose, por 5 dias; reavaliar se ausência de resposta ou gravidade. [S4]
Profilaxia de endocardite em procedimento indicado Crianças de alto risco cardíaco	VO 50 mg/kg, máximo 2 g, dose única 30-60 min antes do procedimento. [S5] Somente cardiopatia/procedimento com indicação de profilaxia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar em insuficiência renal e confirmar alergia a penicilinas. Não tratar virose; reavaliar em 48-72 h se falha.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 10)

Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, faringoamigdalite estreptocócica, pneumonia comunitária típica, profilaxia de endocardite bacteriana.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] UCSF - Acute otitis media (idmp.ucsf.edu)

[S2] UCSF - Acute bacterial sinusitis (idmp.ucsf.edu)

[S3] UCSF - Streptococcal pharyngitis (idmp.ucsf.edu)

[S4] UCSF - Community-acquired pneumonia (idmp.ucsf.edu)

[S5] UPMC Children's - endocarditis prophylaxis (chp.edu)

[S6] CDC - Streptococcal pharyngitis (cdc.gov)

36. Amoxicilina + Clavulanato de Potássio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
OMA com falha/risco de betalactamase ≥6 meses	VO 45 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose. Duração:<2 anos ou grave 10 dias;2-5 anos 7 dias;>5 anos 5 dias. [S1]
Rinossinusite com falha/risco de betalactamase ou grave Pediatria	VO 45 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 2 g/dose, por 10 dias; selecionar formulação que limite clavulanato. [S2]
Mordedura animal/humana Pediatria	VO 22,5 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 875 mg/dose. Profilaxia de alto risco 3-5 dias; infecção estabelecida 7-10 dias. [S3]
Pneumonia aspirativa bacteriana - transição enteral Pediatria	VO 45 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose. Curso 5 dias; resposta lenta pode exigir até 10 dias, com reavaliação 48 h. Sem evidência de infecção às 72 h: suspender antibiótico. [S4, S9] Pneumonite química que melhora em 24-48 h não requer antibiótico.
Celulite pré-septal de origem sinusal; celulite orbitária - transição oral Crianças/adolescentes	VO 45 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 1 g/dose. Pré-septal:5-7 dias ou até resolução; estender se sinusite associada. Orbital: completar 14-21 dias EV+VO. [S5, S7] Orbital requer início EV e avaliação oftalmológica.
ITU complicada - terapia dirigida/etapa oral Pediatria, cultura sensível e estabilidade	VO 25 mg de amoxicilina/kg/dose 12/12 h, máximo 500 mg/dose. Curso usual 7 dias nas ITUs responsivas; complicação anatômica, bacteremia ou abscesso exige individualização. [S6] Não escolha empírica universal nem tratamento único de sepse.
Infecções graves das indicações acima - alternativa intravenosa Nascidos a termo e crianças	EV, componente AMOXICILINA: nascimento-<3 meses e <4 kg 25 mg/kg/dose 12/12 h;≥4 kg 25 mg/kg/dose 8/8 h. ≥3 meses e <40 kg 25 mg/kg/dose 8/8 h, até 6/6 h se grave, máximo 1 g/dose. ≥40 kg 1 g8/8 h, até 2 g6/6-8/8 h em doença grave. Diluir ≤10 mg/mL em SF 0,9% e infundir 30 min. [S8] Dose 2 g exige 1 g de amoxicilina isolada+1 g da associação para limitar clavulanato 200 mg/dose; não duplicar dois frascos 1 g/200 mg. Duração pelo foco nas linhas acima.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Todas as doses são do componente AMOXICILINA. Preferir relação adequada para não exceder clavulanato; ajustar renal, vigiar hepatite colestática/alergia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)
Otite média aguda e rinossinusite com falha à amoxicilina ou risco de betalactamases, mordeduras animais/humanas, pneumonia aspirativa, celulite orbitária/pré-septal, infecções urinárias complicadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] UCSF - Acute otitis media (idmp.ucsf.edu)
- [S2] UCSF - Acute bacterial sinusitis (idmp.ucsf.edu)
- [S3] UCSF - Bite wound (idmp.ucsf.edu)
- [S4] UCSF - Aspiration pneumonia (idmp.ucsf.edu)
- [S5] UCSF - Orbital cellulitis (idmp.ucsf.edu)
- [S6] UCSF - Urinary tract infection (idmp.ucsf.edu)
- [S7] UCSF - Periorbital/preseptal cellulitis (idmp.ucsf.edu)
- [S8] PCH - Amoxicillin/clavulanic acid ChAMP (pch.health.wa.gov.au)
- [S9] NHS Scotland - Aspiration pneumonia in children (rightdecisions.scot.nhs.uk)

37. Amoxicilina + Sulbactam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções respiratórias e otite média por produtores de betalactamase Crianças	VO: amoxicilina 40-100 mg/kg/dia dividida a cada 12 h. A suspensão é amoxicilina:sulbactam 4:1. Ajustar dose ao quadro e gravidade; a bula não define duração própria por foco. OMA:10 dias se <2 anos/grave;7 dias 2-5 anos;5 dias >5 anos. Pneumonia não complicada:5 dias; sinusite:10-14 dias. Durações por síndrome, quando associação selecionada e agente suscetível. [S1, S2, S3] Não confundir com ampicilina/sulbactam ou amoxicilina/clavulanato.
Infecções intra-abdominais e de partes moles; respiratórias graves <12 anos	EV/IM: amoxicilina 40-50 mg/kg/dia + sulbactam 20-25 mg/kg/dia, divididos em 2-3 doses; grave: amoxicilina 100 mg/kg/dia + sulbactam 50 mg/kg/dia. >12 anos: 1 g+500 mg a cada 8 h. Partes moles:celulite 5 dias;abscesso 5-10 dias após drenagem. Intra-abdominal: duração depende de controle do foco e complicações; não há curso universal próprio dessa associação. [S1, S3] Há erro textual na bula: 60-75 mg/kg/dia do total 2:1 corresponde a sulbactam 20-25, não 20-50 mg/kg/dia. Conversão corrigida matematicamente; duração específica não informada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar intervalo na insuficiência renal; anafilaxia a penicilinas contraindica. Concentração total e componente amoxicilina devem ser diferenciados.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)

Infecções respiratórias, otite média aguda, infecções intra-abdominais e de partes moles por microrganismos produtores de betalactamases.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bagó - Trifamox IBL, bula brasileira (cópia) (img.drogasil.com.br)

[S2] UCSF - Otite média aguda: duração por idade (idmp.ucsf.edu)

[S3] Stanford Children's - duração por foco (stanfordchildrens.org)

38. Ampicilina + Sulbactam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções intra-abdominais e pélvicas Crianças	EV 50 mg de AMPICILINA/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g de ampicilina/dose (=25 mg sulbactam/kg/dose, máximo 1 g). Bula geral:5-14 dias, podendo prolongar se foco persistente; controle cirúrgico orienta redução. [S1, S2] Confirmar suscetibilidade de enterobactérias; resistência pode inviabilizar escolha.
Epigloteite Crianças	EV 50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose, por 7-10 dias no total. [S1, S3] Selecionar se cobertura microbiológica adequada; prioridade é via aérea. Stanford prefere ceftriaxona empiricamente.
Sinusite grave com internação Crianças	EV 50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose; completar 10-14 dias ou 7 dias após resolução dos sintomas, mínimo 10 dias. [S1, S3]
Pneumonia complicada/empiema Crianças	EV 50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose; total 14-28 dias EV+VO conforme drenagem e resposta. [S4] Não prolongar automaticamente a fase EV por todo o curso.
Abscesso periamigdaliano e retrofaríngeo Crianças	EV 50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose; completar 10-14 dias com transição oral quando possível; drenagem se indicada. [S5]
Celulite orbitária Crianças	EV 50 mg de ampicilina/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose, seguido de terapia oral; total 14-21 dias. Extensão intracraniana requer outro esquema. [S6]
Alternativa posológica da bula - infecções suscetíveis Crianças/neonatos	Total 150 mg/kg/dia (ampicilina 100+sulbactam 50) dividido 6/6-8/8 h. Primeira semana de vida, especialmente prematuros: total 75 mg/kg/dia (50+25) dividido 12/12 h. Infusão 15-30 min. [S2] Faixa de bula menor que diretrizes de infecção grave; não intercambiar sem avaliar indicação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Doses principais expressas em AMPICILINA; produto 2:1. Ajustar renal; vigiar carga de sódio, alergia e função hepática. Não misturar diretamente com aminoglicosídeos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)

Infecções intra-abdominais, pélvicas, respiratórias (epigloteite, sinusite, pneumonia), abscessos periamigdalianos e retrofaríngeos, celulite orbitária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] UCSF - Antimicrobial dosing 2025 (idmp.ucsf.edu)

[S2] Pfizer - Unasyn bula (labeling.pfizer.com)

[S3] Stanford Children's - initial therapy pediatric infections (stanfordchildrens.org)

[S4] UCSF - Community-acquired pneumonia (idmp.ucsf.edu)

[S5] UCSF - Peritonsillar/retropharyngeal abscess (idmp.ucsf.edu)

[S6] UCSF - Orbital cellulitis (idmp.ucsf.edu)

39. Ampicilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sepse neonatal Neonatos, por idade pós-menstrual(IPM) e pós-natal(IPN)	EV 50 mg/kg/dose. IPM ≤29+6 semanas: IPN 0-28 dias 12/12 h, ≥29 dias 8/8 h. IPM 30-36+6: IPN 0-14 dias 12/12 h, ≥15 dias 8/8 h. IPM 37-44+6: IPN 0-7 dias 12/12 h, ≥8 dias 8/8 h. IPM ≥45 semanas:6/6 h. [S1] Esquema empírico associado a cobertura de Gram-negativos; estreitar após culturas. Duração pela etiologia, conforme linha GBS.
Meningite neonatal Neonatos	EV 100 mg/kg/dose: IPN 0-6 dias 12/12 h;7-20 dias 8/8 h;≥21 dias 6/6 h. Infundir 25 mg/mL em 15-30 min. GBS não complicada 14 dias; outro agente/ventriculite exige curso específico. [S1, S3]
Meningite bacteriana após período neonatal; Listeria monocytogenes ≥1 mês	EV 400 mg/kg/dia divididos 4/4-6/6 h, máximo 2 g/dose. Listeria:21 dias; GBS:14 dias; persistência/abscesso exige extensão. [S2, S3, S4] Uso dirigido ou cobertura de Listeria; não monoterapia empírica universal de meningite.
Pneumonia grave por agente sensível ≥3 meses	EV 50 mg/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose. Não complicada:7 dias no total, incluindo transição oral; complicação demanda curso maior. [S5]
Infecções por estreptococo do grupo B Neonatos/lactentes	Usar dose neonatal de sepsse ou meningite acima. Bacteremia sem foco 10 dias; meningite 14 dias; osteomielite ≥3 semanas e ventriculite ≥4 semanas. [S1, S3] Penicilina G é alternativa preferida para estreitar espectro.
Infecções por Enterococcus faecalis sensível ≥1 mês	EV 50 mg/kg/dose 6/6 h, máximo 2 g/dose; dose e duração adicionais dependem de ITU, bacteremia ou endocardite. Não há duração única para a indicação documental ampla. [S2] Endocardite exige esquema sinérgico e duração própria; não usar este regime isolado como tratamento validado de endocardite.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar à função renal. Monitorar Na/K e neurotoxicidade em altas doses. Não misturar com aminoglicosídeo; preparar/diluir separadamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)
Sepsse e meningite neonatal, meningite bacteriana, pneumonia grave, infecções por *Listeria monocytogenes*, *Enterococcus faecalis* ou estreptococo do grupo B.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NeoMedQ - Ampicillin neonatal (health.qld.gov.au)
[S2] UCSF - Pediatric dosing 2025 (idmp.ucsf.edu)
[S3] AAP 2024 - Neonatal Group B Streptococcus Disease (doi.org)
[S4] NICE NG 240 - meningite 2024 (nice.org.uk)
[S5] UCSF - Pediatric community-acquired pneumonia (idmp.ucsf.edu)

40. Anfotericina B

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase sistêmica/invasiva Crianças; neonatal separado	EV LIPOSSOMAL 3-5 mg/kg 1 vez/dia; neonato: DESOXICOLATO 1 mg/kg/dia. Candidemia sem foco: pelo menos 14 dias após primeira hemocultura negativa documentada e resolução clínica. SNC: lipossomal 5 mg/kg/dia; neonato pode usar desoxicolato 1 mg/kg/dia, até resolução clínica/liquórica/radiológica, geralmente ≥1 mês. [S1] SNC pode exigir flucitosina; remover cateter/foco quando indicado.
Aspergilose invasiva Crianças/adolescentes	EV LIPOSSOMAL 3-5 mg/kg 1 vez/dia OU COMPLEXO LIPÍDICO 5 mg/kg/dia; tratamento total ≥6-12 semanas conforme imunidade/localização/resposta. [S2] Alternativa quando azol adequado não pode ser usado; desoxicolato menos favorável por toxicidade.
Criptococose meníngea/disseminada Crianças, diretriz NIH pediátrica	EV DESOXICOLATO 1 mg/kg/dia OU LIPOSSOMAL 6 mg/kg/dia + flucitosina 25 mg/kg/dose VO 6/6 h, por ≥14 dias; após melhora e cultura liquórica negativa, consolidação com fluconazol ≥8 semanas. Sem flucitosina: lipossomal 6 mg/kg/dia OU complexo lipídico 5 mg/kg/dia OU desoxicolato 1-1,5 mg/kg/dia, com avaliação de fluconazol associado. [S3] Formulações/doses não intercambiáveis; controlar hipertensão intracraniana.
Mucormicose Crianças, equipe especializada	EV LIPOSSOMAL 5-10 mg/kg 1 vez/dia desde o primeiro dia; SNC:10 mg/kg/dia. Alternativa sem SNC: COMPLEXO LIPÍDICO 5 mg/kg/dia. Manter por semanas a meses até resposta clínica/radiológica e reversão da imunossupressão. [S4] Associar desbridamento; desoxicolato é desaconselhado quando formulação lipídica disponível.
Histoplasmose grave/disseminada ou SNC Crianças	EV LIPOSSOMAL 3-5 mg/kg/dia OU DESOXICOLATO 0,7-1 mg/kg/dia. Pulmonar grave:1-2 semanas; disseminada:≥2 semanas e melhora; SNC:4-6 semanas. Depois itraconazol:12 semanas se imunidade preservada na pulmonar;≥12 meses na disseminada/imunossupressão/SNC. [S5]
Leishmaniose visceral Crianças	EV LIPOSSOMAL 3 mg/kg/dia por 7 dias OU 4 mg/kg/dia por 5 dias. Alternativa DESOXICOLATO 1 mg/kg/dia, máximo 50 mg/dia, por 14-20 dias. [S6] Lipossomal: reconstituir 50 mg com 12 mL água estéril; diluir em SG 5% a0,2-2 mg/mL e infundir 30-60 min. Não aplicar preparo a outra formulação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Confirmar formulação antes do cálculo: lipossomal, complexo lipídico e desoxicolato têm doses distintas. Monitorar creatinina, K/Mg, hemograma e reações infusionais; não diluir em SF. Limites de dose acima são por indicação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)
Micoses sistêmicas graves e invasivas (candidíase sistêmica, aspergilose, criptococose, mucormicose, histoplasmose, leishmaniose visceral).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] NIH - Candida pediatric OI (clinicalinfo.hiv.gov)
- [S2] IDSA/PIDS - Aspergillosis 2016 (idsociety.org)
- [S3] NIH - Cryptococcosis pediatric OI (clinicalinfo.hiv.gov)
- [S4] ECMM/MSG - Global mucormycosis guideline (ecmm.info)
- [S5] NIH - Histoplasmosis pediatric OI (clinicalinfo.hiv.gov)
- [S6] Ministério da Saúde - Leishmaniose visceral (gov.br)

41. Anidulafungina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidemia e candidíase invasiva ≥1 mês	EV: ataque 3 mg/kg (máximo 200 mg) no primeiro dia; depois 1,5 mg/kg (máximo 100 mg) a cada 24 h. Diluir em SF 0,9% ou SG 5% até 0,77 mg/mL; infundir ≤1,1 mg/min. [S1, S2] Candidemia sem foco profundo: manter ≥14 dias após primeira hemocultura negativa e resolução dos sintomas; foco profundo exige curso maior.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar função hepática e reações infusionais. Sem ajuste renal/hepático habitual. Não é escolha apropriada isolada para candidíase urinária ou meningite; cautela <4 semanas por polissorbato 80.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)
Candidemia e candidíase invasiva (aprovado para adultos e crianças acima de 1 mês).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] PCH - Anidulafungin (pch.health.wa.gov.au)
[S2] Pfizer - Eraxis, bula FDA (labeling.pfizer.com)

42. Aripiprazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Irritabilidade associada ao autismo 6-17 anos	VO iniciar 2 mg/dia; aumentar para 5 mg/dia, depois 10-15 mg/dia se necessário, em incrementos ≤ 5 mg com intervalos ≥ 1 semana. Máximo 15 mg/dia; reavaliar benefício e efeitos metabólicos continuamente. [S1]
Síndrome de Tourette 6-18 anos	<50 kg: 2 mg/dia por 2 dias, depois 5 mg/dia; máximo 10 mg/dia. ≥ 50 kg: 2 mg/dia por 2 dias, 5 mg/dia por 5 dias, depois 10 mg/dia; máximo 20 mg/dia. Aumentos subsequentes de 5 mg não mais que semanais. [S1]
Esquizofrenia 13-17 anos	VO 2 mg/dia por 2 dias, 5 mg/dia por 2 dias, depois 10 mg/dia; ajustes de 5 mg conforme resposta, máximo 30 mg/dia. Tratamento contínuo, menor dose eficaz. [S1]
Transtorno bipolar I - episódios maníacos/mistos 10-17 anos	VO 2 mg/dia por 2 dias, 5 mg/dia por 2 dias, depois 10 mg/dia; máximo 30 mg/dia em aumentos de 5 mg. Reavaliar resposta aguda e manutenção. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar peso/IMC, glicemia, lipídios, acatisia, movimentos anormais e suicidabilidade. Ajustar com inibidores CYP 2D6/CYP 3A4 e metabolizador lento; não confundir solução e comprimidos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)

Esquizofrenia e transtorno bipolar em adultos; irritabilidade associada ao transtorno do espectro autista e tiques/Tourette em pediatria (off-label regulatório).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Aripiprazole, prescrição pediátrica (dailymed.nlm.nih.gov)

43. Atenolol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial e taquiarritmias ≥1 mês	VO 0,5-2 mg/kg/dia, máximo 100 mg/dia, em 1 tomada ou dividido 12/12 h. Iniciar na faixa inferior e titular à PA/FC/resposta. Uso contínuo com reavaliação clínica. [S1, S2] Off-label em parte das jurisdições; neonatal exige avaliação própria.
Crises hipoxêmicas da tetralogia de Fallot Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Atenolol oral não é tratamento imediato de crise hipoxêmica. Não foi identificado regime pediátrico validado específico de crise; não substituir medidas agudas e betabloqueador de ação adequada. [S1] Indicação documental; evidência de profilaxia não autoriza aplicar dose de hipertensão à crise.
Profilaxia de enxaqueca Crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não identificado esquema pediátrico de eficácia estabelecida para atenolol nas fontes clínicas abertas. Não extrapolar dose adulta de 100 mg/dia. [S1] Uso selecionado exige neurologia; não há duração pediátrica universal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES FC/PA, perfusão e glicemia em lactentes; ajustar renal. Evitar bradicardia/bloqueio AV, insuficiência cardíaca descompensada e retirada abrupta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)

Hipertensão e taquiarritmias (uso adulto na bula); crises hipoxêmicas da tetralogia de Fallot e profilaxia de enxaqueca (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cardiologia pediátrica - doses de fármacos cardiovasculares (doi.org)

[S2] Washington University - Atenolol (pediatriccardiology.wustl.edu)

44. Atracúrio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intubação, relaxamento cirúrgico e ventilação mecânica em UTI	EV, peso ideal: <2 anos (inclui RN), ataque 0,3-0,5 mg/kg, manutenção 0,1-0,2 mg/kg/dose conforme recuperação neuromuscular. ≥2 anos: ataque 0,3-0,6 mg/kg; manutenção 0,08-0,1 mg/kg/dose. Repetir apenas por recuperação do bloqueio; manter pelo tempo do procedimento/necessidade ventilatória. [S1]
Nascimento-18 anos	Se doença cardiovascular/risco de liberação de histamina: iniciar 0,3-0,4 mg/kg em 1 min. Não há intervalo fixo universal. RN: uso PCH off-label; SmPC não recomenda por dados insuficientes, portanto decisão exclusiva da neonatologia.
Manutenção por infusão durante cirurgia/UTI	EV contínua cirúrgica 0,3-0,6 mg/kg/HORA, após recuperação inicial do bolus. UTI: 11-13 mcg/kg/MIN, com ampla variabilidade 4,5-29,5 mcg/kg/min, titulado ao TOF; não usar extremo superior como alvo rotineiro. [S2]
>1 mês	Conversão exata 11 mcg/kg/min=0,66 mg/kg/h; SmPC arredonda 0,65. A necessidade varia com tempo e doença.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não produz analgesia nem sedação: garantir ambas e ventilação. Monitorar TOF, capnografia e PA. Sem ajuste renal/hepático habitual; hipotermia e distúrbios eletrolíticos prolongam ação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 11)

Bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal, cirurgias e adaptação à ventilação mecânica em UTI pediátrica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Atracurium (pch.health.wa.gov.au)

[S2] Atracurium - SmPC (medicines.org.uk)

45. Atropina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bradicardia sintomática por tônus vagal/bloqueio AV Lactentes/crianças, algoritmo PALS 2025	EV/IO 0,02 mg/kg/dose; mínimo 0,1 mg e máximo 0,5 mg/dose. Pode repetir 1 vez. [S2] AHA 2025 não estratifica teto 1 mg para adolescente no algoritmo pediátrico. PCH usa teto 0,6 mg; seguir protocolo institucional único.
Intoxicação por organofosforados/carbamatos ≥1 mês	EV/IO/IM: 0,05 mg/kg inicialmente, máximo inicial 3 mg; dobrar doses ineficazes a cada 5 min até controle da broncorreia e melhora ventilatória/hemodinâmica. Manutenção: 10-20% da dose total de atropinização por hora em BIC. [S1] Sem teto cumulativo fixo na intoxicação; pupila/taquicardia isoladas não devem substituir avaliação respiratória.
Midríase e cicloplegia diagnóstica ≥3 meses	Colírio 1%: 1 gota no olho indicado 40 min antes da avaliação; 3 meses a <3 anos: máximo 1 vez/dia; ≥3 anos: máximo 2 vezes/dia. [S1] Ocluir ponto lacrimal; avaliação oftalmológica.
Sialorreia em paralisia cerebral Pediatria, especialista	Colírio 1% por via sublingual: iniciar 1 gota/dia; titular, podendo chegar a 1 gota a cada 4-6 h se necessário. [S1] Off-label; volume por gota depende do gotejador e deve ser confirmado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar retenção urinária, íleo, hipertermia, delirium e taquiarritmia. Cautela com glaucoma; manter colírio sublingual identificado para evitar erro de via.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)

Bradicardia sintomática, intoxicação por organofosforados e carbamatos; midríase e cicloplegia diagnóstica; sialorreia em paralisia cerebral (off-label sublingual).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Atropine (pch.health.wa.gov.au)

[S2] AHA - PALS Bradycardia 2025 (cpr.heart.org)

46. Azatioprina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hepatite autoimune Pediatria	VO iniciar 1 mg/kg/dia; titular conforme resposta até 3 mg/kg/dia, em 1-2 tomadas. Manutenção prolongada, reavaliada por transaminases/IgG e remissão. [S1]
Lúpus, doença de Crohn e retocolite ulcerativa - manutenção Pediatria	VO iniciar 1-2 mg/kg/dia; titular até 3 mg/kg/dia em 1-2 tomadas. Contínuo enquanto necessário ao controle da doença; não é fármaco de alívio imediato. [S1]
Transplantes de órgãos Pediatria	Transplante renal: VO 2 mg/kg/dia; hepático: 1-2 mg/kg/dia. Manutenção contínua, ajustar por citopenias, infecção/EBV e esquema imunossupressor. [S1] Não aplicar a mesma dose a todos os transplantes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, transaminases e função renal; avaliar TPMT/NUDT 15 quando disponível. Alopurinol aumenta muito toxicidade; febuxostate deve ser evitado. Monitorar pancreatite e mielotoxicidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)

Hepatite autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn e retocolite ulcerativa (manutenção), transplantes de órgãos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] NHS WYICS - Azathioprine in Paediatric Services, março 2026 (wyicsapc.co.uk)

47. Azelastina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica sazonal e perene ≥6 anos	Intranasal: preparação 140 mcg/jato,1 jato em cada narina 12/12 h (=280 mcg por administração). Alternativa 210 mcg/jato:6-11 anos 1 jato/narina 12/12 h por ≤4 semanas;12-17 anos 2 jatos/narina 1 vez/dia, até 2 vezes/dia se necessário. Manter conforme exposição/resposta. [S1]

Não confundir azelastina isolada com combinação com fluticasona.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cabeça levemente inclinada para frente; evitar olhos. Vigiar epistaxe, gosto amargo e sonolência.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Tratamento sintomático da rinite alérgica sazonal e perene por via intranasal.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNF - Azelastine nasal preparations (bnf.nice.org.uk)

48. Azitromicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pneumonia por atípicos ≥6 meses	VO 10 mg/kg no dia 1, máximo 500 mg; depois 5 mg/kg 1 vez/dia, máximo 250 mg, nos dias 2-5. [S1]
Coqueluche - tratamento e profilaxia pós-exposição Todas as idades	<6 meses: VO 10 mg/kg 1 vez/dia por 5 dias. ≥6 meses: 10 mg/kg (máximo 500 mg) no dia 1, depois 5 mg/kg/dia (máximo 250 mg) nos dias 2-5. [S2] Vigiar estenose hipertrófica do piloro nos lactentes, sobretudo <1 mês.
Faringoamigdalite estreptocócica em alergia à penicilina ≥2 anos	VO 12 mg/kg 1 vez/dia, máximo 500 mg/dia, por 5 dias. [S1, S3] Usar conforme resistência local; macrolídeo pode falhar.
Otite média aguda ≥6 meses, alternativa selecionada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquemas de bula: VO 30 mg/kg dose única (máximo 1,5 g) OU 10 mg/kg/dia (máximo 500 mg/dia) por 3 dias OU 10 mg/kg dia 1 (máximo 500 mg), depois 5 mg/kg/dia (máximo 250 mg) dias 2-5. [S1] Não recomendada como rotina por resistência.
Sinusite bacteriana ≥6 meses, indicação de bula RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO 10 mg/kg 1 vez/dia, máximo 500 mg/dia, por 3 dias. [S1, S4] Diretriz UCSF desaconselha azitromicina nesta indicação; não preferência empírica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar risco de QT longo, hepatopatia e interações; não reutilizar dose única se vomitar sem avaliar.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)

Pneumonia por atípicos, coqueluche (tratamento e profilaxia pós-exposição), faringoamigdalite estreptocócica em alérgicos à penicilina, otite média, sinusite.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Azithromycin oral suspension (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] CDC - Pertussis treatment and postexposure prophylaxis (cdc.gov)

[S3] SBP - Febre reumática (sbp.com.br)

[S4] UCSF - Acute bacterial sinusitis (idmp.ucsf.edu)

49. Aztreonam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-negativos aeróbios, inclusive Pseudomonas em fibrose cística ≥9 meses	EV 30 mg/kg/dose 6/6-8/8 h; máximo 120 mg/kg/dia. Em adolescentes, não exceder 2 g/dose nem 8 g/dia do regime adulto. Doença menos grave: 30 mg/kg/dose 8/8 h. Diluir ≤20 mg/mL em SF 0,9%/SG 5%; infundir em 20-60 min. Duração pelo foco, culturas e controle da infecção. [S1] Não cobre Gram-positivos/anaeróbios; associação pode ser necessária.
Pseudomonas pulmonar crônica na fibrose cística ≥7 anos na bula FDA	Aztreonam lisina INALATÓRIO 75 mg 3 vezes/dia, doses separadas ≥4 h, durante 28 dias, seguidos de 28 dias sem tratamento; repetir ciclos se indicado. Reconstituir somente com diluente próprio e usar nebulizador Altera. [S2] Formulação inalatória não é a injetável; broncodilatador antes da dose.
Multirresistência com NDM Pediatria, infectologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Aztreonam isolado pode ser inativado por betalactamases concomitantes. IDSA 2026 admite ceftazidima-avibactam+aztreonam se aztreonam-avibactam indisponível; requer dose pediátrica da associação, ajuste renal e avaliação infectológica. Não foi possível confirmar os números da tabela pediátrica JPIDS 2025 no texto acessível. [S1, S3, S4] Existe consenso pediátrico específico, citado acima; ausência de dose nesta ficha é limitação de acesso/validação, não inexistência de esquemas. Não usar tabela adulta nem dose isolada como validação da combinação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar alergia cruzada com ceftazidima, transaminases e função renal. Bula EV não estabelece ajuste renal pediátrico nem dose <9 meses.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Infecções graves por bacilos Gram-negativos aeróbios (incluindo *Pseudomonas aeruginosa* em fibrose cística); alternativa em multirresistência com NDM (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Aztreonam injection (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] DailyMed/Gilead - Cayston (dailymed.nlm.nih.gov)
[S3] IDSA - AMR guidance 2026, MBL/NDM (idsociety.org)
[S4] Lockowitz et al. - consenso pediátrico AMR 2025, resumo acessível (doi.org)

50. Baclofeno

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Espasticidade cerebral/medular: paralisia cerebral e lesão medular ≥1 mês	VO iniciar 0,075 mg/kg/dose a cada 6 h (=0,3 mg/kg/dia). Aumentar semanalmente até resposta; manutenção até 0,5 mg/kg/dose a cada 6 h, máximo 40 mg/dia em <8 anos ou 60 mg/dia em 8-17 anos. Se não houver benefício após 6 semanas na maior dose tolerada, rever tratamento. [S1]
Espasticidade grave refratária ou intolerância à via oral 4-17 anos	Intratecal: teste 25-50 mcg em ≥1 min; aumentar testes em 25 mcg com intervalo ≥24 h, máximo 100 mcg por teste. Após resposta, titular bomba implantável; manutenção inicial usual 25-200 mcg/dia, ajustada por resposta. [S1] Especialista; doses em mcg, não mg. Faixa de manutenção não é teto universal de bomba.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reduzir na insuficiência renal; depressão respiratória/sedação com outros depressores. Nunca interromper abruptamente, especialmente bomba intratecal; VO desmamar ≥1-2 semanas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Espasticidade grave de origem cerebral ou medular (paralisia cerebral, lesão medular).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Baclofen (bnfc.nice.org.uk)

51. Bamifilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Broncoespasmo associado a asma/bronquite asmática >5 anos, capaz de engolir comprimido RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula brasileira: VO 300 mg a cada 12 h; também menciona 30 mg/kg/dia (=15 mg/kg/dose 12/12 h). Essas expressões só coincidem em 20 kg. Não tratar como doses intercambiáveis em qualquer peso; selecionar esquema compatível com peso e produto. [S1] A bula contém ambiguidade ponderal; não oferece teto pediátrico explícito nem duração fixa. Não é resgate de escolha da asma.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <5 anos e comprimido 600 mg em crianças. Evitar outras xantinas; monitorar tremor, náusea, arritmia e insônia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Broncoespasmo associado a asma brônquica ou bronquite asmática (uso predominantemente adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\]](#) Chiesi - Bamifix, bula profissional aprovada 28/10/2024 ([chiesi.com.br](#))

52. Beclometasona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma persistente - manutenção Crianças/adolescentes conforme dispositivo	Inalatória convencional:2-11 anos 100-200 mcg a cada 12 h;12-17 anos 200-400 mcg a cada 12 h, podendo atingir 1.000 mcg a cada 12 h sob especialista. Pós:5-11 anos 100-200 mcg 12/12 h;≥12 anos 200-400, até 800 mcg 12/12 h. Extrafina Qvar:5-11 anos 50-100 mcg 12/12 h;≥12 anos 50-200, até 400 mcg 12/12 h. Contínuo; reduzir à menor dose após controle. [S1] Dispositivos convencionais e extrafinos NÃO são equivalentes mcg a mcg; doses altas exigem revisão.
Rinite alérgica crônica 6-17 anos	Intranasal 100 mcg em cada narina a cada 12 h; após controle, reduzir para 50 mcg em cada narina a cada 12 h. Manter durante exposição/sintomas, reavaliar periodicamente. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Conferir técnica/dispositivo; enxaguar boca após inalação. Monitorar crescimento, candidíase, epistaxe e supressão adrenal em doses altas; não é resgate da crise.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Controle e manutenção da asma persistente; rinite alérgica crônica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] NICE BNFC - Beclometasone dipropionate (bnfc.nice.org.uk)

53. Benzidamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor/inflamação orofaríngea: aftas, faringites, estomatites e pós-operatório odontológico	Spray 0,15%:1 mês-5 anos,1 jato por 4 kg (máximo 4 jatos) a cada 1,5-3 h;6-11 anos 4 jatos;12-17 anos 4-8 jatos no mesmo intervalo. Spray 0,3%:2-5 anos 1 jato/8 kg (máximo 2);6-11 anos 2;12-17 anos 2-4 jatos. ≥13 anos: bochechar/gargarejar 15 mL 0,15% a cada 1,5-3 h conforme necessidade, por ≤7 dias; cuspir. [S1]
Conforme idade e preparação	Produto/dispositivo deve corresponder exatamente à concentração; não intercambiar jatos. Faixas estrangeiras não comprovam aprovação brasileira.
Vulvovaginites - alívio sintomático	Tópico: dissolver 500-1.000 mg em 1 litro de água; usar em lavagens locais 1-2 vezes/dia. Duração não fixada; reavaliar causa e interromper após melhora. [S2]
>2 anos, bula brasileira	Em criança pré-púbere, uso externo orientado; não realizar ducha/instrumentação intravaginal. Não substitui tratamento etiológico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não ingerir. Cautela em asma/hipersensibilidade; interromper se ardor intenso, alergia ou broncoespasmo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 12)
Alívio sintomático da dor e inflamação de orofaringe (aftas, faringites, estomatites, pós-operatório odontológico); vulvovaginites (solução ginecológica).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Benzydamine (bnfc.nice.org.uk)
[S2] Aché - Flogo-Rosa, bula profissional (cópia) (uploads.consultaremedios.com.br)

54. Benzilpenicilina Benzatina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Faringoamigdalite estreptocócica e profilaxia primária da febre reumática Crianças/adolescentes	IM dose única: SBP <20 kg 600.000 UI;>20 kg 1.200.000 UI. Esquema CDC: <27 kg 600.000 UI;≥27 kg 1.200.000 UI. [S1, S2] Escolher um critério institucional; documento SBP não explicita peso exatamente 20 kg.
Profilaxia secundária da febre reumática Após febre reumática	IM a cada 21 dias: SBP <20 kg 600.000 UI;>20 kg 1.200.000 UI. Sem cardite: até 21 anos OU 5 anos após último surto, o que for maior. Cardite prévia sem sequela importante: até 25 anos OU 10 anos após último surto, o maior. Lesão moderada/grave: até ≥40 anos; após troca valvar, vitalícia. [S1] Adesão contínua; individualizar exposição e risco de recorrência.
Sífilis adquirida recente: primária, secundária ou latente recente Crianças/adolescentes	IM 50.000 UI/kg, máximo 2.400.000 UI, dose única. [S3]
Sífilis adquirida latente tardia ou duração ignorada Crianças/adolescentes	IM 50.000 UI/kg/dose, máximo 2.400.000 UI, 1 vez/semana por 3 semanas: total 150.000 UI/kg, máximo 7.200.000 UI. [S3]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES NUNCA EV/IO. Confirmar alergia e administrar onde haja tratamento de anafilaxia. Sífilis: avaliação neurológica/ocular, HIV e seguimento sorológico; benzatina não trata neurosífilis.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Faringoamigdalite estreptocócica, profilaxia primária e secundária da febre reumática, sífilis adquirida (esquemas do PCDT).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SBP - Febre reumática (sbp.com.br)
[S2] CDC - Group A streptococcal pharyngitis (cdc.gov)
[S3] NIH - Sífilis pediátrica (clinicalinfo.hiv.gov)

55. Benzilpenicilina Potássica (Cristalina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sífilis congênita Neonatos	EV 50.000 UI/kg/dose: primeiros 7 dias de vida 12/12 h; depois 8/8 h. Total 10 dias; reiniciar curso se interrupção >1 dia. [S1]
Sífilis congênita diagnosticada tardiamente; neurosífilis ≥1 mês	EV 50.000 UI/kg/dose 4/4-6/6 h (=200.000-300.000 UI/kg/dia), teto 18-24 milhões UI/dia. Sífilis congênita:10 dias; neurosífilis adquirida:10-14 dias. [S1, S2]
Meningite por pneumococo ou meningococo comprovadamente sensíveis ≥1 mês	EV 400.000 UI/kg/dia divididos 4/4 h, máximo 4 milhões UI/dose. Duração se recuperação adequada: pneumococo 10 dias; meningococo 5 dias pela NICE 2024. [S3, S4] Terapia dirigida; não escolha empírica contra pneumococo potencialmente resistente.
Pneumonia pneumocócica grave sensível >2 meses	EV 200.000 UI/kg/dia divididos 6/6 h por 7-10 dias, esquema SBP histórico. Reavaliar em 48 h e adequar à cultura/complicações. [S5] Documento histórico; cenário vacinal e resistência atuais condicionam escolha.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Conferir UI, carga de potássio/sódio da formulação e função renal; risco de neurotoxicidade em acúmulo. Não misturar com aminoglicosídeo na mesma solução.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Sífilis congênita, neurosífilis, meningite por pneumococo ou meningococo sensíveis, pneumonia pneumocócica grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CDC - Congenital syphilis (cdc.gov)
[S2] NIH - Syphilis pediatric OI (clinicalinfo.hiv.gov)
[S3] UCSF - Pediatric antimicrobial dosing 2025 (idmp.ucsf.edu)
[S4] NICE NG 240 - meningite bacteriana 2024 (nice.org.uk)
[S5] SBP - Pneumonia, documento histórico (sbp.com.br)

56. Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina Potássica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pneumonia pneumocócica não complicada Crianças selecionadas para tratamento ambulatorial	Bula da associação IM: <27 kg 300.000 UI 1 vez/dia; ≥27 kg 600.000-1.200.000 UI 1 vez/dia. Bula não define duração da pneumonia; diretriz SBP histórica usa 7 dias com penicilina procaína. [S1, S2] Não confundir UI do produto associado com UI de procaína isolada; antibiótico oral é habitualmente mais viável.
Erisipela estreptocócica Crianças/adolescentes selecionados	IM: <27 kg 300.000 UI 1 vez/dia; ≥27 kg 600.000-1.200.000 UI 1 vez/dia, por no mínimo 10 dias segundo bula. [S1] Quadro tóxico/extenso ou falha exige reavaliação do agente e via.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Exclusivamente IM profunda; NUNCA EV/IO. Preparação 300.000 UI procaína+100.000 UI potássica por frasco. Risco de anafilaxia e injeção intravascular; alternar locais.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)

Pneumonia comunitária bacteriana não complicada e erisipela em ambiente ambulatorial selecionado.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Blau - Penkaron, bula profissional (blau.com)

[S2] SBP - antibioticoterapia de pneumonia, documento histórico (sbp.com.br)

57. Benznidazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Chagas aguda, congênita, crônica recente na infância e reativação	PCDT brasileiro: VO 5-10 mg/kg/dia divididos 12/12 h por 60 dias. Alternativa FDA/CDC 2-12 anos:5-8 mg/kg/dia divididos 12/12 h por 60 dias. [S1, S2]
Crianças/adolescentes	Reativação/imunossupressão e doença congênita exigem seguimento especializado. Usar cálculo ponderal, sem reproduzir faixas de comprimidos com arredondamentos incompatíveis.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, transaminases, função renal, peso e sintomas neurológicos; interromper/reavaliar rash grave, neuropatia e citopenia. Contraindicado em disfunção renal/hepática grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Tratamento da doença de Chagas aguda, congênita, formas crônicas recentes na infância ou reativação em imunossuprimidos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - PCDT Doença de Chagas (gov.br)

[S2] CDC - Clinical care of Chagas disease (cdc.gov)

58. Benzoato de Benzila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Escabiose >3 anos - produto consultado	Benzoato de benzila 25%: diluir 1 parte do produto+3 partes de água (=6,25%). Após banho, aplicar à noite nas áreas acometidas, deixar secar e reaplicar; lavar pela manhã. Repetir após 24 h se necessário; usualmente 2 dias. [S1] Tratar contatos simultaneamente; evitar face/mucosas e pele irritada.
Pediculose >3 anos	Mesma diluição pediátrica 6,25%: umedecer cabelos/couro cabeludo, deixar 3 min, lavar e usar pente fino; repetir se necessário, usualmente por 2 dias. [S1] Não prolongar aplicações por irritação; produtos distintos possuem instruções diferentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso externo exclusivo; teste em pequena área, suspender se ardor/eritema. Preferir opções menos irritantes quando disponíveis; não usar a solução 25% pura automaticamente em criança.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Tratamento tópico da escabiose (sarna) e pediculose (respeitando restrições etárias do produto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] PharmaScience - Benzoderm, bula profissional brasileira (cópia) (uploads.consultaremedios.com.br)

59. Beractanto

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção da SDR por deficiência de surfactante Recém-nascidos prematuros selecionados	Intratraqueal 100 mg de fosfolipídios/kg do peso ao nascer (=4 mL/kg de 25 mg/mL), preferencialmente nos primeiros 15 min quando adotada estratégia preventiva. [S1]
Resgate da SDR estabelecida Recém-nascidos prematuros	Intratraqueal 100 mg/kg (=4 mL/kg), o mais cedo possível, preferencialmente até 8 h de vida. Repetir somente se SDR persistente, intervalo ≥6 h, máximo 4 doses nas primeiras 48 h. [S1] Dose em 4 alíquotas com ventilação/estabilização entre elas; técnica deve corresponder ao protocolo de administração.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não EV. Não agitar vigorosamente nem filtrar. Monitorar bradicardia/dessaturação/obstrução do tubo; reduzir rapidamente FiO 2 e pressões quando complacência melhorar.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Prevenção e tratamento de resgate da síndrome do desconforto respiratório (doença da membrana hialina) em recém-nascidos prematutos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AbbVie - Survanta prescribing information (rxabbvie.com)

60. Betametasona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Condições alérgicas, inflamatórias e autoimunes sistêmicas graves	VO: dose inicial total 0,017-0,25 mg/kg/dia OU 0,5-7,5 mg/m²/dia; escolher um método e ajustar à doença/resposta. Após controle, reduzir à menor dose eficaz; manutenção pode ser 1 vez/dia pela manhã. [S1]
Crianças	A indicação original é ampla; bula não fixa duração/fracionamento inicial próprios de cada diagnóstico. Dose não substitui protocolo específico de doença.
Maturação pulmonar fetal antenatal	Betametasona acetato+fosfato:12 mg IM a cada 24 h por 2 doses; total 24 mg. OMS:24-34 semanas, parto provável ≤7 dias e condições assistenciais adequadas. [S2]
Gestante com alto risco de parto prematuro; NÃO administrar ao recém-nascido	Dose materna, inclusive gestante adolescente. Não repetir semanalmente de rotina; eventual curso único de resgate requer avaliação obstétrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Glicemia, PA, infecção, crescimento e supressão adrenal. Não retirar abruptamente após uso prolongado. Formulação de depósito com acetato não é para EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Condições alérgicas, inflamatórias e autoimunes sistêmicas graves; maturação pulmonar fetal antenatal (acetato + fosfato).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Celestone - bula profissional brasileira (uploads.consultaremedios.com.br)
[S2] OMS 2022 - Antenatal corticosteroids, recomendações (ncbi.nlm.nih.gov)

61. Bicarbonato de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acidose metabólica grave selecionada Neonatos, após corrigir ventilação/perfusão	EV 1-2 mmol/kg em ≥ 30 min. Alternativa calculada: dose total(mmol)= $0,3 \times \text{peso(kg)} \times \text{déficit de base(mmol/L)}$; administrar metade, repetir gasometria e decidir restante. Diluir 8,4%1:1 para 4,2% (=0,5 mmol/mL). [S1] Não administrar rotineiramente para acidose respiratória, cetoacidose ou reanimação neonatal.
Hipercalcemia associada a acidose metabólica Crianças	RCH: grave, EV 1-3 mmol/kg em 5 min; leve/moderada, 1 mmol/kg em 30 min. Reavaliar K/pH antes de repetir. [S2] Com alteração ECG, cálcio imediato e medidas de redistribuição/remoção de K são essenciais; bicarbonato é adjuvante apenas quando há acidose.
Intoxicação por tricíclicos/bloqueadores do canal de sódio com cardiotoxicidade Crianças/adolescentes	EV 1-2 mmol/kg, máximo 100 mmol por bolus; repetir a cada 3-5 min conforme QRS/PA, até pH 7,50-7,55. PCH: teto acumulado 6 mmol/kg ou 600 mmol, o menor. Em <2 anos usar 4,2%. [S3, S4] Alternativa centro toxicológico: 1 mmol/kg em 1-2 min; não ultrapassar pH 7,55.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES 1 mmol=1 mEq; 8,4%=1 mmol/mL=84 mg/mL. Monitorar Na/K/Ca ionizado, gasometria, ECG e ventilação. Separar de cálcio/catecolaminas; extravasamento lesa tecidos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)

Acidose metabólica grave selecionada, hipercalcemia com alteração eletrocardiográfica, intoxicação por antidepressivos tricíclicos ou bloqueadores de canal de sódio.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ANMF - Sodium bicarbonate 2021, revisão 2026 (anmfonline.org)

[S2] RCH - Hyperkalaemia (rch.org.au)

[S3] PCH - Tricyclic antidepressant poisoning (pch.health.wa.gov.au)

[S4] Atlantic Canada Poison Centre - Sodium bicarbonate pediatric (atlanticcanadapoisoncentre.ca)

62. Bilastina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica sazonal/perene e urticária crônica espontânea	VO:6-11 anos 10 mg 1 vez/dia;≥12 anos 20 mg 1 vez/dia. Tomar 1 h antes ou 2 h após alimento/suco de fruta. Rinite: manter durante exposição/sintomas; urticária: contínuo conforme atividade, com reavaliação. [S1]
≥6 anos e ≥20 kg	<6 anos ou <20 kg: não há dose estabelecida neste produto; não extrapolar dose adulta aumentada para criança.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar associação de inibidores de P-gp em insuficiência renal moderada/grave; monitorar sonolência e risco de QT quando coexistirem fatores predisponentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 13)
Tratamento sintomático da rinite alérgica sazonal/perene e da urticária crônica espontânea.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Bilastine - SmPC (medicines.org.uk)

63. Bimatoprosta

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular	Colírio 0,01%:1 gota no olho acometido 1 vez/dia à noite; não aumentar a frequência. Manutenção contínua pela resposta pressórica. [S1]
≥16 anos; <16 anos uso especializado off-label	Bula consultada não recomenda <16 anos; em crianças menores, decisão oftalmológica não deve ser apresentada como uso estabelecido.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PIO, pigmentação iriana permanente, inflamação e edema macular. Separar outros colírios ≥5 min; ocluir ponto lacrimal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Redução da pressão intraocular no glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular (uso adulto na bula; uso pediátrico especializado, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Bimatoprost, abril 2026 (dailymed.nlm.nih.gov)

64. Biperideno

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Distonia aguda e crise oculógira por neuroléptico	Até 59 kg:0,04 mg/kg IM ou EV em 3-5 min. ≥60 kg:2,5-5 mg IM/EV. Interromper injeção ao cessar sintomas; repetir após 30 min se necessário. Máximo 4 doses/dia; reavaliar e reduzir/suspender agente causador. [S1]
Crianças/adolescentes	Dados pediátricos limitados; distinguir distonia aguda de discinesia tardia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar delirium, hipertermia, taquicardia, retenção urinária e glaucoma; monitorização durante EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Tratamento de reações extrapiramidais agudas (distonias agudas, crises oculógiras) induzidas por neurolépticos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ePed - Biperiden/Akineton pediátrico (eped.se)

65. Bisacodil

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação - tratamento de curto prazo VO ≥4 anos; retal ≥2 anos	VO 5-20 mg à noite, iniciar 5 mg e titular; doses altas pediátricas são off-label. Retal 5-10 mg 1 vez/dia, ajustar à resposta; em 2-9 anos preferir 5 mg. Usar por curto período e rever se necessidade persistente. [S1]
Esvaziamento intestinal antes de exame/cirurgia 4-17 anos	4-9 anos: VO 5 mg ao deitar 2 dias antes e 5 mg ao deitar 1 dia antes; se necessário, retal 5 mg 1 h antes. 10-17 anos: mesmos horários com 10 mg por dose. [S1] Esquema de preparo específico; hidratação e eventuais outras etapas conforme exame.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em obstrução, abdome agudo e desidratação grave. Vigiar diarreia/hipocalemia; não triturar comprimido gastrorresistente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Tratamento de curto prazo da constipação intestinal e esvaziamento/preparo intestinal para exames.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Bisacodyl (bnfc.nice.org.uk)

66. Bosentana

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial pulmonar idiopática/familiar ou associada a cardiopatia/Eisenmenger	VO. 5-10 kg: 15,625 mg/dia por 4 semanas, depois 15,625 mg 12/12 h. >10-20 kg: 31,25 mg/dia por 4 semanas, depois 31,25 mg 12/12 h. >20-40 kg: 31,25 mg 12/12 h por 4 semanas, depois 62,5 mg 12/12 h. >40 kg: 62,5 mg 12/12 h por 4 semanas, depois 125 mg 12/12 h. Contínuo. [S1]
6 meses-18 anos, ≥5 kg	Esquema PCH com comprimidos; formulações dispersíveis podem ter esquema distinto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Transaminases antes e mensalmente; Hb basal, 1 e 3 meses e depois trimestral. Contraindicado em hepatopatia moderada/grave, gestação, ciclosporina e glibenclamida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Tratamento da hipertensão arterial pulmonar (idiopática, familiar ou associada a cardiopatias congênitas / Eisenmenger).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Bosentan (pch.health.wa.gov.au)

67. Brimonidina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular	Colírio 0,2%:1 gota no olho acometido a cada 8 h. Manutenção contínua com avaliação de PIO e sedação. [S1]
≥2 anos, oftalmologia	Contraindicado <2 anos; forte cautela 2-6 anos ou ≤20 kg, devido a depressão do SNC/apneia. Não se torna seguro apenas por ser colírio.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ocluir ponto lacrimal, separar colírios ≥5 min. Monitorar sonolência, hipotonia, bradicardia e depressão respiratória; evitar IMAO e outros depressores.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Redução da pressão intraocular no glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Brimonidine tartrate ophthalmic solution 0,2% (dailymed.nlm.nih.gov)

68. Brometo de Ipratrópio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crise asmática moderada/grave - adjuvante ao beta-2 agonista Crianças/adolescentes	Nebulizar:1 mês-11 anos 250 mcg a cada 20-30 min nas primeiras 2 h, depois 250 mcg a cada 4-6 h se ainda necessário;12-17 anos 500 mcg a cada 4-6 h. Intensificação inicial em adolescentes deve seguir algoritmo de asma grave. Usar na fase aguda, com reavaliação após doses iniciais. [S1] Diluir somente em SF 0,9% quando necessário; não usar isoladamente. Regime intensivo é off-label.
Crise moderada/grave - esquema inicial CPS >1 ano	Nebulizar 250 mcg/dose, podendo 500 mcg/dose se ≥30 kg, a cada 20-30 min por 3 doses iniciais com salbutamol. Alternativa aerossol 20 mcg/jato:80 mcg/dose (4 jatos), até 160 mcg/dose(8 jatos) se ≥30 kg, por 3 doses iniciais. [S2, S3] Não há evidência para manter ipratrópio rotineiramente durante toda internação ou após alta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar aerossol nos olhos; observar taquicardia, boca seca e retenção urinária. Criança com diagnóstico incerto de sibilância não equivale automaticamente a asma.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Broncoespasmo agudo em crise asmática moderada a grave, em associação a agonistas beta-2 de curta ação.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Ipratropium bromide (bnfc.nice.org.uk)
[S2] Canadian Paediatric Society - tabela de doses na asma aguda (cps.ca)
[S3] CPS - Acute asthma exacerbation 2021 (cps.ca)

69. Brometo de Pancurônio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intubação e manutenção do bloqueio na ventilação em UTI >1 mês	EV 0,06-0,1 mg/kg para intubação; doses adicionais 0,01 mg/kg conforme recuperação neuromuscular. Se succinilcolina anteceder, reduzir dose inicial aproximadamente 1/3. Duração do bloqueio pode ultrapassar 60-90 min; não repetir automaticamente pelo relógio. [S1] Formulação com álcool benzílico contraindicada em RN; bloqueio prolongado deve ser orientado por TOF.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sedoanalgesia e ventilação obrigatórias. Reduzir na disfunção renal/hepática; vigiar taquicardia, fraqueza acumulada e potencialização por magnésio/aminoglicosídeos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Bloqueio neuromuscular de longa duração para intubação orotraqueal e manutenção da ventilação mecânica em UTI.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Health Canada - Pancuronium bromide injection (pdf.hres.ca)

70. Brometo de Rocurônio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intubação eletiva e relaxamento cirúrgico	EV 0,6 mg/kg para intubação; manutenção 0,15 mg/kg/dose conforme recuperação do bloqueio. Duração limitada ao procedimento. [S1]
>1 mês	Idade neonatal exige fonte própria; não extrapolar automaticamente.
Intubação em sequência rápida	EV 1-1,2 mg/kg em bolus rápido, dose única. Manter sedoanalgesia após intubação enquanto persistir a paralisia. [S1]
>1 mês	
Intubação eletiva/cirurgia e paralisia neonatal	Intubação EV 0,6 mg/kg, faixa 0,4-1 mg/kg, em 5-10 segundos. Manutenção intermitente 0,6 mg/kg a cada 30-60 min se necessário, conforme bloqueio. BIC 0,6 mg/kg/HORA, faixa 0,4-1 mg/kg/h; titular ao TOF. ANMF teto 2 mg/kg/dose. [S2]
Neonatos	Fonte possui erro tipográfico no parêntese de bolus; dose central 600 mcg/kg foi preservada. Não confundir mg/kg/h com mg/kg/min. Preparo neonatal: 30 mg/kg de rocurônio em SF 0,9% ou SG 5% q.s.p. 50 mL = 0,6 mg/kg/mL; 1 mL/h fornece 0,6 mg/kg/h. Quantidade e concentração são individualizadas pelo peso; não confundir com 0,6 mg/mL fixos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ventilação e sedoanalgesia obrigatórias; TOF, capnografia e PA. Duração pode aumentar em hepatopatia/nefropatia. Lavar o acesso após dose para evitar bolus residual tardio. Em sobrepeso/obesidade, PCH orienta peso ajustado para o cálculo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)

Relaxamento muscular para intubação de sequência rápida e cirurgias em neonatos, lactentes, crianças e adolescentes.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Rocuronium (pch.health.wa.gov.au)

[S2] ANMF - Rocuronium 2026 (anmfonline.org)

71. Brometo de Tiotrópio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma persistente não controlada - manutenção adicional 6-17 anos	Respimat: inalar 5 mcg 1 vez/dia (=2 jatos de 2,5 mcg), continuamente, associado ao corticosteroide e demais controladores indicados. Reavaliar controle e técnica antes de intensificar. [S1] Não é resgate; a dose depende do dispositivo/registro. Cápsula 18 mcg para DPOC não é equivalente.
DPOC Indicação adulta no arquivo RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico para DPOC estabelecido; não extrapolar esta indicação para crianças. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cautela em glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária e insuficiência renal; monitorar broncoespasmo paradoxal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 14)
Tratamento de manutenção da asma persistente não controlada (a partir de 6 anos) e DPOC.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Tiotropium/Spiriva Respimat (bnfc.nice.org.uk)

72. Brometo de Vecurônio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intubação, procedimentos e facilitação da ventilação prolongada	EV 0,05-0,1 mg/kg/dose, repetir a cada 1-2 h conforme bloqueio. Alternativa contínua 0,8-2,5 mcg/kg/min. Reconstituir 10 mg com 5 mL de água (=2 mg/mL) e diluir para 1 mg/mL em SF 0,9%/SG 5%; bolus em 5-10 s ou infusão em bomba. Usar pelo menor tempo necessário. [S1]
>4 semanas	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Garantir ventilação, sedação e analgesia; monitorar TOF e fraqueza prolongada. Reduzir em disfunção renal/hepática. Dose pelo peso ideal na obesidade; não programar mg/kg/min.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Bloqueio neuromuscular intermediário para intubação e procedimentos cirúrgicos ou ventilação mecânica prolongada.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH - Vecuronium (pch.health.wa.gov.au)

73. Bromexina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Afecções broncopulmonares com muco espesso - secretolítico ≥2 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO, cloridrato de bromexina: 2-6 anos 2 mg a cada 8 h; >6-12 anos 4 mg a cada 8 h; >12 anos 8 mg a cada 8 h. Alternativa ponderal 0,1 mg/kg/dose 3 vezes/dia. Solução inalatória específica: 2-6 anos 1,3 mg 12/12 h; >6-12 anos 2 mg 12/12 h; adolescentes 4 mg 12/12 h; diluir 1:1 em SF 0,9%. Duração não fixada, suspender após resolução e reavaliar persistência. [S1] Bula do xarope apresenta total 8 mg/dia para 2-6 anos, incompatível com 2 mg 3 vezes/dia (=6 mg/dia); manter doses individuais explicitadas, sem somar esquemas. Gotas VO 2,7 mg 3 vezes/dia constituem regime distinto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <2 anos. Risco de reação cutânea grave/broncoespasmo; não nebulizar xarope. A ambiguidade da bula impede tratar todas as apresentações como intercambiáveis.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)

Tratamento secretolítico em afecções broncopulmonares associadas a muco espesso e viscoso.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sanofi - Bisolvon, bula profissional (cópia) (onepharma.com.br)

74. Bromoprida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Distúrbios da motilidade gastrointestinal; náuseas/vômitos >1 ano	VO: 0,5-1 mg/kg/DIA dividido em 3 tomadas, a cada 8 h. Na solução 4 mg/mL com 24 gotas/mL:1-2 gotas/kg/dose. EV/IM:0,5-1 mg/kg/dia; a bula injetável não fixa fracionamento pediátrico. EV diluída em SF 0,9%/SG 5% e administrada em >3 min. Suspender após controle; evitar uso prolongado. [S1] Não prescrever como mg/kg/dose a faixa diária da ampola; não é antiemético pediátrico de primeira escolha.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <1 ano, epilepsia, obstrução/perfuração/hemorragia GI e feocromocitoma; risco elevado de distonia. Se ClCr <40 mL/min, iniciar aproximadamente metade da dose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Distúrbios da motilidade gastrointestinal, náuseas e vômitos de diversas etiologias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] União Química - bromoprida, bula profissional brasileira (cópia) (uploads.consultaremedios.com.br)

75. Budesonida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma persistente - controle Conforme faixa etária/dispositivo	Nebulizada:6 meses-11 anos 0,125-0,5 mg 12/12 h, até 2 mg/dia;12-17 anos 0,25-1 mg 12/12 h. Pó inalatório:6-11 anos 100-400 mcg 12/12 h;12-17 anos 100-800 mcg 12/12 h. Estáveis em dose baixa:200-400 mcg 1 vez/dia; adolescentes até 800 mcg/dia. Contínuo, menor dose eficaz. [S1] Alternativa Pulmicort Respules:3 meses-11 anos iniciar 0,5-1 mg 12/12 h, manter 0,25-0,5 mg 12/12 h;12-17 anos iniciar 1-2 mg 12/12 h, manter 0,5-1 mg 12/12 h. Regimes de formulações específicas; não somar.
Crupe viral Crianças	Nebulizar 2 mg dose única OU 1 mg duas vezes com 30 min de intervalo; repetir o conjunto a cada 12 h se necessário até melhora. [S1] Não substituir adrenalina quando há obstrução importante.
Rinite alérgica 6-17 anos	Intranasal total 256 mcg/dia:128 mcg em cada narina 1 vez/dia OU 64 mcg/narina 12/12 h. Reduzir após controle. [S1]
Esofagite eosinofílica Crianças/adolescentes, gastroenterologia	Budesonida viscosa deglutida: <10 anos 0,5 mg 12/12 h;≥10 anos 1 mg 12/12 h, por ≥3 meses, com endoscopia/biópsia. Após remissão, manutenção usual à metade da dose diária por 1-2 anos. Casos selecionados utilizam até 2,8 mg/dia <10 anos ou 4 mg/dia ≥10 anos. [S2] Off-label; não inalar o preparado destinado a contato esofágico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Enxaguar boca após inalação; vigiar candidíase, crescimento e supressão adrenal. Não trocar dose em mg por mcg. Inibidores CYP 3A4 aumentam exposição.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Controle da asma persistente; crupe viral (laringite estridulosa); rinite alérgica; esofagite eosinofílica (via oral deglutida, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Budesonide (bnfc.nice.org.uk)
[S2] BSPGHAN - swallowed topical steroids in pediatric EoE 2024 (bmjpaedsopen.bmj.com)

76. Bupivacaína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infiltração e bloqueios periféricos 1-12 anos	Bupivacaína 0,25-0,5%:0,5-2 mg/kg por procedimento, respeitando total ≤2 mg/kg na bula. Bloqueio ilioinguinal/ilio-hipogástrico:0,25-1,25 mg/kg com 0,25%;≥5 anos podem receber 1,25-2 mg/kg com 0,5%. Administrar fracionadamente com aspiração. [S1]
Peridural e caudal 1-12 anos	Solução 0,25% (=2,5 mg/mL):0,6-0,8 mL/kg (=1,5-2 mg/kg) por bloqueio; máximo 2 mg/kg total. Peridural torácica/lombar em incrementos. [S1] Infusão contínua e <1 ano não estabelecidas nesta bula; técnica especializada.
Raquianestesia Neonatos/crianças até 40 kg	Intratecal, solução hiperbárica 0,5%: <5 kg 0,4-0,5 mg/kg;5-15 kg 0,3-0,4 mg/kg;15-40 kg 0,25-0,3 mg/kg, dose única do bloqueio. [S2] Usar somente apresentação própria intratecal; faixa de bloqueio periférico não se aplica à raqui.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Somar todos os anestésicos locais; não EV nem bloqueio de Bier. ECG/PA, acesso venoso e emulsão lipídica disponíveis; toxicidade pode provocar convulsão/arritmia. Dose pelo peso ideal na obesidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Anestesia local infiltrativa, bloqueios de nervos periféricos, bloqueio peridural, caudal e raquianestesia.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bupivacaine 0,25% - SmPC pediátrico (medicines.org.uk)

[S2] Bupivacaine Heavy 0,5% - SmPC (medicines.org.uk)

77. Buprenorfina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor moderada/intensa oncológica ou pós-operatória 2-12 anos	EV lenta em ≥2 min ou IM 2-6 mcg/kg/dose, a cada 4-6 h conforme dor; alguns pacientes só necessitam nova dose após 6-8 h. Não estabelecer horário fixo antes de observar duração individual. Não repetir aos 30-60 min nem exceder 6 mcg/kg/dose nessa faixa. Manter pelo menor tempo necessário. [S1]
Dor moderada/intensa oncológica ou pós-operatória >12 anos	EV lenta em ≥2 min ou IM 0,3 mg a cada 6 h se necessário, titular individualmente. Não converter diretamente para adesivo/filme/sublingual. [S1] <2 anos: dose não estabelecida na bula; formulações de dependência não são equivalentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorização respiratória e de sedação; risco maior com benzodiazepínicos. Reversão por naloxona pode ser incompleta/prolongada; suporte ventilatório é essencial. Ajustar em hepatopatia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Analgesia opioide para dor moderada a intensa em contexto oncológico e pós-operatório (uso predominantemente adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] [DailyMed/Hospira - Buprenorphine hydrochloride injection](#) (dailymed.nlm.nih.gov)

78. Bupropiona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Depressão maior - alternativa especializada 6-17 anos; uso off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Florida 2022: liberação imediata VO 75 mg/dia em 2-3 tomadas; titular a cada 1-2 semanas, máximo 250-300 mg/dia e 150 mg/dose. SR ≥11 anos: 100 mg pela manhã; titular a cada 2-3 semanas, em 2 tomadas, teto operacional 300 mg/dia, máximo 150 mg/dose. XL ≥12 anos: 150 mg pela manhã; máximo 300 mg/dia em crianças e 450 mg/dia em adolescentes da tabela. [S1] Não primeira linha. SR: tabela limita 150 mg/dose, incompatível com 400 mg/dia em 2 tomadas; por essa inconsistência, não ultrapassar 300 mg/dia sem fonte/protocolo adicional. Reavaliar resposta e suicidabilidade precocemente; manutenção conforme remissão.
TDAH 6-17 anos, alternativa após falha/intolerância RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO iniciar 1,5-3 mg/kg/dia, máximo inicial 150 mg/dia. Liberação imediata: dividir 2-3 tomadas; teto 6 mg/kg/dia ou 300 mg/dia, o menor; máximo 150 mg/dose. XL: 1 vez/dia, mesmo teto diário. [S1, S2] Off-label; avaliação funcional periódica. Ensaio 6-12 anos estudou 3-6 mg/kg/dia dividido 12/12 h.
Cessaç�o do tabagismo 14-17 anos, regime de pesquisa RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ensaio: bupropiona SR 150 mg/dia OU 300 mg/dia por 6 semanas, com aconselhamento semanal. Dose 300 mg/dia deve ser fracionada em 150 mg 12/12 h. [S3] Benef�cio de curto prazo n�o estabelece indica��o pedi�trica aprovada nem manuten��o prolongada; priorizar programa estruturado de cessac��o.

MONITORIZA  O E PRECAU  ES Contraindicado em epilepsia, anorexia/bulimia e retirada abrupta de  lcool/sedativos; n o associar IMAO. Monitorar PA, ins nia, mania e idea  o suicida. N o triturar SR/XL; ajustar renal/hep tico.

INDICA  ES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Tratamento da depress o maior e cessac  o do tabagismo (uso adulto; uso em TDAH ou depress o em adolescentes, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Florida 2022-2023 - Pediatric psychotherapeutic medication guidelines (floridabhcenter.org)
[S2] Conners et al. - ensaio pedi trico TDAH, reposit rio Johns Hopkins (pure.johnshopkins.edu)
[S3] Muramoto et al. - cessac  o tab gica adolescente (doi.org)
[S4] DailyMed - Bupropion label (dailymed.nlm.nih.gov)

79. Cafeína (Citrato de Cafeína)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Apneia da prematuridade - tratamento e profilaxia em prematuros extremos	CITRATO de cafeína: ataque EV/VO 20 mg/kg; após 24 h, 5-10 mg/kg 1 vez/dia. ANMF admite manutenção até 20 mg/kg/dia em refratariedade, com avaliação especializada. EV: ataque em ≥30 min e manutenção em 10 min; pode diluir a 8 mg/mL em SF 0,9%/SG 5%. Manter até resolução sustentada; observar ≥5-7 dias após suspensão. [S1]
Prematuros, neonatologia	Cafeína BASE corresponde à metade da dose do citrato. Não usar ataque 80 mg/kg de estudo como rotina.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FC/apneias, ganho ponderal e toxicidade; considerar suspender dose se FC >180/min. Não associar aminofilina/teofilina; níveis séricos se doses altas, disfunção renal/hepática ou toxicidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Tratamento da apneia primária da prematuridade; profilaxia da apneia em prematuros extremos (recomendação da OMS).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] ANMF - Caffeine 2023 (anmfonline.org)

80. Calcipotriol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Psoríase em placas 6-17 anos, dermatologia	Aplicar calcipotriol 50 mcg/g nas placas 2 vezes/dia.6-11 anos: máximo 50 g de pomada/semana (=2,5 mg de calcipotriol).12-17 anos: máximo 75 g/semana (=3,75 mg). Se combinar formulações, somar o princípio ativo e respeitar o mesmo teto. Reavaliar resposta antes de prolongar. [S1] Off-label na população pediátrica; <6 anos sem esquema estabelecido nesta fonte.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar em face nem em distúrbios do cálcio; evitar área extensa, insuficiência renal/hepática grave e exposição solar excessiva. Monitorar hipercalcemia se uso relevante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 15)
Tratamento tópico da psoríase em placas vulgar (uso adulto na bula; uso pediátrico selecionado, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Calcipotriol (bnfc.nice.org.uk)

81. Calcitonina Sintética de Salmão

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor óssea associada à osteólise e osteoporose pós-menopausa	Não há esquema pediátrico estabelecido para analgesia por osteólise ou osteoporose pós-menopausa. A monografia pediátrica considera experiência em osteoporose muito limitada e remete ao especialista, sem dose. [S1]
Indicações predominantemente adultas	Não transpor a dose para hipercalcemia para tratamento de dor óssea; indicação pós-menopausa não se aplica à criança.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar tratamento prolongado pelo sinal de malignidade; monitorar hipocalcemia e hipersensibilidade a peptídeo de salmão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)
Tratamento da dor óssea associada a osteólise, osteoporose pós-menopausa (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NICE BNFC - Calcitonin salmon (bnfc.nice.org.uk)

82. Calcitriol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipoparatiroidismo congênito/adquirido e raquitismo dependente de vitamina D	VO:1 mês-11 anos iniciar 0,015 mcg/kg/dia (máximo inicial 0,25 mcg); aumentar 0,005 mcg/kg/dia por etapa (incremento máximo 0,25 mcg), a cada 2-4 semanas.12-17 anos iniciar 0,25 mcg/dia, mesmos incrementos; usual 0,5-1 mcg/dia. Uso contínuo, guiado pelo cálcio e etiologia. [S1]
≥1 mês	15 ng=0,015 mcg; não mg.
Hipoparatiroidismo - alternativa da bula	VO iniciar 0,25 mcg/dia; faixa habitual 1-5 anos 0,25-0,75 mcg/dia e ≥6 anos 0,5-2 mcg/dia. Aumentar a cada 2-4 semanas conforme cálcio. [S2]
≥1 ano	Não somar esse esquema ao ponderal.
Osteodistrofia renal/DMO-DRC - pré-diálise	<3 anos: VO 0,01-0,015 mcg/kg 1 vez/dia inicialmente. ≥3 anos:0,25 mcg 1 vez/dia, até 0,5 mcg/dia conforme PTH/Ca/P. Tratamento contínuo com nefrologia. [S2]
Crianças	Em diálise, a fonte consultada não define esquema pediátrico validado; não extrapolar dose EV adulta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cálcio pelo menos 2 vezes/semana durante titulação, fósforo, creatinina, PTH e calciúria. Suspender se hipercalcemia; evitar duplicação de vitamina D e cálcio não supervisionado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)

Hipoparatiroidismo congênito ou adquirido, raquitismo dependente de vitamina D, osteodistrofia renal e distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] NICE BNFC - Calcitriol (bnfc.nice.org.uk)

[S2] DailyMed - Calcitriol oral solution/capsule (dailymed.nlm.nih.gov)

83. Canabidiol (CBD)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises de Dravet e Lennox-Gastaut ≥1 ano, produto farmacêutico purificado	VO iniciar 2,5 mg/kg/dose 12/12 h por 1 semana; depois 5 mg/kg/dose 12/12 h. Se necessário, aumentar semanalmente 2,5 mg/kg/dose até máximo 10 mg/kg/dose 12/12 h (=20 mg/kg/dia). Uso contínuo com avaliação das crises e tolerância. [S1]
Crises associadas ao complexo de esclerose tuberosa ≥1 ano	VO iniciar 2,5 mg/kg/dose 12/12 h; aumentar semanalmente 2,5 mg/kg/dose até 12,5 mg/kg/dose 12/12 h (=25 mg/kg/dia). Uso contínuo; retirar gradualmente. [S1] Doses menores que 25 mg/kg/dia não foram avaliadas como manutenção no ensaio rotulado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dosar ALT/AST/bilirrubina basal e durante tratamento; maior risco com valproato e sedação com clobazam. Hepatopatia moderada: metade das doses; grave: iniciar 0,5 mg/kg 12/12 h, manutenção 1-2 mg/kg 12/12 h em Dravet/LGS ou 2,5 mg/kg 12/12 h em TSC. Manter relação consistente com refeições.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)
Tratamento de crises epiléticas associadas às síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa (produtos farmacêuticos purificados sob autorização sanitária).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Epidiolex, prescrição 2025 (accessdata.fda.gov)

84. Captopril

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva Crianças e adolescentes	VO: início 0,3 mg/kg/DIA dividido em 3 tomadas (0,1 mg/kg/dose a cada 8 h), com dose-teste e titulação pela PA, perfusão e função renal; tratamento contínuo. [S1] Off-label pediátrico; não interpretar 0,3 mg/kg/DIA como dose de cada tomada.
Hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva neonatal Prematuros, neonatos, lactentes ou disfunção renal	VO: início reduzido 0,15 mg/kg/DIA, dividido em 3 tomadas (0,05 mg/kg/dose a cada 8 h); adaptar intervalo e titulação sob monitorização hospitalar. [S1] Resposta neonatal imprevisível: hipotensão, oligúria e apneia podem ocorrer com doses pequenas.
Hipertensão arterial - titulação institucional Lactentes, crianças e adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: lactentes, 0,1-0,3 mg/kg/dose a cada 8-12 horas; crianças, 0,3-0,5 mg/kg/dose a cada 8 horas; adolescentes, 6,25-12,5 mg/dose a cada 8-12 horas. Titular pela resposta; máximo 6 mg/kg/dia ou 150 mg/dia, o menor. [S2] Dose-teste IWK: 0,1 mg/kg, máximo inicial 6,25 mg; monitorar PA. Uso contínuo.
Insuficiência cardíaca congestiva - titulação institucional Lactentes; crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: lactentes, 0,1-0,8 mg/kg/dose a cada 8 horas OU 0,15-1,25 mg/kg/dose a cada 12 horas. Crianças/adolescentes, 0,1-2 mg/kg/dose a cada 8 horas OU 0,15-3 mg/kg/dose a cada 12 horas; máximo 6 mg/kg/dia ou 150 mg/dia, o menor. Tratamento contínuo. [S2] Selecionar um esquema; titular lentamente após estabilidade hemodinâmica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, potássio, creatinina, diurese. Evitar hipovolemia, estenose bilateral de artéria renal, angioedema prévio e associação com sacubitril/valsartana sem intervalo de 36 h.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)
Hipertensão arterial sistêmica (incluindo faixa neonatal e pediátrica off-label), insuficiência cardíaca congestiva.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Captopril: SmPC do fabricante, eMC (medicines.org.uk)
[S2] IWK - captopril, revisão agosto 2025 (dir.iwk.nshealth.ca)

85. Carbamazepina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais com ou sem generalização secundária e crises tônico-clônicas generalizadas	VO: iniciar 10-20 mg/kg/DIA em 2-3 tomadas de comprimidos ou 4 tomadas da suspensão; aumentar semanalmente. Não exceder 35 mg/kg/DIA. Uso contínuo, menor dose eficaz. [S1]
<6 anos	
Crises focais com ou sem generalização secundária e crises tônico-clônicas generalizadas	6-12 anos: iniciar 100 mg VO 12/12 h; aumentar até 100 mg/dia por semana; usual 400-800 mg/dia, teto 1.000 mg/dia. >12 anos: 200 mg 12/12 h, incrementos até 200 mg/dia por semana; teto 1.000 mg/dia aos 12-15 anos e 1.200 mg/dia >15 anos. [S1]
6-12 anos; >12 anos	Liberação prolongada: 12/12 h; formulações comuns: dividir 3-4 vezes/dia conforme titulação.
Neuralgia do trigêmeo	A fonte apresenta esquema adulto, mas não estabelece esquema pediátrico específico para esta indicação. Não transpor a dose adulta automaticamente. [S1]
Pediatria	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Avaliação neuropediátrica; indicação preservada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, sódio, função hepática, interações e erupção cutânea; não retirar abruptamente. Níveis séricos auxiliam toxicidade/falha.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)

Crises epiléticas focais com ou sem generalização secundária, crises tônico-clônicas generalizadas; neuralgia do trigêmeo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Carbamazepina: bula DailyMed/Sun (dailymed.nlm.nih.gov)

86. Carbocisteína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Alívio sintomático de afecções respiratórias hipersecretivas com muco espesso >2-12 anos	Administrar 5 mg/kg/dose VO 8/8 h (15 mg/kg/dia). Duração vinculada à persistência de secreções e benefício; a bula não fixa número de dias. [S1] Bula brasileira: solução pediátrica 20 mg/mL corresponde a 0,25 mL/kg/dose. Não é tratamento etiológico.
Alívio sintomático de afecções respiratórias hipersecretivas com muco espesso Adolescentes ≥12 anos	Faixa descrita para apresentação adulta: 250-500 mg VO 8/8 h, total 750-1.500 mg/dia; manter pelo menor período sintomático necessário. [S1] Respeitar indicação etária da marca selecionada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <2 anos, úlcera gástrica/duodenal e hipersensibilidade. Evitar associação a antitussígenos e anticolinérgicos; cautela em insuficiência respiratória.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)
Alívio sintomático de afecções respiratórias hipersecretivas com muco espesso (mucolítico adjuvante, a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Geolab: carbocisteína, bula profissional brasileira (geolab.com.br)

87. Carbonato de Cálcio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Suplementação de cálcio e prevenção de raquitismo carencial Crianças e adolescentes	Suplementar apenas o déficit entre ingestão alimentar e necessidade etária. Cálcio ELEMENTAR: 200 mg/dia aos 0-6 meses; 270 mg/dia aos 7-12 meses; 500 mg/dia aos 1-3 anos; 700 mg/dia aos 4-8 anos; 1.000 mg/dia aos 9-11 anos; 1.300 mg/dia aos 12-18 anos. [S2] São metas de ingestão total, não doses a acrescentar integralmente à dieta.
Tratamento de raquitismo carencial Pediatria	Cálcio ELEMENTAR 500 mg VO/dia pela dieta ou suplemento, associado a vitamina D por no mínimo 3 meses. Hipocalcemia crônica: 45-65 mg/kg/dia de cálcio ELEMENTAR, dividido em 4 tomadas com refeições. [S1, S2] 1.250 mg de carbonato fornecem 500 mg de cálcio elementar.
Controle da hiperfosfatemia na doença renal crônica Pediatria	50-100 mg/kg/DIA de cálcio ELEMENTAR VO, dividido em 1-4 tomadas junto às refeições; teto da referência 2.500 mg/dia. Titular por fósforo, cálcio e ingestão total; tratamento contínuo sob nefrologia. [S1] Carga de cálcio excessiva favorece calcificação; teto não é meta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar cálcio, fósforo, PTH e calciúria. Evitar hipercalcemia; separar quinolonas, tetraciclinas e levotiroxina. Carbonato contém 40% de cálcio elementar.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)

Suplementação de cálcio, prevenção e tratamento de raquitismo carencial, controle da hiperfosfatemia na doença renal crônica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP: Carbonato cálcico, monografia pediátrica (aeped.es)

[S2] RCH: deficiência de vitamina D e raquitismo (rch.org.au)

88. Carmelose Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Olho seco, irritação ocular, queimação e proteção contra agentes externos Uso oftálmico; avaliar causa dos sintomas em crianças	Instilar 1-2 gotas no olho afetado, repetindo conforme necessidade sintomática. Não há dose por peso nem curso fixo. [S1] Solução pronta: não diluir. Persistência, dor ou redução visual exigem exame ocular.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar contaminação do gotejador. Suspende em hipersensibilidade. Lubrificante não substitui tratamento de infecção, trauma ou corpo estranho.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)
Alívio sintomático do olho seco, irritação ocular, queimação e proteção contra agentes externos (lubrificante ocular).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] Cristália: carmelose sódica, bula profissional \(cristalia.com.br\)](#)

89. Carvão Vegetal Ativado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Descontaminação gastrointestinal em intoxicação aguda por substância adsorvível Lactentes, crianças e adolescentes com indicação toxicológica e via aérea protegida	Dose inicial usual 1 g/kg VO ou sonda, dose única; em crianças de 1-12 anos a referência permite 1-2 g/kg ou 25-50 g. Administrar precocemente, usualmente até 1-2 h. [S1, S2] Dose deve refletir gravidade e capacidade de administração. Não usar em intoxicação leve apenas por rotina.
Intoxicação selecionada que exige doses múltiplas Casos graves por carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina ou teofilina	Após dose inicial, pode-se repetir metade da dose em 2-6 h; múltiplas doses somente com toxicologista e controle de trânsito intestinal. Interromper se íleo. [S1, S2] Não generalizar para qualquer substância.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado com via aérea desprotegida ou íleo; não adsorve ferro, lítio, álcoois, cáusticos. Aspiração pode ser fatal. Não associar sorbitol rotineiramente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 16)

Descontaminação gastrointestinal em intoxicações agudas exógenas por substâncias adsorvíveis, dentro do intervalo terapêutico inicial.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Hospital Sírio-Libanês: carvão ativado (guiafarmaceutico.hsl.org.br)

[S2] RCH: carvão em intoxicações (rch.org.au)

90. Carvedilol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência cardíaca crônica com disfunção sistólica; hipertensão arterial Lactentes e crianças <12 anos, hemodinamicamente estáveis	VO: iniciar 0,05-0,1 mg/kg/dose 12/12 h, máximo inicial 3,125 mg/dose. Aumentar a cada 1-2 semanas; faixa superior descrita 0,5-0,8 mg/kg/dose 12/12 h, teto 25 mg/dose. Uso contínuo. [S1] AEP descreve faixas <12 e >12 anos sem esclarecer o limite exato de 12; nessa transição, individualizar com cardiologia e iniciar conservadoramente.
Insuficiência cardíaca crônica com disfunção sistólica Adolescentes >12 anos	Iniciar 3,125 mg VO 12/12 h e titular a cada 2 semanas, teto 25 mg 12/12 h. Se interrupção >2 semanas, reiniciar na menor dose. [S1]
Hipertensão arterial Adolescentes >12 anos	12,5 mg VO 1 vez/dia por 2 dias; depois 25 mg/dia. Incrementos em intervalos ≥2 semanas, máximo 25 mg 12/12 h. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, FC, perfusão e glicemia. Contraindicado em asma com broncoespasmo, bloqueio AV avançado e hepatopatia manifesta. Evitar retirada abrupta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Insuficiência cardíaca crônica com disfunção sistólica e hipertensão arterial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label consolidado).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP: carvedilol pediátrico (aeped.es)

91. Caspofungina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase invasiva e candidemia 3 meses-17 anos	Ataque 70 mg/m ² EV no dia 1; manutenção 50 mg/m ² EV 24/24 h. Se resposta insuficiente e boa tolerância: 70 mg/m ² /dia. Máximo 70 mg/dose; infundir em 1 h. Candidemia sem foco metastático: ≥14 dias após depuração documentada (primeira hemocultura negativa sustentada), com resolução clínica e, se neutropênico, recuperação da neutropenia. [S1, S2] Superfície corporal = $\sqrt{[altura(cm) \times peso(kg)]/3.600}$.
Aspergilose invasiva refratária 3 meses-17 anos	Mesmo ataque 70 mg/m ² EV e manutenção 50-70 mg/m ² EV 24/24 h, máximo 70 mg/dia, em 1 h. Duração guiada pela resposta clínica e recuperação imunológica, sem curso fixo em dias. [S1] Resgate para refratariedade ou intolerância; não é esquema inicial preferencial.
Tratamento antifúngico empírico em neutropenia febril 3 meses-17 anos	Mesmo ataque e manutenção. Tratamento empírico: manter até resolução da neutropenia conforme evolução. Se candidemia comprovada sem foco metastático: ≥14 dias após depuração documentada, com resolução dos sintomas e neutropenia. Focos profundos exigem duração própria. [S1, S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não diluir em SG 5%. SF 0,9% ou Ringer lactato: concentração final ≤0,5 mg/mL. Sem bolus. Monitorar transaminases; ajuste hepático pediátrico não estabelecido.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Candidíase invasiva, candidemia, aspergilose invasiva refratária e tratamento antifúngico empírico em neutropenia febril.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Merck: CANCIDAS, prescrição completa (merck.com)

[S2] IDSA - Candidíase: recomendações 12 e 20 (depuração documentada)

Divergência de referência: a bula Merck emprega a última cultura positiva como marco. Para candidemia, esta ficha adota a diretriz IDSA: documentar depuração com hemoculturas seriadas e contar a duração a partir da negatificação sustentada, além dos critérios clínicos.

92. Cefaclor

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Otite média aguda ≥1 mês	40 mg/kg/DIA VO em 2 tomadas de 12/12 h ou 3 tomadas de 8/8 h; máximo 1 g/dia. Curso usual 5-10 dias segundo idade e gravidade. [S1, S2]
Faringoamigdalite estreptocócica ≥1 mês	20 mg/kg/DIA VO em 2 ou 3 tomadas; se grave, 40 mg/kg/dia. Máximo 1 g/dia. Administrar por 10 dias. [S1]
Rinossinusite bacteriana, pneumonia comunitária e infecção urinária por sensíveis ≥1 mês	20-40 mg/kg/DIA VO dividido de 8/8 h; máximo 1 g/dia. Pneumonia/ITU: duração orientada por foco e resposta; sinusite exige confirmação de adequação microbiológica. [S1] A bula aberta sustenta pneumonia/ITU; rinossinusite não consta como indicação formal e a resistência limita uso empírico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reavaliar em 48-72 h. Reações tipo doença do soro são particularmente associadas ao cefaclor. Não é primeira escolha universal para foco respiratório.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, faringoamigdalite, pneumonia comunitária e infecções urinárias por agentes sensíveis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed: cefaclor suspensão (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

93. Cefadroxila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções de pele e tecidos moles por MSSA/estreptococos	30 mg/kg/DIA VO em dose única diária ou dividido 12/12 h; impetigo: dose diária única é opção. Curso usual 5-7 dias se superficial e evolução favorável. [S1, S2]
Crianças	
Faringite estreptocócica	30 mg/kg/DIA VO em dose única ou 12/12 h durante 10 dias; teto prático da indicação 1 g/dia. [S1]
Crianças	
Infecção urinária não complicada	30 mg/kg/DIA VO dividido 12/12 h. Selecionar pela urocultura; duração conforme cistite versus infecção febril. [S1]
Crianças	Bula não estabelece máximo pediátrico único para todos os focos; não transpor teto da faringite à ITU.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar em insuficiência renal; suspender em reação alérgica importante. Não trata MRSA.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Infecções de pele e tecidos moles por estafilococos sensíveis à meticilina e estreptococos; faringite e infecção urinária não complicada.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed: cefadroxila (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

94. Cefalexina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Impetigo, foliculite, celulite e erisipela >1 mês	20 mg/kg/dose VO 8/8 h, máximo 750 mg/dose; casos graves selecionados: 40 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 1,5 g/dose. Lesões superficiais: usual 5-7 dias; ampliar pela extensão/resposta. [S1, S2]
Faringite estreptocócica Crianças	20 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 500 mg/dose, durante 10 dias. [S3] Evitar em hipersensibilidade imediata grave à penicilina.
Infecção urinária afebril >1 mês	20 mg/kg/dose VO 8/8 h, máximo 750 mg/dose; curso de 5 dias em cistite simples selecionada, com cultura e reavaliação. [S1, S2]
Profilaxia de ITU recorrente em crianças selecionadas >1 mês	12,5 mg/kg VO 1 vez/noite, máximo 250 mg/dia. Uso contínuo enquanto persistir indicação urológica; reavaliar benefício/resistência periodicamente. [S1] Off-label; não indicada para toda recorrência.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar doses na disfunção renal. Dose elevada de 120 mg/kg/dia é esquema especializado descrito na fonte, não início para infecção leve.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Impetigo, foliculite, celulite, erisipela, faringite estreptocócica, infecção urinária afebril e profilaxia de ITU recorrente em crianças selecionadas (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: cefalexina (pch.health.wa.gov.au)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

[S3] CDC: faringite estreptocócica (cdc.gov)

95. Cefalotina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções sistêmicas graves por estafilococos e estreptococos sensíveis	Administrar 20-40 mg/kg/dose EV ou IM a cada 6 horas; alternativa: 12-25 mg/kg/dose a cada 4 horas. Não somar os esquemas. Duração conforme bacteremia, foco profundo, culturas e controle de fonte. [S1]
Pediatria	Os totais são 80-160 mg/kg/dia no esquema de 6 horas e 72-150 mg/kg/dia no de 4 horas; a bula não define teto pediátrico absoluto.
Profilaxia cirúrgica antimicrobiana	Regime documentado em série brasileira de fechamento de comunicação interatrial: 50 mg/kg EV, máximo 2 g, no momento do procedimento. A série relata mais 2 doses de 25 mg/kg após o procedimento, sem informar intervalo; não transpor essa repetição sem protocolo local. [S2]
Crianças maiores/adolescentes - contexto de cardiologia intervencionista	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Evidência histórica e específica; a bula não estabelece profilaxia pediátrica universal. Não utilizar a dose de tratamento como dose profilática por suposição.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reconstituir e diluir para EV conforme frasco; administrar em 3-5 min ou infusão 30 min. Ajustar por função renal. Lidocaína de preparo IM nunca por via EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Infecções sistêmicas graves por estafilococos e estreptococos sensíveis; profilaxia cirúrgica antimicrobiana.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ABL Brasil: cefalotina, bula profissional (ablbrasil.com.br)

[S2] Chamié et al. - profilaxia com cefalotina em oclusão de comunicação interatrial, estudo brasileiro 2009 (doi.org)

96. Cefazolina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Celulite e infecções cutâneas por MSSA/estreptococos ≥4 semanas	25 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose; grave: 50 mg/kg/dose 8/8 h. Curso usual 5-10 dias conforme extensão e resposta. [S1, S2]
Osteomielite e bacteremia por MSSA ≥4 semanas	50 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose; choque séptico/UTI: opção 50 mg/kg/dose 6/6 h. Duração: osteomielite geralmente 3-4 semanas totais; bacteremia requer negativação de culturas e exclusão de foco profundo. [S1, S2] Transição oral quando há melhora e foco controlado.
Profilaxia cirúrgica ≥4 semanas	30 mg/kg EV, máximo 2 g, nos 60 min anteriores à incisão. Na fonte PCH, repetir após 3 h de cirurgia. >120 kg: teto 3 g. [S1] Dose única de profilaxia não exige ajuste renal; repetição depende de duração/perdas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES EV 5-20 mg/mL em SF 0,9% ou SG 5%, infundir 10-60 min. Reduzir frequência se disfunção renal; monitorar hemograma em curso prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Profilaxia cirúrgica de escolha em grande parte dos procedimentos; tratamento de celulite, infecções cutâneas, osteomielite e bacteremia por *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina (MSSA).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: cefazolina, revisão agosto/2025 (pch.health.wa.gov.au)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

97. Cefepima

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Neutropenia febril, sepse hospitalar e infecções graves por Gram-negativos, incluindo Pseudomonas suscetível	50 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose (150 mg/kg/dia; máximo 6 g/dia). Infundir em 30 min; opção de 3 h em paciente crítico. Reavaliar diariamente culturas e necessidade; duração pelo foco e resolução clínica. [S1]
>4 semanas	Atividade não deve ser presumida para todo Gram-negativo multirresistente.
Meningite bacteriana	50 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose. Curso dirigido ao patógeno: geralmente 7 dias meningococo, 10-14 dias pneumococo, ≥21 dias enterobactérias. [S1, S2]
>4 semanas	Uso específico se suscetibilidade sustentada; não cobre sozinho todo cenário empírico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES SF 0,9%/SG 5%, concentração final ≤40 mg/mL. Se TFG 30-59: 50 mg/kg 12/12 h; 10-29: 24/24 h; <10: 25-50 mg/kg 24/24 h, teto 1 g. Neurotoxicidade exige revisão imediata.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)
Neutropenia febril, sepse hospitalar, infecções graves por Gram-negativos multirresistentes (incluindo *Pseudomonas aeruginosa*), meningite bacteriana em crianças.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: cefepima, revisão 2024 (pch.health.wa.gov.au)
[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

98. Cefotaxima Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sepse e meningite bacteriana neonatal Neonatos	Administrar 50 mg/kg/dose EV. Intervalos por idade pós-menstrual (IPM) e pós-natal (IPN): IPM <30 semanas, IPN 0-28 dias: 12/12 h; IPN ≥29 dias: 8/8 h. IPM 30-36+6 semanas, IPN 0-14 dias: 12/12 h; IPN ≥15 dias: 8/8 h. IPM ≥37 semanas, IPN 0-7 dias: 8/8 h; IPN ≥8 dias: 6/6 h. [S4, S3] Infundir em 15-30 minutos. Duração definida pelo patógeno, culturas de sangue/LCR e foco; meningite por Gram-negativos geralmente ≥21 dias, com infectologia.
Sepse, infecções respiratórias, urinárias, osteoarticulares e intra-abdominais suscetíveis ≥4 semanas	50 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose. Infecção grave: 50 mg/kg/dose 6/6 h. Duração por foco: resp./urinário 5-10 dias; osteoarticular não complicada, cerca de 3 semanas totais; intra-abdominal requer controle de foco e cobertura anaeróbia. [S1, S3]
Meningite bacteriana pediátrica ≥4 semanas	50 mg/kg/dose EV 6/6 h, máximo 2 g/dose (200 mg/kg/dia). Duração pelo agente: meningococo 7 dias; pneumococo 10-14 dias; Gram-negativos ≥21 dias. [S1, S3]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Diluir em SF 0,9% ou SG 5% para ≤40 mg/mL, infundir 15-30 min. Injeção rápida <1 min pode causar arritmia. Ajustar na disfunção renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 17)

Sepse e meningite bacteriana neonatal e pediátrica; infecções respiratórias, urinárias, osteoarticulares e intra-abdominais por agentes suscetíveis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: cefotaxima (pch.health.wa.gov.au)

[S2] Queensland NeoMedQ: cefotaxima (health.qld.gov.au)

[S3] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

[S4] ANMF - cefotaxime neonatal, 2020 (anmfonline.org)

99. Cefoxitina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções intra-abdominais mistas e doença inflamatória pélvica	80-160 mg/kg/DIA EV, dividido em 4-6 doses, máximo 12 g/dia. Formas graves: faixa superior. Duração guiada pelo foco; DIP necessita completar 14 dias de esquema combinado com cobertura de clamídia. [S1]
≥3 meses	Não usar isoladamente como cobertura etiológica completa da DIP.
Profilaxia em cirurgia colorretal	Bula, ≥3 meses: 30-40 mg/kg EV 30-60 minutos antes da incisão. Alternativa ASHP, 1-18 anos: 40 mg/kg EV, máximo 2 g, com redose a cada 2 horas se cirurgia prolongada e função renal normal. Cessar profilaxia em até 24 horas. [S1, S3]
≥3 meses	Não confundir dose de profilaxia com tratamento de infecção estabelecida.
Infecções por Mycobacterium abscessus	Cefoxitina 50 mg/kg/dose EV a cada 8 horas, máximo 12 g/dia. Fase intensiva de 3-12 semanas, combinada a macrolídeo e amicacina, conforme suscetibilidade e tolerância. O tratamento combinado total prossegue por 12 meses após conversão das culturas. [S2]
Pediatria	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Dose da coluna pediátrica; 200 mg/kg/dia na tabela corresponde à coluna adulta. Não usar em monoterapia nem manter cefoxitina durante todo o tratamento sem indicação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar renal, hemograma e transaminases; ajustar intervalo na insuficiência renal. Requer controle de foco intra-abdominal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Infecções intra-abdominais mistas, doença inflamatória pélvica, profilaxia em cirurgia colorretal, infecções por *Mycobacterium abscessus* (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed: cefoxitina (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] North West/Manchester Cystic Fibrosis - NTM, tabela pediátrica (nwmcf.nhs.uk)

[S3] ASHP/IDSA/SIS/SHEA - profilaxia cirúrgica, tabela de doses pediátricas (ashp.org)

100. Ceftarolina Fosamila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções complicadas de pele/tecidos moles, incluindo MRSA; pneumonia comunitária	2 meses-<2 anos: 8 mg/kg EV 8/8 h. ≥2 anos <33 kg: 12 mg/kg EV 8/8 h, máximo 400 mg/dose; ≥33 kg: 600 mg EV 12/12 h. Pele: usual 5-14 dias; pneumonia: 5-7 dias. [S1]
2 meses-<2 anos; 2-<18 anos	Infundir em 5-60 minutos, conforme preparo e protocolo. Esquemas neonatais ou para MIC elevada exigem avaliação especializada.
MRSA com MIC 2-4 mg/L; infecções graves refratárias	MIC elevada: 2 meses-<2 anos, 10 mg/kg EV 8/8 h; ≥2 anos, 12 mg/kg EV 8/8 h, máximo 600 mg/dose. Bacteremia/osteoarticular de resgate: 2-<6 meses 10 mg/kg 8/8 h; ≥6 meses 15 mg/kg 8/8 h, máximo 600 mg/dose. Infusão prolongada 120 min. [S1]
≥2 meses	Off-label para foco/dose de resgate; duração determinada pela negativação, foco e resposta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Concentração final ≤12 mg/mL. Ajustar na insuficiência renal; monitorar neutropenia em curso prolongado. MRSA na pneumonia exige confirmar foco/isolamento.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Infecções complicadas de pele e tecidos moles (incluindo MRSA); pneumonia comunitária; infecções graves por MRSA refratárias (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: ceftarolina (pch.health.wa.gov.au)

101. Ceftazidima

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-negativos suscetíveis; exacerbação pulmonar da fibrose cística; meningite pós-neurocirúrgica >2 meses e <40 kg	50 mg/kg/dose EV 8/8 h (150 mg/kg/dia), máximo 2 g/dose ou 6 g/dia. Alternativa especializada: ataque 60-100 mg/kg seguido de 100-200 mg/kg/DIA em infusão contínua, máximo 6 g/dia. [S1, S2, S4] Na meningite, não extrapolar infusão contínua para neonatos. Meningite por Gram-negativos: geralmente ≥21 dias. FC: curso EV padrão de 14 dias; reduzir a 10 somente por decisão da equipe conforme resposta.
Infecções graves por Gram-negativos suscetíveis ≤2 meses RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	25-60 mg/kg/DIA EV dividido 12/12 h na bula; gravidade/SNC neonatal exige referência neonatal específica. [S1] Infusão contínua não estabelecida nesta faixa.
Infecções graves por Gram-negativos; meningite pós-neurocirúrgica Crianças/adolescentes ≥40 kg; função renal normal	Administrar 2 g EV a cada 8 horas. Alternativa por infusão contínua: ataque de 2 g, depois 4-6 g ao longo de 24 horas. Meningite por Gram-negativos: geralmente ≥21 dias; demais focos conforme culturas e controle de fonte. [S1, S2] Seleção da infusão contínua requer infectologia e estabilidade da solução pelo período administrado.
Exacerbação pulmonar da fibrose cística - alternativa institucional >4 semanas a 18 anos; função renal normal RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	PCH: 50 mg/kg/dose EV a cada 8 horas, máximo 3 g/dose (9 g/dia), em fibrose cística. Curso EV padrão de 14 dias; especialista pode reduzir a 10 dias se evolução permitir. [S3, S4] Teto hospitalar específico, superior aos 2 g/dose do esquema pediátrico geral. Infundir em 15-30 minutos após diluição em SF 0,9% ou SG 5% até ≤40 mg/mL.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar à função renal; neurotoxicidade com acúmulo. Para BIC: $\text{mL/h} = \text{dose(mg/kg/dia)} \times \text{peso} / [24 \times \text{concentração final(mg/mL)}]$.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Infecções graves por Gram-negativos com atividade antipseudomonal confirmada, exacerbações pulmonares em fibrose cística, meningite pós-neurocirúrgica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ceftazidima: SmPC Wockhardt (medicines.org.uk)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

[S3] PCH/ChAMP - ceftazidima, revisão maio 2025 (pch.health.wa.gov.au)

[S4] Royal Brompton/Harefield - cuidados de crianças com fibrose cística, 2023 (rbht.nhs.uk)

102. Ceftazidima + Avibactam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-negativos produtores de KPC/enterobactérias multirresistentes; infecção intra-abdominal complicada; pielonefrite ≥6 meses-<18 anos; função renal preservada	Ceftazidima 50 mg/kg + avibactam 12,5 mg/kg POR DOSE EV 8/8 h; teto 2 g + 0,5 g/dose. Infundir 2 h. Intra-abdominal: 5-14 dias com metronidazol; ITU/pielonefrite: 7-14 dias. [S1] Confirmar suscetibilidade. Não cobre metalo-betalactamase isoladamente.
Mesmas indicações 3-<6 meses	Ceftazidima 40 mg/kg + avibactam 10 mg/kg/dose EV 8/8 h em 2 h; duração pelo foco acima. [S1]
Mesmas indicações desde o nascimento >28 dias-<3 meses; ≤28 dias com IG ≥31 semanas	>28 dias: ceftazidima 30 mg/kg + avibactam 7,5 mg/kg por dose. ≤28 dias: ceftazidima 20 mg/kg + avibactam 5 mg/kg por dose. EV 8/8 h, infusão 2 h. No prematuro, usar idade corrigida conforme bula. [S1] Esquema de bula norte-americana 2025; autorização brasileira precisa avaliação separada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES TFG deve ser revista diariamente. Ajuste definido a partir de 2 anos; <2 anos com disfunção renal: esquema não estabelecido. Dose sempre identificar os dois componentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)
Infecções graves por Gram-negativos produtores de KPC e enterobactérias multirresistentes; infecção intra-abdominal complicada e pielonefrite desde o nascimento.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AbbVie: AVYCAZ, bula 2025 (rxabbvie.com)

103. Ceftolozana + Tazobactam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecção intra-abdominal complicada por Gram-negativos multirresistentes, incluindo Pseudomonas suscetível Do nascimento à adolescência, idade gestacional ≥32 semanas; função renal preservada	Ceftolozana 20 mg/kg + tazobactam 10 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 1 g + 0,5 g/dose, infundir em 1 h; 5-14 dias. Associar metronidazol para anaeróbios. [S1]
ITU complicada e pielonefrite por Gram-negativos multirresistentes, incluindo Pseudomonas Mesma população	Mesmo esquema EV 8/8 h durante 7-14 dias. [S1] A dose de 30 mg/kg corresponde à SOMA dos componentes, não a ceftolozana isolada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar conforme função renal; em <2 anos com disfunção renal, dose não estabelecida. Confirmar autorização etária brasileira da formulação; fonte regulatória dos EUA.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)
Infecções intra-abdominais complicadas e infecção urinária complicada/pielonefrite por bacilos Gram-negativos multirresistentes, incluindo *Pseudomonas*.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Merck: ZERBAXA, prescrição completa (merck.com)

104. Ceftriaxona Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Meningite bacteriana e doença meningocócica com meningite ≥1 mês	80-100 mg/kg/DIA EV, máximo 4 g/dia; dose diária única ou dividido 12/12 h. Curso pelo agente: meningococo 7 dias; pneumococo 10-14 dias; Gram-negativos ≥21 dias. [S1, S2]
Sepse e doença meningocócica sem meningite ≥1 mês	50-100 mg/kg/DIA EV, máximo 4 g/dia; usar extremidade superior em bacteremia grave. Reavaliar culturas e foco em 24-48 h; duração dirigida pelo agente. [S1]
Pneumonia grave com derrame pleural, pielonefrite e celulite orbitária ≥1 mês	50-100 mg/kg/DIA EV, máximo 4 g/dia; 24/24 h ou 12/12 h se dose diária >2 g. Pielonefrite: 7-10 dias; celulite orbitária: 10-14 dias; derrame/empiema geralmente 2-4 semanas totais com drenagem quando indicada. [S1, S2] Para celulite orbitária, RCH utiliza 100 mg/kg/dia, máximo 4 g/dia; considerar cobertura adicional e avaliação oftalmológica/ORL.
Febre em lactente sem foco 29-56 dias; selecionados após estratificação de risco	Bom estado geral e sem pleocitose no LCR: ceftriaxona 50 mg/kg/dose EV a cada 24 horas quando antibiótico parenteral for indicado. Aspecto séptico e/ou pleocitose: 50 mg/kg/dose EV a cada 12 horas, com terapia associada conforme protocolo. Reavaliar em 24 horas e ajustar por culturas. [S3] CHOP exclui ceftriaxona EV em ≤28 dias. Não tratar automaticamente todo lactente com febre.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES EV ≥30 min. Evitar em neonatos com hiperbilirrubinemia, prematuros <41 semanas pós-menstruais ou ≤28 dias recebendo cálcio EV. Não misturar com Ringer/lactato ou cálcio.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Meningite bacteriana, seps, doença meningocócica, pneumonia grave com derrame pleural, pielonefrite, celulite orbitária, febre em lactente sem foco.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ceftriaxona: SmPC Synchrony (medicines.org.uk)

[S2] RCH: diretriz antimicrobiana pediátrica (rch.org.au)

[S3] CHOP - lactente febril, doses de antimicrobianos (chop.edu)

105. Cefuroxima (Axetila / Sódica)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, pneumonia comunitária, infecções urinárias e cutâneas suscetíveis	Axetila: 15 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 500 mg/dose. Administrar com alimento. Duração usual 5-10 dias conforme foco/gravidade; reavaliar em 48-72 h. [S1] A dose/teto da fonte hospitalar pode exceder bula brasileira para algumas faixas/indicações; identificar como esquema especializado.
≥3 meses	
Pneumonia, infecções urinárias ou de pele que exigem tratamento parenteral	Cefuroxima sódica: 50-100 mg/kg/DIA EV, dividido em doses iguais a cada 6-8 horas; usar 100 mg/kg/dia nas infecções graves, sem exceder dose adulta máxima. Esquema adulto usual grave: 1,5 g a cada 8 horas; situações ameaçadoras à vida: até 1,5 g a cada 6 horas. [S2]
Acima de 3 meses	EV direto: administrar lentamente em 3-5 minutos, conforme bula. Para infusão, diluição compatível em SF 0,9% ou SG 5%, 1-30 mg/mL, com tempo do protocolo local. Duração usual 5-10 dias; ≥10 dias para S. pyogenes. Ajustar função renal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar via oral se TFG ≤10: 15 mg/kg, máximo 500 mg, 24/24 h. Axetila oral e cefuroxima sódica EV não são intercambiáveis mg por mg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Otite média aguda, rinossinusite bacteriana, pneumonia comunitária, infecções urinárias e de pele por agentes suscetíveis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH/ChAMP: cefuroxima, revisão maio/2026 (pch.health.wa.gov.au)

[S2] DailyMed - cefuroxime for injection (dailymed.nlm.nih.gov)

106. Celecoxibe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Artrite idiopática juvenil ≥2 anos e ≥10 kg RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ADMINISTRAR VO: 10-25 kg, 50 mg a cada 12 horas; >25 kg, 100 mg a cada 12 horas. Uso contínuo enquanto necessário ao controle inflamatório; reavaliar resposta e toxicidade. Tetos destes esquemas: 100 e 200 mg/dia, respectivamente. [S1] Esquema pediátrico da bula norte-americana; a bula brasileira consultada é de uso adulto. Não extrapolar para <2 anos ou <10 kg.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Avaliar função renal, pressão arterial, sangramento gastrointestinal e alergia a AINE/sulfonamida. Hepatopatia moderada: reduzir dose 50%; grave: evitar. Não associar outro AINE.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)
Tratamento da dor inflamatória em artrite idiopática juvenil (uso pediátrico off-label frente à bula adulta).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - celecoxib, seção 2.4 (dailymed.nlm.nih.gov)

107. Escetamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sedação para procedimentos dolorosos; indução de anestesia Pediatria, exclusivamente anesthesiologia; evidência por idade limitada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Referência internacional para ESCETAMINA INJETÁVEL: 0,5-1 mg/kg EV lentamente ou 2-4 mg/kg IM para indução; se necessário, repetir metade da dose inicial após 10-15 minutos. Duração: procedimento, titulada à resposta. [S1] A monografia declara investigação pediátrica insuficiente e uso pediátrico sob especialista. Existe divergência importante com doses da bula brasileira; reconciliação institucional obrigatória antes de incorporar o esquema.
Manutenção anestésica Pediatria sob anesthesiologista RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ESCETAMINA INJETÁVEL: infusão EV de 0,5-3 mg/kg/h, titulada à profundidade anestésica e aos fármacos associados; interromper ao término do procedimento. Pode ser diluída em SF 0,9% ou SG 5% para concentração final de 1 ou 2 mg/mL. [S1] Faixa da monografia internacional com ressalva pediátrica; não é esquema de spray nasal.
Asma refratária - infusão subdissociativa Pediatria DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Não foi identificado esquema pediátrico específico suficientemente respaldado para ESCETAMINA nesta indicação nas fontes abertas consultadas. Não importar automaticamente dose de cetamina racêmica. [S1] Indicação preservada do original; requer protocolo específico e decisão do intensivista.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorização cardiorrespiratória contínua e recursos de ventilação. Distinguir escetamina base, cloridrato, cetamina racêmica e spray nasal. Não coadministrar xantinas segundo a monografia internacional; considerar esta interação na asma.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 18)

Sedoanalgesia para procedimentos dolorosos e indução/manutenção anestésica; infusão subdissociativa em asma grave refratária (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] eMC - Esketamine injetável, Kalceks (medicines.org.uk)

[S2] Cristália - Ketamin, bula profissional (cristalia.com.br)

108. Cetirizina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica perene; urticária crônica idiopática 6-23 meses	ADMINISTRAR 2,5 mg VO uma vez ao dia. Aos 12-23 meses, se necessário, aumentar até 2,5 mg a cada 12 horas (máximo 5 mg/dia). Manter enquanto houver indicação, com reavaliação clínica. [S1] Não há esquema aprovado nesta fonte para <6 meses.
Rinite alérgica sazonal/perene; urticária crônica idiopática 2-5 anos	ADMINISTRAR 2,5 mg VO uma vez ao dia; se necessário, 5 mg uma vez ao dia ou 2,5 mg a cada 12 horas. Máximo 5 mg/dia. Duração conforme persistência dos sintomas. [S1]
Rinite alérgica sazonal/perene; urticária crônica idiopática 6-12 anos; >12 anos	6-12 anos: 5 mg VO a cada 12 horas. >12 anos: 10 mg VO uma vez ao dia. Máximo 10 mg/dia. Tratamento enquanto houver sintomas/exposição e benefício. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar individualmente na insuficiência renal; evitar na disfunção renal terminal conforme monografia. Pode causar sonolência; não duplicar anti-histamínicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Rinite alérgica sazonal/perene e urticária crônica idiopática (gotas e xarope a partir de 6 meses; comprimidos acima de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] DailyMed - cetirizina solução \(dailymed.nlm.nih.gov\)](#)
[\[S2\] Tecnimede/Farmoz - cetirizina, RCM \(tecnimede.com\)](#)

109. Cetoconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatite seborreica Uso tópico; crianças sob avaliação médica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Cetoconazol creme 2%: aplicar camada fina uma vez ao dia; em quadros graves, até 2 vezes/dia por avaliação médica. Curso usual de 2-4 semanas. [S1, S2] Uso pediátrico da bula brasileira; duração por diagnóstico da ficha técnica europeia. Lactentes requerem diagnóstico e acompanhamento.
Pitíriase versicolor Uso cutâneo; crianças sob avaliação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Creme 2%: aplicar uma vez/dia; quadros graves, até 2 vezes/dia, por 2-3 semanas. [S1, S2] Persistência de alteração de cor isolada não prova falha antifúngica.
Micoses superficiais Uso cutâneo; crianças sob avaliação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Creme 2%, uma vez/dia, podendo aumentar a 2 vezes/dia: tinea corporis, 3-4 semanas; cruris, 2-4; pedis/manuum, 4-6; candidíase cutânea, 2-3 semanas. [S1, S2] Reavaliar diagnóstico se não houver melhora em 4 semanas. Não aplicar esquema de pele a tinea capitis.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar olhos e mucosas; suspender por irritação/hipersensibilidade. Diagnóstico e extensão determinam necessidade de outro antifúngico.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)

Tratamento tópico de dermatite seborreica, pitíriase versicolor e micoses superficiais.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Laboratório Globo - cetoconazol creme, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] AEMPS - Ketoconazol Abamed 20 mg/g creme, ficha técnica (cima.aemps.es)

110. Cetoprofeno (Base / Lisinato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor pós-operatória, musculoesquelética e traumática; febre >1 ano - cetoprofeno base em solução oral	ADMINISTRAR 1 mg/kg/dose VO a cada 6-8 horas conforme necessidade. A bula também apresenta, aos 7-11 anos, alternativa fixa de 25 mg a cada 6-8 horas. Usar pelo menor período necessário e suspender quando cessar dor/febre. [S1] Não somar os esquemas. A faixa ponderal equivale a 3-4 mg/kg/dia. A bula não fixa teto pediátrico absoluto para a dose ponderal; não aplicar o teto adulto de 300 mg/dia como autorização pediátrica.
Dor aguda - lisinato de cetoprofeno >15 anos; formulação italiana específica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Lisinato: 40 mg do SAL VO (equivalentes a 25 mg de cetoprofeno base), inicialmente uma vez/dia; dor mais intensa, 2-3 vezes/dia, máximo 120 mg de sal/dia. Manter somente até resolução do episódio doloroso, na menor dose eficaz. [S3] Faixa de bula Zentiva italiana, não aprovação brasileira. A dose de sal não é igual à de cetoprofeno base.
Analgesia com lisinato - evidência pediátrica específica 6-12 anos; estudo em faringoamigdalite RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime estudado: 40 mg de lisinato de cetoprofeno VO a cada 8 horas, máximo 3 doses/dia, por até 3 dias, com reavaliação no dia 4. [S2] Braço de cetoprofeno aberto, não duplo-cego. Evidência específica de dor de garganta; não estabelece dose universal de lisinato para pós-operatório, trauma ou lactentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em desidratação, insuficiência renal, sangramento/úlcera ou hipersensibilidade a AINE. Não associar outro AINE. Reavaliar febre ou dor persistente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)

Dor pós-operatória, inflamações osteoarticulares, quadros traumáticos e febre (gotas aprovadas acima de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Eurofarma - cetoprofeno gotas 20 mg/mL, bula profissional (bulas.eurofarma.com.br)

[S2] Ruperto et al. - ensaio pediátrico de cetoprofeno lisinato na faringoamigdalite, 2011 (ijponline.biomedcentral.com)

[S3] Zentiva Italia - cetoprofeno lisinato 40 mg, folheto novembro 2025 (assets.ctfassets.net)

111. Cetotifeno

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia da asma 6 meses-3 anos; >3 anos	ADMINISTRAR VO 0,05 mg/kg/dose a cada 12 horas entre 6 meses e 3 anos; >3 anos, 1 mg a cada 12 horas. Avaliar resposta após 2-3 meses; tratamento contínuo apenas se benéfico. Retirar gradualmente em 2-4 semanas. [S1] Não trata crise aguda. O papel profilático é histórico; não substitui tratamento inalatório controlador indicado.
Rinite alérgica; conjuntivite alérgica 6 meses-3 anos; >3 anos	Mesmo esquema ORAL: 0,05 mg/kg/dose a cada 12 horas (6 meses-3 anos), ou 1 mg a cada 12 horas (>3 anos). Duração conforme sintomas/exposição e resposta. [S1] Não confundir dose oral com dose de colírio; 1 mg refere-se a cetotifeno, não à massa do fumarato.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sedação, aumento do apetite e excitação paradoxal. Cautela em epilepsia; não interromper abruptamente os demais controladores da asma.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Profilaxia de longo prazo da asma brônquica alérgica, rinite e conjuntivite alérgica (acima de 6 meses); não indicado para crise aguda.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Neo Química - fumarato de cetotifeno, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

112. Ciclopirox Olamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Micoses superficiais; candidíase cutânea; dermatite seborreica	CICLOPIROX OLAMINA creme 1%/solução tópica 1%: aplicar fina camada nas áreas afetadas a cada 12 horas. Após desaparecerem os sintomas (em geral cerca de 2 semanas), continuar por mais 1-2 semanas. [S1]
>6 anos	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há dose ponderal. <6 anos: uso não respaldado pela bula consultada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso externo; evitar olhos, mucosas e oclusão. Se persistirem lesões, reavaliar diagnóstico em vez de prolongar indefinidamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Micoses cutâneas superficiais, candidíase cutânea e dermatite seborreica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Sanofi/Medley - ciclopirox olamina, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

113. Ciclosporina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Síndrome nefrótica corticodependente ou corticorresistente Crianças	ADMINISTRAR 6 mg/kg/DIA VO divididos a cada 12 horas, se função renal normal; se função renal comprometida, iniciar no máximo 2,5 mg/kg/dia. Titular por proteinúria, creatinina e níveis; máximo pediátrico da bula 6 mg/kg/dia. Sem eficácia em 3 meses, suspender; manutenção na menor dose eficaz. [S1] Titular por proteinúria, função renal e níveis sanguíneos.
Transplante de órgãos sólidos Crianças sob equipe transplantadora	Esquema da bula: 10-15 mg/kg/DIA VO divididos a cada 12 horas, iniciado nas 12 horas anteriores ao transplante; manter 1-2 semanas e reduzir por níveis sanguíneos até aproximadamente 2-6 mg/kg/dia. Em associação imunossupressora, podem ser usadas doses iniciais menores. [S1] Ajustar por órgão, níveis sanguíneos e associações. Manutenção prolongada.
Transplante de medula óssea Crianças sob equipe transplantadora	Regime descrito: iniciar EV 3-5 mg/kg/DIA no dia anterior, continuar até 2 semanas; transição VO em torno de 12,5 mg/kg/DIA, divididos a cada 12 horas. Manutenção por pelo menos 3 meses, preferencialmente 6; reduzir gradualmente até cerca de 1 ano se permitido pela evolução. [S1, S2] EV: diluir o concentrado injetável em SF 0,9% ou SG 5% até 0,5-2,5 mg/mL e infundir em 2-6 horas; recipiente/equipo sem PVC/DEHP. CHEO também descreve 1,5 mg/kg/dose EV a cada 12 horas, dependente do protocolo transplantador.
Dermatite atópica grave Pediatria - off-label com experiência limitada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ADMINISTRAR 2,5 mg/kg/DIA VO divididos a cada 12 horas; sem resposta em 2 semanas, elevar até 5 mg/kg/dia. Após controle, reduzir gradualmente e tentar suspensão; curso de 8 semanas pode ser suficiente, conforme resposta. [S1] Experiência pediátrica limitada; avaliação especializada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar pressão, creatinina, potássio, magnésio e interações CYP 3A 4. Aumento persistente da creatinina >30%: reduzir 25-50%; >50% exige redução adicional. Não intercambiar formulações sem níveis.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)

Síndrome nefrótica corticodependente ou corticorresistente; imunossupressão em transplantes de órgãos e medula óssea; dermatite atópica grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sandoz - ciclosporina, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] CHEO - ciclosporina injetável (outreach.cheo.on.ca)

114. Cimetidina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Úlcera péptica >1 ano; avaliação gastroenterológica	Administrar 5-10 mg/kg/dose VO a cada 6 horas (20-40 mg/kg/dia). Tratar até cicatrização documentada; a fonte pediátrica não fixa duração única nem teto absoluto. [S1] Investigar H. pylori e causas medicamentosas; antagonista H 2 isolado não erradica H. pylori.
Doença do refluxo gastroesofágico >1 ano; doença ácido-péptica confirmada	Administrar 5-10 mg/kg/dose VO a cada 6 horas; total 20-40 mg/kg/dia. Reavaliar resposta e necessidade de supressão ácida em 4-8 semanas. [S1, S2] Não tratar regurgitação fisiológica com cimetidina.
Condições hipersecretoras patológicas >1 ano; especialista	Administrar inicialmente 5-10 mg/kg/dose VO a cada 6 horas; titular pela resposta secretória e tolerância. Uso contínuo enquanto persistir a causa; doses além de 40 mg/kg/dia não padronizadas nesta fonte. [S1] Não importar doses adultas elevadas sem referência pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajuste renal AEP: depuração >40 mL/min, intervalo 6 horas; 20-40, 8 horas ou reduzir 25%; <20, 12 horas ou reduzir 50%. Interações relevantes com varfarina, anticonvulsivantes e outros substratos hepáticos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Úlcera péptica, DRGE e condições hipersecretoras patológicas (bula oral rotulada acima de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Cimetidina, Pediamécum (aeped.es)
[S2] SBP - Doença do refluxo gastroesofágico, guia prático (sbp.com.br)

115. Cinchocaína + Policresuleno

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorroidas; fissuras anais; prurido anal	NÃO HÁ ESQUEMA PEDIÁTRICO ESTABELECIDO na bula consultada. Não transpor a aplicação ou dose retal adulta para crianças. [S1]
Produto de uso adulto	Indicações preservadas do documento original; exigem avaliação etiológica pediátrica.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Preparação retal pode causar irritação e hipersensibilidade; verificar composição exata, pois marcas com nomes semelhantes podem conter componentes adicionais.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Alívio sintomático de hemorróidas, fissuras anais e prurido anal (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Proctox-H - policresuleno + cinchocaína, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

116. Ciproeptadina + Cobamamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anorexia/desnutrição; convalescença com necessidade de estimular apetite	ADMINISTRAR VO antes das refeições: 2-6 anos, cobamamida 0,5-1 mg + ciproeptadina 2-4 mg por dose a cada 12 horas; >6 anos, cobamamida 1 mg + ciproeptadina 4 mg a cada 12 horas. Máximo pediátrico de ciproeptadina: 8 mg/dia. Duração não fixada em bula; reavaliar benefício nutricional e sedação. [S1]
2-6 anos; >6 anos	A associação não substitui diagnóstico e tratamento nutricional. Não usar <2 anos. Se sonolência acentuada, reduzir a dose à metade.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sedação e efeitos anticolinérgicos; evitar associação com outros depressores do SNC. Doses expressas separadamente por componente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)
Estimulante do apetite em quadros de desnutrição e convalescença (acima de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Abbott - Cobavital, bula profissional (abbottbrasil.com.br)

117. Ciprofloxacino

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Exacerbação pulmonar da fibrose cística por Pseudomonas	ADMINISTRAR 15-20 mg/kg/dose VO a cada 12 horas (máximo 750 mg/dose), ou 10 mg/kg/dose EV a cada 8 horas (máximo 400 mg/dose), infundido em 60 minutos. Duração de 10-14 dias para exacerbação aguda por Pseudomonas. [S1, S3]
5-17 anos; demais idades sob infectologista	Usar um esquema segundo gravidade, tolerância e resposta; ajustar à função renal.
Infecções graves por Gram-negativos multirresistentes	ADMINISTRAR 20 mg/kg/dose VO a cada 12 horas (máximo 750 mg/dose), ou 10 mg/kg/dose EV a cada 8 horas (máximo 400 mg/dose). Para infecções menos graves: VO 10-15 mg/kg/dose a cada 12 horas, máximo 500 mg/dose; EV 10-15 mg/kg/dose a cada 12 horas, máximo 400 mg/dose. Duração determinada pelo foco, controle da fonte e culturas. [S1]
≥4 semanas - uso selecionado/off-label	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Via EV em 60 minutos; a categoria documental não define foco e portanto não admite um único número de dias.
Otite externa - associação ciprofloxacino/hidrocortisona	INSTILAR 3 gotas da suspensão otológica ciprofloxacino 0,2% + hidrocortisona 1% no ouvido afetado a cada 12 horas, por 7 dias. [S2]
≥1 ano	Não usar se perfuração timpânica conhecida/suspeita. Não confundir com formulação oftálmica ou associação com dexametasona.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar intervalo se TFG <30 mL/min/1,73 m². Separar VO de ferro/cálcio/antiácidos; monitorar QT, tendões, neuropatia e função renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 19)

Exacerbação pulmonar por *Pseudomonas* na fibrose cística (5-17 anos); otite externa (com hidrocortisona, a partir de 1 ano); infecções sistêmicas graves por Gram-negativos multirresistentes em pediatria (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - ChAMP, Ciprofloxacin (pch.health.wa.gov.au)

[S2] DailyMed - Cipro HC Otic (dailymed.nlm.nih.gov)

[S3] Bayer - Cipro, bula brasileira (consultaremedios.com.br)

118. Cisatracúrio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bloqueio neuromuscular para intubação 2-12 anos; >12 anos	ADMINISTRAR EV: 2-12 anos, 0,1 mg/kg; >12 anos, 0,15-0,2 mg/kg. Reforço: 0,03 mg/kg conforme recuperação do bloqueio; em >12 anos, habitualmente após 40-65 minutos. Duração limitada ao procedimento. [S1]
Bloqueio neuromuscular durante ventilação mecânica em UTI >2 anos	INFUNDIR EV 1-4 mcg/kg/min, titulando à resposta de estimulação nervosa periférica e ao objetivo ventilatório; reavaliar continuamente a necessidade e suspender tão logo possível. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES NÃO produz analgesia, sedação ou amnésia: assegurar ambas antes e durante a paralisia. Exige ventilação e monitorização contínuas; evitar administração inadvertida em paciente consciente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)
Bloqueio neuromuscular para intubação e ventilação mecânica em UTI pediátrica (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] CHEO - Cisatracurium (outreach.cheo.on.ca)

119. Citrato de Potássio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acidose tubular renal distal Crianças - nefrologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	CITRATO DE POTÁSSIO: referência brasileira descreve 4 mEq/kg/DIA VO, fracionados ao longo do dia e titulados para normalizar bicarbonato, potássio e calciúria. Tratamento prolongado, frequentemente vitalício. [S1] A dose total é de equivalentes alcalinos; a concentração da preparação deve estar expressa em mEq/mL. Fonte não fixa intervalo nem teto universal; fracionamento individualizado.
Prevenção de nefrolitíase por hipocitratúria Crianças - off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Administrar inicialmente 1 mEq/kg/DIA VO, dividido em 2 tomadas a cada 12 horas. Titular pela citratúria e pH urinário; tratamento contínuo com reavaliação metabólica. [S2, S3] EAU fornece o fracionamento em 2 doses; UFG descreve faixa diária 0,5-1 mEq/kg. Não há teto único sem conhecer função renal e composição.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar potássio, bicarbonato, creatinina, citratúria e pH; evitar em hipercalemia ou insuficiência renal que impeça excreção de potássio. Não confundir mg de citrato com mEq de potássio.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)

Acidose tubular renal distal e prevenção de litíase renal por hipocitratúria (uso adulto na bula; uso pediátrico especializado, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Jornal Brasileiro de Nefrologia/SBN - Acidose tubular renal em pediatria (bjnephrology.org)

[S2] Universidade Federal de Goiás - Rotina em nefrologia pediátrica, distúrbios metabólicos (publica.ciar.ufg.br)

[S3] EAU - Paediatric Urology, urinary stone disease (cn.patients.uroweb.org)

120. Claritromicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções respiratórias por agentes atípicos; otite média; faringoamigdalite estreptocócica com alergia à penicilina	ADMINISTRAR 7,5 mg/kg/dose VO a cada 12 horas, máximo 500 mg/dose. Faringite estreptocócica: 10 dias; outras infecções: duração conforme foco e resposta, tipicamente curso curto de 5-10 dias. [S1] Reservar por suscetibilidade e resistência local; não é primeira escolha indiscriminada para otite.
≥4 semanas; em <6 meses uso especializado	
Micobacterioses não tuberculosas	ADMINISTRAR 7,5-15 mg/kg/dose VO a cada 12 horas, máximo 500 mg/dose, SEMPRE em combinação apropriada. Duração varia por espécie, foco e conversão de culturas; não limitar o tratamento crônico a 10-14 dias. [S1] A faixa alta exige decisão especializada, especialmente com interações e QT.
≥4 semanas - infectologia	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES TFG <30 mL/min/1,73 m²: reduzir dose usual em 50%. Forte inibidor CYP 3A 4: revisar colchicina, ciclosporina e outros substratos; risco de QT longo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)

Infecções respiratórias por bactérias atípicas, otite média, faringoamigdalite em alérgicos à penicilina, tratamento de micobactérias não tuberculosas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - ChAMP, Clarithromycin (pch.health.wa.gov.au)

121. Clindamicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves de pele/partes moles por MRSA sensível ≥4 semanas	ADMINISTRAR EV 15 mg/kg/dose a cada 8 horas, máximo 600 mg/dose; alternativa VO 10 mg/kg/dose a cada 6 horas, máximo 450 mg/dose. Outra diretriz hospitalar usa 15 mg/kg/dose VO a cada 8 horas, máximo 600 mg/dose. Celulite: total 5-10 dias, maior se necrosante/complicada. [S1, S2] Confirmar suscetibilidade, incluindo resistência induzível. Não somar alternativas.
Osteomielite; artrite séptica ≥4 semanas	ADMINISTRAR EV 15 mg/kg/dose a cada 8 horas (máximo 600 mg/dose); após melhora, VO 10 mg/kg/dose a cada 6 horas (máximo 450 mg/dose). Em casos não complicados com boa resposta, tratamento total em torno de 3 semanas; prolongar por foco, agente ou complicações. [S1, S2] Drenar articulação/abscesso quando indicado; clindamicina não cobre Kingella de forma confiável.
Infecções anaeróbias abdominais ou pulmonares ≥4 semanas	ADMINISTRAR EV 10 mg/kg/dose a cada 8 horas, máximo 450 mg/dose; infecção grave, 15 mg/kg/dose a cada 8 horas, máximo 600 mg/dose. VO usual 10 mg/kg/dose a cada 8 horas, máximo 450 mg/dose. Duração até controle da fonte e resolução clínica; abscessos exigem curso individual prolongado. [S1] No abdome, associar cobertura de Gram-negativos. Categoria original ampla não define dias únicos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Diluir EV até ≤18 mg/mL; infundir em 10-60 minutos, sem exceder 30 mg/min nem 20 mg/kg/h. Monitorar diarreia/C. difficile e hepatopatia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)

Infecções graves de pele e partes moles por Gram-positivos (incluindo MRSA), osteomielite, artrite séptica, infecções anaeróbias intra-abdominais e pulmonares.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - ChAMP, Clindamycin (pch.health.wa.gov.au)

[S2] RCH - Antimicrobial guidelines (rch.org.au)

122. Clioquinol + Hidrocortisona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatite com superinfecção bacteriana/fúngica sensível	APLICAR clioquinol + hidrocortisona em camada fina nas áreas afetadas 2-3 vezes ao dia. Tratamento inicial curto; reavaliar dentro de 1 semana e retirar quando controlada a infecção/inflamação. [S1]
>2 anos	A bula não define dias fixos de cura; não usar prolongadamente nem em áreas extensas.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar curativo oclusivo. Risco de absorção de iodo e interferência em exames tireoidianos; evitar olhos. Escolher antimicrobiano específico se resposta insuficiente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)
Dermatites inflamatórias com infecção secundária fúngica ou bacteriana associada (acima de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Hidrocorte - bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

123. Clobazam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Epilepsia refratária - Lennox-Gastaut ≥2 anos na bula internacional; documento original >3 anos	ADMINISTRAR VO: ≤30 kg, 5 mg/dia inicialmente, 10 mg/dia a partir do dia 7 e até 20 mg/dia a partir do dia 14; >30 kg, 10, 20 e até 40 mg/dia, respectivamente. Doses >5 mg/dia divididas a cada 12 horas. Titular no máximo semanalmente e apenas se necessário. Tratamento contínuo. [S1] Tetos: 20 mg/dia (≤30 kg) ou 40 mg/dia (>30 kg); não importar teto adulto de 80 mg/dia.
Epilepsia refratária - síndrome de Dravet Crianças sob neurologia - off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 0,2 mg/kg/DIA; titular gradualmente para 0,3-1 mg/kg/dia, dividido em 2 tomadas. Regime combinado do ensaio Dravet resumido pelo NICE: 0,5 mg/kg/dia junto a valproato e estiripentol. Tratamento contínuo, com avaliação de crises e sedação. [S3, S4] Off-label. Estiripentol e canabidiol podem elevar clobazam/metabólito: reduzir se sedação; não usar teto experimental elevado como meta. Faixa inicial/alvo do guia especializado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sedação/depressão respiratória, DRESS e interações CYP 2C19. Desmame gradual; a bula sugere reduzir 5-10 mg da dose diária por semana, mais lentamente se necessário ou em doses pediátricas pequenas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)

Terapia adjuvante em epilepsias refratárias (síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet) a partir de 3 anos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Lundbeck - Onfi, prescribing information (lundbeck.com)

[S2] Consenso internacional - diagnóstico e manejo de Dravet (onlinelibrary.wiley.com)

[S3] NICE NG 217 - evidência em Dravet, ensaio de Chiron (nice.org.uk)

[S4] Strzelczyk/Schubert-Bast - Practical guide to ASMs in Dravet, tabela 3 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

124. Clobetasol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatoses inflamatórias graves; psoríase localizada resistente >1 ano - corticoide tópico de potência muito alta RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	CLOBETASOL 0,05%: aplicar camada fina 1-2 vezes ao dia; em crianças, limitar o curso, quando possível, a 5 dias e reavaliar semanalmente. Usar a menor quantidade que cubra a lesão. [S1] O teto adulto de 50 g/semana não representa dose segura pediátrica; não usar em dermatite de fraldas ou sob oclusão.
Líquen escleroso anogenital em meninas Crianças/adolescentes - especialista RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	CLOBETASOL 0,05% pomada: aplicar uma vez ao dia por 1 mês; em dias alternados por 1 mês; depois 2 vezes por semana por 1 mês. Total inicial: 3 meses. Manutenção individual apenas se doença ativa. [S2] Regime específico de diretriz difere do curso curto para outras dermatoses; monitorar área/quantidade.
Líquen escleroso genital em meninos Crianças/adolescentes - especialista RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	APLICAR corticoide ultrapotente, como clobetasol 0,05%, uma vez ao dia por 1-3 meses, com emoliente. Sem resposta/fimose persistente: avaliação urológica. [S2] Evitar extrapolar para uretra; doença genital exige acompanhamento.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar atrofia, estrias e supressão adrenal; evitar face, olhos e grandes áreas. Contraindicado em <1 ano na monografia consultada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)

Dermatoses inflamatórias graves de curta duração e resistentes a corticoides mais fracos (psoríase, líquen escleroso).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] eMC - Dermovate Ointment (medicines.org.uk)

[S2] British Association of Dermatologists - Lichen sclerosus 2018 (lichensclerosus.ch)

125. Clomipramina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno obsessivo-compulsivo Crianças/adolescentes; sem dados <5 anos na bula brasileira	INICIAR 25 mg/dia VO; aumentar gradualmente durante 2 semanas até o menor limite entre 3 mg/kg/dia e 100 mg/dia. Nas semanas seguintes, se necessário, até o menor entre 3 mg/kg/dia e 200 mg/dia. Durante titulação, dividir tomadas. Tratamento contínuo com reavaliação. [S1] A bula não autoriza todas as indicações psiquiátricas do adulto em pediatria.
Enurese noturna, após excluir causas orgânicas >5 anos	ADMINISTRAR VO após o jantar: 5-8 anos, 20-30 mg/dia; 9-12 anos, 25-50 mg/dia; >12 anos, 25-75 mg/dia. Usar a menor dose da faixa inicialmente. Se enurese no começo da noite, parte pode ser dada às 16 h. Após resposta, continuar por 1-3 meses e reduzir gradualmente. [S1] Avaliar risco/benefício frente às alternativas; não extrapolar doses acima destas faixas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG e risco de arritmia, convulsões, síndrome serotoninérgica e toxicidade anticolinérgica. Risco elevado na ingestão acidental; retirada gradual.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)
Tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e enurese noturna refratária em crianças acima de 5 anos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Anafranil - clomipramina, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

126. Clonazepam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Epilepsias mioclônicas; ausências atípicas; espasmos infantis como segunda linha Até 10 anos ou ≤30 kg	INICIAR VO 0,01-0,03 mg/kg/DIA, divididos em 2-3 tomadas; dose inicial nunca >0,05 mg/kg/dia. Aumentar a dose diária em 0,25-0,5 mg a cada 3 dias, conforme resposta, até manutenção de 0,1-0,2 mg/kg/dia. Uso contínuo. [S1] Não é primeira linha universal para espasmos infantis; reavaliar eficácia e sedação.
Mesmas indicações epilépticas 10-16 anos	INICIAR 1-1,5 mg/DIA VO divididos em 2-3 tomadas. Incrementos de 0,25-0,5 mg na dose diária a cada 3 dias; manutenção usual 3-6 mg/dia. Após estabilização, a bula admite dose única noturna. [S1] Não somar com o esquema ponderal; individualizar e usar menor dose eficaz.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não interromper abruptamente. Monitorar sedação, secreções, deglutição e ventilação; interação com opioides e outros anticonvulsivantes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 20)
Tratamento de crises epilépticas mioclônicas, ausências atípicas e espasmos infantis (segunda linha).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Geolab - clonazepam, bula profissional (geolab.com.br)

127. Clonidina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial Pediatria - off-label; indicação adulta no original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ADMINISTRAR VO 2,5-5 mcg/kg/dose a cada 12 horas OU 1,67-3,3 mcg/kg/dose a cada 8 horas; titular lentamente até 6,25 mcg/kg/dose a cada 6 horas. Tetos da referência: 900 mcg/dia em crianças, 1.200 mcg/dia em adolescentes. Tratamento contínuo. [S1] Faixas altas exigem equipe especializada.
Tiques/Tourette; TDAH associado a tiques Crianças/adolescentes - off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	INICIAR 25 mcg VO à noite; aumentar a dose diária em 25 mcg a cada 1-2 semanas, dividindo em 2-3 tomadas com maior fração noturna. Doses >200-300 mcg/dia requerem atenção especial à sedação. Reavaliar eficácia em 4-6 semanas e, estável, a cada 6 meses. [S2] Protocolo de titulação lenta para tiques; teto e ritmo diferem dos esquemas específicos de TDAH.
Desmame/abstinência de opioides e sedativos ≥1 mês; UTI pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO ou EV: 1-12 meses, 0,5-2 mcg/kg/dose a cada 6 horas; 1-18 anos, 1-2 mcg/kg/dose a cada 6 horas, máximo 200 mcg/dose. Pode titular até 5 mcg/kg/dose a cada 6 horas, máximo 200 mcg/dose, sob equipe de dor/UTI. [S3] Monitorar WAT-1, PA e FC. EV: diluir em SF 0,9% até ≤30 mcg/mL, infundir em 10-15 minutos. Duração e desmame conforme exposição prévia e abstinência.
TDAH - formulação de liberação prolongada 6-17 anos; formulação específica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 100 mcg ao deitar por 1 semana; aumentar a dose diária em 100 mcg por semana. Esquemas manhã/noite: total 200 mcg/dia = 100/100 mcg; 300 mcg/dia = 100/200 mcg; 400 mcg/dia = 200/200 mcg. Máximo 400 mcg/dia. Tratamento contínuo com revisão de eficácia. [S4] Não substituir mg por mg pela liberação imediata. Desmame em reduções de até 100 mcg a cada 3-7 dias.
TDAH / tiques - alternativa com liberação imediata 6-18 anos; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 25-50 mcg à noite; aumentar 25-50 mcg da dose diária a cada 3 dias conforme resposta, até 300 mcg/dia em 2-3 tomadas. [S3] Alternativa PCH mais rápida que protocolo Nottingham; escolher um protocolo e vigiar PA/FC.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar bradicardia/hipotensão; retirada abrupta causa hipertensão rebote. Desmamar por ≥1 semana; em tiques, reduzir 25 mcg a cada 2-4 dias quando compatível com dose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)

Hipertensão arterial (uso adulto); TDAH, tiques/Tourette, abstinência de opioides e sedativos em UTI pediátrica (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - clonidine, Pediatric Drug Dosing Guidelines (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] NHS Nottinghamshire - clonidine in tic disorders 2025 (nottsapc.nhs.uk)

[S3] Perth Children's Hospital - clonidine, monografia pediátrica (pch.health.wa.gov.au)

[S4] FDA/DailyMed - Kapvay, liberação prolongada (dailymed.nlm.nih.gov)

128. Cloperastina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tosse seca irritativa Crianças até 12 anos; ausência de idade mínima clara na bula consultada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	FENDIZOATO DE CLOPERASTINA: ADMINISTRAR 1,77-3,54 mg/kg/DIA VO, divididos em 3 tomadas; alternativa: dividir a dose diária em 4 partes e dar 1 pela manhã, 1 à tarde e 2 juntas à noite. A bula fixa teto de 212,4 mg/dia do SAL (equivale a 60 mL da concentração 3,54 mg/mL). Curso sintomático curto, com reavaliação se persistente. [S1] Dose expressa no sal, não na base. A dose habitual para ≥40 kg da tabela é 141,6 mg/dia; teto não é alvo. Não indicar a lactentes sem avaliação específica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Pode causar sedação, efeitos anticolinérgicos e mascarar causa da tosse; não usar rotineiramente em tosse produtiva. Conferir sal/concentração e evitar associação sedativa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Tratamento sintomático da tosse seca, irritativa e não produtiva.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] EMS - Clope, bula profissional atualizada 2025 \(onepharma.com.br\)](#)

129. Clopidogrel

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Cardiopatias congênitas/circulação com shunt - antiagregação selecionada 0-24 meses - off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime farmacodinâmico estudado: 0,2 mg/kg/dose VO uma vez ao dia, sem ataque. Duração deve ser definida pela cardiologia segundo dispositivo e risco trombótico; estudo PICOLO avaliou efeito após 7-28 dias, não uma duração universal de tratamento. [S1] A inibição plaquetária demonstrada não prova prevenção de eventos em todas as cardiopatias; não usar como rotina automática.
Stents e outros dispositivos em crianças maiores Crianças/adolescentes - off-label DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Não há esquema pediátrico universal validado por idade/tipo de stent nas fontes primárias abertas. Necessita plano individual da cardiologia e hematologia. [S1] Indicação mantida; não extrapolar dose adulta 75 mg/dia nem carga 300-600 mg.
Prevenção aterotrombótica Indicação adulta do original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não constitui indicação pediátrica habitual; sem esquema pediátrico padronizado. [S1] Preservação documental, sem extrapolação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sangramento, hemograma e interações CYP 2C19; associação com AAS aumenta risco. Dose baixa de lactentes exige manipulação/concentração validada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Prevenção de eventos aterotrombóticos em adultos; antiagregação após cirurgias de cardiopatias congênitas e stents em pediatria (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] PICOLO - ensaio primário de dose pediátrica de clopidogrel (ahajournals.org)

130. Cloreto de Potássio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipocalemia; reposição de perdas gastrointestinais Crianças; neonatos requerem esquema específico	Preferir VO/enteral: 1-2 mEq/kg/dose, máximo 20 mEq/dose; repetir somente após controle do potássio, até 5 mEq/kg/dia e máximo 50 mEq/dia na reposição aguda. Se EV: enfermaria 0,2 mEq/kg/h por 3 h (máximo 10 mEq/h); UTI 0,4 mEq/kg/h por 1-2 h (máximo 20 mEq/h), com ECG. [S1] 1 mEq de K+=1 mmol. Reavaliar antes de novas reposições; a concentração sérica não define sozinha o déficit.
Manutenção de potássio Crianças	VO: 2-5 mEq/kg/DIA em doses divididas, máximo 20 mEq/tomada. EV: 1-4 mEq/kg/DIA, contabilizando todas as fontes e sem exceder 10 mEq/h. Duração enquanto houver necessidade, com eletrólitos e diurese. [S1] Concentração periférica usual ≤40 mEq/L; >60 mEq/L exige acesso central. Não misturar reposição aguda com manutenção sem somar a velocidade total.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES NUNCA administrar KCl concentrado em bolus EV/IO. Usar bomba, bolsa bem homogeneizada e dupla checagem. Confirmar diurese/função renal; corrigir hipomagnesemia. Não lavar linha contendo resíduo de KCl.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)

Prevenção e tratamento da hipocalemia, perdas gastrointestinais e composição da fluidoterapia de manutenção.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] RCH - Hypokalaemia (rch.org.au)

131. Cloreto de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Expansão volêmica/resuscitação 1 mês-18 anos	SF 0,9%: ADMINISTRAR 10-20 mL/kg EV rapidamente, reavaliando perfusão e sobrecarga após cada alíquota. Novas alíquotas apenas se necessárias; envolver especialista a partir de 20 mL/kg e considerar vasoativo ao atingir 40 mL/kg. [S1] Individualizar em cardiopatia, desnutrição grave, disfunção renal e outros choques; não é volume automático acumulativo.
Hidratação de manutenção 1 mês-18 anos	Solução EV contendo NaCl 0,9% e glicose 5%: taxa inicial de referência 4 mL/kg/h nos primeiros 10 kg +2 mL/kg/h nos 10 kg seguintes +1 mL/kg/h acima 20 kg; teto usual 100 mL/h. A maioria das crianças doentes precisa de cerca de 2/3 desta taxa. Reavaliar diariamente e suspender quando via enteral suficiente. [S1] Adicionar potássio somente após avaliação renal/eletrolitos.
Hiponatremia grave com convulsão Crianças - emergência RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	NICE: NaCl 2,7%, 2 mL/kg EV (máximo 100 mL) em 10-15 minutos. Se sintomas persistirem, repetir uma vez em 10-15 minutos; antes de terceira dose, medir sódio e discutir com UTI. Medir sódio pelo menos a cada hora. [S4, S3] É solução de 2,7%, não 3% com o mesmo volume por suposição. Após resgate, planejar correção conservadora; RCH limita elevação a 8 mmol/L/24 h na criança sem convulsão. Não buscar normalização imediata.
Higiene/desobstrução nasal -0,9-3% Pediatria; limite varia por produto	NaCl nasal 0,9%: aplicar em cada narina conforme necessidade; em bebês, jato breve para não interferir na respiração. NaCl nasal 3% (Rinosoro SIC): 3-12 anos, 2 nebulizações/instalações nasais 3 vezes ao dia, até resolução dos sintomas. [S5, S6] A frequência do spray 0,9% é conforme necessidade; não existe dose universal em mL para todos os dispositivos. A formulação 3% citada é para ≥3 anos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar peso, balanço, sódio, cloro e glicemia. NaCl 3% contém cerca de 0,513 mEq/mL; SF 0,9%, 0,154 mEq/mL. Soluções nasais não são estéreis para injeção.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)

Ressuscitação volêmica, fluidoterapia de manutenção, higiene nasal (0,9% a 3%); correção de hiponatremia grave (solução hipertônica).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] RCH - Intravenous fluids,2026 (rch.org.au)

[S2] SORT NHS - Hypertonic saline,2024 (sort.nhs.uk)

[S3] RCH - Hyponatraemia (rch.org.au)

[S4] NICE NG 29 - fluidoterapia e hiponatremia pediátrica (nice.org.uk)

[S5] Farmasa - Rinosoro SIC 3%, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S6] Farmasa - Rinosoro Jet 0,9%, bula (bulas.med.br)

132. Cloroquina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Malária por P.vivax, P.malariae ou P.ovale sensíveis Pediatría - dose em cloroquina BASE	ADMINISTRAR VO 10 mg de base/kg no dia 1; 7,5 mg de base/kg no dia 2; 7,5 mg de base/kg no dia 3. Total 25 mg de base/kg em 3 dias. Não ultrapassar esquema adulto: 600 mg no dia 1 e 450 mg nos dias 2 e 3. [S1] Para vivax/ovale, a cura radical exige tratamento dos hipnozoítos compatível com idade e avaliação G6PD; cloroquina sozinha não evita recaída. Malária grave requer outro esquema.
Lúpus eritematoso sistêmico; artrite reumatoide Crianças; reumatologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Administrar 2,5 mg/kg de CLOROQUINA BASE VO a cada 24 horas, máximo 150 mg de base/dose. Tratamento contínuo conforme resposta, com avaliação oftalmológica e revisão periódica. [S3] Dose de cloroquina, não hidroxicloroquina. Conferir equivalência do sal e ajustar ao risco retiniano.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de cardiotoxicidade, hipoglicemia e retinopatia. Confirmar equivalência do sal: comprimido de difosfato 250 mg pode corresponder a 150 mg base. Superdose é particularmente tóxica em crianças.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Tratamento da malária por espécies sensíveis (*P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*); lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Ministério da Saúde - Guia de tratamento da malária (gov.br)
[S2] Ministério da Saúde - PCDT LES 2013, documento histórico (bvsms.saude.gov.br)
[S3] AEP - Cloroquina, Pediamécum (aeped.es)

133. Clorpromazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Agitação importante; náuseas/vômitos refratários 6 meses-12 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ADMINISTRAR 0,55 mg/kg/dose VO a cada 4-6 h conforme necessidade. Reavaliar antes de repetir e usar pelo menor período possível. [S1] Conversão da bula 0,25 mg/libra. A fonte oral não define teto pediátrico uniforme; doses psiquiátricas elevadas do texto não constituem teto de emergência.
Solução intratável Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Sem posologia pediátrica estabelecida na bula aberta; não transpor 25-50 mg por tomada do adulto. [S1] A própria bula contraindica extrapolar para condições sem dose pediátrica definida.
Coreia de Sydenham Pediatria - indicação off-label do original DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Não identificado esquema pediátrico atual suficientemente respaldado para clorpromazina nesta pesquisa; manter avaliação neurológica/reumatológica. [S1] Não substituir o nome por haloperidol nem copiar sua dose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar pressão, ECG/QT, distonia, sedação e síndrome neuroléptica maligna. Não usar para mascarar vômitos por doença neurológica/obstrução; maior sensibilidade em lactentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Agitação psicomotora grave, soluços intratáveis, náuseas e vômitos refratários; coreia de Sydenham (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - clorpromazina oral (dailymed.nlm.nih.gov)

134. Clotrimazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatofitoses Crianças - uso tópico	CLOTRIMAZOL 1%: aplicar camada fina 2-3 vezes ao dia por 3-4 semanas; continuar cerca de 2 semanas após desaparecimento dos sintomas quando necessário à cura completa. [S1] Reavaliar se sem melhora em 4 semanas.
Pitíriase versicolor Crianças - uso tópico	CLOTRIMAZOL 1%: aplicar camada fina 2-3 vezes ao dia por 1-3 semanas; ajustar à resposta. [S1] Pigmentação residual pode persistir sem infecção ativa.
Candidíase de fraldas Lactentes/crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	CLOTRIMAZOL 1%: aplicar camada fina 2-3 vezes ao dia na pele afetada. A bula aberta não individualiza a duração de candidíase de fraldas; reavaliar precocemente e manter até resolução. [S1] A duração de 1-2 semanas citada para candidíase genital não foi automaticamente aplicada à dermatite de fraldas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso externo, evitar mucosas/olhos e associação indiscriminada com corticoide potente. Trocar fraldas e reduzir umidade; rever diagnóstico se resistente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Tratamento tópico de dermatite de fraldas complicada por Candida, dermatofitoses superficiais e pitíriase versicolor.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Vitamedic - clotrimazol, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

135. Codeína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor moderada a intensa Adolescentes ≥12 anos - uso restrito RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	CODEÍNA solução oral: 0,5-1 mg/kg/dose VO a cada 4-6 h, reduzindo a dose calculada/omitindo tomadas para NÃO ultrapassar 60 mg no total de 24 h, teto pediátrico da bula brasileira consultada. Dor aguda: menor período possível, com reavaliação e retirada à melhora; bula descreve até cerca de 4 dias. [S1] Não usar <12 anos, após tonsilectomia/adenoidectomia em <18 anos, em metabolizador CYP 2D6 ultrarrápido ou com depressão respiratória. O teto 60 mg/DIA não é 60 mg/dose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Metabolismo imprevisível em morfina; monitorar ventilação e sedação. Evitar benzodiazepínicos e outros depressores. A apresentação comprimido desta bula não é indicada em pediatria.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 21)
Dor moderada a intensa em adolescentes elegíveis acima de 12 anos (contraindicada para analgesia pós-tonsilectomia em menores de 18 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Cristália - Codein, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

136. Colagenase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Desbridamento de feridas, úlceras de pressão e tecidos desvitalizados	COLAGENASE pomada: aplicar uniformemente camada de cerca de 2 mm sobre toda a área necrótica uma vez ao dia, com troca diária do curativo; em alguns casos, a cada 12 h. Finalizar quando removida a necrose e estabelecido tecido de granulação. Sem melhora em 14 dias, suspender e rever conduta. [S1]
Adultos/crianças conforme avaliação da ferida	A quantidade depende da área, não do peso; manter umidade adequada e proteger bordas. Procedimento de desbridamento deve ser feito por profissional.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar detergentes, metais pesados e antissépticos incompatíveis que inativam a enzima. Não aplicar em olhos/mucosas; cautela na umidificação de gangrena seca.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Desbridamento enzimático de feridas, úlceras de pressão e tecidos desvitalizados cutâneos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cristália - Kollagenase (cristalia.com.br)

137. Colchicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Febre familiar do Mediterrâneo ≥4 anos	COLCHICINA VO total diário: 4-<6 anos, 0,3-1,8 mg; 6-12 anos, 0,9-1,8 mg; >12 anos, 1,2-2,4 mg. Administrar uma vez ao dia ou dividido a cada 12 h; titular em passos de 0,3 mg/dia por resposta/tolerância. Tratamento contínuo, usualmente prolongado. [S1] Faixas de bula norte-americana para comprimidos 0,6 mg; outras concentrações exigem ajuste preciso. Não aplicar teto 2,4 mg aos menores.
Pericardite aguda ou recorrente Crianças - off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Referência ESC pediátrica: ≤5 anos, 0,5 mg VO uma vez ao dia; >5 anos, 1-1,5 mg/DIA divididos em 2-3 tomadas. Sem dose de ataque. Em associação ao anti-inflamatório: 3 meses após primeiro episódio; ≥6 meses nas recorrências, individualizando. [S2] Fonte 2015; evidência pediátrica limitada. Reduzir por intolerância, função renal/hepática e interações; não usar faixa máxima automaticamente.
Gota Indicação adulta no original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Sem esquema pediátrico estabelecido para crise ou profilaxia da gota; não transpor regime adulto. [S1] Condição rara em crianças exige investigação etiológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Margem terapêutica estreita. Claritromicina, azóis, ciclosporina e inibidores P-gp/CYP 3A 4 podem causar toxicidade fatal; associação é contraindicada na insuficiência renal/hepática. Monitorar hemograma, fígado, rim e miopatia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)

Tratamento e profilaxia da febre familiar do Mediterrâneo e crises de gota (uso adulto); pericardite aguda e recorrente em pediatria (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - colchicine tablets (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] ESC 2015 - Web addenda, tabelas pediátricas de pericardite (sks.sk)

138. Colecalciferol (Vitamina D3)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção de deficiência; manutenção da homeostase mineral Nascimento-12 meses; >12 meses	COLECALCIFEROL VO: 400 UI uma vez ao dia no primeiro ano; 600 UI uma vez ao dia após 12 meses, considerando dieta e fatores de risco. Manutenção contínua durante período de necessidade. [S1] 1 mcg=40 UI; a concentração por gota varia muito.
Deficiência de vitamina D - reposição 0-18 anos, deficiência confirmada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Alternativa descrita pela SBP/Endocrine Society: 2.000 UI VO diariamente por 6 semanas OU 50.000 UI VO uma vez por semana por 6 semanas, com controle laboratorial e posterior manutenção. Em lactentes, priorizar esquema diário; dose semanal alta exige supervisão especializada. [S1] As alternativas NÃO se somam. Pós-reposição: 400-1.000 UI/dia <1 ano; 600-1.000 UI/dia ≥1 ano. Dose acima da prevenção tem duração delimitada.
Raquitismo nutricional Crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquema do consenso global citado pela SBP: ≤12 meses, 2.000 UI VO/dia; 1-12 anos, 3.000-6.000 UI/dia; >12 anos, 6.000 UI/dia; por 12 semanas, associado a aporte adequado de cálcio. Depois manutenção 400 UI/dia no primeiro ano ou 600 UI/dia após. [S1] Alternativa AAP citada: neonato 1.000 UI/dia; 1-12 meses 1.000-5.000 UI/dia; >12 meses 5.000 UI/dia, por 8-12 semanas. Escolher um protocolo, sem combinar faixas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dosar 25-OH-D, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e PTH quando indicado; vigiar hipercalcemia/hipercalciúria. Não usar megadoses crônicas ou confundir deficiência nutricional com raquitismo genético.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina D, raquitismo carencial e suporte à homeostase mineral óssea.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SBP - Hipovitaminose D, atualização 2024 (sbp.com.br)

139. Colestiramina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prurido colestático Crianças	COLESTIRAMINA: ADMINISTRAR 60 mg/kg/dose VO uma ou duas vezes ao dia. Iniciar uma vez ao dia e aumentar em intervalos de 5-7 dias conforme resposta/tolerância. Duração conforme colestase/prurido; reavaliar continuamente. [S1] Dose de resina, não peso total do sachê; não usar em obstrução biliar completa.
Diarreia por má absorção de ácidos biliares Crianças - individualizar, especialmente recém-nascidos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Dose inicial descrita em bula: 2-8 g/DIA de resina VO divididos em 3 tomadas, utilizando o extremo inferior nos menores e ajustando à resposta. Deve haver benefício em 3 dias; sem resposta, procurar alternativa. [S1] Faixa ampla não é prescrição automática por idade/peso; cautela em neonatos e risco de obstrução.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Nunca ingerir pó seco; dispersar em líquido. Dar outros medicamentos ≥1 h antes ou 4-6 h depois. Monitorar constipação, vitaminas lipossolúveis e acidose hiperclorêmica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Prurido associado a colestase crônica, diarreia por má absorção de ácidos biliares.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Questran Light - bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

140. Colistimetato de Sódio (Colistina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-negativos multirresistentes ≥4 semanas RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	COLISTIMETATO EV, dose expressa em COLISTINA BASE: 2,5-5 mg/kg/DIA divididos a cada 8 h; máximo 450 mg de base/dia. Usar peso ideal. Duração pelo foco, suscetibilidade e controle da infecção. [S1] Neonatos: uso excepcional; foram usados 2,5-5 mg de base/kg/dia divididos a cada 6-12 h, sob infectologia.
Fibrose cística - tratamento sistêmico ≥4 semanas RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Dose EV de até 8 mg de COLISTINA BASE/kg/DIA dividida a cada 8 h, máximo 450 mg/dia, foi descrita, com maior toxicidade; reservar à infectologia e monitorização intensiva. Duração segundo resposta pulmonar. [S1] Não é faixa rotineira segura para qualquer criança.
Fibrose cística - Pseudomonas, via inalatória ≥4 semanas	<2 anos: 500.000-1.000.000 UI inaladas a cada 12 h; recorrência pode requerer a cada 8 h. ≥2 anos: 1-2 milhões UI a cada 12 h por 3 semanas; refratário: 2 milhões UI a cada 8 h por até 3 meses. Colonização crônica: 1-2 milhões UI a cada 12 h de forma contínua. [S1] Usar preparação adequada à nebulização; não trocar UI por mg de sal/base sem equivalência específica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Neurotoxicidade e nefrotoxicidade; ajustar à função renal e suspender por toxicidade renal relevante. Não interpretar mg de colistimetato como mg de colistina base. Monitorar broncoespasmo na inalação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (p. 22; terminologia corrigida)
Infecções graves por bacilos Gram-negativos multirresistentes (Acinetobacter, Pseudomonas e Enterobacterales produtores de KPC, quando suscetíveis); terapia inalatória em fibrose cística. KPC designa uma carbapenemase.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] Perth Children’s Hospital - Colistimethate monograph \(pch.health.wa.gov.au\)](#)

[\[S2\] Ministério da Saúde - Boletim Epidemiológico 55\(2\), 2024: carbapenemase KPC](#)

141. Complexo Protrombínico Concentrado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão urgente de antagonista da vitamina K com hemorragia	Complexo protrombínico de 4 fatores EV, dose expressa em UI de fator IX: INR de 2 a 3,9 → 25 UI/kg; INR de 4 a 6 → 35 UI/kg; INR >6 → 50 UI/kg. Máximos respectivos: 2.500, 3.500 e 5.000 UI. Dose inicial única, associada à vitamina K; medir INR após administração. [S1]
Crianças - off-label, hematologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquema pediátrico institucional; a bula brasileira informa ausência de dados pediátricos. Repetição exige hematologista, não é automática.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Bula Beriplex: infundir ≤3 UI/kg/min e ≤210 UI/min. Risco trombótico/CIVD; contém heparina, verificar HIT. Confirmar produto 4 fatores e potência de FIX.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Reversão rápida de deficiência de fatores da coagulação dependentes de vitamina K (anticoagulantes cumarínicos) em hemorragias graves.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NHS GGC - Antithrombotic therapy, paediatrics (clinicalguidelines.scot.nhs.uk)
[S2] CSLBehring - Beriplex, bula 2025 (labeling.cslbehring.com)

142. Concentrado de Fibrinogênio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Afibrinogenemia/hipofibrinogenemia congênita - RiaSTAP Crianças/adolescentes	Dose EV(mg/kg)=[fibrinogênio alvo–medido, ambos em mg/dL]÷ 1,7. Se nível desconhecido, 70 mg/kg. Manter fibrinogênio ≥100 mg/dL até hemostasia. Repetir conforme níveis/resposta, sem intervalo fixo. Infusão ≤5 mL/min. [S1] Fórmula específica do produto; considerar recuperação individual.
Deficiência congênita - Fibryga <12 anos; ≥12 anos	Dose EV(mg/kg)=[alvo–medido em mg/dL]÷ 1,4 se <12 anos; ÷ 1,8 se ≥12 anos. Alvo 100 mg/dL em sangramento menor ou 150 mg/dL em maior. Se nível desconhecido, 70 mg/kg. Infusão ≤5 mL/min; repetição conforme hemostasia/níveis. [S2] Regulador internacional; não prova indicação de produto no Brasil.
Hipofibrinogenemia adquirida com hemorragia <12 anos; ≥12 anos - Fibryga	ADMINISTRAR EV 70 mg/kg se <12 anos ou 50 mg/kg se ≥12 anos. Repetir conforme hemorragia e fibrinogênio ≤200 mg/dL ou FIBTEM A10 ≤10 mm. Infusão ≤20 mL/min, ajustada à tolerância. Duração até hemostasia e recuperação laboratorial. [S2] Não extrapolar este esquema automaticamente a outro concentrado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar fibrinogênio funcional/viscoelasticidade e trombose; não tratar disfibrinogenemia com estas indicações. Conferir conteúdo real do frasco e não confundir mg/dL com g/L.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Reposição em afibrinogenemia congênita ou hipofibrinogenemia adquirida grave com sangramento ativo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CSLBehring - RiaSTAP, prescribing information (labeling.cslbehring.com)

[S2] Octapharma - Fibryga, prescribing information 2025 (fibrygausa.com)

143. Crioprecipitado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipofibrinogenemia com hemorragia ou procedimento Todas as idades pediátricas	CRIOPRECIPITADO: TRANSFUNDIR 5-10 mL/kg EV; velocidade usual 10-20 mL/kg/h, modificada conforme sangramento e tolerância. Reavaliar fibrinogênio e clínica após a dose; repetir somente se persistir indicação. [S1] Usar volume e conteúdo do hemocomponente local; número de bolsas não é constante.
Deficiência de fator XIII; doença de von Willebrand sem concentrado específico disponível Crianças - resgate excepcional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há dose pediátrica universal de crioprecipitado que assegure atividade-alvo de FXIII ou vWF, pela variabilidade do produto. Hematologia deve calcular pela atividade necessária/disponível e monitorar resposta. [S1] Indicações históricas preservadas; concentrados específicos são preferidos. Não transpor automaticamente a dose de reposição de fibrinogênio.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Avaliar compatibilidade, identificação e reações transfusionais. Crioprecipitado não é tratamento de escolha para corrigir INR isolado ou hemofilia quando concentrados específicos disponíveis.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)

Hemorragias por deficiência de fibrinogênio, fator XIII e doença de von Willebrand quando concentrados específicos não estão disponíveis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] RCH - Blood product prescription (rch.org.au)

[S2] Ministério da Saúde - Guia para uso de hemocomponentes (bvsms.saude.gov.br)

144. Cromoglicato Dissódico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Conjuntivite alérgica; ceratoconjuntivite vernal	CROMOGLICATO DISSÓDICO colírio 2%: INSTILAR 1-2 gotas em cada olho afetado 4 vezes ao dia. Duração enquanto houver atividade alérgica/exposição, com reavaliação oftalmológica. [S1]
Crianças	Não transferir volume de gotas de 2% para 4% sem prescrição; efeito preventivo requer regularidade.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar contaminação do frasco. Conservante pode irritar córnea; retirar lentes e seguir intervalo do produto. Dor, fotofobia ou baixa visual exigem exame.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 22)
Tratamento e profilaxia da conjuntivite alérgica e ceratoconjuntivite vernal.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] eMC - Sodium cromoglicate 2% eye drops (medicines.org.uk)

145. Dantroleno Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertermia maligna - crise Todas as idades	Administrar dantroleno 2,5 mg/kg EV rapidamente. Repetir conforme hipercapnia, rigidez e taquicardia; MHAUS orienta nova dose se ausência de resposta em 10-15 minutos, ou mais cedo se instável/crise acelerando. Doses totais >10 mg/kg podem ser necessárias; sem resposta, reconsiderar diagnóstico. [S1, S4] Dantrium/Revonto: 20 mg + 60 mL de água para injeção sem conservante. Ryanodex: 250 mg + 5 mL de água para injeção. Preparações distintas; não substituir diluente por SF.
Hipertermia maligna - prevenção de recrudescência Todas as idades após controlar crise	ADMINISTRAR 1 mg/kg EV a cada 4-6 h por pelo menos 24 h. Interromper/alongar intervalo apenas com estabilidade metabólica 24 h, temperatura <38°C, CK em queda, ausência de mioglobínúria e rigidez. [S2] Monitorar em UTI.
Síndrome neuroléptica maligna Pediatria - off-label, evidência limitada DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Dantroleno é opção especializada, porém a fonte de emergência aberta não oferece validação pediátrica específica independente. Não converter o esquema de hipertermia maligna em prescrição automática para esta síndrome. [S3] Suspender agente desencadeante e suporte intensivo são essenciais; posologia individual pela toxicologia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Pode causar fraqueza/comprometimento ventilatório e hepatotoxicidade. Evitar associação com verapamil/diltiazem na crise. Doses em mg/kg, não mcg/kg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)

Tratamento de resgate da hipertermia maligna anestésica; síndrome neuroléptica maligna grave (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MHAUS - Dosing and reconstituting dantrolene (mhaus.org)

[S2] MHAUS - Dantrolene after an MH event (mhaus.org)

[S3] EmergencyCareBC - Neuroleptic malignant syndrome (emergencycarebc.ca)

[S4] MHAUS - tratamento da crise de hipertermia maligna (mhaus.org)

146. Daptomicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecção complicada de pele/partes moles por Gram-positivos 1-17 anos, função renal normal	DAPTOMICINA EV uma vez ao dia: 1-<2 anos, 10 mg/kg; 2-6 anos, 9 mg/kg; 7-11 anos, 7 mg/kg; 12-17 anos, 5 mg/kg. Infundir em 60 min aos 1-6 anos ou 30 min aos 7-17 anos. Duração: até 14 dias conforme resposta. [S1]
Bacteremia por Staphylococcus aureus 1-17 anos, função renal normal	DAPTOMICINA EV uma vez ao dia: 1-6 anos, 12 mg/kg; 7-11 anos, 9 mg/kg; 12-17 anos, 7 mg/kg. Infundir em 60 min aos 1-6 anos ou 30 min aos 7-17 anos. Duração conforme foco/complicações, até 42 dias no esquema estudado. [S1] Investigar endocardite/focos e controlar fonte; não é tratamento de pneumonia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar <1 ano; monitorar CK pelo menos semanalmente, rim e sintomas musculares/pneumonite eosinofílica. Ajuste pediátrico na insuficiência renal não estabelecido. Para Cubicin, diluição emSF 0,9%, nãoSG 5%.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Infecções complicadas de pele e partes moles por Gram-positivos e bacteremia por *S. aureus* (aprovado a partir de 1 ano de idade).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Cubicin, daptomycin (dailymed.nlm.nih.gov)

147. Deferasirox

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sobrecarga crônica de ferro transfusional ≥2 anos - comprimido revestido/grânulos Jadenu	INICIAR 14 mg/kg/dose VO uma vez ao dia; ajustar a cada 3-6 meses em passos de 3,5-7 mg/kg/dia por ferritina/carga de ferro. Faixa até 28 mg/kg/dia; não exceder. Ferritina <1.000 ng/mL em 2 visitas: considerar redução; <500 ng/mL: interromper e monitorar mensalmente. [S1]
Mesma indicação - formulação dispersível Exjade ≥2 anos	A equivalência da bula é: 20 mg/kg/dia dispersível≈14 mg/kg/dia revestido; incrementos 5-10 mg/kg/dia e máximo 40 mg/kg/dia da dispersível correspondem a 3,5-7 e 28 mg/kg/dia da revestida. ADMINISTRAR uma vez ao dia. [S1] As formulações não são intercambiáveis mg por mg. Duração contínua enquanto houver sobrecarga, com pausas por toxicidade.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES TFG 40-60: reduzir início 50%; TFG <40: contraindicado. Pausar em desidratação aguda. Monitorar rim/função tubular, fígado, hemograma, audição/visão e risco de sangramentoGI.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Tratamento da sobrecarga crônica de ferro secundária a transfusões sanguíneas repetidas em talassemia e outras anemias (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Jadenu, deferasirox (dailymed.nlm.nih.gov)

148. Deferoxamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intoxicação aguda por ferro Crianças - toxicologia	DESFERROXAMINA: INFUNDIR EV até 15 mg/kg/h, reduzindo assim que possível. Teto usual 80 mg/kg ou 6 g em 24 h, o menor. Em geral 6-12 h; evitar >24 h pelo risco pulmonar. Interromper conforme recuperação clínica/metabólica e orientação toxicológica. [S1] Doses/velocidades superiores são resgate excepcional e não faixa pediátrica rotineira.
Sobrecarga crônica de ferro Crianças	ADMINISTRAR 20-40 mg/kg/DIA por infusão SC/EV lenta em 8-12 h, 5-7 dias/semana, ajustando à carga de ferro. Em criança em crescimento, evitar dose média diária >40 mg/kg. Tratamento prolongado enquanto persistir sobrecarga. [S2] A via/quantidade semanal devem ser individualizadas; não usar o regime de intoxicação aguda para quelar cronicamente.
Sobrecarga de alumínio Crianças com doença renal/dialítica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A monografia canadense declara experiência pediátrica muito limitada. Requer esquema nefrológico individual e confirmação de sobrecarga; não transpor doses de diagnóstico ou de tratamento adulto para criança. [S2] Indicação preservada; ausência de esquema pediátrico padronizado nesta fonte.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hipotensão se rápida, toxicidade ocular/auditiva, crescimento, infecção por *Yersinia/mucor* e lesão pulmonar. Monitorar rim, ferritina e crescimento; avaliar remoção dialítica do quelato se insuficiência renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Tratamento da intoxicação aguda grave por ferro e sobrecarga crônica de ferro ou alumínio.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] OntarioPoisonCentre - Deferoxamine,2024 (ontariopoisoncentre.ca)
[S2] NovartisCanadá - Desferal, monografia (novartis.com)

149. Deflazacorte

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doenças inflamatórias, autoimunes e alérgicas Crianças	DEFLAZACORTE: faixa de bula 0,22-1,65 mg/kg/DIA VO, diária ou em dias alternados, individualizada por doença e gravidade. Manter até resposta, depois reduzir até menor dose eficaz e desmamar. [S1] A categoria original não identifica doenças específicas; não há número universal de dias nem dose única para todas. Regime alternado só quando adequado à doença.
Distrofia muscular de Duchenne ≥2 anos - aprovação norte-americana RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ADMINISTRAR 0,9 mg/kg/dose VO uma vez ao dia. Tratamento contínuo, com reavaliação funcional e de toxicidade; não interromper abruptamente. [S2] Registro internacional não demonstra aprovação brasileira para esta indicação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar crescimento, osso, glicemia, PA, catarata, infecções e eixo adrenal. Inibidores CYP 3A 4 fortes/moderados: a bula Emflaza recomenda 1/3da dose; evitar indutores.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Doenças inflamatórias, autoimunes e alérgicas com indicação de corticoterapia sistêmica; distrofia muscular de Duchenne (off-label por indicação).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Libbs - Deflanil, bula profissional (libbs.com.br)

[S2] Emflaza - prescribing information (hcp.emflaza.com)

150. Deltametrina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pediculose do couro cabeludo Crianças - formulação xampu	DELTAMETRINA xampu 0,02%: aplicar em cabelos/couro cabeludo, friccionar suavemente, deixar 5 minutos e enxaguar. A bula Deltametril orienta 1 aplicação/dia por 4 dias consecutivos. [S1] Regime específico desta bula; não aplicar loção corporal no couro cabeludo. Verificar resistência e remoção mecânica de lêndeas.
Ftíriase/pediculose pubiana Pediatria - avaliação especializada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	DELTAMETRINA loção 0,02%: friccionar área corporal afetada, deixar até banho seguinte, por 4 dias; reaplicar após 7 dias segundo bula Deltalab. [S2] Evitar genitais mucosos, olhos e lesões; em criança, avaliar contexto clínico da infestação. A bula não fixa idade mínima pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso externo; não ingerir nem usar em pele lesionada. O produto antigo contém orientações ultrapassadas para intoxicação que NÃO foram reproduzidas. Suspender por irritação/alergia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)

Tratamento tópico da pediculose do couro cabeludo e ftíriase.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Medquímica - Deltametril,xampu (img.drogasil.com.br)

[S2] Multilab - Deltalab,loção (multilab.com.br)

151. Desloratadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica perene; urticária crônica idiopática ≥6 meses	DESLORATADINA VO uma vez ao dia: 6-11 meses, 1 mg; 1-5 anos, 1,25 mg; 6-11 anos, 2,5 mg; ≥12 anos, 5 mg. Estas são as doses máximas diárias usuais das faixas. Duração conforme sintomas/exposição. [S1]
Rinite alérgica sazonal ≥2 anos na bula norte-americana	ADMINISTRAR VO uma vez ao dia: 2-5 anos, 1,25 mg; 6-11 anos, 2,5 mg; ≥12 anos, 5 mg, enquanto houver sintomas/exposição. [S1] Não extrapolar aprovação de rinite perene aos menores de 2 anos para rinite sazonal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não há recomendação pediátrica validada de ajuste renal/hepático na bula. Não associar loratadina ou duplicar anti-histamínicos; vigiar reações de hipersensibilidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica (xarope a partir de 6 meses; comprimidos acima de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - desloratadine oral solution (dailymed.nlm.nih.gov)

152. Desmopressina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diabetes insípido central Crianças; endocrinologia	VO: 1-23 meses, iniciar 10 mcg por dose 2-3 vezes/dia, usual 30-150 mcg/DIA. 2-11 anos, iniciar 50 mcg por dose 2-3 vezes/dia, usual 100-800 mcg/DIA. 12-17 anos, iniciar 100 mcg por dose 2-3 vezes/dia, usual 0,2-1,2 mg/DIA. Titular à diurese e natremia; contínuo. [S4] Formulação/manipulação deve permitir a dose exata. Doses do BNF distinguem lactentes de crianças maiores.
Enurese noturna primária A partir de 5 anos	VO: 0,2 mg ao deitar; se necessário, aumentar para 0,4 mg à noite. Tratar por até 3 meses e suspender por pelo menos 1 semana para reavaliar necessidade. Sem resposta em 4 semanas com ajuste adequado: interromper. [S1] Restringir líquidos desde 1 hora antes até 8 horas após a dose; não utilizar via nasal para enurese.
Hemorragias leves na hemofilia A e doença de von Willebrand tipo 1 responsiva Resposta ao teste documentada; idade conforme ressalva ao lado	Administrar 0,3 mcg/kg de peso real, máximo 20 mcg, EV. Diluir em SF 0,9%: 10 mL se ≤10 kg; 50 mL se >10 kg. Infundir em 15-30 min; para procedimento, administrar 30 min antes. Em von Willebrand: repetir somente se necessário, intervalo ≥24 h, até 3 dias consecutivos (MASAC), com FVIII/VWF e hematologia. [S2, S5] Divergência: FDA admite hemostasia desde 3 meses e primeira repetição em 8-12 h; MASAC orienta não usar em von Willebrand <2 anos, pelo risco de hiponatremia/convulsões. Controlar sódio e líquidos por 24 h, evitar sobrecarga, tipo 2B e taquifilaxia. Essa restrição hemostática não é contraindicação global ao uso em diabetes insípido.
Diabetes insípido central - liofilizado sublingual 2-17 anos; endocrinologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Iniciar 60 mcg sublinguais a cada 8 horas; manutenção 60-120 mcg a cada 8 horas, conforme diurese e natremia. Uso contínuo. [S3, S4] Faixa inicial/manutenção AEP; BNF restringe seu esquema sublingual pediátrico a ≥2 anos.
Diabetes insípido central - nasal ≥3 meses; solução que permita a dose RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	3 meses-12 anos: 5-10 mcg/DIA, máximo 20 mcg/dia, em 1-2 aplicações. >12 anos: 10-20 mcg/DIA, máximo 40 mcg/dia, em 1-2 aplicações. Ajustar manhã e noite separadamente. [S3] Não usar spray de 10 mcg para administrar 5 mcg por estimativa; conferir dispositivo.
Diabetes insípido central - parenteral ≥12 anos; menores: uso não estabelecido na bula RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A partir de 12 anos: iniciar 2-4 mcg/DIA EV ou SC, em 1-2 doses; ajustar cada dose à diurese e natremia. A faixa citada é o total diário inicial, não 4 mcg duas vezes/dia. Não diluir para esta indicação, conforme bula Ferring. Uso contínuo conforme necessidade. [S2, S3] De 12 meses a <12 anos, AEP descreve 0,1-1 mcg/DIA em 1-2 doses como orientação não padronizada; bula atual não estabelece uso nessa idade. Não converter diretamente entre vias. Divergência AEP/bula na dose parenteral de adolescentes: adotado total diário da bula atual.
Enurese primária - alternativa sublingual >5 anos	120 mcg sublinguais ao deitar; aumentar, se necessário, até 240 mcg. Reavaliar após 3 meses com pausa ≥1 semana. [S3] Mesma restrição de líquidos da formulação oral.
Hemofilia A / von Willebrand responsiva - alternativa nasal concentrada >12 anos; hematologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Solução hemostática 1,5 mg/mL: <50 kg, 150 mcg intranasais; ≥50 kg, 300 mcg (150 mcg/narina), 30 min antes do procedimento (AEP). Em von Willebrand: repetição apenas se necessária, intervalo ≥24 h e até 3 dias consecutivos (MASAC); controlar líquidos/sódio. AEP descreve 12 h: decisão hematológica específica. [S3, S5] Não é o spray de 10 mcg para diabetes insípido; monitorar sódio e atividade hemostática.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de intoxicação hídrica e hiponatremia; controlar sódio e água livre. Contraindicada se depuração <50 mL/min. A bula parenteral também contraindica uso concomitante com diuréticos de alça ou glicocorticoides sistêmicos/inalados. Lactentes exigem endocrinologia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Tratamento do diabetes insípido central; enurese noturna primária (a partir de 5 anos); controle de hemorragias leves na hemofilia A e von Willebrand.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ferring - DDAVP comprimidos, bula profissional brasileira (cr-net-public-prod.s3.amazonaws.com)

[S2] Ferring/DailyMed - DDAVP Injection, bula revisada em 2022 (dailymed.nlm.nih.gov)

[S3] AEP - Desmopresina, Pediamécum (aeped.es)

[S4] BNF/NICE - Desmopressin, doses por faixa etária (bnf.nice.org.uk)

[S5] NBDF/MASAC 266 - Von Willebrand: desmopressina, idade, repetição e líquidos

153. Desonida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatoses inflamatórias leves a moderadas; eczema infantil; dermatite de contato	Desonida 0,05%: aplicar camada fina na área afetada uma vez ao dia. Suspende quando houver controle; reduzir frequência conforme resposta. A bula não estabelece um número universal de dias. [S1]
Crianças - uso cutâneo	Em crianças, a bula brasileira consultada recomenda uma aplicação diária. Cursos repetidos ou extensos exigem reavaliação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar olhos e aplicação prolongada, extensa ou sob fralda/oclusão sem orientação. Não usar isoladamente em infecção cutânea não tratada. Monitorar atrofia e absorção sistêmica em lactentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 23)
Dermatoses inflamatórias leves a moderadas, eczema infantil e dermatite de contato.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Sanofi Medley - desonida, bula profissional brasileira (uploads.consultaremedios.com.br)

154. Dexametasona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Edema cerebral Crianças; edema vasogênico com indicação definida RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ataque EV: 1-2 mg/kg, limitado a 10 mg, uma vez. Manutenção: 0,25-0,375 mg/kg/dose a cada 6 horas, máximo 4 mg/dose; alternativa IWK: 0,17-0,25 mg/kg/dose a cada 4 horas, máximo 4 mg/dose. [S1, S2] Individualizar desmame conforme causa e resposta; CHEO descreve 5 dias seguidos de redução gradual. Não é esquema para traumatismo craniano indiscriminado.
Exacerbação grave de asma Crianças com asma; via oral tolerada	Administrar 0,6 mg/kg VO uma vez, máximo 12 mg no protocolo IWK; repetir aproximadamente 24 horas depois. Internados: máximo 16 mg/dose. Total usual do esquema: 2 doses. [S1, S3] UC Davis também utiliza 0,6 mg/kg, máximo 16 mg, com dose adicional após a urgência. Instabilidade grave exige terapia de resgate concomitante.
Crupe / laringotraqueíte viral Crianças	Crupe leve/moderado com indicação de corticosteroide: 0,15 mg/kg VO, dose única (RCH). Crupe grave: 0,6 mg/kg VO, EV ou IM, dose única, máximo 12 mg. IWK utiliza 0,6 mg/kg para crupe. [S1, S4] Reavaliar gravidade e necessidade de adrenalina nebulizada; não repetir automaticamente.
Meningite bacteriana - adjuvante Acima de 3 meses; entre 28 dias e 3 meses, decisão da infectologia	Administrar 0,15 mg/kg/dose EV a cada 6 horas, máximo 10 mg/dose, por 4 dias. Iniciar antes ou junto da primeira dose de antibiótico, sem atrasar antibiótico. Se atraso <12 horas, administrar assim que possível; >12 horas, discutir com infectologia. [S5] Manter se pneumococo ou H. influenzae b; suspender para outros agentes. Agente desconhecido: decisão especializada. Neonatos: evidência insuficiente para rotina.
Choque refratário UTI pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico padronizado de dexametasona estabelecido nesta ficha para choque refratário. A escolha de corticosteroide e a suspeita de insuficiência adrenal requerem protocolo de choque; não transpor a dose de edema cerebral. [S1, S2] A indicação original foi conservada; não constitui indicação rotineira de dexametasona com dose pediátrica padronizada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Doses referem-se à dexametasona ativa; conferir equivalência do fosfato no produto. Monitorar glicemia, PA e infecção. Duração e retirada dependem da causa; não interromper abruptamente tratamento prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Edema cerebral, exacerbação grave de asma, crupe laringotraqueíte viral, meningite bacteriana (adjuvante), choque refratário.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] IWK - dexamethasone, Pediatric Drug Dosing Guidelines (dir.iwk.nshealth.ca)
[S2] CHEO - dexamethasone (outreach.cheo.on.ca)
[S3] UC Davis - Pediatric Asthma Pathway, maio 2025 (health.ucdavis.edu)
[S4] RCH - Croup, setembro 2024 (rch.org.au)
[S5] NICE NG 240 - corticosteroides na meningite bacteriana, evidência G4 (2024) (nice.org.uk)

155. Dexclorfeniramina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reações alérgicas agudas; urticária; prurido; rinite alérgica	VO, liberação imediata: 2 a <6 anos, 0,5 mg por dose 3 vezes/dia; máximo 3 mg/dia. 6-12 anos, 1 mg por dose 3 vezes/dia; máximo 6 mg/dia. >12 anos, 2 mg por dose 3-4 vezes/dia; máximo 12 mg/dia. [S1]
≥2 anos	Uso sintomático pelo menor tempo necessário; persistência exige reavaliar causa. Não duplicar dose para alcançar o teto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada abaixo de 2 anos na formulação consultada. Pode provocar sonolência ou excitação paradoxal; evitar associação com outros sedativos. Não substitui adrenalina na anafilaxia. Não extrapolar para drágeas de liberação prolongada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Alívio de reações alérgicas agudas, urticária, prurido e rinite alérgica (respeitar faixas etárias).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Cimed - maleato de dexclorfeniramina, bula brasileira (cimedremedios.com.br)

156. Dexmedetomidina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sedação em UTI e ventilação mecânica Crianças após período neonatal; UTI, off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Manutenção EV: titular a infusão entre 0,2-2 mcg/kg/h conforme alvo de sedação. Se ataque indicado: 0,5-1 mcg/kg em 10 minutos. Reavaliar diariamente a necessidade e titular a partir de dose baixa conforme protocolo de UTI. [S1] CHEO utiliza faixa pediátrica de UTI; doses superiores às da bula adulta e duração prolongada exigem acompanhamento intensivo.
Sedação para exames e procedimentos não invasivos 1 mês a <18 anos; esquema da bula americana	Ataque EV em 10 minutos: 1 mês a <2 anos, 1,5 mcg/kg; 2 a <18 anos, 2 mcg/kg. Manutenção: iniciar 1,5 mcg/kg/h e titular entre 0,5-1,5 mcg/kg/h durante o procedimento. [S2] Não aplicar este ataque automaticamente em paciente instável ou como esquema de UTI.
Premedicação intranasal para procedimento Pediatria; off-label, equipe de anestesia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Administrar 2-3 mcg/kg intranasal, dose única, máximo 200 mcg, 30-60 minutos antes da indução. Dividir metade do volume em cada narina com atomizador. [S3] Protocolo Leeds cardiologia; a associação com outros sedativos exige dose e vigilância próprias.
Sedação por via IM 1-10 anos; evidência de ensaio, anestesiologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime estudado como premedicação: 2 mcg/kg IM em dose única, em crianças de 1-10 anos, ASA I. Uso experimental/off-label; não há dose universal nem esquema de repetição estabelecido por esse ensaio. [S4] Evidência limitada; não extrapolar para lactentes, pacientes instáveis ou UTI. O estudo encontrou sedação menos eficaz que cetamina IM.
Sedação em UTI e ventilação mecânica - recém-nascidos Recém-nascidos; UTI neonatal, off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Iniciar EV 0,2-0,3 mcg/kg/h; aumentar em 0,1 mcg/kg/h a cada 30-60 minutos, máximo 0,7 mcg/kg/h. Na hipotermia terapêutica: incrementos de 0,05 mcg/kg/h, teto 0,5 mcg/kg/h; ataque opcional de 0,3 mcg/kg em 15 minutos somente se indicado. Duração conforme necessidade clínica. [S5] Retirada: reduzir 0,1 mcg/kg/h a cada 6-24 horas, conforme tolerância. Monitorar bradicardia, hipotensão e abstinência.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Preparação EV: 200 mcg (2 mL a 100 mcg/mL) + 48 mL de SF 0,9% = 50 mL a 4 mcg/mL; apresentações prontas a 4 mcg/mL não exigem diluição. Velocidade em mcg/kg/HORA. ECG, PA e oximetria contínuos; reduzir em disfunção hepática. Evitar retirada abrupta após uso prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Sedação em UTI e ventilação mecânica; sedação para exames e procedimentos (uso pediátrico e vias intranasal/IM, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - dexmedetomidine pediátrica, janeiro 2026 (outreach.cheo.on.ca)
[S2] Pfizer - PRECEDEX, prescribing information (labeling.pfizer.com)
[S3] Leeds Teaching Hospitals - dexmedetomidina intranasal/bucal, agosto 2025 (leedsformulary.nhs.uk)
[S4] Bhandari et al. - ensaio randomizado de dexmedetomidina IM em crianças (doi.org)
[S5] CHEO - dexmedetomidina neonatal, dezembro 2025 (outreach.cheo.on.ca)

157. Dexpantenol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção e tratamento de assaduras	Pomada dermatológica 5%: aplicar camada na pele limpa a cada troca de fralda. Manter enquanto houver exposição à fralda ou até recuperação da lesão. [S1]
Lactentes e crianças	Não existe dose em mg/kg para proteção cutânea.
Fissuras mamilares	Pomada dermatológica 5%: aplicar camada no mamilo após cada mamada, até recuperação da fissura. [S1]
Pessoa que amamenta - indicação do catálogo, não dose da criança	Avaliar pega e causa da lesão; não é administração sistêmica ao lactente.
Cicatrização de lesões cutâneas superficiais	Pomada 5%: aplicar camada na lesão 1-3 vezes ao dia até cicatrização; reavaliar se houver infecção ou ausência de melhora. [S1]
Uso cutâneo	
Ceratites / lesões corneanas	Não aplicar pomada dermatológica nos olhos. Epitegel oftálmico tem uso adulto na bula consultada; não foi estabelecida dose pediátrica generalizável. [S2]
Uso oftálmico pediátrico não estabelecido na bula consultada	Avaliação oftalmológica; não extrapolar a posologia adulta.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Escolher formulação cutânea ou oftálmica apropriada. Dexpantenol não substitui tratamento de infecção nem investigação de ceratite.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)

Prevenção e tratamento de assaduras, fissuras mamilares, suporte à cicatrização de lesões cutâneas superficiais e ceratites.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cimed - Bepantriz, bula profissional (bula.gratis)

[S2] Bausch & Lomb - Epitegel, bula brasileira (bulas.med.br)

158. Diazepam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Estado de mal epiléptico; convulsões agudas	EV: 0,2-0,3 mg/kg, máximo 10 mg, lentamente em 3-5 minutos; OU via retal: 0,5 mg/kg, máximo 10 mg. Se persistir crise, repetir uma vez após 5 minutos. [S1]
1 mês a 11 anos	Contar benzodiazepínicos já administrados: após 2 doses totais, avançar no protocolo de estado de mal.
Estado de mal epiléptico; convulsões agudas	EV: 10 mg em 3-5 minutos; alternativa retal: 10-20 mg. Repetir uma vez após 5 minutos se necessário; máximo 2 doses de benzodiazepínico no resgate inicial. [S1]
≥12 anos	
Tétano - controle de espasmos	Administrar 0,1-0,3 mg/kg/dose EV lenta a cada 1-4 horas; alternativa MSF: infusão EV 0,1-0,5 mg/kg/h. Titular à supressão dos espasmos e ventilação; duração conforme evolução. [S1]
≥1 mês; UTI	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Para infusão, MSF limita concentração a 0,25 mg/mL em SF 0,9% ou SG 5%; não misturar outros fármacos. Confirmar compatibilidade do produto e sistema.
Espasmos musculares intensos; sedação pré-procedimento	Administrar 0,04-0,3 mg/kg/dose EV lenta; pode repetir após 2-4 horas se necessário, sem exceder 0,6 mg/kg em 8 horas. No procedimento, administrar a menor dose titulada suficiente. [S2]
Crianças; monitorização de sedação	CHEO admite IM profunda, porém a absorção é imprevisível; evitar como primeira escolha. Adolescentes: 2-10 mg/dose EV a cada 3-4 horas se necessário.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Suporte ventilatório imediato disponível; monitorar consciência, FR, PA e SpO 2. Evitar veias pequenas; solução EV pode precipitar. CHEO não admite infusão contínua do seu produto: a alternativa MSF exige verificação farmacêutica da apresentação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)

Controle do estado de mal epiléptico, convulsões agudas, espasmos musculares intensos e tétano; sedação pré-procedimento.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MSF - diazepam injetável, Essential drugs (medicalguidelines.msf.org)

[S2] CHEO - diazepam (outreach.cheo.on.ca)

159. Diazóxido

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Emergências hipertensivas graves refratárias Crianças; uso hospitalar especializado histórico RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Diazóxido injetável: 1-3 mg/kg/dose EV, máximo 150 mg/dose, sem diluir, em menos de 30 segundos. A fonte admite repetir após 5-15 minutos até resposta e, depois, a cada 4-24 horas se necessário. [S1] Monografia CHEO de 2005: opção histórica, não esquema preferencial contemporâneo; disponibilidade e escolha devem ser confirmadas por intensivista.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não confundir com diazóxido VO para hiperinsulinismo. Monitorar PA a cada 1-5 minutos inicialmente, ECG, glicemia e retenção hídrica. Manter deitado durante e por 60 minutos após administração. Redução pressórica excessiva pode causar isquemia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Tratamento de emergências hipertensivas graves em ambiente hospitalar especializado.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] CHEO - diazoxide / Hyperstat, monografia histórica 2005 \(outreach.cheo.on.ca\)](#)

160. Diclofenaco (Potássico / Sódico / Resinato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Artrite idiopática juvenil ≥1 ano; formulação oral pediátrica	Administrar 0,5-2 mg/kg/DIA VO, divididos em 2-3 tomadas; máximo 150 mg/dia. Ajustar ao controle da doença e reavaliar periodicamente. [S1] Dose calculada como diclofenaco equivalente; bula de resinato consultada equivale a 15 mg/mL, 0,5 mg/gota. Não usar a concentração de 50 mg/mL citada no original sem conferir produto.
Dor pós-operatória e pós-traumática ≥14 anos na bula brasileira consultada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: 75-100 mg/dia, divididos em 2-3 tomadas, suficientes em quadros menos intensos; conforme gravidade, até 150 mg/dia. Usar pelo menor período necessário. [S1] A bula limita a indicação entre 1 e 14 anos à artrite juvenil; analgesia em menores de 14 anos requer protocolo pediátrico off-label específico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não combinar AINEs. Evitar desidratação, disfunção renal, sangramento digestivo e hipersensibilidade a AINEs. Sal sódico, potássico e resinato não autorizam troca indiscriminada de formulação ou via.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Dor pós-operatória e pós-traumática; artrite idiopática juvenil (gotas a partir de 1 ano, conforme formulação).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Cimed - diclofenaco resinato oral, bula brasileira (bula.cimedremedios.com.br)

161. Difenidramina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reações alérgicas graves; manifestações cutâneas após estabilização de anafilaxia ≥4 semanas; evitar em prematuros/RN RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Difenidramina EV/IM: 1 mg/kg/dose, máximo 50 mg, a cada 6-8 horas se necessário; não exceder 5 mg/kg/dia. Suspende ao controle dos sintomas. [S1, S2] Anafilaxia exige adrenalina IM e suporte; difenidramina não trata obstrução respiratória ou choque e pode piorar hipotensão.
Reações transfusionais alérgicas ≥4 semanas	Administrar 1 mg/kg EV/IM, máximo 50 mg/dose; se necessário, repetir a cada 6-8 horas, até 5 mg/kg/dia. EV: diluir a 5 mg/mL em SF 0,9% ou SG 5% e infundir em 10-15 minutos. [S1, S2] Interromper transfusão e investigar a reação antes de considerar retomada.
Cinetose Crianças >9 kg; apresentação oral que permita dose exata RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: 5 mg/kg/DIA, divididos em 3-4 tomadas; teto da bula 300 mg/dia. Alternativa da bula: 12,5-25 mg por dose 3-4 vezes/dia. Primeira dose 30 minutos antes do movimento; continuar apenas durante exposição. [S3] Não utilizar cápsula de 50 mg para improvisar dose pequena; sedação e excitação paradoxal limitam uso.
Reações extrapiramidais agudas medicamentosas Crianças; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Administrar 1 mg/kg EV ou IM, máximo 50 mg/dose; reavaliar resposta. Se necessário, manutenção a cada 6-8 horas, máximo 5 mg/kg/dia, até resolução e retirada do agente causal. [S1] CHEO inclui reação extrapiramidal na indicação; duração depende da meia-vida do fármaco causador.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, sedação e ventilação. EV nunca mais rápido que 25 mg/min. Não usar em neonatos/prematuros; cautela especial abaixo de 2 anos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)

Reações alérgicas graves e anafilaxia (como adjuvante); reações transfusionais; cinetose; reações extrapiramidais agudas (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - diphenhydramine (outreach.cheo.on.ca)

[S2] Perth Children's Hospital - diphenhydramine (pch.health.wa.gov.au)

[S3] DailyMed - diphenhydramine hydrochloride oral, prescribing information (dailymed.nlm.nih.gov)

162. Digoxina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência cardíaca por disfunção sistólica ou shunts volumosos	VO, a cada 12 horas: prematuro 2,3-3,9 mcg/kg/dose; RN a termo 3,8-5,6; 1-24 meses 5,6-9,4; 2-5 anos 4,7-6,6; 5-10 anos 2,8-5,6 mcg/kg/dose. >10 anos: 3-4,5 mcg/kg uma vez/dia. Tratamento contínuo, titulado por clínica e nível sérico. [S1]
Função renal normal; manutenção oral	Digitalização não é obrigatória na IC estável. Começar conservadoramente; reduzir em insuficiência renal. Faixas etárias e arredondamentos seguem a bula da solução oral.
Controle da frequência em taquiarritmias supraventriculares; digitalização quando indicada	Carga ORAL TOTAL: prematuro 20-30 mcg/kg; termo 25-35; 1-24 meses 35-60; 2-5 anos 30-45; 5-10 anos 20-35; >10 anos 10-15 mcg/kg. Administrar metade inicialmente e dividir o restante em 2 parcelas, espaçadas por 4-8 horas, avaliando antes de cada parcela. Depois, usar manutenção por idade acima. [S1]
Pediatria; cardiologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Carga total não é dose única nem dose diária repetida. Não é agente de reversão rápida de TSV instável.
Alternativa neonatal EV para IC ou taquiarritmia selecionada	Carga EV TOTAL: prematuro 22,5 mcg/kg; termo 30 mcg/kg. Dar metade imediatamente e um quarto após 8 e 16 horas; cada parcela EV em 3-5 minutos. Manutenção, 12 horas após última parcela: prematuro 2-3 mcg/kg/dose; termo 2,5-4 mcg/kg/dose, a cada 12 horas. [S2]
Prematuros / RN a termo - protocolo CHEO RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Alternativa institucional distinta da bula oral. Dose EV não é igual à oral.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Margem terapêutica estreita: ECG, função renal, potássio, magnésio e digoxinemia. Usar peso magro e seringa adequada; mcg ≠ mg. Evitar em fibrilação atrial com pré-excitação/WPW. Não confundir concentração em ng/mL com nmol/L.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 24)
Insuficiência cardíaca com disfunção sistólica ou shunts volumosos; controle da frequência ventricular em taquiarritmias supraventriculares.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - digoxin oral solution, bula (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] CHEO - digoxin neonatal, agosto 2026 (outreach.cheo.on.ca)

163. Diltiazem

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial Crianças; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 1,5-2 mg/kg/DIA, divididos em 3-4 tomadas; teto usual 3,5 mg/kg/dia. AEP descreve centros que utilizam até 6 mg/kg/dia, máximo 360 mg/dia, sob cardiologia. Tratamento contínuo com titulação. [S1] Não aplicar limites experimentais de distrofia muscular à hipertensão.
Hipertensão arterial - alternativas por formulação Adolescentes; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Liberação imediata: iniciar 30 mg 3 vezes/dia; hipertensão grave, 60 mg 3 vezes/dia; máximo 120 mg 3 vezes/dia. Retard 1 vez/dia: iniciar 120-240 mg/dia, titular após ≥ 14 dias; máximo 480 mg/dia. Retard 2 vezes/dia: iniciar 80-120 mg/dose; manutenção total 240-360 mg/dia. [S1] Escolher UM esquema e conferir formulação; não mastigar/triturar liberação prolongada.
Taquiarritmias supraventriculares; controle de frequência Adolescentes; uso hospitalar off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	EV: 0,25 mg/kg em 2 minutos; se sem resposta após 15 minutos, 0,35 mg/kg em 2 minutos. Infusão: 0,1-0,25 mg/kg/h, máximo 15 mg/h, por até 24 horas. [S1] AEP descreve este esquema em adolescentes/adultos; não extrapolar para lactentes. Contraindicado em pré-excitação com FA/flutter e disfunção sistólica importante.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG e PA; risco de bloqueio AV, bradicardia e hipotensão, especialmente com betabloqueadores/digoxina. Crianças pequenas com arritmia exigem eletrofisiologia; a fonte não define esquema universal nessa idade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)

Controle de taquiarritmias supraventriculares e hipertensão arterial (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Diltiazem, Pediamécum (aeped.es)

164. Dimenidrinato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Náuseas e vômitos; prevenção e tratamento de cinetose	6-12 anos: 25-50 mg VO por dose a cada 6-8 horas, máximo 150 mg/dia. >12 anos: 50-100 mg por dose a cada 4-6 horas, máximo 400 mg/dia. [S1]
≥6 anos; cápsulas orais	Na prevenção de cinetose, administrar ≥30 minutos antes da viagem; manter somente durante sintomas ou exposição. Não associar a outro produto com dimenidrinato.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cápsulas contraindicadas abaixo de 6 anos. Pode causar sedação ou excitação paradoxal. Reduzir dose em insuficiência hepática aguda.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Prevenção e tratamento de náuseas, vômitos e cinetose (cápsulas a partir de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Takeda - Dramin, bula profissional brasileira (uploads.consultaremedios.com.br)

165. Dimenidrinato + Piridoxina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Náuseas; vômitos; vertigens; labirintopatias - tratamento e prevenção	Administrar 1,25 mg/kg/dose de DIMENIDRINATO VO: 2-12 anos, a cada 6-8 horas; >12 anos, a cada 4-6 horas. Tetos do dimenidrinato: 2 a <6 anos, 75 mg/dia; 6-12 anos, 150 mg/dia; >12 anos, 400 mg/dia. A associação 25: 5 fornece 0,25 mg/kg/dose de piridoxina. [S1, S2]
≥2 anos; solução oral	Ajustar a dose para não ultrapassar o teto diário. Administrar ≥30 minutos antes da viagem na prevenção; manter pelo menor período sintomático necessário.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose principal expressa pelo dimenidrinato; não somar miligramas dos dois componentes. Não transpor dose oral para produto EV com glicose/frutose. Sedação, excitação paradoxal e efeitos anticolinérgicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)

Tratamento e prevenção de náuseas, vômitos, vertigens e labirintopatias (gotas acima de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Vitamedic - Dimenidrin, bula profissional (vitamedic.ind.br)

[S2] Takeda - Dramin B6, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

166. Dipirona Sódica (Metamizol)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Febre ≥3 meses e ≥5 kg	Administrar 10 mg/kg/dose VO; se necessário, repetir a cada 6-8 horas, até 4 doses em 24 horas. Usar enquanto houver desconforto febril, com investigação da causa. [S1] EMA considera 10 mg/kg geralmente suficiente para febre.
Dor aguda leve a moderada ≥3 meses e ≥5 kg, até 14 anos	Administrar 8-16 mg/kg/dose VO, a cada 6-8 horas se necessário, no máximo 4 doses em 24 horas. Duração: menor tempo necessário para a causa dolorosa, com reavaliação se persistir. [S1]
Febre ou dor - dose por idade/peso adulto ≥15 anos e >53 kg	VO: 500-1.000 mg por dose a cada 6-8 horas, máximo 4.000 mg/dia. Não adotar teto adulto apenas pela idade em adolescente de baixo peso. [S1]
Dor/febre quando via parenteral é necessária ≥3 meses e ≥5 kg; EV somente ≥1 ano RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Dipirona EV/IM por dose, conforme peso: 5-8 kg, 50-100 mg apenas IM; 9-15 kg, 100-250 mg; 16-23 kg, 150-400 mg; 24-30 kg, 200-500 mg; 31-45 kg, 250-750 mg; 46-53 kg, 400-900 mg. Bula brasileira admite até 4 doses/dia. [S2] EV muito lenta, nunca acima de 500 mg/min; pode diluir em SF 0,9%, SG 5% ou Ringer lactato e administrar imediatamente. Monitorar PA; doses >1 g parenteral exigem avaliação específica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada <3 meses ou <5 kg; via EV contraindicada <1 ano. Suspende e investigar imediatamente febre inexplicada, odinofagia ou ulcerações pela possibilidade de agranulocitose. Via parenteral aumenta risco de hipotensão e anafilaxia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)

Alívio de febre e dor aguda leve a moderada de diversas etiologias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Metamizole Article 31, harmonização posológica, Anexo III (ema.europa.eu)

[S2] Hypofarma - dipirona injetável, bula profissional (hypofarma.com.br)

167. Dobutamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Choque cardiogênico, baixo débito cardíaco; choque séptico com disfunção miocárdica	Iniciar EV contínua em 2,5 mcg/kg/min; faixa usual 2,5-15 mcg/kg/min, titulada à perfusão. Teto descrito pelo CHEO: 40 mcg/kg/min, excepcional, em UTI. Manter somente enquanto necessário ao débito/perfusão. Preparo: 40 mg + SF 0,9% até volume final 50 mL = 800 mcg/mL; alternativa 80 mg até 50 mL = 1.600 mcg/mL. Bomba: mL/h = dose (mcg/kg/min) × peso (kg) × 60 ÷ concentração final (mcg/mL). [S1]
Crianças/adolescentes; RN requerem avaliação neonatal	Não é esquema de vasopressor isolado para vasoplegia; tratar hipovolemia. Off-label pediátrico conforme produto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, PA contínua, perfusão e diurese; reduzir diante de taquiarritmia/hipotensão. Preferir acesso central. Incompatível com bicarbonato e soluções alcalinas; verificar conexão com outras drogas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Suporte inotrópico no choque cardiogênico, baixo débito cardíaco e choque séptico com disfunção miocárdica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] CHEO - Dobutamina \(outreach.cheo.on.ca\)](#)

168. Domperidona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Náuseas e vômitos ≥ 12 anos e ≥ 35 kg	10 mg VO de 8/8 h, máximo 30 mg/dia, pela menor duração necessária; reavaliar se não houver resposta rápida. [S1]
Náuseas/vômitos; dispepsia e distúrbios da motilidade gastrointestinal < 12 anos ou < 35 kg RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquema off-label descrito pela AEP: 0,25 mg/kg/dose VO de 8/8 h; máximo 30 mg/dia. Não representa recomendação rotineira: indicação antiemética foi retirada em crianças pequenas na Europa por ausência de benefício demonstrado. Para dispepsia/motilidade, não há esquema pediátrico de eficácia estabelecida na fonte consultada. [S1] Uso somente por decisão especializada após avaliação de QT e alternativas; restrição regulatória internacional não equivale automaticamente à bula brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar QT longo, distúrbios de K/Mg, cardiopatia, obstrução/perfuração/hemorragia gastrointestinal, hepatopatia moderada/grave, macrolídeos e azóis fortes inibidores CYP 3A4.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)

Náuseas e vômitos; dispepsia e distúrbios da motilidade gastrointestinal (respeitar restrições regulatórias de peso e idade).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Domperidona (aeped.es)

169. Dopamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Choque com hipotensão e necessidade inotrópica/vasopressora	EV contínua, iniciar 5 mcg/kg/min; titular usualmente 5-20 mcg/kg/min. CHEO descreve faixa 1-20 e teto excepcional 50 mcg/kg/min; doses acima de 20 exigem reavaliação da estratégia vasoativa. Não administrar em bolus. Concentrações finais: 800 ou 1.600 mcg/mL; 3.200 mcg/mL apenas central. mL/h = dose × peso × 60 ÷ concentração final. Suspender gradualmente ao recuperar perfusão. [S1]
Crianças/adolescentes	
	Não usar “dose renal” para prevenir lesão renal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PA/ECG contínuos, lactato, diurese e extremidades; corrigir hipovolemia e vigiar extravasamento. Incompatível com bicarbonato/soluções alcalinas. Contraindicada no feocromocitoma.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Suporte hemodinâmico no choque com hipotensão arterial e necessidade de ação inotrópica/vasopressora.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - [Dopamina](#) (outreach.cheo.on.ca)

170. Doxazosina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bexiga neurogênica e sintomas urinários por disfunção de esvaziamento	Estudo exploratório: iniciar aproximadamente 0,03 mg/kg VO à noite; faixas usadas: ≤ 20 kg, 0,5-1 mg; > 20-40 kg, 1-2 mg; > 40 kg, 2 mg, uma vez ao dia. Avaliar resposta clínica e urodinâmica após 6-8 semanas. [S1]
Crianças 6-16 anos estudadas RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Off-label. Pequeno estudo não demonstrou eficácia global significativa; dose estudada não equivale a indicação consolidada.
Hipertensão arterial População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não foi confirmado esquema pediátrico padronizado de tratamento da hipertensão nas fontes primárias recuperadas; não extrapolar automaticamente a titulação adulta. [S1] A indicação no original é adulta. Não foi encontrada validação pediátrica para hipertensão nas fontes consultadas; ensaio de bexiga não valida dose anti-hipertensiva.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PA sentada/em pé, tontura, síncope e resíduo pós-miccional. Primeira dose à noite; redução/interrupção se hipotensão. Não substituir cateterismo intermitente/controle da pressão vesical.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Hipertensão arterial e sintomas urinários (uso adulto na bula; uso pediátrico em bexiga neurogênica, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Kroll et al. - estudo primário de doxazosina em bexiga neurogênica pediátrica (mdpi-res.com)

171. Doxiciclina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Febre maculosa e outras riquetsioses Todas as idades, inclusive < 8 anos	2,2 mg/kg/dose VO/EV a cada 12 h, máximo 100 mg/dose. Febre maculosa: mínimo 5-7 dias e continuar por ≥ 3 dias após cessar a febre e haver melhora clínica. Outras riquetsioses exigem duração conforme agente. [S1] Tratamento curto não deve ser negado pela idade.
Doença de Lyme inicial com eritema migrans Crianças de todas as idades, seleção clínica	4,4 mg/kg/dia VO divididos em 2 tomadas; máximo 100 mg/dose, por 10-14 dias. [S2]
Infecção urogenital por Chlamydia trachomatis Crianças ≥ 8 anos e adolescentes; infecção não complicada	Doxiciclina 100 mg VO de 12/12 h por 7 dias (CDC). Confirmar sítio da infecção e seguimento; não aplicar este esquema a gestantes ou crianças < 8 anos. [S4] Investigar contexto da infecção e coinfeções.
Acne inflamatória grave Geralmente ≥ 8 anos; acompanhamento dermatológico RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	2-4 mg/kg/dia VO em 1-2 tomadas, máximo 200 mg/dia, como adjuvante tópico. A monografia não define duração por gravidade; reavaliar resposta e limitar exposição antimicrobiana. [S3] Não usar isoladamente; duração específica permanece dependente da estratégia dermatológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar ingestão junto de ferro, cálcio/antiácidos; tomar com água e permanecer ereto para reduzir esofagite. Fotossensibilidade. Na gestação, avaliar alternativa salvo infecção ameaçadora à vida. Não ajustar habitualmente por função renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Febre maculosa, riquetsioses, doença de Lyme inicial, infecções por clamídia e acne grave (em geral a partir de 8 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] CDC - Clinical care of RMSF (cdc.gov)
- [S2] CDC - Erythema migrans treatment (cdc.gov)
- [S3] AEP - Pediamécum: Doxiciclina (aeped.es)
- [S4] CDC - Chlamydial infections, STI guidelines (cdc.gov)

172. Dropropizina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tosse seca, irritativa e não produtiva	2-3 anos: 3,75-7,5 mg VO por dose, 4 vezes/dia (15-30 mg/dia). > 3-12 anos: 15 mg VO por dose, 4 vezes/dia (60 mg/dia). > 12 anos: 30 mg VO por dose, 4 vezes/dia (120 mg/dia). Uso por poucos dias; reavaliar persistência. [S1]
2-3 anos; > 3-12 anos; > 12 anos	Equivalências verificadas: xarope 1,5 mg/mL, 2,5-5 mL ou 10 mL/dose; 3 mg/mL, 10 mL/dose somente > 12 anos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada em < 2 anos, tosse produtiva, asma, insuficiência respiratória grave e hipotensão. Pode causar sonolência/hipotensão; cautela na disfunção renal/hepática.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 25)
Alívio sintomático da tosse seca, irritativa e não produtiva em pediatria e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Aché - bula profissional de dropropizina (cópia pública) (uploads.consultaremedios.com.br)

173. Ebastina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica e urticária	2-5 anos: 2,5 mg VO 24/24 h. 6-11 anos: 5 mg VO 24/24 h. ≥ 12 anos: 10 mg VO 24/24 h; casos selecionados podem precisar de 20 mg/dia. Manter durante período sintomático/exposição; reavaliar necessidade contínua. [S1]
≥ 2 anos	Usar apresentação pediátrica; não extrapolar comprimidos a < 12 anos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Na hepatopatia grave, máximo 10 mg/dia, sem superar dose etária. Cautela no QT longo, hipocalemia, macrolídeos e azóis.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária (xarope a partir de 2 anos; comprimidos acima de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Ebastina (aeped.es)

174. Eculizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
HPN e SHUa Peso 5 a < 40 kg	EV: 5-< 10 kg: 300 mg semana 1 e 300 mg semana 2, depois a cada 3 semanas. 10-< 20 kg: 600 mg semana 1; 300 mg semana 2 e a cada 2 semanas. 20-< 30 kg: 600 mg/semana por 2 semanas; 600 mg semana 3 e a cada 2 semanas. 30-< 40 kg: 600 mg/semana por 2 semanas; 900 mg semana 3 e a cada 2 semanas. Diluir para 5 mg/mL; infusão pediátrica em 1-4 h. Tratamento contínuo com reavaliação hematológica/renal. [S1] A bula EMA extrapola HPN < 40 kg a partir da farmacocinética da SHUa; < 5 kg sem esquema estabelecido.
HPN ≥ 40 kg	600 mg EV semanal por 4 semanas; 900 mg na semana 5; depois 900 mg a cada 14 ±2 dias. Tratamento contínuo. [S1]
SHUa ≥ 40 kg	900 mg EV semanal por 4 semanas; 1.200 mg na semana 5; depois 1.200 mg a cada 14 ±2 dias. Tratamento contínuo. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vacinação meningocócica e prevenção de infecção antes do início; risco de sepse meningocócica persiste. Monitorar hemólise, plaquetas e função renal. Troca plasmática/plasma requerem dose suplementar específica; não usar calendário padrão isoladamente nesses casos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) e síndrome hemolítico-urêmica atípica (SHUa).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] EMA - Soliris, informação profissional (ema.europa.eu)

175. Emulsão Lipídica 20%

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Aporte energético e ácidos graxos essenciais em nutrição parenteral Crianças; adolescentes	Emulsão 20% = 0,2 g/mL: iniciar 0,5-1 g/kg/dia EV; aumentar 0,5 g/kg/dia, até 3 g/kg/dia nas crianças. Adolescentes: iniciar 1 g/kg/dia; máximo 2,5 g/kg/dia. Velocidade nutricional máxima 0,25 g/kg/h = 1,25 mL/kg/h. Se infundida em 24 h: mL/h = g/kg/dia × peso ÷ 4,8. Manter enquanto houver necessidade de nutrição parenteral. [S1]
Toxicidade sistêmica por anestésicos locais Pediatria até 70 kg; acima desse peso ver esquema fixo ASRA	Emulsão 20%: 1,5 mL/kg EV em 2-3 min; seguir 0,25 mL/kg/min. Se instabilidade persistir, repetir bolus e dobrar infusão para 0,5 mL/kg/min. Continuar > 15 min após estabilidade, respeitando máximo acumulado 12 mL/kg (ASRA). CHEO descreve alternativa mais conservadora: bolus em 1 min e teto 10 mL/kg em 30 min; não somar protocolos. Acima de 70 kg: bolus aproximadamente 100 mL em 2-3 min e 250 mL em 15-20 min, com os mesmos critérios de escalonamento/teto cumulativo. [S1, S2] Off-label; velocidade de resgate é distinta da velocidade nutricional; não substituir por propofol.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar triglicérides, função hepática e tolerância; risco de sobrecarga lipídica. Resgate integra ressuscitação e exige controle da dose cumulativa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)

Aporte calórico e de ácidos graxos essenciais em nutrição parenteral; resgate em toxicidade sistêmica por anestésicos locais (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Emulsão lipídica 20% (outreach.cheo.on.ca)

[S2] ASRA - LAST checklist 2020, vigente durante revisão 2026 (asra.com)

176. Enalapril

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial > 1 mês	Iniciar 0,08 mg/kg VO 24/24 h (máximo inicial 5 mg). Titular à PA; doses acima de 0,58 mg/kg/dia ou 40 mg/dia não estudadas. Alternativa ≥ 6 anos e ≥ 20 kg: 20-50 kg, iniciar 2,5 mg/dia, teto 20 mg/dia; > 50 kg, iniciar 5 mg/dia, teto 40 mg/dia. Uso contínuo. [S1]
Insuficiência cardíaca > 1 mês	Iniciar 0,1 mg/kg/dia VO em 1-2 tomadas; aumentar gradualmente em cerca de 2 semanas até 0,5 mg/kg/dia conforme tolerância, respeitando teto adulto. Uso contínuo com reavaliação. [S1] Off-label; evidência pediátrica limitada.
Hipertensão neonatal RN, uso excepcional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	0,04 mg/kg/dia VO inicial; faixa publicada 0,04-0,1 mg/kg/dia; teto publicado 0,27 mg/kg/dia. [S1] Off-label de alto risco: 0,1 mg/kg como primeira dose já se associou a oligúria/hipotensão; não recomendado rotineiramente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PA, K e creatinina antes/após titulação; risco de hiperpotassemia com espironolactona. Evitar gestação, angioedema por IECA, estenose bilateral renal; uso pediátrico com TFG < 30 exige especialista.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Enalapril (aeped.es)

177. Enoxaparina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento de TEV e trombose de cateter < 2 meses; ≥ 2 meses a < 18 anos	SC: < 2 meses: 1,75 mg/kg/dose a cada 12 h; ≥ 2 meses: 1 mg/kg/dose a cada 12 h. Ajustar por anti-Xa 0,5-1 U/mL, colhido 4-6 h pós-dose. CHEO 2026 admite tetos de titulação 3 e 2 mg/kg/dose, respectivamente, somente com anti-Xa. Duração TOTAL de anticoagulação: TEV provocado selecionado, 6 semanas; se embolia pulmonar, recorrência, trombo oclusivo persistente em 6 semanas, câncer, anticorpos antifosfolípides persistentes/trombofilia maior ou risco contínuo, em geral 3 meses ou individualizar. TEV não provocado: 6-12 meses. Recomendações condicionais ASH/ISTH 2025. [S1, S2] Off-label pediátrico. Doses neonatais iniciais variam entre diretrizes; 1,75 mg/kg/dose é a revisão CHEO de junho/2026.
Profilaxia de TEV, incluindo risco relacionado a cateter < 2 meses; ≥ 2 meses	SC: < 2 meses: 0,75 mg/kg/dose 12/12 h OU 1,5 mg/kg 24/24 h. ≥ 2 meses: 0,5 mg/kg/dose 12/12 h (máx. 30 mg/dose) OU 1 mg/kg 24/24 h (máx. 40 mg/dia). Alvo anti-Xa 0,2-0,4 U/mL. Enquanto persistir risco definido. [S1] Cateter isolado não torna profilaxia farmacológica obrigatória.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma/plaquetas, sangramento, creatinina e anti-Xa. Não administrar IM; evitar duplicação com heparina. Insuficiência renal pode exigir redução/intervalo maior guiado por anti-Xa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso e trombose associada a cateter venoso central em pediatria (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] CHEO - Enoxaparina - revisão junho/2026 (outreach.cheo.on.ca)
[S2] ASH/ISTH - Tratamento de TEV pediátrico, atualização 2025 (hematology.org)

178. Enzimas Pancreáticas (Pancrelipase)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência pancreática exócrina: fibrose cística, pancreatite crônica e síndrome de Shwachman-Diamond	VO junto às refeições. ≤ 12 meses: 3.000 U de lipase por 120 mL de fórmula ou por mamada. > 12 meses-< 4 anos: iniciar 1.000 U de lipase/kg/refeição; ≥ 4 anos: 500 U/kg/refeição. Lanches: cerca de metade da dose da refeição. Titular à absorção/esteatorreia e crescimento; limites usuais 2.500 U/kg/refeição, 10.000 U/kg/dia ou 4.000 U/g de gordura ingerida/dia. Uso contínuo enquanto houver insuficiência. [S1]
Do nascimento à adolescência	Unidade é de LIPASE; não de massa total da pancrelipase. Necessidade maior exige investigação de resposta/aderência, não escalada automática.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não triturar/mastigar microgrânulos. Não misturar à mamadeira inteira. Vigiar constipação, dor e colonopatia fibrosante em altas doses; hiperuricemia em pacientes de risco.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Insuficiência pancreática exócrina na fibrose cística, pancreatite crônica e síndrome de Shwachman-Diamond.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AbbVie - Creon, prescrição profissional (rxabbvie.com)

179. Epinastina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento e prevenção da conjuntivite alérgica sazonal ≥ 3 anos	Epinastina colírio 0,5 mg/mL: instilar 1 gota em cada olho afetado, 2 vezes/dia. Manter durante exposição/sintomas; ensaios da bula acompanharam até 8 semanas. [S1] Não tocar ponta do frasco; retirar lentes e aguardar ≥ 15 min para recolocar.
Rinite alérgica - epinastina oral > 12 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	10-20 mg VO uma vez/dia, ajustada aos sintomas, enquanto exposição/atividade alérgica; reavaliar necessidade. [S2] Bula Talerc/Aché transcrita em repositório; página atual do fabricante não disponibilizou bula. Não confirmada indicação oral para ≤ 12 anos nem disponibilidade comercial atual. Colírio não pode ser ingerido.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES O colírio é exclusivamente oftálmico: não injetar nem ingerir. Reavaliar dor ocular, fotofobia ou perda visual. Hipersensibilidade contraindica. A formulação oral, quando utilizada, segue o esquema e as ressalvas próprios acima.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)

Tratamento e prevenção da conjuntivite alérgica sazonal (colírio a partir de 3 anos); rinite alérgica (via oral).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AbbVie - Relestat, bula profissional (abbvie.com.br)

[S2] Aché - Talerc comprimido, bula profissional transcrita (bulas.med.br)

180. Eritromicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Coqueluche Crianças; evitar escolha inicial em RN	40-50 mg/kg/DIA VO divididos em 4 tomadas (de 6/6 h), máximo 2 g/dia, por 14 dias. Alternativa ChAMP para ≥ 4 semanas: 10 mg/kg/dose VO de 6/6 h, máximo 250 mg/dose, por 7 dias. As durações pertencem a diretrizes distintas; não encurtar o esquema CDC sem adoção formal de protocolo. [S2, S3] No RN < 1 mês, azitromicina é preferida; se eritromicina necessária, vigiar estenose hipertrófica de piloro.
Conjuntivite neonatal por clamídia RN a termo	50 mg/kg/dia VO divididos de 6/6 h durante 14 dias. Pode ser necessário novo ciclo após documentar persistência. [S1] Tratamento tópico isolado não erradica infecção sistêmica.
Pneumonia atípica por agente suscetível Crianças/adolescentes	≥ 4 semanas: 30-50 mg/kg/DIA VO em 3-4 tomadas; alternativa EV 15-20 mg/kg/DIA em 4 doses, máximo 4 g/dia. Diluir EV em SF para 1-5 mg/mL, preferir ≤ 1 mg/mL, e infundir em 20-60 min. Para Mycoplasma sensível, consenso japonês: 25-50 mg/kg/DIA VO em 4-6 tomadas por 14 dias. Outros agentes/sítios exigem duração própria e reavaliação em 48-72 h. [S3, S4]
Uso procinético gastrointestinal Neonatos > 14 dias, dados limitados RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regimes estudados VO: 1,5-2,5 mg/kg/dose de 6/6 h (baixa dose); 5 mg/kg/dose de 6/6 h por 14 dias (intermediária); 10-12,5 mg/kg/dose de 6/6 h (alta dose). ChAMP ≥ 4 semanas: 3 mg/kg/dose VO de 6/6 h, titulável até 10 mg/kg/dose (máximo 250 mg/dose); EV 3 mg/kg/dose de 6-8 h, máximo 250 mg/dose. Duração conforme resposta/tolerância; reavaliar uso prolongado. [S1, S3] Off-label; eficácia variável, sobretudo dose alta; não prescrever todas as alternativas simultaneamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES QT, interação CYP 3A4, função hepática e tolerância gastrointestinal. Nos RN, vigiar vômitos em jato/estenose pilórica. Evitar associação com domperidona.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)

Tratamento da coqueluche, pneumonia atípica, conjuntivite neonatal por clamídia; procinético gastrointestinal (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Eritromicina (aeped.es)

[S2] CDC - Antimicrobial agents for pertussis (cdc.gov)

[S3] ChAMP/PCH - Eritromicina, março 2023 (pch.health.wa.gov.au)

[S4] Japanese Society of Mycoplasmaology - Guiding principles 2014 (square.umin.ac.jp)

181. Ertapenem Sódico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecção intra-abdominal complicada ≥ 3 meses	3 meses-12 anos: 15 mg/kg/dose EV ou IM 12/12 h, máximo total 1 g/dia; ≥ 13 anos: 1 g 24/24 h. Duração descrita: 5-14 dias, reduzida conforme controle do foco e evolução. [S1]
Infecção urinária grave/pielonefrite e pneumonia comunitária ≥ 3 meses	Mesma dose: 15 mg/kg/dose 12/12 h (máximo 1 g/dia) até 12 anos; ≥ 13 anos 1 g/dia. Duração descrita na monografia: 10-14 dias, com transição VO quando apropriado. EV em 30 min. [S1] Não cobre Pseudomonas, Acinetobacter ou enterococo. Não usar apresentação IM reconstituída com lidocaína por via EV.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar na insuficiência renal grave com infectologia/farmácia, pois esquema pediátrico renal validado é escasso. Risco de convulsões; carbapenêmicos reduzem fortemente nível de valproato.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 26)
Infecções intra-abdominais complicadas, infecções urinárias graves e pneumonia comunitária por bactérias sensíveis (a partir de 3 meses).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Ertapenem (aeped.es)

182. Escitalopram

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno depressivo maior ≥ 12 anos	10 mg VO uma vez/dia; se necessário, aumentar para 20 mg/dia após pelo menos 3 semanas. Máximo 20 mg/dia. Tratamento por meses, com resposta, funcionalidade e necessidade de manutenção reavaliadas regularmente. [S1]
Transtorno de ansiedade generalizada ≥ 7 anos, conforme autorização FDA	10 mg VO uma vez/dia; aumentar, se necessário, para 20 mg/dia após pelo menos 2 semanas. Máximo 20 mg/dia. Duração individual, usualmente prolongada; desmame gradual. [S1] Faixa etária regulatória pode diferir da bula brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ideação suicida, ativação/manias, Na, QT e interações serotoninérgicas. Evitar IMAO; respeitar washout. Insuficiência hepática: dose recomendada 10 mg/dia; renal grave exige cautela.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FDA/DailyMed - Escitalopram, bula profissional (dailymed.nlm.nih.gov)

183. Escopolamina (Butilbrometo de Escopolamina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Espasmos/cólicas gastrointestinais, biliares e geniturinárias > 6 anos, via oral	Butilbrometo de escopolamina: 10-20 mg VO por dose, 3-5 vezes/dia; teto derivado da faixa: 100 mg/dia. Uso breve, conforme causa; dor persistente exige diagnóstico. [S1]
Espasmos/cólicas quando via parenteral indicada 1 mês-17 anos	EV lenta: 1 mês-4 anos, 0,3-0,6 mg/kg/dose, máximo 5 mg, a cada 6-8 h; 5-11 anos, 5-10 mg/dose a cada 6-8 h; 12-17 anos, 10-20 mg/dose a cada 6-8 h. Não exceder 1,5 mg/kg/dia. Usar menor duração necessária. [S1] Esquemas pediátricos da AEP são off-label conforme formulação. Aplicar sempre o menor dos limites.
Secreções respiratórias na fase final de vida ≥ 1 mês, cuidados paliativos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bolus SC/EV/IM: 1 mês-4 anos 0,3-0,5 mg/kg/dose, máximo 5 mg; 3-4 vezes/dia; 5-11 anos 5-10 mg 3-4 vezes/dia; ≥ 12 anos 10-20 mg 3-4 vezes/dia. Alternativa SC contínua: 1 mês-4 anos 1,5 mg/kg/DIA, máximo 15 mg/dia; 5-11 anos 30 mg/dia; ≥ 12 anos 60-80 mg/dia. Titular ao conforto, mantendo enquanto benefício. EV lenta em ≥ 1 min. [S2] Off-label. Não confundir com bromidrato; soluções/doses diferentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar obstrução/íleo, retenção urinária, megacólon, miastenia, glaucoma de ângulo fechado e taquiarritmia. Monitorar FC, distensão e diurese; não usar para mascarar abdome agudo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Espasmos e cólicas do trato gastrointestinal, biliar e geniturinário; secreções respiratórias na fase final de vida (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Butilbrometo de escopolamina (aeped.es)
[S2] APPM 2024 - Butilbrometo de escopolamina,pp 107-108 (appm.org.uk)

184. Esmolol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Taquiarritmias supraventriculares, taquicardia sinusal selecionada e hipertensão aguda	Ataque EV 100-500 mcg/kg em 1 min; seguir 100-500 mcg/kg/min, titulado à FC/PA; teto excepcional descrito 1.000 mcg/kg/min. Solução final 10 mg/mL = 10.000 mcg/mL. mL/h = dose × peso × 60 ÷ 10.000. Duração: controle agudo e transição ao tratamento definitivo. [S1]
Pediatria em UTI/centro cirúrgico	Taquicardia sinusal compensatória por choque/hipovolemia exige correção da causa; não bloquear automaticamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG/PA contínuos. Evitar em bradicardia, bloqueio AV significativo e insuficiência cardíaca descompensada; risco de broncoespasmo. Incompatível com furosemida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)

Controle rápido de taquiarritmias supraventriculares, taquicardia sinusal e hipertensão aguda (uso adulto e pediátrico monitorizado).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Esmolol (outreach.cheo.on.ca)

185. Esomeprazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DRGE e esofagite erosiva 1-11 anos; ≥ 12 anos	1-11 anos ≥ 10 kg: 10 mg VO 24/24 h; esofagite e peso ≥ 20 kg: 10-20 mg/dia. ≥ 12 anos: 20-40 mg/dia. Duração inicial 4-8 semanas, reavaliando indicação. Administrar antes da primeira refeição. [S1]
Esofagite erosiva do lactente 1 a < 12 meses	3-5 kg: 2,5 mg VO 24/24 h; > 5-7,5 kg: 5 mg/dia; > 7,5 kg: 10 mg/dia, por até 6 semanas. [S1] Não tratar regurgitação fisiológica com IBP.
Erradicação de H. pylori e doença ulcerosa associada ≥ 15 kg, tratamento combinado	15-< 25 kg: 20 mg VO 12/12 h; 25-34 kg: 30 mg 12/12 h; > 34 kg: 40 mg 12/12 h, associado a antibióticos escolhidos pela susceptibilidade. Esquema erradicador usual por 14 dias; cicatrização da úlcera pode demandar IBP adicional. [S1, S2] Dose de esomeprazol conforme AEP; IBPs diferentes não são intercambiáveis mg por mg. Erradicação requer associação e confirmação posterior.
Úlcera gástrica/duodenal sem H. pylori Crianças/adolescentes	Usar esquema de supressão ácida da faixa etária descrito acima, com avaliação endoscópica e etiológica; cicatrização costuma exigir 4-8 semanas. [S1] Uso pediátrico e duração devem ser compatíveis com diagnóstico documentado, não apenas dor abdominal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reavaliar tratamento crônico; monitorar Mg em uso prolongado. Hepatopatia grave: teto 10 mg/dia < 12 anos ou 20 mg/dia ≥ 12 anos; regimes para H. pylori exigem adaptação especializada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Doença do refluxo gastroesofágico, esofagite erosiva, úlcera gástrica/duodenal e erradicação de *H. pylori*.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Esomeprazol (aeped.es)
[S2] ESPGHAN/NASPGHAN - H.pylori 2024 (espghan.org)

186. Espiramicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Toxoplasmose na gestante para reduzir transmissão vertical	Espiramicina 1 g (3.000.000 UI) VO a cada 8 h. Iniciar diante de infecção materna no período em que espiramicina é indicada; manter até esclarecimento diagnóstico/amniocentese e definição da estratégia fetal. Diretriz MS usa espiramicina inicialmente até 16 semanas; após esse marco, avaliar sulfadiazina/pirimetamina/ácido folínico conforme investigação fetal. [S1]
Tratamento MATERNO, inclusive gestante adolescente	Não é posologia do RN nem tratamento suficiente da infecção fetal confirmada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Acompanhar no pré-natal de alto risco, sorologia e ultrassonografia; confirmar necessidade de troca conforme idade gestacional/PCR fetal. Cautela com QT, hepatopatia e interação com outros prolongadores de QT.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Tratamento da toxoplasmose adquirida na gestação para prevenção da transmissão vertical (uso materno).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MS - Nota Técnica 480/2021, disponibilidade e posologia de toxoplasmose (farmaciadada.es.gov.br)

[S2] MS - Tratamento da gestante com toxoplasmose (gov.br)

187. Espironolactona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência cardíaca; edema nefrótico; ascite cirrótica; hipertensão e hiperaldosteronismo	Como diurético/antagonista mineralocorticoide: 1-3 mg/kg/dia VO; RN em 1 tomada, crianças em 1-2 tomadas; máximo 100 mg/dia. Manter enquanto houver retenção/indicação; titular à resposta e potássio. [S1]
Neonatos, crianças/adolescentes	O teste diagnóstico de hiperaldosteronismo tem regime diferente e não deve ser confundido com manutenção. Não corrige rapidamente edema pulmonar agudo.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar K/Na, creatinina e PA. Evitar hipercalemia, anúria, insuficiência renal grave e Addison. Risco de hiperpotassemia com IECA, BRA e suplementação de K.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Insuficiência cardíaca, edema na síndrome nefrótica e ascite cirrótica; hipertensão arterial e hiperaldosteronismo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Espironolactona (aeped.es)

188. Etambutol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tuberculose pulmonar e extrapulmonar, em esquema combinado Crianças, inclusive pequenas quando indicado pela diretriz	Etambutol 20 mg/kg VO uma vez/dia; faixa 15-25 mg/kg/dia. Geralmente compõe os primeiros 2 meses da fase intensiva com outros antituberculosos; duração total do esquema depende de forma, gravidade e sensibilidade. Ao aproximar-se de 25 kg, aplicar tabela adulta do programa, sem aumentar indefinidamente pela faixa pediátrica. [S1] O limite > 6 anos do original não é universal: OMS admite crianças menores quando necessário. Não usar sozinho.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Acuidade visual e discriminação vermelho/verde antes/durante uso quando viável; interromper e avaliar alteração visual. Ajustar na insuficiência renal; vigiar adesão e peso. TB meníngea e osteoarticular têm estratégia/duração próprias do esquema combinado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Tratamento da tuberculose pulmonar e extrapulmonar em esquema combinado (uso oral acima de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] OMS - Treatment of TB in children (ncbi.nlm.nih.gov)
[S2] OMS - TB children/adolescents 2022 (ncbi.nlm.nih.gov)

189. Etomidato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução anestésica para intubação e procedimento breve	0,15-0,3 mg/kg EV lentamente, dose única; até 0,4 mg/kg se resposta insuficiente e anestesista considerar necessário. Não usar em infusão contínua ou doses repetidas para sedação prolongada. [S1]
Crianças; evitar < 6 meses salvo emergência	Não é analgésico. Uso pediátrico pode ser off-label conforme apresentação/idade.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Disponibilizar ventilação/reanimação. Supressão adrenal; evitar escolha em choque séptico quando houver alternativa apropriada. Reduzir na cirrose; observar mioclonia, apneia e excipientes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Indução da anestesia geral para intubação traqueal de emergência e procedimentos de curta duração.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Etomidato (aeped.es)

190. Etossuximida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises de ausência típicas	3-< 6 anos: iniciar 15 mg/kg/dia VO em 2 tomadas (máximo inicial 250 mg/dose); titular a cada 4-7 dias para 15-40 mg/kg/dia. ≥ 6 anos: iniciar 500 mg/dia em 2 tomadas; aumentar 250 mg/dia a cada 4-7 dias até 20-40 mg/kg/dia. Máximo 1.500 mg/dia. Uso contínuo; retirada gradual conforme controle clínico/EEG. [S1]
≥ 3 anos	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Nível usual 40-100 mg/L. Monitorar hemograma, função hepática e rash. Pode não controlar e eventualmente agravar crises tônico-clônicas em epilepsia mista. Não suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 27)
Tratamento de crises epiléticas de ausência típicas (aprovado acima de 3 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] AEP - Pediamécum: Etossuximida \(aeped.es\)](#)

191. Famotidina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DRGE/esofagite Nascimento à adolescência	< 3 meses: 0,5 mg/kg VO 24/24 h; 3-12 meses: 0,5 mg/kg/dose 12/12 h; 1-12 anos: 0,5 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 40 mg/dose; adolescentes: 20 mg 12/12 h. Cursos de até 6-8 semanas; reavaliar. Alternativa EV ≥ 1 ano: 0,25 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 20 mg/dose. [S1]
Úlcera péptica ≥ 1 ano	0,5 mg/kg/dia VO ao deitar ou em 2 tomadas, máximo 40 mg/dia. > 40 kg: duodenal 40 mg ao deitar OU 20 mg 12/12 h por 4-8 semanas; gástrica 40 mg ao deitar por 8 semanas. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reduzir dose ou ampliar intervalo na disfunção renal; risco de acúmulo/confusão. Não usar para refluxo fisiológico sem doença.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)
DRGE (suspensão aprovada desde o nascimento) e úlcera péptica (a partir de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Famotidina (aeped.es)

192. Fator VIIa Recombinante

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemofilia A/B com inibidores: sangramento Crianças/adolescentes	90 mcg/kg EV em 2-5 min; repetir inicialmente de 2-3 h até hemostasia, depois ampliar para 4-12 h conforme resposta. Sangramento leve/moderado: 2-3 doses de 90 mcg/kg a cada 3 h, eventual 4ª dose, OU dose única 270 mcg/kg. Sangramento grave pode exigir 2-3 semanas. [S1]
Hemofilia A/B com inibidores: procedimento/cirurgia Crianças/adolescentes	90 mcg/kg EV imediatamente antes; repetir após 2 h e de 2-3 h nas primeiras 24-48 h. Cirurgia maior: continuar de 2-4 h por 6-7 dias, depois de 6-8 h por até outras 2 semanas. [S1]
Deficiência de fator VII Pediatria	15-30 mcg/kg EV de 4-6 h até hemostasia, também para cobertura de procedimento. [S1]
Trombastenia de Glanzmann Pediatria com refratariedade a plaquetas/indisponibilidade	80-120 mcg/kg EV (usual 90) de 1,5-2,5 h; administrar pelo menos 3 doses e reavaliar hemostasia. [S1] Não fazer infusão contínua para Glanzmann.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hemostasia clínica e trombose/CIVD; TP corrigido não garante resposta. Evitar associação simultânea com complexo protrombínico. Dose é mcg, não mg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)
Tratamento e prevenção de sangramentos na hemofilia A ou B com inibidores, deficiência de fator VII e trombastenia de Glanzmann.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - NovoSeven (ema.europa.eu)

193. Fenilefrina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipotensão severa com necessidade de vasoconstrição Pediatria, UTI/anestesia	Fenilefrina 5-20 mcg/kg EV lenta; repetir conforme resposta e protocolo. Infusão EV contínua 0,1-0,5 mcg/kg/min, titulada à PA/perfusão. Duração até correção da causa. Não usar concentrado diretamente. [S1]
Crise hipercianótica na tetralogia de Fallot Crianças com crise refratária, equipe especializada	Bolus 5-20 mcg/kg EV lenta, máximo 500 mcg; BIC 0,1-0,5 mcg/kg/min por acesso central. Preparo: 10 mg em SF/SG 5% até volume FINAL 500 mL = 20 mcg/mL. mL/h = dose (mcg/kg/min) × peso × 60 ÷ 20. [S2] Associar medidas que aumentem fluxo pulmonar; evitar agitação e envolver cardiologia imediatamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PA/ECG contínuos, perfusão e diurese. Pode causar bradicardia reflexa e queda do débito cardíaco; corrigir hipovolemia. Vigiar isquemia e extravasamento. Teto de bolus não define teto universal da infusão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)

Tratamento de hipotensão arterial aguda severa; crises hipercianóticas da tetralogia de Fallot (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fenilefrina (aeped.es)

[S2] NHS - Hypercyanotic episodes guideline (cem.scot.nhs.uk)

194. Fenitoína Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Estado de mal epiléptico após benzodiazepínico Neonatos, crianças e adolescentes, monitorização contínua	Fenitoína 15-20 mg/kg EV de ataque, velocidade ≤ 1 mg/kg/min e nunca > 50 mg/min. Reavaliar crises e nível antes de suplementar; não repetir automaticamente uma carga completa. Diluir exclusivamente em SF 0,9%; não usar SG 5%. [S1] Carga usual 20 mg/kg; máximo absoluto depende do protocolo institucional. Não usar IM.
Crises focais e tônico-clônicas generalizadas - manutenção Crianças/adolescentes	Iniciar 5 mg/kg/dia VO em 2-3 tomadas; ajustar gradualmente por resposta e nível. Faixa de 8-10 mg/kg/dia pode ser necessária; a monografia limita a 300 mg/dia no esquema pediátrico. Tratamento contínuo. [S1]
Manutenção anticonvulsivante Neonatos	4-8 mg/kg/dia VO/EV divididos em 2 doses; individualizar por idade, albumina e níveis. Tratamento e duração conforme etiologia neonatal. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, PA e acesso durante EV; risco de arritmia, hipotensão e lesão local. Nível total usual 10-20 mg/L deve ser interpretado com albumina; preferir fração livre em hipoalbuminemia/uremia. Cinética não linear: pequenos aumentos podem causar toxicidade. Muitas interações.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)

Estado de mal epiléptico (após benzodiazepínico) e manutenção de crises focais e tônico-clônicas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fenitoína (aeped.es)

195. Fenobarbital

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Estado de mal epiléptico Crianças, exceto RN	CHEO: 10-20 mg/kg EV, máximo 1.000 mg na dose de ataque; suplementar 5-10 mg/kg a cada 15-30 min se necessário, máximo cumulativo 30 mg/kg. Alternativa AEP: ataque 10-20 mg/kg, teto inicial 300 mg; suplementação 5-10 mg/kg após 10-20 min, máximo cumulativo 40 mg/kg. Escolher um protocolo. Diluir para 5 mg/mL; infundir em ≥ 20 min, sem exceder 1 mg/kg/min nem 30 mg/min. [S1, S2] Usar velocidade pediátrica conservadora CHEO; não adotar 60 mg/min da AEP para crianças pequenas.
Crises neonatais RN	ANMF: ataque 20 mg/kg EV em 20 min (máximo 1 mg/kg/min); se persistência, 10 mg/kg a cada 30 min, máximo cumulativo 40 mg/kg. Manutenção VO/EV 3-5 mg/kg uma vez/dia, usual 4 mg/kg, iniciada 24 h após ataque. Duração guiada pela etiologia e pelo controle eletroclínico. [S3]
Manutenção de crises pediátricas RN, lactentes e crianças	VO: RN 2-5 mg/kg/dia; lactentes 5-8 mg/kg/dia; crianças 3-5 mg/kg/dia, divididos em 1-2 tomadas. Faixa adulta de referência 50-200 mg/dia; titular por resposta e nível 15-40 mcg/mL. Uso contínuo, com retirada gradual. Alternativa de manutenção EV CHEO: lactentes 5-6 mg/kg/dia; 1-5 anos 6-8; 5-12 anos 4-6; > 12 anos 1-3 mg/kg/dia, em 1-2 doses, com níveis e resposta. [S1, S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Depressão respiratória/hipotensão, sobretudo após benzodiazepínico; ECG/PA/SpO₂ no ataque. Ajustar em disfunção hepática/renal e avaliar interações indutoras. Conferir álcool benzílico/propilenoglicol da ampola no RN.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)

Estado de mal epiléptico e controle de crises convulsivas neonatais e pediátricas (atentar para restrições neonatais de marcas específicas de apresentação injetável).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fenobarbital (aeped.es)

[S2] CHEO - Fenobarbital (outreach.cheo.on.ca)

[S3] ANMF - Fenobarbital, consenso neonatal v3.1 (anmfonline.org)

196. Fenoterol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Broncoespasmo por asma ou sibilância responsiva Pediatria, aerossol 100 mcg/dose, sob supervisão	Fenoterol inalatório 100 mcg (1 jato) para alívio; se necessário, repetir 100 mcg após cerca de 5 min. Sem alívio após 2 jatos, avaliação urgente. Teto da bula: 800 mcg/dia. Duração conforme episódio; necessidade repetida exige rever controle da asma. [S1]
Broncoespasmo - nebulização < 6 anos/≤ 22 kg; 6-12 anos; > 12 anos	< 6 anos/≤ 22 kg: 0,05 mg/kg/dose, máximo 1 mg, até 3 vezes/dia; máximo 0,15 mg/kg/dia. 6-12 anos: 0,25-0,5 mg/dose; grave 1 mg, excepcional 1,5 mg até 3 vezes/dia sob hospitalização. > 12 anos: 0,5 mg/dose; grave até 1,25 mg, máximo 2 mg/dia. Intervalo mínimo 4 h. Diluir dose em SF até 3-4 mL e nebulizar; usar menor dose eficaz. [S2] Bula da solução 5 mg/mL; 1 gota=0,25 mg. Regimes hospitalares intensivos exigem protocolo distinto. Disponibilidade da marca não confirmada.
Broncoespasmo - via oral excepcional Posologias históricas de bula, somente se inalação inviável RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: < 1 ano 0,75-1,75 mg 2-3 vezes/dia; 1-6 anos 1,25-2,5 mg 3 vezes/dia; 6-12 anos 2,5 mg 3 vezes/dia; > 12 anos 2,5-5 mg 3 vezes/dia. [S2] Via inalatória é preferível; maior exposição sistêmica. Não constitui recomendação rotineira em lactentes ou bronquiolite. Curso limitado ao episódio, reavaliando imediatamente resposta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FC, tremor, K e resposta respiratória; doses excessivas podem causar arritmia, hipocalemia e acidose láctica. Usar espaçador adequado. Não substitui corticoide quando indicado nem tratamento de bronquiolite sem resposta demonstrada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)

Alívio do broncoespasmo agudo em crises asmáticas e sibilância responsiva.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Boehringer Ingelheim - Berotec HFA, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] Hipolabor - Bromidrato de fenoterol 5 mg/mL, bula profissional (cópia pública) (uploads.consultaremedios.com.br)

197. Fentanila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor intensa, analgesia para intubação e procedimentos Crianças/adolescentes	0,5-1 mcg/kg/dose EV lenta; para procedimentos podem ser necessários 1-2 mcg/kg. Administrar em 3-5 min; reavaliar e repetir pequenas doses após 2-5 min. Doses 2-4 mcg/kg são descritas para analgesia mais intensa com suporte ventilatório; não aplicar rapidamente. Duração: durante dor/procedimento. [S1] Para anestesia cirúrgica profunda, esquema individual do anestesiológista; fentanila não garante hipnose.
Analgesia/sedação em UTI pediátrica Crianças ventiladas, monitorização contínua	Ataque 1-2 mcg/kg EV lento; iniciar BIC 0,5-1 mcg/kg/h; aumentar em 0,5 mcg/kg/h. Faixa descrita para necessidade elevada 2-10 mcg/kg/h. Concentração final 10 ou 50 mcg/mL em SF 0,9%/SG 5%. $\text{mL/h} = \text{dose (mcg/kg/h)} \times \text{peso} \div \text{concentração final}$. Reavaliar diariamente e desmamar após uso prolongado. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ventilação, capnografia, sedação, PA e FC. Risco de rigidez torácica/apneia com injeção rápida; disponibilidade de ventilação e naloxona. Reduzir/titular na disfunção hepática ou renal e com outros depressores.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)

Analgesia opioide potente para dor intensa, intubação orotraqueal, sedação em UTI pediátrica e procedimentos cirúrgicos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Fentanila (outreach.cheo.on.ca)

198. Ferro Aminoácido Quelato (Glicinato Férrico)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento da deficiência de ferro/anemia ferropriva Lactentes, crianças e adolescentes	3-6 mg/kg/dia de FERRO ELEMENTAR VO, uma vez/dia ou dividido conforme tolerância, por 3-6 meses, até normalizar hemoglobina e estoques. Reavaliar Hb em 30-45 dias; esperado aumento ≥ 1 g/dL. [S1]
Profilaxia em lactentes a termo saudáveis 6-24 meses	10-12,5 mg/dia de ferro elementar VO, em dois ciclos de 3 meses, preferencialmente iniciados aos 6 e 12 meses (SBP 2026). [S1]
Profilaxia em prematuros ou baixo peso ao nascer A partir de 30 dias até 24 meses	Primeiro ano: peso ao nascer 1.500-2.500 g, 2 mg/kg/dia; 1.000-< 1.500 g, 3 mg/kg/dia; < 1.000 g, 4 mg/kg/dia. Calcular com peso ATUAL. Depois, 1 mg/kg/dia dos 12 aos 24 meses, continuamente. [S1] Considerar transfusões e aporte de fórmula/alimentos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose refere-se ao elemento ferro, não à massa do quelato ou complexo polimaltosado. Conferir concentração elementar da bula; não somar suplementos inadvertidamente. Não administrar em sobrecarga de ferro; guardar fora do alcance de crianças.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)
Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] SBP 2026 - Deficiência de ferro e anemia ferropriva \(sbp.com.br\)](#)

199. Ferro Polimaltosado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento da deficiência de ferro/anemia ferropriva Lactentes, crianças e adolescentes	3-6 mg/kg/dia de FERRO ELEMENTAR VO, uma vez/dia ou dividido conforme tolerância, por 3-6 meses, até normalizar hemoglobina e estoques. Reavaliar Hb em 30-45 dias; esperado aumento ≥ 1 g/dL. [S1]
Profilaxia em lactentes a termo saudáveis 6-24 meses	10-12,5 mg/dia de ferro elementar VO, em dois ciclos de 3 meses, preferencialmente iniciados aos 6 e 12 meses (SBP 2026). [S1]
Profilaxia em prematuros ou baixo peso ao nascer A partir de 30 dias até 24 meses	Primeiro ano: peso ao nascer 1.500-2.500 g, 2 mg/kg/dia; 1.000-< 1.500 g, 3 mg/kg/dia; < 1.000 g, 4 mg/kg/dia. Calcular com peso ATUAL. Depois, 1 mg/kg/dia dos 12 aos 24 meses, continuamente. [S1] Considerar transfusões e aporte de fórmula/alimentos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose refere-se ao elemento ferro, não à massa do quelato ou complexo polimaltosado. Conferir concentração elementar da bula; não somar suplementos inadvertidamente. Não administrar em sobrecarga de ferro; guardar fora do alcance de crianças.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 28)
Profilaxia e tratamento da anemia ferropriva em pediatria e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] SBP 2026 - Deficiência de ferro e anemia ferropriva \(sbp.com.br\)](#)

200. Fexofenadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica ≥ 2 anos	2-11 anos: 30 mg VO 12/12 h; ≥ 12 anos: 120 mg 24/24 h. Durante sintomas/exposição, com reavaliação. [S1]
Urticária crônica ≥ 6 meses	6-23 meses: 15 mg VO 12/12 h; 2-11 anos: 30 mg 12/12 h; ≥ 12 anos: 180 mg 24/24 h. Uso contínuo enquanto ativa, reavaliando controle. [S1] Não aplicar a dose de rinite a < 2 anos; autorização depende da apresentação brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Separar de antiácidos Al/Mg e evitar sucos de frutas na administração. Verificar ajuste da bula específica em disfunção renal, pois recomendações regulatórias diferem.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Tratamento da rinite alérgica (suspensão a partir de 2 anos) e urticária crônica (a partir de 6 meses); comprimidos acima de 12 anos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fexofenadina (aeped.es)

201. Filgrastim (G-CSF)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Neutropenia associada à quimioterapia Pediatria, oncologia	Filgrastim 5 mcg/kg/dia SC ou EV, uma vez/dia, começando ≥ 24 h após quimioterapia e nunca nas 24 h anteriores. Manter até recuperação pós-nadir; bula descreve até 2 semanas ou neutrófilos ≥ 10.000/mm ³ após nadir. Em ciclos seguintes, ajuste por resposta. [S1]
Neutropenia congênita grave Crianças	Iniciar 6 mcg/kg/DOSE SC, 2 vezes/dia (12 mcg/kg/dia). Titular à menor dose que mantenha resposta clínica e neutrófilos adequados; tratamento contínuo. [S1] Não confundir com 5 mcg/kg/dia usado após quimioterapia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma diferencial/plaquetas, dor óssea, esplenomegalia/ruptura esplênica, sintomas pulmonares e reações alérgicas. Diagnóstico hematológico e seguimento de alterações clonais em neutropenia congênita. Não usar próximo à quimioterapia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Tratamento da neutropenia associada à quimioterapia oncológica e neutropenia congênita grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\]](#) FDA/DailyMed - Neupogen, revisão julho 2026 (dailymed.nlm.nih.gov)

202. Fitomenadiona (Vitamina K1)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia da doença hemorrágica por deficiência de vitamina K	Fitomenadiona IM, dose única nas primeiras 6 h: ≤ 1.500 g, 0,5 mg; > 1.500 g, 1 mg. Via IM preferida. Alternativa oral quando IM recusada: 2 mg no nascimento, repetir 2 mg em 2-4 semanas e 6-8 semanas; confirmar protocolo local. [S1, S3]
Recém-nascidos	Oral oferece proteção menos confiável; não aplicar em má absorção/colestase.
Sangramento por deficiência de vitamina K	1 mg EV lenta, uma dose, com reavaliação de INR e necessidade de hemoderivados. Diluir apresentação sem conservante para 1 mg/mL; administrar lentamente conforme produto. [S1]
Recém-nascidos	Sangramento grave exige reposição imediata de fatores: vitamina K isolada não atua de imediato.
Reversão de antagonista da vitamina K	Sem sangramento e necessidade futura de anticoagular: 0,5-2 mg EV lenta conforme protocolo. Sangramento sem risco imediato: CHEO descreve 2-5 mg; hemorragia ameaçadora à vida: 5 mg EV, com complexo protrombínico/plasma e INR seriado. Repetição orientada por INR, não automática. [S2]
Crianças; conforme INR, sangramento e necessidade de anticoagular	CHEO cita SC/EV; via SC tem absorção menos previsível. Não usar dose adulta máxima de rotina.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de reação anafilactoide EV; monitorizar e evitar infusão rápida. Usar produto apropriado ao RN, sem álcool benzílico. INR, função hepática e causa da deficiência devem orientar seguimento.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Profilaxia e tratamento da doença hemorrágica do recém-nascido; reversão de coagulopatia por antagonistas da vitamina K.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Vitamina K1 neonatal (outreach.cheo.on.ca)
[S2] CHEO - Fitomenadiona (outreach.cheo.on.ca)
[S3] CPS - Profilaxia neonatal com vitaminaK (cps.ca)

203. Flucitosina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Meningite criptocócica, sempre em combinação	Flucitosina 25 mg/kg/dose VO a cada 6 h (100 mg/kg/dia), associada à anfotericina B, por pelo menos 2 semanas de indução; prolongar conforme cultura do LCR e evolução. [S1]
Crianças/adolescentes	Se anfotericina inviável, NIH descreve combinação com fluconazol; infectologia define alternativa.
Candidíase invasiva grave, especialmente SNC/resgate	25 mg/kg/dose VO a cada 6 h, associada à anfotericina B. Na candidíase do SNC, manter até resolução clínica, microbiológica e radiológica; cursos podem alcançar 6 semanas. [S2, S3]
Crianças; neonatos com monitorização farmacológica	Não é monoterapia nem adjuvante universal para toda candidemia. Neonatos exigem individualização e níveis.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar intervalo pela função renal e diálise; monitorar hemograma, transaminases, creatinina e concentração. Evitar pico > 100 mg/L; NIH orienta nível 2 h pós-dose 40-60 mg/L. Toxicidade medular/hepática e resistência rápida em monoterapia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Terapia combinada em meningite criptocócica e candidíase invasiva grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] NIH - Cryptococcosis, pediatric OIs (clinicalinfo.hiv.gov)
- [S2] IDSA - Candidiasis guideline (idsociety.org)
- [S3] AEP - Flucitosina (aeped.es)

204. Fluconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase orofaríngea Crianças	Fluconazol VO/EV: 6 mg/kg no dia 1; depois 3 mg/kg uma vez/dia, por ≥ 14 dias. Ajustar gravidade/resposta; máximo habitual correspondente 200 mg/dia. [S1]
Candidíase esofágica Crianças	6 mg/kg no dia 1; depois 3-6 mg/kg VO/EV uma vez/dia; casos graves até 12 mg/kg/dia, máximo 400 mg/dia. Manter ≥ 21 dias e ≥ 14 dias após resolução de sintomas. [S1]
Candidemia/candidíase invasiva suscetível Crianças e neonatos, seleção por espécie e exposição prévia	12 mg/kg/dia VO/EV uma vez/dia na população pediátrica; máximo 800 mg/dia. Candidemia sem foco metastático: tratar ≥ 14 dias após primeira cultura negativa e resolução dos sinais; focos profundos prolongam tratamento. [S2] Neonatos: IDSA usa 12 mg/kg a cada 24 h; não importar intervalo neonatal antigo de 48-72 h para doença invasiva.
Criptococose - consolidação após indução Pediatria, especialmente HIV	12 mg/kg no primeiro dia; depois 10-12 mg/kg VO/EV uma vez/dia, máximo 800 mg/dia, por ≥ 8 semanas; iniciar após controle clínico e cultura líquida negativa. Depois avaliar profilaxia secundária. [S3]
Profilaxia em prematuros de extremo baixo peso < 1.000 g em UTI com candidíase invasiva > 10%	3-6 mg/kg VO/EV, 2 vezes/semana, por 6 semanas. [S2] Estratégia por risco da unidade; não profilaxia universal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajuste renal em doses repetidas, monitorização hepática e QT. Interações CYP relevantes; verificar espécie/resistência. Não somar dose de ataque e manutenção no mesmo dia sem plano explícito.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Candidíase orofaríngea, esofágica, candidemia, meningite criptocócica (consolidação) e profilaxia antifúngica em prematuros de extremo baixo peso.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] AEP - Pediamécum: Fluconazol (aeped.es)
- [S2] IDSA - Candidiasis guideline (idsociety.org)
- [S3] NIH - Cryptococcosis pediatric Ols (clinicalinfo.hiv.gov)

205. Fludrocortisona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal; insuficiência adrenal primária com deficiência mineralocorticoide	VO: RN/lactentes, 0,1-0,2 mg/dia; > 2 anos, 0,05-0,1 mg/dia, em 1-2 tomadas. HAC pode exigir até 0,3 mg/dia conforme renina, eletrólitos e PA. Tratamento contínuo; ajustar com crescimento e ingestão de sal. [S1]
Recém-nascidos/lactentes e crianças	Associar glicocorticoide quando indicado; lactentes com HAC frequentemente precisam suplementação de NaCl.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, Na/K, renina, edema e crescimento. Excesso causa hipertensão/hipocalemia. Não substitui hidrocortisona na crise adrenal; doses de estresse de hidrocortisona fornecem atividade mineralocorticoide temporária.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)

Reposição mineralocorticoide na hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal e insuficiência adrenal primária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Fludrocortisona (aeped.es)

206. Flumazenil

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão da sedação e depressão respiratória induzidas por benzodiazepínicos	0,01 mg/kg EV em 15-30 s (máx. 0,2 mg); repetir a cada 1 min até 5 doses, teto total 0,05 mg/kg OU 1 mg, o menor. CHEO descreve 0,01-0,02 mg/kg/dose; usar menor dose inicial. Se ressedação recorrente selecionada: infusão 5-10 mcg/kg/h, concentração 0,1 mg/mL; mL/h = dose × peso ÷ 100. [S1]
≥ 1 ano, exposição iatrogênica selecionada	Infusão é off-label. Não substitui suporte ventilatório; pode não reverter totalmente depressão respiratória.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em uso crônico de benzodiazepínicos, epilepsia tratada com benzodiazepínicos ou intoxicação por tricíclicos/mista pró-convulsivante. Monitorar ressedação, convulsões e arritmia; prolongar observação na disfunção hepática.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Reversão específica da sedação e depressão respiratória induzidas por benzodiazepínicos (a partir de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Flumazenil (outreach.cheo.on.ca)

207. Fluoxetina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno depressivo maior ≥ 8 anos	VO 10 mg 24/24 h; elevar para 20 mg/dia após avaliação de tolerância/resposta. Baixo peso pode permanecer em 10 mg por várias semanas. Regime usual de bula pediátrica: 10-20 mg/dia. AEP descreve alternativa especializada até 40 mg/dia. Tratamento contínuo com avaliação inicial frequente e manutenção após remissão. [S1]
TOC ≥ 7 anos	VO 10 mg/dia; após cerca de 2 semanas, 20 mg/dia. Baixo peso: faixa 20-30 mg/dia; maior peso/adolescentes: 20-60 mg/dia. Tratamento contínuo; avaliar resposta em semanas, não em dias. [S1] Off-label no Brasil conforme produto; doses pré-escolares não são esquema rotineiro.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ideação suicida, ativação/manias, peso/crescimento e síndrome serotoninérgica. Evitar IMAO; após fluoxetina aguardar 5 semanas antes de IMAO. Reduzir frequência/dose na hepatopatia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)

Tratamento do transtorno depressivo maior e TOC (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fluoxetina (aeped.es)

208. Fluticasona (Furoato / Propionato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Controle da asma - PROPIONATO inalatório 1-4 anos; > 4 anos; > 16 anos	1-4 anos: 100 mcg de 12/12 h com espaçador/máscara. > 4-16 anos: 50-200 mcg de 12/12 h (usual 50-100). > 16 anos: 100-250 mcg de 12/12 h na asma leve; 250-500 na moderada; 500-1.000 na grave sob especialista. Uso contínuo; reduzir ao mínimo eficaz. [S1]
Rinite alérgica - FUROATO nasal ≥ 2 anos	2-11 anos: 27,5 mcg em CADA narina uma vez/dia (55 mcg/dia); se resposta insuficiente, 55 mcg/narina/dia (110 mcg/dia), reduzindo após controle. ≥ 12 anos: iniciar 55 mcg/narina/dia, manutenção 27,5 mcg/narina/dia. Uso regular durante sintomas/exposição. [S2]
Rinite alérgica - PROPIONATO nasal ≥ 4 anos	4-11 anos: 50 mcg em CADA narina uma vez/dia; máximo 50 mcg/narina 2 vezes/dia (200 mcg/dia). ≥12 anos: 100 mcg/narina uma vez/dia; se necessário, 100 mcg/narina 2 vezes/dia (máximo 400 mcg/dia). Usar a menor dose eficaz. [S3, S5]
Dermatites - PROPIONATO creme ≥ 1 ano	Creme 0,05%: camada fina 1-2 vezes/dia, até melhora, pelo menor período; bula admite até 4 semanas, porém crianças geralmente necessitam curso mais curto. Reavaliar em 2-4 semanas se sem melhora. Prevenção de recidiva selecionada: 1 aplicação/dia, 2 dias/semana, com emoliente. [S4]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sais, vias e dispositivos não são intercambiáveis. Vigiar crescimento, candidíase oral/epistaxe, atrofia cutânea e supressão adrenal com doses altas/ritonavir. Enxaguar boca após inalação. Não usar corticoide inalatório isolado como resgate agudo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 29)
Tratamento de manutenção da asma persistente, rinite alérgica e dermatite atópica (creme a partir de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] GSK - Flixotide Spray (br.gsk.com)
- [S2] GSK - Avamys (br.gsk.com)
- [S3] GSK - Flixonase (br.gsk.com)
- [S4] GSK - Flutivate creme (br.gsk.com)
- [S5] V Consenso Brasileiro sobre Rinites, 2024 - tabela 11 (idade >11 anos)

209. Fomepizol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intoxicação por metanol ou etilenoglicol Crianças/adolescentes, uso especializado	15 mg/kg EV em 30 min; após 12 h, 10 mg/kg a cada 12 h por 4 doses; depois 15 mg/kg 12/12 h. Diluir em SF 0,9%/SG 5%; infusão nunca em bolus. Suspende quando tóxico < 20 mg/dL, paciente assintomático e pH normal. Na hemodiálise: doses a cada 4 h OU BIC 1-1,5 mg/kg/h; concentração final 10 mg/mL, mL/h = dose × peso ÷ 10. [S1] Off-label pediátrico respaldado por relatos e protocolo hospitalar. Volume de 100 mL descrito no CHEO deve ser adaptado com farmácia para criança com restrição hídrica; não confundir metanol mg/dL com mmol/L.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar gasometria, ânion/osmol gap, função renal, eletrólitos e concentração do tóxico. Na diálise ajustar também a dose ao início/fim; correção da acidose e diálise podem ser urgentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)
Antídoto específico para intoxicação aguda grave por metanol ou etilenoglicol.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] CHEO - Fomepizol (outreach.cheo.on.ca)

210. Formoterol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção da asma, sempre associada a corticoide inalatório	Formoterol inalatório: 12 mcg de 12/12 h; AEP descreve 12-24 mcg de 12/12 h, máximo 48 mcg/dia, reservado às apresentações autorizadas e gravidade. Uso contínuo, titulando à menor dose eficaz. [S1]
> 6 anos; dose depende do dispositivo	Não equivaler automaticamente cápsula de 12 mcg às doses de 4,5/6 mcg em combinações; esquema MART exige bula/protocolo da combinação.
DPOC	Não há esquema pediátrico de DPOC estabelecido; não extrapolar a indicação adulta para crianças. [S1]
Indicação essencialmente adulta	Indicação original mantida como restrição clínica.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES LABA isolado é contraindicado na asma; não substitui corticoide. Tremor, taquicardia, hipocalemia e QT; avaliar técnica/dispositivo e controle antes de aumentar. Não usar cápsulas inalatórias por via oral.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)

Broncodilatador de longa ação associado a corticosteroides inalatórios na manutenção da asma e DPOC.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Formoterol (aeped.es)

211. Fosfomicina Trometamol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Cistite aguda não complicada	Fosfomicina trometamol 3 g VO, dose única. Não repetir diariamente por rotina. [S1]
Adolescentes do sexo feminino > 12 anos	Não é esquema para pielonefrite, sepse ou ITU complicada. Doses repetidas têm evidência incerta e maior risco de eventos adversos.
Cistite em crianças menores	Sem regime de trometamol confirmado nesta monografia para recomendação pediátrica rotineira; formulação europeia de 2 g foi retirada após revisão regulatória em 2020. [S1, S2]
≤ 12 anos	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não substituir por dose de fosfomicina cálcica ou dissódica EV.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reavaliar febre/dor lombar e cultura. Administrar afastada de alimento conforme bula. Selecionar alternativa na insuficiência renal grave e infecção complicada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)

Tratamento de cistite aguda não complicada (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label selecionado).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Fosfomicina (aeped.es)

[S2] EMA - Revisão regulatória das formulações de fosfomicina,2020 (ema.europa.eu)

212. Furosemida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca e sobrecarga volêmica; crise hipertensiva com excesso de volume	EV 0,5-2 mg/kg/dose a cada 6-12 h inicialmente; ajustar à diurese. Se resposta insuficiente após ≥ 2 h, incrementos de 1 mg/kg/dose até teto excepcional de 6 mg/kg/dose e 200 mg/dose. Infundir lentamente, nunca ≥ 4 mg/min. BIC alternativa: ataque 0,1-2 mg/kg (máximo 40 mg), depois 0,05-0,4 mg/kg/h; teto absoluto individualizado 10-40 mg/h. Final 1 ou 10 mg/mL em SF/SG 5%; mL/h = mg/kg/h $\times$ peso $\div$ mg/mL. Manter até euvolemia e reavaliar. [S1, S3]
Crianças/adolescentes	A indicação hipertensiva é adjuvante quando há hipervolemia; não é esquema universal da emergência hipertensiva.
Edema pulmonar/insuficiência cardíaca no RN	RN com idade gestacional < 31 semanas: 1 mg/kg EV a cada 24 h, máximo 1 mg/kg/DIA; alguns usos crônicos permitem intervalo de 48 h. RN ≥ 31 semanas: iniciar 1 mg/kg/dose EV; máximo 2 mg/kg/dose a cada 12-24 h. Doses > 1 mg/kg infundir em 15-30 min. Ajustar à idade pós-natal, função renal e resposta; reavaliar diariamente. [S2, S3]
Neonatos	Intervalo neonatal exige idade gestacional/pós-natal e função renal.
Edema/insuficiência cardíaca e sobrecarga volêmica - manutenção oral	VO: início habitual 0,5-2 mg/kg/dose (não ultrapassar 20-40 mg na dose inicial), a cada 6-24 h; titular gradualmente, teto 6 mg/kg/DIA e 600 mg/dia. No edema agudo com VO viável, AEP descreve 2 mg/kg uma vez, incrementos 1-2 mg/kg a cada 6-8 h, teto 6 mg/kg/dose e 200 mg/dose. Usar menor dose eficaz; duração conforme retenção de volume. [S3]
Lactentes/crianças, exceto RN	Tetos elevados pertencem a tratamento especializado; na emergência pulmonar prefere-se via EV.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Diurese, peso, balanço, Na/K/Mg/Ca e creatinina. Ototoxicidade com doses altas/rápidas e aminoglicosídeos; risco de alcalose/hipovolemia. Sem benefício em anúria irreversível.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)

Edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga volêmica e crises hipertensivas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Furosemida (outreach.cheo.on.ca)

[S2] CHEO - Furosemida neonatal (outreach.cheo.on.ca)

[S3] AEP - Furosemida, atualização maio 2025 (aeped.es)

213. Gabapentina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais: adjuvante ≥ 6 anos; adolescência	6 anos em diante: iniciar 10-15 mg/kg/dia VO em 3 tomadas; titular em cerca de 3 dias para 25-35 mg/kg/dia, máximo 50 mg/kg/dia. Adolescentes: 300 mg dia 1; 300 mg 12/12 h dia 2; 300 mg 8/8 h dia 3, titulando a 900-3.600 mg/dia em 3 tomadas. [S1] Idade de bula brasileira pode ser ≥ 12 anos; < 12 anos é off-label conforme produto.
Dor neuropática, espasticidade/alterações do tônus e irritabilidade neurológica Neonato-23 meses; 2-11 anos; ≥ 12 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: neonato-23 meses 5 mg/kg/dose: 1 vez no dia 1; 2 vezes no dia 2; 3 vezes/dia a partir do dia 3; titular até 10 mg/kg/dose 3 vezes/dia. 2-11 anos: iniciar 5-10 mg/kg/dose, máximo inicial 300 mg, com mesma progressão; titular até 20 mg/kg/dose 3 vezes/dia, máximo 600 mg/dose. ≥ 12 anos: 300 mg no dia 1 →300 mg 12/12 h dia 2 →300 mg 8/8 h dia 3; titular até 3.600 mg/dia. Aumentos a cada 3-7 dias ou mais lentamente. [S2] Off-label paliativo; reavaliar conforto/função e sedação. Retirada gradual, ajuste renal. Não extrapolar máximos maiores à faixa < 2 anos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajuste obrigatório na insuficiência renal. Monitorar sonolência, ataxia e depressão respiratória com opioides. Suspender gradualmente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)
Terapia adjuvante de crises focais (a partir de 12 anos); tratamento de dor neuropática; espasticidade e irritabilidade neurológica (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Gabapentina (aeped.es)
[S2] APPM 2024 - Gabapentina,pp 93-95 (appm.org.uk)

214. Galsulfase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Mucopolissacaridose VI	1 mg/kg EV uma vez por semana, infundir em pelo menos 4 h. Diluir em SF 0,9%: volume de 100 mL para ≤ 20 kg, 250 mL para > 20 kg. Usar filtro 0,2 micra, sem agitar. Tratamento contínuo com metas funcionais e bioquímicas. [S1]
Crianças/adolescentes	Pré-medicação com anti-histamínico, com ou sem antipirético, 30-60 min antes; ajustar velocidade por tolerância.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar anafilaxia, obstrução de via aérea, febre e reação infusional; interromper diante de reação grave. Não misturar a outras drogas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)
Tratamento de reposição enzimática na mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Galsulfase (outreach.cheo.on.ca)

215. Ganciclovir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
CMV congênito sintomático moderado/grave	Ganciclovir 6 mg/kg/dose EV a cada 12 h por 2-6 semanas se muito grave ou VO inviável; depois valganciclovir 16 mg/kg/dose VO de 12/12 h para completar 6 meses de tratamento antiviral total. [S1]
RN, iniciar preferencialmente no primeiro mês	CPS atualizada 2025/reafirmada 2026; reavaliar dose pelo crescimento.
Infecção grave por CMV em imunossuprimidos	5 mg/kg/dose EV a cada 12 h por 14-21 dias de indução. Manutenção, quando indicada: 5 mg/kg EV uma vez/dia, 7 dias/semana, OU 6 mg/kg uma vez/dia, 5 dias/semana. Duração da manutenção conforme órgão, imunidade e virologia. [S2]
Crianças/adolescentes	Infundir em 1 h; nunca bolus. Ajuste renal obrigatório.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma/plaquetas, creatinina e transaminases; mielossupressão e toxicidade reprodutiva. Dose neonatal antiga de 7,5 mg/kg/12 h do CHEO não foi adotada: priorizada CPS atual. Preparo citotóxico pela farmácia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)

Tratamento da infecção grave por citomegalovírus (CMV) em imunossuprimidos e citomegalovirose congênita sintomática (off-label IV pediátrico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Canadian Paediatric Society - Congenital CMV (cps.ca)

[S2] CHEO - Ganciclovir (outreach.cheo.on.ca)

216. Gentamicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sepse neonatal/infecção por Gram-negativos RN, idade pós-menstrual	Gentamicina 5 mg/kg/dose EV: < 30 semanas, a cada 48 h; 30-34+6 semanas, a cada 36 h; ≥ 35 semanas, a cada 24 h. Ajustar pelo nível/renal; sob indometacina/ibuprofeno, ANMF amplia intervalo em 12 h. Preparo 2 mg/mL em SF; primeira dose em 5 min, demais em 5-30 min. Reavaliar suspensão em 36-48 h se culturas negativas e infecção excluída. [S1]
Infecção grave por Gram-negativos e ITU Crianças/adolescentes	7 mg/kg EV uma vez/dia (teto inicial CHEO 360 mg até dosagem sérica); alternativa convencional 2,5 mg/kg/dose a cada 8 h (7,5 mg/kg/dia; teto inicial 120 mg/dose). Infundir em 30 min. Duração conforme foco/cultura; evitar prolongar aminoglicosídeo após alternativa dirigida. [S2] Teto inicial não é máximo absoluto após farmacocinética individual.
Endocardite - sinergia quando indicada Crianças/adolescentes	1 mg/kg/dose EV a cada 8 h (3 mg/kg/dia), máximo inicial 80 mg/dose até níveis. Duração e necessidade dependem do agente, prótese e antibiótico associado; não aplicar curso universal. [S2] Não usar dose de sinergia como monoterapia de sepse.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar diurese/creatinina, audição e níveis. No RN, vale < 2 mg/L; ajustar pelo nível de 22 h conforme ANMF, diferente de vale. Insuficiência renal/hipotermia exigem níveis antes de redose. Evitar nefro/ototóxicos e misturar com betalactâmicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)
Sepse neonatal (em associação), infecções graves por bacilos Gram-negativos suscetíveis, infecções urinárias e endocardite.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ANMF - Gentamicin 2024 (anmfonline.org)

[S2] CHEO - Gentamicina (outreach.cheo.on.ca)

217. Glicerina (Glicerol)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação distal e impactação fecal retal	Via retal: 1 supositório pediátrico apropriado à faixa etária a cada 24 h quando necessário; < 2 anos, apresentação de lactente; 2-12 anos, infantil; > 12 anos, adulto. Duração curta; evitar > 7 dias consecutivos sem reavaliação. [S1]
Lactentes/crianças/adol escentes	A massa por supositório varia: não intercambiar tamanhos. Não constitui tratamento completo da impactação proximal/extensa.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar em suspeita de obstrução, abdome agudo, sangramento/inflamação retal; interromper se resistência à introdução ou dor.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 30)

Alívio sintomático da constipação intestinal distal e impactação fecal (via retal).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Glicerol (aeped.es)

218. Glicose

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipoglicemia grave/sintomática Nascimento-18 anos	Glicose 200 mg/kg EV = SG 10% 2 mL/kg, em 5-10 min. Seguir com infusão de glicose, verificar glicemia em 30 min e depois de hora em hora, ajustando à resposta. Não administrar solução concentrada sem diluição apropriada. [S1]
Infusão para manter euglicemia após correção Crianças, titulada por glicemia	AEP descreve necessidades: < 1 ano 7-9 mg/kg/min; 2-6 anos 6-7; 7-14 anos 5-6; 15-18 anos 4-5. Iniciar conforme idade/contexto e titular; RN/prematuros usam protocolo neonatal. mL/h = taxa (mg/kg/min) × peso × 60 ÷ concentração (mg/mL). SG 10%=100 mg/mL. De 1 a < 2 anos, a tabela AEP não oferece faixa explícita: o protocolo PCH orienta iniciar SG 10% à taxa hídrica de manutenção e titular pela glicemia, com ajuste endocrinológico se necessário. [S2, S1]
Nutrição parenteral e veículo de diluição Pediatria, prescrição individual RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	NP: calcular aporte de glicose em mg/kg/min dentro do total energético/hídrico, titulado à glicemia e fase da doença; não há volume fixo universal. Como veículo: volume/concentração obedecem à compatibilidade e concentração final do medicamento diluído. [S1, S2] Veículo não é indicação para bolus ou aporte calórico automático.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Acesso central para concentrações elevadas; vigiar extravasamento, hiperglicemia, Na/K e sobrecarga. Coletar amostra crítica quando possível sem atrasar tratamento. Reduzir infusão gradualmente se risco de hipoglicemia recorrente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)

Correção de hipoglicemia, suporte calórico em nutrição parenteral e veículo de diluição para medicamentos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - Hypoglycaemia (pch.health.wa.gov.au)

[S2] AEP - Hipoglucemia, protocolo endocrinologia (static.aeped.es)

219. Glucagon

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipoglicemia grave quando acesso venoso indisponível Crianças/adolescentes	Glucagon IM/SC: < 25 kg, 0,5 mg; ≥ 25 kg, 1 mg, dose única. Alternativa ponderal 0,02-0,2 mg/kg, máximo 1 mg. Reavaliar em 10-15 min e obter acesso para glicose se resposta inadequada. Após despertar, ofertar carboidrato. [S1]
Choque por intoxicação por betabloqueador Pediatria, toxicologia/UTI	50-150 mcg/kg EV de ataque, máximo 10 mg, diluído em SG 5% e administrado lentamente; se resposta, BIC 0,3-2 mcg/kg/min titulada à perfusão. Manter enquanto necessário, com tratamento toxicológico associado. Concentração final hospitalar $0,04 \text{ mg/mL} = 40 \text{ mcg/mL}$ em SG 5%; $\text{mL/h} = \text{dose}(\text{mcg/kg/min}) \times \text{peso} \times 60 \div 40$. [S1, S2] Dose toxicológica pela AEP; concentração pelo CHEO. Monitorar vômito/aspiração; não atrasar suporte e outras terapias.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não adiar glicose EV esperando efeito. Eficácia menor com depleção de glicogênio/jejum prolongado; monitorar glicemia, K, PA e vômitos/aspiração. Contraindicado em feocromocitoma; cautela em insulinoma. Soluções eletrolíticas podem precipitar glucagon.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)

Tratamento de emergência da hipoglicemia grave quando o acesso IV não está disponível; intoxicação por betabloqueadores (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Glucagon (aeped.es)

[S2] CHEO - Glucagon, concentração para BIC (outreach.cheo.on.ca)

220. Gluconato de Cálcio 10%

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipocalcemia sintomática Crianças/adolescentes	Gluconato de cálcio EV: 0,11 mmol/kg de CÁLCIO ELEMENTAR em 5-10 min, máximo 4,4 mmol (20 mL da solução 0,22 mmol/mL). Com solução contendo 0,22 mmol/mL: 0,5 mL/kg, máximo 20 mL. Repetição/infusão contínua conforme cálcio ionizado e resposta. Diluição periférica citada: 10 mL(2,2 mmol) até 50 mL SF=0,044 mmol/mL. [S1] Fonte arredonda o teto para 4,5 mmol/20 mL; catálogo adota 4,4 mmol correspondente a 20 mL exatos na concentração 0,22 mmol/mL. Conferir potência da ampola.
Hipercalcemia com alteração eletrocardiográfica Crianças/adolescentes	0,15 mmol/kg de cálcio elementar EV/IO, máximo 6,6 mmol. Solução 0,22 mmol/mL: 0,68 mL/kg, máximo 30 mL. Administrar em 2-5 min se instável, 15-20 min se estável; reavaliar ECG e repetir até 2 vezes se necessário. [S2] Estabiliza miocárdio, mas não reduz potássio.
Hipocalcemia, hipercalcemia ou toxicidade por magnésio Neonatos	0,15 mmol/kg de cálcio elementar EV/IO; repetir conforme resposta/ionizado. Na circulação espontânea, infundir lentamente 10-60 min; situações de parada exigem protocolo de ressuscitação. Manutenção neonatal: 0,15 mmol/kg/dose de 4/4-6/6 h, titulada; teto 3 mmol/kg/dia. [S3]
Hipermagnesemia sintomática Crianças/adolescentes	CHEO descreve 60-100 mg/kg de gluconato de cálcio 10% EV, máximo 3 g, em cenário de toxicidade por magnésio/ressuscitação; reavaliar antes de repetir. Em paciente com pulso, administrar lentamente e monitorar ECG. [S4] Massa refere-se ao SAL gluconato, não ao cálcio elementar.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Confirmar potência elementar da ampola: formulações 10% variam ≈ 0,22-0,23 mmol/mL. ECG contínuo, acesso e extravasamento; risco de necrose/bradicardia. Não misturar com bicarbonato/fosfato; ceftriaxona+cálcio é especialmente perigosa no RN. Cautela com digoxina.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)

Tratamento de urgência da hipocalcemia sintomática, hipercalcemia com alteração eletrocardiográfica e hipermagnesemia.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] NHS Tayside - Hypocalcaemia, revisão 2025 (rightdecisions.scot.nhs.uk)

[S2] RCH - Hyperkalaemia 2024 (rch.org.au)

[S3] ANMF - Calcium gluconate (seslhd.health.nsw.gov.au)

[S4] CHEO - Gluconato de cálcio (outreach.cheo.on.ca)

221. Gramicidina + Triancinolona + Neomicina + Nistatina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatoses inflamatórias/pruriginosas com infecção bacteriana ou fúngica superficial secundária	Aplicar camada fina da associação tópica sobre a área afetada, 2-3 vezes/dia. Usar a menor quantidade e duração necessárias; reavaliar resposta precocemente e interromper se infecção não controlada. A bula não define número fixo de dias. [S1]
Pediatria, área limitada	Cada g contém triancinolona 1 mg, neomicina base 2,5 mg, gramicidina 0,25 mg e nistatina 100.000 U.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar em olhos/ouvidos, lesões virais ou tuberculose cutânea, pele extensamente lesada nem sob oclusão. Crianças têm maior risco de supressão adrenal. Neomicina: sensibilização, nefro/ototoxicidade se absorção extensa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)

Dermatoses inflamatórias e pruriginosas cutâneas com infecção bacteriana ou fúngica secundária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bula profissional Omcilon-A M - cópia pública (uploads.consultaremedios.com.br)

222. Granisetrona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Náuseas/vômitos associados à quimioterapia > 2 anos	10-40 mcg/kg/dia EV em 1-2 doses; dose inicial 15-60 min antes da quimioterapia. CHEO cita teto 3 mg/dose; não somar doses acima da faixa diária ponderal sem oncologia. Duração acompanha janela emetogênica do regime. [S1]
Náuseas/vômitos pós-operatórios > 4 anos	20-40 mcg/kg EV, dose única, máximo 1 mg. Pode ser administrada antes da indução, antes da reversão anestésica ou no pós-operatório. [S1] Faixa abaixo de 4 anos não validada nesta fonte. EV lenta ou diluída em pequeno volume de SF/SG 5% por 5 min.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar QT, constipação e síndrome serotoninérgica com agentes serotoninérgicos. Corrigir K/Mg; sem ajuste renal usual.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)
Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia antineoplásica (a partir de 2 anos) e pós-operatório.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] CHEO - Granisetrona (outreach.cheo.on.ca)

223. Haloperidol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Agitação aguda grave Crianças/adolescentes em emergência, quando medidas ambientais insuficientes	Haloperidol 0,05-0,1 mg/kg/dose VO/IM a cada 6 h se necessário, máximo 5 mg/dose. Teto do protocolo UNC: 15-40 kg 6 mg/dia; > 40 kg 15 mg/dia, dependente de exposição prévia. Iniciar no menor extremo em virgem de antipsicótico; reavaliar após cada dose. [S1] Faixa < 15 kg exige especialista; não extrapolar teto adulto.
Delirium em paciente crítico Pediatria, uso off-label em UTI RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	AEP descreve EV 0,013-0,1 mg/kg/dose; iniciar no menor extremo, reavaliar em 15-30 min antes de repetir. Não adotar faixa extrema 0,28 mg/kg citada em séries como dose rotineira. Curso breve, suspensão ao controlar delirium/causa. [S2] Não há máximo diário universal validado para delirium pediátrico; ECG e protocolo institucional obrigatórios.
Tiques graves/síndrome de Tourette ≥ 6 anos, respeitar indicação regulatória local	VO: 6-13 anos iniciar 0,25-0,5 mg/dia em 2-3 tomadas; usual 0,5-3 mg/dia, máximo 3 mg/dia. > 13 anos: mesmo início; usual 2-6 mg/dia, teto 6-10 mg/dia sob especialista. Titular lentamente; uso contínuo com reavaliação funcional. [S2] AEP refere aprovação Tourette > 10 anos; 6-10 anos pode ser off-label.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES QTc, K/Mg, PA, distonia/acatisia, sedação e síndrome neuroléptica maligna. Maior risco EV; usar apenas solução imediata, nunca decanoato EV. Evitar Parkinson, coma e associação indiscriminada com sedativos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)
Agitação psicomotora grave, delirium hiperativo, tiques e síndrome de Tourette (uso oral a partir de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] UNC Children’s - Acute agitation pathway 2023 (med.unc.edu)

[S2] AEP - Pediamécum: Haloperidol (aeped.es)

224. Hedera Helix

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tosse produtiva com necessidade de facilitar expectoração	Extrato seco 7 mg/mL: 2-7 anos, 17,5 mg VO 3 vezes/dia (2,5 mL/dose); > 7 anos, 35 mg 3 vezes/dia (5 mL/dose). Usar por pelo menos 1 semana; manter 2-3 dias após cessarem sintomas. [S1]
≥ 2 anos, extrato específico de Hedera helix	Doses são do extrato padronizado da bula Abrilar; outros extratos não são automaticamente equivalentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado < 2 anos. Reavaliar dispneia, febre, escarro purulento ou persistência. Pode causar alergia, náuseas/diarreia; contém sorbitol, evitar intolerância hereditária à frutose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)
Expectorante e secretolítico vegetal para tosse produtiva em afecções broncopulmonares (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FQM - Abrilar, bula profissional (fitoterapiabrasil.com.br)

225. Heparina Não Fracionada

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento de tromboembolismo venoso Neonatos, lactentes, crianças/adolescentes	HNF 75 U/kg EV em 10 min; depois < 1 ano 28 U/kg/h, ≥ 1 ano 20 U/kg/h. Titular para anti-Xa 0,35-0,7 U/mL ou TTPa correspondente do laboratório. Manter fase parenteral até estratégia de anticoagulação definida. Final 100 U/mL; mL/h=U/kg/h×peso÷ 100. Duração TOTAL de anticoagulação: TEV provocado selecionado, 6 semanas; se embolia pulmonar, recorrência, trombo oclusivo persistente em 6 semanas, câncer, anticorpos antifosfolípides persistentes/trombofilia maior ou risco contínuo, em geral 3 meses ou individualizar. TEV não provocado: 6-12 meses. Recomendações condicionais ASH/ISTH 2025. [S1, S2, S5] O prazo total pode ser completado com outro anticoagulante; não implica manter HNF EV durante todos esses meses.
Profilaxia de TEV Pediatria, risco individual RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não existe regime universal de HNF profilática para todas as crianças; não usar anticoagulação sistêmica rotineira apenas por cateter. Em cardiopatia/shunt ou cateter com risco específico, AEP descreve 10-15 U/kg/h EV, pelo período de risco, com hematologia/cardiologia. [S1] Não substituir profilaxia individual por dose terapêutica.
Hemofiltração/hemodiálise contínua Pediatria, circuito extracorpóreo	Bolus 20-50 U/kg antes do filtro; iniciar RN/lactentes 10 U/kg/h e crianças/adolescentes 5 U/kg/h. Manutenção 5-20 U/kg/h, ajustada a TTPa pós-filtro 1,5-2 vezes o controle ou ACT 180-220 s. Duração enquanto circuito em uso. [S1]
Hemodiálise intermitente Crianças	Diretriz pediátrica descreve infusão no circuito 20-30 U/kg/h, ajustada a coagulação do circuito e sangramento; duração conforme sessão. Bolus e interrupção final individualizados pelo serviço renal. [S3] Não extrapolar as doses fixas de adultos.
Circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca Crianças, perfusionista/anestesia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Esquema estudado: 300 U/kg EV antes da CEC, suplementado por ACT/nível de heparina; alvo histórico ACT > 450 s. Protocolos individualizados podem requerer dose diferente, especialmente no RN. Administrar e reverter conforme plano de perfusão; não usar infusão de TEV como substituto. [S4] Variação 200-450 U/kg relatada em crianças não constitui faixa de dose livre; titulação é obrigatória.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sangramento, hemograma/plaquetas, anti-Xa/TTPa; evitar HNF em HIT. Evitar IM e produtos com álcool benzílico no RN. Distinguir U/mL de U/kg/h; CEC, diálise e TEV têm metas diferentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)

Anticoagulação em circuitos de hemodiálise e circulação extracorpórea; profilaxia e tratamento tromboembólico (fórmulas sem álcool benzílico em neonatos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Heparina (aeped.es)

[S2] CHEO - Heparina (outreach.cheo.on.ca)

[S3] European Paediatric Dialysis Working Group - Hemodialysis in children (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S4] Gruenwald/Manlihot - Anticoagulation in pediatric CPB (ject.edpsciences.org)

[S5] ASH/ISTH - Tratamento de TEV pediátrico, atualização 2025 (hematology.org)

226. Hidralazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Emergência hipertensiva e hipertensão refratária quando VO inviável Crianças/adolescentes	0,1-0,2 mg/kg/dose EV a cada 4-6 h, máximo 20 mg/dose. Diluir em SF 0,9% para 1 mg/mL; administrar em 3-5 min ou infusão em 15 min. Titulação hospitalar pode atingir 1,7-3,5 mg/kg/dia divididos em 4-6 doses. Usar enquanto houver necessidade parenteral e migrar a manutenção após estabilização. AEP descreve lactentes 0,1-0,5 mg/kg/dose EV/IM a cada 6-8 h; respeitar máximo 20 mg/dose e resposta. Limite de velocidade EV 0,2 mg/kg/min; transição VO usual em 24-48 h. [S1, S2] Não reduzir abruptamente PA; reavaliar antes de repetir, pois efeito pode ser prolongado.
Hipertensão arterial crônica refratária Lactentes/crianças - uso off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 0,75-1 mg/kg/DIA em 2-4 tomadas, máximo inicial 25 mg/dose; titular em 3-4 semanas. Tetos: lactentes 5 mg/kg/dia; crianças 7,5 mg/kg/dia, sem exceder 200 mg/dia. Tratamento contínuo com reavaliação; geralmente associado a diurético/betabloqueador. [S2] Insuficiência renal/hepática exige intervalo maior ou dose menor.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES PA/FC contínuas; risco de hipotensão e taquicardia reflexa. Evitar SG 5% no preparo. Na disfunção renal, ampliar intervalo; tratamento prolongado pode causar síndrome lúpus-like.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 31)
Tratamento de emergências hipertensivas graves e hipertensão arterial refratária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Hidralazina (outreach.cheo.on.ca)
[S2] AEP - Hidralazina, novembro 2022 (aeped.es)

227. Hidroclorotiazida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão; edema de insuficiência cardíaca ou síndrome nefrótica	Hidroclorotiazida 1-2 mg/kg/DIA VO em 1-2 tomadas. Lactentes < 6 meses podem necessitar até 3 mg/kg/dia sob monitorização. Teto da AEP: lactentes 37,5 mg/dia; crianças 100 mg/dia. Ajustar ao controle da PA/edema; duração conforme doença. [S1]
Crianças; lactentes	
Hipercalcúria idiopática persistente/sintomática	1,5-2,5 mg/kg VO uma vez pela manhã, ajustando à calciúria e tolerância; respeitar teto etário. Meta usual: cálcio urinário < 4 mg/kg/24 h após 2 anos. Reavaliar tentativa de retirada após cerca de 1 ano de controle. [S2]
Crianças sob nefrologia	Iniciar medidas dietéticas adequadas; não restringir cálcio alimentar indiscriminadamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar Na/K/Mg/Ca, função renal, PA e balanço. Pode causar hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia e hiperuricemia. Evitar em anúria e corrigir distúrbios hidroeletrólíticos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Tratamento de hipertensão arterial e edemas associados à insuficiência cardíaca ou síndrome nefrótica; hipercalcúria idiopática.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Hidroclorotiazida (aeped.es)

[S2] SEPEAP - Hipercalcúria, *Pediatría Integral* (pediatriaintegral.es)

228. Hidrocortisona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crise adrenal Pediatria	Hidrocortisona 50-100 mg/m ² EV/IM de ataque, máximo 100 mg; seguir 50-100 mg/m ² /DIA divididos de 6/6 h. Alternativa inicial por peso 2-3 mg/kg, máximo 100 mg. Reduzir para dose de estresse/VO ao estabilizar. Não confundir mg/m ² /dia com mg/m ² /dose. [S1]
Reposição fisiológica Pediatria	8-10 mg/m ² /DIA VO divididos em 3 tomadas, maior pela manhã; HAC 10-15 mg/m ² /dia em 3 tomadas, podendo exigir ajuste especializado. Tratamento contínuo; estresse leve/moderado geralmente 2-3 vezes a dose habitual temporariamente. [S2]
Choque refratário a fluidos/vasoativos, insuficiência adrenal suspeita Crianças, UTI	Ataque 2 mg/kg EV, máximo 100 mg; CHEO: depois 1 mg/kg/dose de 6/6 h, máximo 50 mg/dose. Alternativa por superfície 50-100 mg/m ² /dia, máximo 200 mg/dia, fracionada ou contínua. Manter até resolução hemodinâmica e reduzir conforme exposição. [S1, S3]
Exacerbação grave de asma quando VO inviável ≥ 2 anos	4 mg/kg/dose EV a cada 6 h, máximo 100 mg/dose; mudar para corticoide VO assim que tolerado e completar curso sistêmico curto, em geral 3-5 dias se transição a prednisona/prednisolona; cursos de 1-2 dias correspondem a dexametasona, não à hidrocortisona isolada. [S4, S6] Não associar simultaneamente doses plenas equivalentes de outro corticoide.
Dermatites/eczema - tratamento tópico Pediatria	Hidrocortisona 1% creme/pomada: camada fina 2 vezes/dia até resolver inflamação; suspender ou reduzir após controle e manter emoliente. Reavaliar uso persistente, sobretudo face/dobras. [S5] Dose tópica é por área, não mg/kg.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Na crise, corrigir hipoglicemia/volemia e monitorar Na/K. Doses referem-se à hidrocortisona equivalente da bula, não à massa do sal. Uso sistêmico prolongado requer desmame; monitorar infecção, glicemia, PA, crescimento e eixo adrenal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Crise adrenal aguda, reposição na insuficiência adrenal crônica, choque refratário, asma grave, dermatite atópica leve (tópica).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Hidrocortisona (aeped.es)
[S2] SmPC - Hydrocortisone oral solution (medicines.org.uk)
[S3] CHEO - Hidrocortisona (outreach.cheo.on.ca)
[S4] NHS NECTAR - Severe asthma, versão 2023 (newcastle-hospitals.nhs.uk)
[S5] RCH - Eczema 2024 (rch.org.au)
[S6] CPS - Manejo da exacerbação aguda de asma (cps.ca)

229. Hidroxicloroquina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Lúpus eritematoso sistêmico, artrite idiopática juvenil e afecções reumáticas selecionadas	3-5 mg/kg/dia de SULFATO de hidroxicloroquina VO em 1-2 tomadas, máximo 400 mg/dia. Para uso crônico, manter teto de 5 mg/kg/dia do peso real para limitar toxicidade retiniana. Tratamento contínuo com avaliação de atividade após semanas/meses. [S1, S2]
Crianças, bula citada ≥ 6 anos	200 mg do sulfato = 155 mg de base; não aplicar conversão duas vezes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Avaliação oftalmológica basal e seguimento conforme risco. Monitorar função renal/hepática e sintomas visuais; ajustar em doença renal/hepática. Risco de QT e hipoglicemia; evitar em retinopatia estabelecida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)
Tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, artrite idiopática juvenil e afecções reumáticas (bula acima de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Hidroxicloroquina (aeped.es)
[S2] AAO 2026 - Hydroxychloroquine retinopathy screening (aao.org)

230. Hidróxido de Alumínio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pirose e hiperacidez - indicação adulta no original	Fonte CONITEC descreve suspensão 60 mg/mL: 300-600 mg VO por dose, 4 vezes/dia, antes das refeições e ao deitar. Este é esquema de referência da indicação adulta, não dose pediátrica. [S1]
Adultos; sem extrapolação pediátrica automática	Para criança, não foi validado regime antiácido seguro nesta fonte; priorizar diagnóstico/tratamento etiológico.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em insuficiência renal por acúmulo de alumínio. Constipação, hipofosfatemia e interações por redução de absorção. Uso > 2 semanas aumenta risco e requer reavaliação; não tratar sintomas persistentes indefinidamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Alívio sintomático da pirose e hiperacidez gástrica (uso adulto na bula).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CONITEC - Relatório 833, hidróxido de alumínio 60 mg/mL (gov.br)

231. Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio (+ Simeticona)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dispepsia, pirose, epigastralgia e gases - associação com simeticona	Associação da bula Mylanta Plus: 10-20 mL VO entre refeições e ao deitar, máximo 60 mL/dia; não manter dose máxima por > 2 semanas. Por 10 mL: Al(OH) ₃ equivalente 612 mg, Mg(OH) ₂ 800 mg e simeticona 60 mg. [S1]
> 12 anos	Volume só se aplica à concentração estudada; “gel seco de alumínio 80 mg/mL” equivale a 61,2 mg/mL de Al(OH) ₃ .
Mesmas queixas em menores; associação sem simeticona	Não há dose pediátrica validada pela bula citada. Sem simeticona, não atribuir efeito específico sobre gases. Selecionar formulação e faixa autorizada antes de calcular dose. [S1]
≤ 12 anos ou outra concentração/produto	Não extrapolar volume da associação para outro antiácido.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar insuficiência renal grave; risco de hipermagnesemia e acúmulo de alumínio. Separar de ferro, quinolonas, tetraciclina e outros fármacos conforme bula. Persistência de dor requer investigação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Alívio da dispepsia ácida, pirose, epigastralgia e distensão abdominal por gases.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Johnson & Johnson - Mylanta Plus, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

232. Hidróxido Férrico em Sacarose (Sacarato Férrico)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência de ferro na DRC - manutenção ≥ 2 anos	Sacarato de ferro EV 0,5 mg/kg/dose, máximo 100 mg. Em hemodiálise: a cada 2 semanas por 12 semanas; DRC sem diálise ou diálise peritoneal com eritropoetina: a cada 4 semanas por 12 semanas. Diluir em SF para 1-2 mg/mL e infundir 5-60 min. [S1] Regime de MANUTENÇÃO da bula; reposição do déficit total pediátrico não está estabelecida nela.
Falha/intolerância ao ferro oral, incluindo DII Pediatria, uso off-label	CHEO descreve 2 mg/kg EV semanal, com ajuste ao déficit; teto 7 mg/kg/dose e 300 mg/dose no paciente sem DRC. DII em estudo pediátrico: 2,5-3,5 mg/kg/dose, máximo 200 mg, em 2 infusões separadas por 1 semana; reavaliar estoques e necessidade de novos ciclos. Diluir em SF e infundir 30-60 min no esquema de DII. [S2, S3] Não administrar déficit calculado inteiro em uma dose; total e número de infusões dependem de Hb, ferritina, peso e perdas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Todas as doses em FERRO ELEMENTAR. Monitorar PA/reações durante e ≥ 30 min após; evitar sobrecarga e avaliar infecção ativa. Conferir ferritina/TSAT, Hb e inflamação; ferro sérico nas primeiras 48 h pode ser enganoso.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Tratamento da anemia ferropriva grave com intolerância ou falha ao ferro oral (doença renal crônica, DII).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/DailyMed - Venofer (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] CHEO - Ferro sacarato (outreach.cheo.on.ca)

[S3] Danko/Weidkamp - Iron sucrose in pediatric IBD, estudo primário (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

233. Hidroxiquinolina + Trolamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Amolecimento/remoção de tampão de cerume	Solução otológica hidroxiquinolina 0,4 mg/mL + trolamina 140 mg/mL: instilar 5 gotas no ouvido afetado, 3 vezes/dia. Manter ouvido voltado para cima por 5 min após aplicação. Duração conforme remoção/reavaliação; bula não fixa número de dias. [S1]
Adulto e pediátrico, conforme bula	Não exceder dose/frequência: segurança de doses maiores não estabelecida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar diante de perfuração timpânica, inflamação, secreção ou dor de ouvido sem avaliação. Evitar contato ocular e ingestão; possível dermatite. Confirmar integridade do tímpano antes de irrigação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)
Remoção de rolha de cerume e limpeza do conduto auditivo externo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Novartis - Cerumin, bula aprovada 16/09/2025 (cópia pública) (onepharma.com.br)

234. Hidroxizina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prurido, urticária e dermatites pruriginosas ≥ 12 meses conforme formulação	Hidroxizina VO 1-2 mg/kg/DIA divididos em 2-3 tomadas. Máximo 2 mg/kg/dia se ≤ 40 kg; se > 40 kg, máximo 100 mg/dia. Menor dose e duração eficazes; reavaliar sintomas. [S1]
Sedação/premedicação Crianças, ambiente supervisionado	0,6 mg/kg VO, dose única cerca de 1 h antes do procedimento; pode haver dose de 0,6 mg/kg na noite anterior conforme protocolo. Respeitar teto diário por peso. [S1] Monitorar sedação e respiração; não é técnica isolada para procedimento doloroso.
Ansiedade População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico de tratamento continuado da ansiedade estabelecido na fonte consultada; não converter dose de prurido em tratamento psiquiátrico sem avaliação. [S1] Risco de sedação e QT deve pesar na decisão.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar QT longo, bradicardia relevante, hipocalemia/hipomagnesemia e outros fármacos que prolongam QT. Reduzir na insuficiência renal; hepatopatia requer redução. Potencializa depressores do SNC.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)
Prurido alérgico, urticária, dermatite atópica; sedação adjuvante e ansiedade (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Hidroxizina (aeped.es)

235. Hidroxocobalamina (Vitamina B12)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intoxicação por cianeto Todas as idades, emergência	Hidroxocobalamina 70 mg/kg EV, máximo 5 g, em 15 min; se necessário repetir 70 mg/kg, máximo 5 g, em 15 min-2 h conforme gravidade. Dose total máxima 140 mg/kg ou 10 g. Reconstituir 5 g com 200 mL SF = 25 mg/mL. [S1]
Deficiência clínica de vitamina B12 < 2 anos; crianças maiores/adolescentes	< 2 anos sintomáticos: 1.000 mcg IM/dia por 3 doses; reavaliar e manter plano hematológico por ≥ 6 semanas. Maiores: 1.000 mcg IM uma vez, seguido de B12 oral 1.000 mcg/dia por 6 dias, depois semanal por 6 semanas; confirmar se absorção oral é adequada. [S2] A fase oral pode utilizar outra forma de B12; não ingerir preparação antidótica.
Deficiência irreversível/má absorção de B12 Pediatria, apresentação IM apropriada	Alternativa AEP: 1.000 mcg IM a cada 2-3 dias, total 5 doses; depois 1.000 mcg IM a cada 3 meses. Manutenção permanente se causa irreversível. [S3]
Acidemia metilmalônica responsiva Pediatria, centro metabólico	Com homocistinúria: 1.000 mcg IM/dia, ajustável a dias alternados; casos selecionados até 2.000 mcg/dose ou 200 mcg/kg/dia nos pequenos. Sem homocistinúria: 1.000 mcg IM/semana como esquema descrito, reavaliando resposta bioquímica. Tratamento contínuo se responsivo. [S3]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Doses antidóticas são em mg; reposição/metabólica em mcg. Verificar álcool benzílico no produto IM infantil. Monitorar K/hemograma e marcadores metabólicos; após antídoto, PA/creatinina e interferência em análises/hemodiálise.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 32)

Antídoto específico para intoxicação aguda por cianeto; tratamento de deficiência de vitamina B12 e acidemia metilmalônica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Hidroxocobalamina (outreach.cheo.on.ca)

[S2] RCH - Vitamin B12 guideline (rch.org.au)

[S3] AEP - Pediamécum: Hidroxocobalamina (aeped.es)

236. Ibuprofeno

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Febre e dor leve/moderada ≥ 6 meses	5-10 mg/kg/dose VO a cada 6-8 h se necessário; máximo 40 mg/kg/dia, sem exceder 400 mg/dose para analgesia habitual. Usar menor duração eficaz, reavaliando febre persistente e causa da dor. [S1]
Fechamento de canal arterial Prematuros, apresentação EV neonatal	Ciclo de 3 doses EV, a cada 24 h: 10 mg/kg na primeira, depois 5 mg/kg na segunda e terceira. Infundir cada dose em 15 min; iniciar após primeiras 6 h de vida quando indicado. Segundo ciclo pode ser considerado se persistência/reabertura após reavaliação. [S1] Não intercambiar mg de ibuprofeno com massa do sal; suspender doses subsequentes se oligúria/anúria.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar desidratação, insuficiência renal, sangramento, NEC e cardiopatia ducto-dependente. Não associar outros AINE. Monitorar diurese, plaquetas, creatinina e ecocardiograma no prematuro.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Febre e dor leve a moderada (gotas e suspensões contraindicadas abaixo de 6 meses); fechamento do canal arterial em prematuros (formulação intravenosa neonatal IV).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Ibuprofeno (aeped.es)

237. Idarucizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão urgente da dabigatrana em sangramento grave/cirurgia	Não há dose pediátrica estabelecida: a informação EMA declara segurança/eficácia não estabelecidas < 18 anos. Em evento pediátrico, decisão de resgate por hematologia/toxicologia; não extrapolar automaticamente o regime adulto de 5 g. [S1]
Indicação regulatória em ADULTOS	Indicação original explicitamente adulta, mantida para evitar uso pediátrico indevido.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reverte dabigatrana, não heparinas ou inibidores Xa. Avaliar testes de coagulação, última dose e função renal. Risco trombótico reaparece após reversão; sorbitol é relevante em intolerância hereditária à frutose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Reversão urgente da anticoagulação por dabigatrana em hemorragias graves ou cirurgias de emergência (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] EMA - Praxbind, informação profissional (ema.europa.eu)

238. Idursulfase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Mucopolissacaridose II (Hunter) Crianças/adolescentes	0,5 mg/kg EV a cada semana, diluir a dose em 100 mL de SF 0,9%, inicialmente em 3 h; reduzir progressivamente até 1 h se tolerado. Iniciar 8 mL/h por 15 min; incrementos de 8 mL/h a cada 15 min, máximo 100 mL/h, com filtro de 0,2 micrômetro; ajustar ao volume efetivo e nunca ultrapassar 8 h de infusão. Tratamento contínuo. [S1] O tempo final e os mL/h dependem do volume final prescrito, não só da massa da enzima.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de anafilaxia e reações infusivas; monitorar PA, FC, FR e SpO 2. Maior risco com doença respiratória; considerar adiar durante episódio febril/respiratório importante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (p. 33; redação corrigida)
Tratamento de reposição enzimática na mucopolissacaridose tipo II (síndrome de Hunter).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP - Pediamécum: Idursulfase (aeped.es)

239. Iloprosta

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial pulmonar avançada	Iloprosta inalatória: iniciar 2,5 mcg/dose; aumentar a 5 mcg/dose conforme resposta/tolerância, 6-9 vezes/dia. Doses referem-se à quantidade entregue pelo nebulizador específico. Usual máximo correspondente: 45 mcg/dia. Tratamento contínuo; reavaliação hemodinâmica especializada. [S1]
Lactentes, crianças e adolescentes	
	Off-label pediátrico. AEP relata até 100 mcg/dia em literatura, que não é teto seguro estabelecido nem recomendação rotineira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hipotensão, síncope, hemoptise e broncoespasmo. Edema pulmonar pode indicar doença veno-oclusiva; interromper/investigar. Evitar interrupção inadvertida na doença grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)

Tratamento da hipertensão arterial pulmonar em classes funcionais avançadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Iloprosta (aeped.es)

240. Imiglucerase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Gaucher tipos 1 e 3 - manifestações não neurológicas Crianças/adolescentes	Imiglucerase 15-60 U/kg EV a cada 2 semanas; início com 60 U/kg a cada 2 semanas quando doença significativa/óssea. 15 U/kg pode melhorar citopenias e organomegalia, sem eficácia óssea equivalente. Tratamento contínuo, ajustado às metas. Diluir em SF para 100-200 mL; primeira infusão ≤ 0,5 U/kg/min, seguintes ≤ 1 U/kg/min. [S1]
Gaucher tipo 3 - manifestações neurológicas Crianças/adolescentes	Não há esquema de imiglucerase comprovadamente eficaz para sintomas neurológicos; o regime acima visa manifestações sistêmicas. [S1]
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não prometer reversão do acometimento neurológico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de reação à infusão/anafilaxia e anticorpos; monitorar hemograma, volume visceral, osso e crescimento. Reconstituição/filtro conforme bula, sem agitar. Ajustes de frequência/dose por centro de referência.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Terapia de reposição enzimática a longo prazo na doença de Gaucher tipos 1 e 3.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] EMA - Cerezyme, informação profissional (ema.europa.eu)

241. Imipenem + Cilastatina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções intra-abdominais graves, sepse e infecções polimicrobianas/ESBL suscetíveis	Dose pelo componente IMIPENEM: 15-25 mg/kg/dose EV de 6/6 h (=60-100 mg/kg/dia); máximo 4 g/dia. Diluir para 2,5-5 mg/mL. Doses ≤ 500 mg: infusão 15-30 min; > 500 mg: 40-60 min. Duração exige foco, controle de fonte e microbiologia; reavaliar diariamente para descalonamento. [S1]
≥ 3 meses	Cilastatina acompanha na proporção da formulação; não somar os componentes para calcular mg/kg. Não é escolha para meningite pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar na disfunção renal; neurotoxicidade/convulsões. Interação importante com valproato e ganciclovir. Não usar diluente de formulação IM contendo lidocaína por via EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)

Infecções intra-abdominais graves, sepse, infecções polimicrobianas por bactérias produtoras de ESBL (aprovado a partir de 3 meses).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Imipenem/cilastatina (outreach.cheo.on.ca)

242. Imipramina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Enurese noturna, adjuvante temporário após avaliação ≥ 6 anos	Imipramina 25 mg VO cerca de 1 h antes de deitar; se resposta insuficiente após 1 semana: < 12 anos até 50 mg/noite; ≥ 12 anos até 75 mg/noite. Nunca exceder 2,5 mg/kg/dia nem 75 mg/dia. Para perda urinária no começo da noite, dividir 25 mg à tarde e dose remanescente à noite. Reavaliar benefício e tentar retirada gradual após período de controle. [S1]
Depressão e transtorno do pânico - indicação adulta do original População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não transportar automaticamente os esquemas adultos. Depressão em adolescentes tem doses históricas de bula, mas indicação/segurança pediátrica e alternativas exigem psiquiatria; pânico pediátrico sem esquema validado nesta fonte. [S1] Uso de tricíclico requer decisão especializada; não é primeira escolha para depressão pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, PA/FC e interações antes/durante uso; risco de arritmia, retenção urinária, glaucoma, convulsão e toxicidade letal em sobredose. Dispensar quantidade segura; retirar gradualmente. Evitar IMAO.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Enurese noturna refratária (acima de 5 anos); depressão e transtornos de pânico em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FDA/DailyMed - Imipramine hydrochloride (dailymed.nlm.nih.gov)

243. Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia neonatal: mãe HBsAg positiva Recém-nascidos	Imunoglobulina humana anti-hepatite B 0,5 mL IM, dose única, preferencialmente nas primeiras 12 h, junto da vacina em local distinto; se atraso, administrar o mais cedo possível, até 7 dias de vida. [S1, S2] Volume corresponde à apresentação para profilaxia neonatal; conferir potência do produto.
Profilaxia após exposição percutânea, mucosa ou sexual Crianças/adolescentes suscetíveis conforme vacinação/anti-HBs	0,06 mL/kg IM, geralmente dose única, o mais cedo possível. Exposição sexual: até 14 dias; para acidente percutâneo, iniciar idealmente em 24 h e avaliar benefício após 7 dias. Não respondedores após 2 séries de vacina: 2 doses, intervalo 1 mês, quando indicado. [S1] Indicação e associação à vacina dependem do status da fonte, imunidade e imunodepressão.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não converter mL em UI sem potência real do lote. Não misturar à vacina; documentar vacinação/anti-HBs e organizar seguimento sorológico. Contraindicação principal: anafilaxia ao produto prévio.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)

Profilaxia pós-exposição ao vírus da hepatite B e prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos de mães HBsAg positivas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SES-GO - Guia CRIE 2024 (goias.gov.br)

[S2] CDC - Perinatal hepatitis B vaccine administration (cdc.gov)

244. Imunoglobulina Humana Antirrábica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia pós-exposição da raiva quando imunoglobulina indicada	Imunoglobulina HUMANA antirrábica 20 UI/kg, dose única. Infiltrar o máximo possível em/ao redor de todas as feridas; remanescente IM distante da vacina conforme CDC. Administrar no dia 0, ou até o 7º dia após primeira vacina. [S1]
Todas as idades; não previamente imunizado	Não confundir com soro equino, cuja dose é diferente. Vacina e imunoglobulina em locais distintos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não exceder 20 UI/kg de rotina, nem aplicar na mesma seringa/local da vacina. Diluição depende do produto: usualmente SF; HyperRab 300 UI/mL requer SG 5%. Feridas digitais: evitar pressão/isquemia. Completar vacinação e protocolo nacional de PEP.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Imunização passiva pós-exposição ao vírus da raiva em acidentes graves.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] CDC - Rabies biologics, atualização agosto 2026 \(cdc.gov\)](#)

245. Imunoglobulina Humana Antitetânica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia do tétano em ferimento de alto risco quando indicada Todas as idades, inclusive RN em risco	Imunoglobulina humana antitetânica 250 UI IM, dose única, em local diferente da vacina. Indicação conforme tipo de ferida, doses vacinais, imunodepressão e risco neonatal. Limpeza/desbridamento e vacinação complementam a proteção. [S1]
Tratamento de tétano manifesto, inclusive neonatal Todas as idades	500 UI IM, dose única. Doses históricas de 3.000-6.000 UI podem constar de protocolos, porém CDC e nota brasileira 2025 indicam 500 UI como tão eficaz e menos dolorosa. Não repetir sem indicação específica. [S1] Não neutraliza toxina já ligada às terminações nervosas; exige UTI, controle de espasmos e tratamento do foco.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Distinguir imunoglobulina HUMANA de soro antitetânico equino. Não usar apresentação IM por via EV/intratecal. Vigiar reação alérgica e atualizar vacinação, pois a doença não confere imunidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 33)
Profilaxia do tétano em ferimentos de alto risco e tratamento do tétano acidental e neonatal.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] SESAU-AL - Nota informativa 07/2025 (saude.al.gov.br)
[S2] CDC - Clinical care of tetanus (cdc.gov)

246. Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Kawasaki Crianças	IGIV 2 g/kg EV, dose TOTAL única; alternativa histórica: 0,4 g/kg/dia por 4-5 dias (total 1,6-2 g/kg). Infusão conforme produto, habitualmente prolongada em 8-12 h; associar tratamento anti-inflamatório/antiplaquetário do protocolo. Refratariedade exige reavaliação, não repetição automática. [S1, S3]
Púrpura trombocitopênica imune Crianças com indicação de tratamento	0,8-1 g/kg EV no dia 1, podendo repetir uma vez em até 3 dias; alternativa 0,4 g/kg/dia por 2-5 dias. Escolher pelo sangramento/necessidade de elevar plaquetas. [S1]
Imunodeficiências primárias humorais Crianças	Ataque 0,4-0,8 g/kg EV; manutenção 0,2-0,8 g/kg a cada 3-4 semanas, ajustando infecções e IgG pré-infusão. Terapia contínua, individualizada. [S1]
Síndrome de Guillain-Barré Crianças	0,4 g/kg/dia EV por 5 dias (total 2 g/kg). Velocidade conforme produto e tolerância; monitorar respiração/autonomia. [S1]
Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) Pediatria hospitalizada	IGIV 2 g/kg EV de dose TOTAL pelo peso ideal, máximo 100 g (ACR). Avaliar função ventricular e volume antes; na disfunção cardíaca, alternativa 1 g/kg/dia por 2 dias, mantendo teto total 100 g. Protocolo Le Bonheur permite dividir o total durante 24 h. Associar corticoide quando indicado. [S2, S4]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Infusão e diluente dependem da marca/concentração; não existe velocidade universal em mL/kg/h. Riscos: anafilaxia, hemólise, trombose, meningite asséptica e lesão renal. Monitorar PA, função renal, hidratação e reações; ajustar vacinas vivas após IGIV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Doença de Kawasaki, púrpura trombocitopênica imune, imunodeficiências primárias, síndrome de Guillain-Barré, SIM-P associada à Covid-19 (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Imunoglobulina EV (aeped.es)

[S2] Le Bonheur Children's Hospital - MIS-C guideline (lebonheur.org)

[S3] RCH - Kawasaki disease (rch.org.au)

[S4] ACR - Clinical Guidance MIS-C, versão 3,2022 (rcastoragev2.blob.core.windows.net)

247. Indometacina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Inflamações articulares e febre inflamatória	1-4 mg/kg/dia VO em 2-4 tomadas; máximo 200 mg/dia. > 14 anos: 25-50 mg 2-3 vezes/dia; máximo 200 mg/dia. Menor dose e duração eficaz; uso crônico exige reavaliação reumatológica. [S1]
> 2 anos	Não é antitérmico pediátrico rotineiro.
Fechamento do canal arterial	EV: primeira dose 0,2 mg/kg; duas doses adicionais de 12-24 h conforme idade na primeira dose: < 48 h, 0,1 mg/kg; 2-7 dias, 0,2 mg/kg; > 7 dias, 0,25 mg/kg. Infundir em 20-30 min. Diurese > 1 mL/kg/h: intervalo 12 h; 0,6-1: 24 h; < 0,6: suspender. Segundo ciclo somente após reavaliação. [S1]
RN prematuros	Usar formulação neonatal e diluente sem conservante.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em NEC, sangramento, trombocitopenia, insuficiência renal e cardiopatia ducto-dependente. Monitorar diurese/creatinina, plaquetas, perfusão intestinal e eco.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Tratamento de inflamações articulares e febre (acima de 2 anos); fechamento do canal arterial em recém-nascidos prematuros.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Indometacina (aeped.es)

248. Insulina Asparte

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM 1 e DM 2: cobertura prandial e correção de hiperglicemia ≥ 1 ano, esquema individual	Insulina asparte SC imediatamente antes da refeição; em situações selecionadas logo após comer. A dose total de TODAS as insulinas costuma ser 0,5-1,5 U/kg/dia; aproximadamente 50-70% pode ser componente prandial distribuído entre refeições. Não administrar essa dose diária inteira como um bolus. Ajustar cada refeição à ingestão de carboidrato, glicemia, fator de sensibilidade e insulina ativa. Uso contínuo. [S1] Não existe dose fixa segura por “hiperglicemia” sem glicemia-alvo, sensibilidade, cetonas e doses prévias. Sem máximo absoluto universal; valores altos exigem avaliação de resistência/erro.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar glicemia/CGM, hipoglicemia, K e cetonas quando indicado. Insuficiência renal/hepática pode reduzir necessidades. Bomba SC é possível com formulação autorizada; correção EV exige ambiente monitorizado e diluição validada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2: cobertura prandial ultrarrápida e correção de hiperglicemia (a partir de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP - Pediamécum: Insulina asparte (aeped.es)

249. Insulina Degludeca

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM 1: início de insulina basal ≥ 1 ano	Degludeca SC uma vez/dia no mesmo horário. Em virgem de insulina, estimar dose inicial TOTAL de todas as insulinas em 0,2-0,4 U/kg/dia; atribuir aproximadamente 1/3-1/2 à degludeca e o restante às refeições com insulina rápida. Ajustar individualmente; uso contínuo. [S1]
DM 1/DM 2: troca de basal prévia ≥ 1 ano	Iniciar degludeca em 80% da dose DIÁRIA total anterior de insulina basal longa/intermediária, SC uma vez/dia. Rever glicemias; aumentos preferencialmente a cada 3-4 dias. [S1]
DM 2: início de basal sem insulina prévia Pediatria ≥ 1 ano, necessidade individual RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula FDA traz 10 U SC uma vez/dia como início em DM 2, mas a escolha pediátrica precisa considerar peso, glicemia, cetose e tratamento concomitante. Dose fixa não deve ser aplicada automaticamente a criança pequena. [S1] Evidência pediátrica de DM 2 é extrapolada; endocrinologia ajusta início e titulação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não administrar EV, em bomba, diluir ou misturar. U100/U200: caneta já mostra unidades, sem conversão; nunca aspirar conteúdo da caneta com seringa. Monitorar hipoglicemia, função renal/hepática; não usar para cetoacidose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Controle glicêmico basal no diabetes mellitus tipo 1 (a partir de 1 ano) e tipo 2.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/DailyMed - Tresiba (dailymed.nlm.nih.gov)

250. Insulina Glargina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM 1 - insulina basal Glargina U100 ≥2 anos; U300 ≥6 anos	SC 1 vez/dia, no mesmo horário. Estimar inicialmente a necessidade TOTAL de insulina em 0,4-1 U/kg/dia; aproximadamente 30-50% como basal e restante prandial. Titular pelas glicemias de jejum/noturnas; não aplicar a dose total como glargina. Tratamento contínuo, sem máximo universal. [S1, S2, S3] Remissão parcial e crianças pequenas podem precisar de doses menores; puberdade pode exigir maiores.
DM 2 - controle basal ≥6 anos para U300; demais apresentações conforme registro	U300: iniciar 0,2 U/kg SC 1 vez/dia e titular conforme glicemia. U100: individualizar basal segundo necessidade; a bula não fixa dose inicial pediátrica única. Tratamento contínuo. [S2, S3]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar glicemia/CGM, hipoglicemia e K+. Insuficiência renal/hepática pode reduzir necessidade. U100 e U300 não são bioequivalentes: U300→U100 iniciar cerca de 80% da dose. Não EV, não em bomba, não misturar nem diluir.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Diabetes mellitus tipos 1 e 2: controle glicêmico basal prolongado (formulação basal 100 UI/mL a partir de 2 anos; formulação basal 300 UI/mL a partir de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SBD 2026 - insulinoaterapia no DM 1 (diretriz.diabetes.org.br)

[S2] Bula regulatória Lantus U100 (medicines.org.uk)

[S3] Bula regulatória Toujeo U300 (medicines.org.uk)

251. Insulina Glulisina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM - cobertura prandial	SC até 15 minutos antes ou até 20 minutos após iniciar refeição. Dose = carboidratos da refeição (g) ÷ relação carboidrato/insulina individual; somar correção = (glicemia atual – alvo) ÷ fator de sensibilidade, descontando insulina ativa. Repetir nas refeições; contínuo, sem dose máxima universal. [S1, S2]
DM 1 ≥4 anos	Associar insulina basal. Relação e fator devem ser estabelecidos por perfil glicêmico; não há número fixo de U/kg por refeição seguro para toda criança.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Prevenir sobreposição de correções e hipoglicemia. Ajustar na disfunção renal/hepática e alteração alimentar. Evidência pediátrica de DM 2 não estabelecida na fonte do fabricante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)
Diabetes mellitus: cobertura prandial rápida a partir de 4 anos de idade.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Sanofi - Apidra: uso, idade e horário (apidra.com)
[S2] SBD 2026 - tratamento do DM 1 no SUS (diretriz.diabetes.org.br)

252. Insulina Lispro

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM - cobertura prandial e correção de hiperglicemia Crianças e adolescentes	Lispro SC antes das refeições; dose prandial = $\text{carboidratos(g)}/\text{relação g/U}$; correção = $(\text{glicemia atual} - \text{alvo})/\text{fator mg/dL por U}$, subtraindo insulina ativa. Administrar próximo da refeição, habitualmente 0-15 minutos antes; se necessário, logo após. Contínuo; sem máximo universal. [S1, S2]
DM - bomba subcutânea contínua Crianças e adolescentes; equipamento compatível	Usar lispro U100 compatível com a bomba. Programar basal em U/h e bolus por carboidratos/correção; estimativa inicial basal cerca de 30-50% da dose diária, distribuída nas 24 h e ajustada por horário. Não existe taxa única pediátrica. [S1, S2] Não usar U200 nem misturas em bomba; interromper bomba sem reposição basal expõe à cetoacidose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar glicose continuamente ou antes/depois das refeições. Necessidade cai com insuficiência renal/hepática. A precisão de meia unidade é útil em crianças pequenas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Diabetes mellitus: cobertura prandial, correção de hiperglicemia e infusão subcutânea contínua por bomba.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bula regulatória Humalog - lispro (medicines.org.uk)

[S2] SBD 2026 - insulinoterapia no DM 1 (diretriz.diabetes.org.br)

253. Insulina NPH (Humana)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DM 1 e DM 2 - basal intermediária Crianças e adolescentes	NPH SC em 2-3 aplicações/dia; em situações selecionadas 4. No DM 1, iniciar a parcela basal abaixo de 50% da dose TOTAL diária de insulina e titular por glicemias. Dose noturna ao deitar (aproximadamente 22 h). No DM 2, necessidade individual; não há dose fixa pediátrica universal. Tratamento contínuo. [S1, S2] Não somar automaticamente a NPH à dose total preexistente; reconstruir basal+bolus.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES NPH tem pico e risco de hipoglicemia noturna. Ressuspender suavemente; nunca EV nem em bomba. Reduzir necessidade estimada em insuficiência renal/hepática e baixa ingestão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Controle glicêmico basal intermediário no diabetes mellitus tipos 1 e 2.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SBD 2026 - NPH no SUS (diretriz.diabetes.org.br)

[S2] IWK - insulina humana NPH (dir.iwk.nshealth.ca)

254. Insulina Regular (Humana)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Cetoacidose diabética Crianças e adolescentes	Iniciar EV contínua após 1 h de fluidos: 0,05 U/kg/h em <5 anos, se glicemia <270 mg/dL no início da infusão após fluidos, ou durante transporte com monitorização bioquímica limitada; 0,1 U/kg/h nos demais. Sem bolus inicial. Manter até resolver cetose/acidemia e tolerar alimentação, com sobreposição de 30-60 min após insulina rápida SC. Preparar 50 U + SF 0,9% q.s.p. 50 mL = 1 U/mL; mL/h = U/kg/h × peso ÷ 1. [S1] Corrigir K+ <3 mmol/L antes da insulina; acrescentar glicose para manter insulina até resolução.
Controle glicêmico habitual Crianças e adolescentes	Regular SC 30 minutos antes das refeições; dose bolus total diária repartida nas refeições e ajustada pela glicemia e carboidratos. Não há U/kg/dose universal. Tratamento contínuo. [S2]
Hipercalcemia grave Crianças e adolescentes	Regular 0,1 U/kg EV (máx. 10 U) associada a glicose 0,5 g/kg EV = SG 10% 5 mL/kg. Reavaliar K+/glicemia; se persistência, infusão 0,1 U/kg/h com oferta de glicose titulada. Diluição 1 U/mL; para infusão mL/h = 0,1 × peso. [S3] Não repetir automaticamente bolus. Glicemia a cada 30-60 min e vigilância após efeito. SG 10% isolado conforme RCH na ausência de hiponatremia; se hiponatremia, adequar solução e aporte de sódio ao protocolo, preservando a dose de glicose.
Cetoacidose leve - alternativa subcutânea Crianças selecionadas pela endocrinologia	Regular 0,1 U/kg SC inicialmente, depois 0,1 U/kg SC a cada 2 h. Após corrigir acidose, 0,1 U/kg a cada 4-6 h, até transição ao regime habitual. [S1] Alternativa institucional para CAD leve, com reavaliação frequente; não substituir infusão EV em CAD grave/choque.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dupla checagem U versus mU, solução 100 U/mL versus final. ECG, glicemia, K+, Na+, gasometria; considerar adsorção ao equipo no preparo institucional.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Tratamento da cetoacidose diabética; controle glicêmico e tratamento de urgência da hipercalcemia grave associada à glicose.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] RCH 2025 - cetoacidose pediátrica (rch.org.au)

[S2] SBD - insulina regular (diretriz.diabetes.org.br)

[S3] RCH - hipercalcemia (rch.org.au)

255. Iodeto de Potássio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bloqueio tireoidiano após radioiodo RN a adolescentes	VO, dose única a cada 24 h enquanto persistir exposição: nascimento-1 mês 16 mg; >1 mês-<3 anos 32 mg; 3-18 anos 65 mg; adolescente >70 kg 130 mg. Máximo 130 mg/dia. Iniciar somente por orientação da autoridade em emergência radiológica. [S1] Evitar repetição em RN se evacuação/proteção alternativa; verificar função tireoidiana neonatal.
Expectorante de curta duração População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A bula de iodeto como expectorante não estabelece segurança, eficácia ou dose pediátrica. Indicação documental preservada; não extrapolar esquema adulto nem a dose usada no bloqueio de radioiodo. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de hipotireoidismo, sialadenite e hipersensibilidade. Não protege contra outras radiações nem substitui abrigo/evacuação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 34)

Bloqueio tireoidiano em exposição acidental a iodo radioativo (emergências nucleares); expectorante de curta duração.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - iodeto de potássio em emergência radiológica (fda.gov)

[S2] DailyMed - SSKI, iodeto expectorante (dailymed.nlm.nih.gov)

256. Isavuconazol (Sulfato de Isavuconazônio)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Aspergilose invasiva; mucormicose quando anfotericina B não apropriada	Isavuconazol BASE 5,4 mg/kg/dose EV (máx. 200 mg/dose), 8/8 h por 6 doses; manutenção mesma dose 24/24 h, iniciada 12-24 h após último ataque. Diluir para 0,4-0,8 mg/mL e infundir ≥1 h com filtro. Duração até resposta clínica/micológica; reavaliar benefício se >6 meses. [S1]
≥1 ano EV	372,6 mg de sulfato de isavuconazônio equivalem a 200 mg de isavuconazol; não intercambiar massas. Evidência regulatória internacional, não comprova aprovação pediátrica BR.

Aspergilose invasiva; mucormicose - opção VO	Dose de isavuconazol por administração: 16-<18 kg 80 mg; 18-<25 kg 120 mg; 25-<32 kg 160 mg; 32-<37 kg 180 mg; ≥37 kg 200 mg. Ataque 8/8 h x 6 doses; depois 24/24 h, iniciando 12-24 h após o último ataque. Duração por resposta. [S2]
≥6 anos e ≥16 kg	Cápsulas inteiras; apresentações pediátricas internacionais podem não estar no mercado brasileiro.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar função hepática, interações CYP 3A4 e QT curto. Contraindicado em QT curto familiar e com rifampicina, carbamazepina, fenitoína/indutores potentes. Ajustes pediátricos em disfunção renal/hepática não definidos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Tratamento da aspergilose invasiva e mucormicose (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Bula regulatória CRESEMBA EV - 2025 (medicines.org.uk)
[S2] Bula regulatória CRESEMBA cápsulas - 2025 (medicines.org.uk)

257. Isoflurano

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução/manutenção da anestesia geral Neonatos, crianças e adolescentes; anestesiologia	Inalatório por vaporizador específico: concentração inspirada 1,5-3% costuma produzir anestesia em 7-10 min. Manutenção 1-2,5% com N2O; em O2 isolado pode precisar acréscimo 0,5-1%. Titular à concentração expirada/CAM e resposta. CAM em O2: RN 1,6%; 1-6 meses 1,87%; 6-12 meses 1,8%; 1-5 anos 1,6%; 6-10 anos 1,45%; 11-18 anos 1,38%. Durante procedimento. [S2] CAM é referência populacional, não dose obrigatória. Risco de laringo/broncoespasmo na indução e hipertermia maligna.
Sedação em UTI; estado de mal asmático refratário Criança intubada, UTI com equipamento anestésico e exaustão de gases	Iniciar concentração inspirada 0,5%; titular em passos de 0,5% conforme broncoespasmo/sedação e pressão arterial; faixa 0,5-2%, teto 2,5% no protocolo citado. Reduzir gradualmente após estabilização, com reavaliação diária. [S1] Off-label; não infundir o líquido por via parenteral.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, PA invasiva, gases inspirados/expirados, capnografia, temperatura e função hepática. Contraindicado em suscetibilidade à hipertermia maligna e hepatite prévia por halogenados.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Indução e manutenção de anestesia geral; sedação em UTI (estado de mal asmático refratário, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Montreal Children’s Hospital - anestésicos inalatórios em UTI (mchrt.ca)
[S2] DailyMed - isoflurano, revisão novembro 2025 (dailymed.nlm.nih.gov)

258. Isoniazida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tuberculose ativa - esquema combinado Crianças	Isoniazida 10-15 mg/kg VO 24/24 h (máx. 300 mg/dia), integrada ao esquema multidroga. Não usar monoterapia. Duração usual do esquema básico 6 meses, podendo exigir extensão em meningite/ostearticular. [S1] A fonte internacional também descreve 20-30 mg/kg, máximo 900 mg, 3 vezes/semana; não transferir esta alternativa automaticamente para o esquema brasileiro.
Infecção latente - isoniazida isolada Crianças	10 mg/kg VO 24/24 h (faixa 7-15; máximo 300 mg/dia), 180 doses em 6 meses ou 270 doses em 9 meses. Escolher 9 meses quando indicado em HIV/interações com rifamicinas. [S1, S2] Excluir doença ativa antes de iniciar.
Infecção latente - combinação 3RH <10 anos e 4-<25 kg	Isoniazida/rifampicina VO diariamente por 90 doses: 4-7 kg H50 mg+R75 mg; 8-11 kg H100+R150; 12-15 kg H150+R225; 16-24 kg H200+R300. [S2] 3HP semanal com rifapentina é outra alternativa documentada, mas sua dose deve seguir tabela específica por idade/peso; não usar a dose do esquema diário 3RH.
Infecção latente - combinação 3HP ≥2 anos; elegibilidade e interações verificadas	Isoniazida VO 1 vez/SEMANA por 12 doses: 2-11 anos 25 mg/kg/dose; ≥12 anos 15 mg/kg/dose; máximo 900 mg/dose. Associar rifapentina semanal por peso: 10-14 kg 300 mg; >14-25 kg 450 mg; >25-32 kg 600 mg; >32-<50 kg 750 mg; ≥50 kg 900 mg. Não administrar diariamente. [S3] Escolher um regime preventivo completo; excluir TB ativa. Criança <10 kg requer especialista/tabela própria.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hepatotoxicidade e neuropatia; piridoxina em grupos de risco. Evitar monoterapia na TB ativa. Interações com anticonvulsivantes e hepatotóxicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Tratamento da tuberculose ativa (esquema combinado) e profilaxia da infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] [IWK - isoniazid](#) (dir.iwk.nshealth.ca)
- [S2] [MS - Nota Informativa 6/2024, ILTB pediátrica](#) (gov.br)
- [S3] [CDC - tratamento da infecção latente](#) (cdc.gov)

259. Isossorbida (Dinitrato / Mononitrato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Angina; insuficiência cardíaca crônica descompensada População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Mononitrato: dose pediátrica não estabelecida na bula. Dinitrato: AEMPS não recomenda em crianças/adolescentes por falta de dados de segurança/eficácia. Não extrapolar doses adultas nem trocar um sal pelo outro. [S1, S2] Indicações adultas do original preservadas. Uso excepcional pediátrico requer definição do sal e protocolo cardiológico com fonte própria.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado com inibidores de PDE 5/riociguato e em hipotensão importante. Monitorar PA, cefaleia, tolerância aos nitratos e metemoglobinemia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)

Profilaxia e tratamento da angina; insuficiência cardíaca crônica descompensada (uso adulto predominante).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Biolab - bula profissional Coronar, mononitrato (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] AEMPS - Iso-Lacer, dinitrato de isossorbida (cima.aemps.es)

260. Itraconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Paracoccidioidomicose Crianças selecionadas; maior experiência com cotrimoxazol RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Itraconazol VO 5-10 mg/kg/dia, em 1 tomada; tratamento 9-12 meses nas formas leves e 12-18 meses nas moderadas, guiado por cura clínica/micológica. [S1] Página MS contém divergência etária entre texto e tabela (>5 versus <5 anos); para <5 anos requer decisão especializada, sem assumir aprovação.
Histoplasmose disseminada Crianças; especialmente HIV/imunossupressão	VO 2-5 mg/kg/dose 8/8 h por 3 dias; depois 2-5 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 400 mg/dia na manutenção, por 12 meses; envolvimento SNC exige ≥12 meses após indução apropriada. [S2] AEP também descreve 6-8 mg/kg/dia divididos 12/12 h; ajustar por nível sérico e formulação.
Esporotricose Crianças	VO 5-10 mg/kg/dia em 1 tomada, até 1 mês após desaparecimento de lesões; frequentemente cerca de 3 meses, podendo prolongar. [S3] Doença grave/disseminada pode necessitar indução com anfotericina.
Dermatomicoses refratárias - tinea capitis >6 meses; off-label	VO 5 mg/kg/dia, máximo 200 mg/dia. Trichophyton: 4-6 semanas; Microsporum: 6-8 semanas, até 12 em M. canis. Alternativa: 5 mg/kg/dia em 1-2 tomadas por 1 semana/pulso; intervalo sem tratamento de 2 semanas após o primeiro e 3 após o segundo; reavaliar antes de cada pulso. [S4] Reservar quando tratamento preferencial falhou/não é viável.
Dermatomicoses refratárias - corpo, virilha e pés >6 meses; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	3-5 mg/kg/DIA VO em 1-2 tomadas por 1-2 semanas, máximo usual 200 mg/dia; confirmar cura e ajustar conforme sítio/agente. T. indotineae pode exigir 4-12 semanas até cura microbiológica. [S4] Não intercambiar cápsula e solução sem considerar absorção.
Dermatomicoses refratárias - onicomicose >6 meses; off-label, seleção dermatológica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	3-5 mg/kg VO 24/24 h, máximo usual 200 mg/dia: mãos 6-8 semanas; pés 12 semanas. Alternativa: 5 mg/kg/DIA por 1 semana a cada mês; mãos 2 pulsos, pés 3 pulsos. [S4] Confirmar etiologia antes de exposição prolongada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Cápsula convencional, solução e formulação de maior biodisponibilidade não são intercambiáveis. Monitorar enzimas hepáticas, interações CYP 3A4, insuficiência cardíaca e concentração sérica em doença invasiva.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)

Tratamento de micoses sistêmicas endêmicas (paracoccidioidomicose, histoplasmose, esporotricose) e dermatomicoses refratárias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MS - paracoccidioidomicose: tratamento (gov.br)

[S2] AEP/Pediamécum - itraconazol (aeped.es)

[S3] SESA-PR - manejo de esporotricose (www.3.maringa.pr.gov.br)

[S4] Guía-ABE 2025 - dermatofitoses pediátricas (guia-abe.es)

261. Ivermectina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Estrongiloidíase ≥15 kg; respeitar restrição de idade da bula BR	200 mcg/kg VO 24/24 h por 1-2 dias; se hiperinfecção/disseminação, 200 mcg/kg/dia até exames de fezes/escarro negativos por 2 semanas. [S1]
Escabiose ≥15 kg	200 mcg/kg VO, repetir em 7-14 dias. Crostosa: associar tratamento tópico; 200 mcg/kg nos dias 1,2,8; ou 1,2,8,9,15; ou 1,2,8,9,15,22,29 segundo gravidade. [S2]
Pediculose ≥15 kg	200 mcg/kg OU 400 mcg/kg VO, repetir a mesma dose em 9-10 dias; usar esquema sistêmico em casos selecionados/refratários. [S3]
Oncocercose ≥15 kg	Ivermectina 150 mcg/kg VO em dose única a cada 6 meses enquanto houver evidência de infecção; fora de área endêmica pode-se considerar 3/3 meses por especialista. Programa de controle pode usar periodicidade anual. [S5] Não mata verme adulto; não aumentar dose para compensar persistência. Avaliar exposição a Loa loa.
Rosácea - creme tópico Menores de 18 anos	Posologia pediátrica não estabelecida; creme 1% tem indicação adulta. Não usar automaticamente esquema adulto em criança. [S6]
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Descartar risco de Loa loa antes do uso em expostos, sobretudo alta microfilaremia; risco de encefalopatia. ≥15 kg não elimina restrições etárias específicas da bula brasileira.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Estrongiloidíase, escabiose, oncocercose e pediculose (via oral; restrições para menores de 5 anos ou < 15 kg na bula de referência); rosácea (creme tópico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] CDC - [estrongiloidíase](#) (cdc.gov)
- [S2] CDC - [escabiose](#) (cdc.gov)
- [S3] CDC 2025 - [pediculose](#) (cdc.gov)
- [S4] AEP/Pediamécum - [ivermectina](#) (aeped.es)
- [S5] CDC - [oncocercose](#) (cdc.gov)
- [S6] SmPC Soolantra 2024 - [ivermectina tópica](#) (medicines.org.uk)

262. L-Ornitina L-Aspartato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hiperamonemia em hepatopatia aguda/crônica; encefalopatia hepática	A bula profissional é de uso adulto e não estabelece dose segura pediátrica. Não converter doses adultas em mg/kg nem substituir terapias de hiperamonemia de erros inatos por L-ornitina-L-aspartato. [S1]
População pediátrica	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em insuficiência renal grave. Hiperamonemia pediátrica aguda exige definir causa e não aguardar resposta a adjuvante sem dose estabelecida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Tratamento da hiperamonemia em hepatopatias agudas ou crônicas e encefalopatia hepática (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Biolab - bula profissional Hepa-Merz (uploads.consultaremedios.com.br)

263. Lacosamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais - adjuvância ≥2 anos e ≥10 kg; <16 anos off-label frente à bula BR do original	VO 1 mg/kg/dose 12/12 h; após 1 semana 2 mg/kg/dose 12/12 h; aumentar 1 mg/kg/dose por semana. Tetos por dose: 10-<20 kg 6 mg/kg; 20-<30 kg 5 mg/kg; 30-<50 kg 4 mg/kg. ≥50 kg: 50 mg 12/12 h, aumentando 50 mg/dose/semana até 200 mg 12/12 h. Contínuo. [S1]
Crises tônico-clônicas generalizadas - adjuvância ≥4 anos e ≥10 kg; adjuvância para crises tônico-clônicas generalizadas	VO 1 mg/kg/dose 12/12 h; após 1 semana 2 mg/kg/dose 12/12 h; aumentar 1 mg/kg/dose por semana. Tetos por dose: 10-<20 kg 6 mg/kg; 20-<30 kg 5 mg/kg; 30-<50 kg 4 mg/kg. ≥50 kg: 50 mg 12/12 h, aumentando 50 mg/dose/semana até 200 mg 12/12 h. Contínuo. [S1] Fonte EMA sustenta indicação internacional; não altera registro BR automaticamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG/intervalo PR; contraindicado bloqueio AV 2º/3º grau. CrCl ≤30: <50 kg reduzir teto 25%; ≥50 kg teto 250 mg/dia. Hepatopatia leve/moderada: <50 kg reduzir teto 25%; ≥50 kg teto 300 mg/dia. Desmame gradual.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)

Tratamento adjuvante de crises epiléticas focais a partir de 16 anos nas bulas brasileiras (uso abaixo de 16 anos ou em generalizadas, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Vimpat, informação do produto (ema.europa.eu)

264. Lactulose

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação funcional crônica Lactentes, crianças, adolescentes	Lactulose 667 mg/mL VO: lactentes 2,5-5 mL (1,67-3,34 g) 1-2 vezes/dia; crianças 5-10 mL (3,34-6,67 g) 1-2 vezes/dia; adolescentes 15-30 mL (10-20 g) 1-2 vezes/dia. Ajustar a fezes macias; uso continuado, com redução gradual após controle estável. [S1, S2]
Encefalopatia hepática Lactentes, crianças, adolescentes	Mesmas doses por administração, aumentando frequência para 6/6-24/24 h: lactentes 2,5-5 mL; crianças 5-10 mL; adolescentes 15-30 mL. Titular a 2-3 evacuações macias/dia; duração conforme encefalopatia/doença hepática. [S1] Evitar diarreia intensa como alvo; não substitui tratar precipitante.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar distensão, diarreia, desidratação, Na⁺/K⁺; contraindicado em obstrução intestinal. Conversões de volume assumem exclusivamente solução 667 mg/mL.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 35)
Tratamento da constipação intestinal funcional crônica e encefalopatia hepática.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[\[S1\] McMaster Children’s Hospital - lactulose \(app.hhsc.ca\)](#)
[\[S2\] IWK - lactulose \(dir.iwk.nshealth.ca\)](#)

265. Lamotrigina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Epilepsias focais/generalizadas; Lennox-Gastaut - com valproato 2-12 anos	VO: semanas 1-2 0,15 mg/kg/DIA; semanas 3-4 0,3 mg/kg/DIA; depois aumentar $\leq 0,3$ mg/kg/dia a cada 1-2 semanas. Manutenção 1-5 mg/kg/dia, em 1-2 tomadas; teto 200 mg/dia. Contínuo. [S1]
Mesmas epilepsias - sem valproato e sem indutor 2-12 anos	VO: semanas 1-2 0,3 mg/kg/DIA; semanas 3-4 0,6 mg/kg/DIA; subir $\leq 0,6$ mg/kg/dia a cada 1-2 semanas. Manutenção 1-10 mg/kg/dia em 1-2 tomadas, teto 200 mg/dia. Contínuo. [S2]
Mesmas epilepsias - indutor enzimático, sem valproato 2-12 anos	VO: semanas 1-2 0,6 mg/kg/DIA; semanas 3-4 1,2 mg/kg/DIA, dividir 12/12 h; subir $\leq 1,2$ mg/kg/dia a cada 1-2 semanas. Manutenção 5-15 mg/kg/dia, teto 400 mg/dia. Contínuo. [S1]
Mesmas epilepsias - adolescentes ≥ 13 anos	VO: sem interações 25 mg/dia por 2 semanas, 50 mg/dia por 2 semanas, depois +50-100 mg/dia a cada 1-2 semanas; usual 100-200 mg/dia. Com valproato 25 mg em dias alternados por 2 semanas, 25 mg/dia por 2 semanas, depois +25-50 mg/dia a cada 1-2 semanas; usual 100-200 mg/dia. Com indutor sem valproato 50 mg/dia por 2 semanas, 50 mg 12/12 h por 2 semanas, depois +100 mg/dia a cada 1-2 semanas; usual 200-400 mg/dia em 2 tomadas. [S2] Doses maiores são exceções de especialista; não acelerar titulação.
Prevenção de episódios depressivos no transtorno bipolar <18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não recomendada pela bula regulatória consultada: estudo pediátrico não demonstrou eficácia e registrou maior relato de suicidalidade. Não aplicar esquema de epilepsia como posologia bipolar. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de Stevens-Johnson/NET/DRESS: rash exige avaliação imediata. Valproato inibe depuração; carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e primidona induzem. Retomar titulação após interrupção prolongada; reduzir em hepatopatia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)

Epilepsias focais e generalizadas (incluindo Lennox-Gastaut); prevenção de episódios depressivos no transtorno bipolar.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - lamotrigine (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] GSK - Lamictal dispersível, SmPC (medicines.org.uk)

266. Lansoprazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DRGE com esofagite 1-11 anos	≤30 kg: 15 mg VO 24/24 h; >30 kg: 30 mg VO 24/24 h, até 12 semanas; administrar 30 min antes de comer. Reavaliar resposta. [S1, S2] Se persistência documentada apesar de técnica/adesão, IWK admite aumento especializado, até 3 mg/kg/dia ou 60 mg/dia, o menor, em 1-2 tomadas.
DRGE/esofagite; úlcera péptica ≥12 anos	DRGE sem erosão 15 mg/dia até 8 semanas; esofagite 30 mg/dia por 8 semanas, podendo prolongar 8 se não curada. Úlcera duodenal 15 mg/dia por 4 semanas; úlcera gástrica 30 mg/dia até 8 semanas. VO. [S2]
Erradicação de H.pylori Crianças ≥15 kg; off-label conforme formulação	VO por 14 dias: 15-24 kg, 15 mg 12/12 h; 25-34 kg, 30 mg 12/12 h; >35 kg, 30 mg 12/12 h, podendo 8/8 h em esquema especializado. Em ≥12 anos, AEP admite 30 mg 12/12 h ou 8/8 h conforme regime combinado. Aos 35 kg e <12 anos, confirmar o limite impreciso da tabela UCSF com gastroenterologia. [S3, S4, S2] Dose específica de lansoprazol; não intercambiável com dose de omeprazol. Não usar monoterapia.
DRGE com esofagite comprovada no lactente - uso excepcional 28 dias-<1 ano; off-label, gastroenterologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	AEP: 28 dias-<10 semanas, 0,2-0,3 mg/kg VO 24/24 h; ≥10 semanas, 1-2 mg/kg VO 24/24 h. Alternativa institucional IWK em 28 dias-<1 ano: 1-2 mg/kg 24/24 h OU 0,5-1 mg/kg 12/12 h. Doses maiores no lactente jovem exigem gastroenterologia. Curso curto, conforme doença documentada e resposta. [S1, S2] As fontes divergem no lactente jovem; não escolher automaticamente o extremo superior. Eficácia para refluxo inespecífico <1 ano não demonstrada; não tratar regurgitação fisiológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não esmagar grânulos gastrorresistentes. Na hepatopatia moderada/grave reduzir 50%; não requer ajuste renal. <1 ano: não usar para regurgitação fisiológica; eficácia não demonstrada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)
Tratamento da DRGE com esofagite, úlcera péptica e erradicação de *H. pylori*.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] IWK - lansoprazole (dir.iwk.nshealth.ca)
- [S2] AEP/Pediamécum - lansoprazol (aeped.es)
- [S3] UCSF - IBP para H.pylori em pediatria (idmp.ucsf.edu)
- [S4] ESPGHAN/NASPGHAN 2024 - H.pylori (espghan.org)

267. Laronidase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
MPS I - manifestações não neurológicas Crianças de todas as idades sob centro especializado	Laronidase 100 U/kg = 0,58 mg/kg EV 1 vez/semana, continuamente. Diluir em SF 0,9% até volume FINAL 100 mL se ≤20 kg ou 250 mL se >20 kg. Infundir em 3-4 h; começar 2 U/kg/h, aumentar a cada 15 min se tolerado até 43 U/kg/h. mL/h = U/kg/h × peso ÷ concentração FINAL(U/mL). [S1] Unidades de atividade da laronidase não são UI de outras enzimas; não aumentar a dose para sintomas neurológicos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Pré-medicação anti-histamínica/antitérmica cerca de 60 min antes conforme histórico. Vigilância de anafilaxia/obstrução de via aérea; interromper reação grave. Ajuste renal/hepático não estabelecido.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)
Terapia de reposição enzimática para manifestações não neurológicas da mucopolissacaridose tipo I (Hurler e Scheie).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Aldurazyme (ema.europa.eu)

268. Levetiracetam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais - adjuvância 1-<6 meses	7 mg/kg/dose VO 12/12 h; aumentar 7 mg/kg/dose a cada 2 semanas até 21 mg/kg/dose 12/12 h (42 mg/kg/dia). Contínuo. [S1]
Crises focais - adjuvância 6 meses-<4 anos; 4-15 anos ou <50 kg	Iniciar 10 mg/kg/dose VO 12/12 h; aumentar a cada 2 semanas conforme resposta. Teto 6 meses-<4 anos 25 mg/kg/dose 12/12 h; ≥4 anos 30 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 3000 mg/dia. Contínuo. [S1]
Crises focais - monoterapia ≥16 anos	500 mg VO 12/12 h; aumentar 500 mg/dose a cada 2 semanas até 1500 mg 12/12 h. Pode-se iniciar 250 mg 12/12 h por 2 semanas para tolerabilidade, conforme bula específica. Contínuo. [S1]
Crises mioclônicas e tônico-clônicas generalizadas - adjuvância Mioclônicas: ≥12 anos; tônico-clônicas generalizadas: ≥6 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Dose inicial 10 mg/kg/dose 12/12 h se <50 kg, até 30 mg/kg/dose 12/12 h; ≥50 kg 500 mg 12/12 h até 1500 mg 12/12 h. Contínuo. [S1, S2] Faixas etárias da monografia AEP; registro varia por jurisdição. Não estender automaticamente ao lactente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar por função renal, comportamento/irritabilidade e ideação suicida. EV substitui VO na mesma dose diária quando necessário; não retirar abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)

Crises focais (monoterapia a partir de 16 anos; adjuvância oral a partir de 1 mês), crises mioclônicas e tônico-clônicas generalizadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - levetiracetam (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - levetiracetam (aeped.es)

269. Levocetirizina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica; urticária crônica	2-<6 anos: 1,25 mg VO 12/12 h (máximo 2,5 mg/dia). ≥6 anos: 5 mg VO 24/24 h (máximo 5 mg/dia). Manter durante exposição/sintomas; reavaliar periodicamente em doença crônica. [S1]
≥2 anos	A dose de ≥6 anos segue SmPC europeu; não aplicar dose reduzida de bula norte-americana como se idêntica à brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sonolência possível. Ajustar em disfunção renal pela depuração/peso; não usar em insuficiência renal terminal. Hepatopatia isolada sem ajuste.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)
Tratamento da rinite alérgica e urticária crônica (gotas a partir de 2 anos; comprimidos a partir de 6 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bula regulatória Xyzal solução (medicines.org.uk)

270. Levodopa + Benserazida / Carbidopa

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Distonia responsiva à dopa/síndrome de Segawa Crianças	Dose expressa em LEVODOPA: <6 anos 1-10 mg/kg/DIA VO divididos em 2-3 tomadas, iniciar no limite inferior e subir lentamente. ≥6 anos 25-50 mg de levodopa 1-3 vezes/dia. Geralmente controle com <300-400 mg/dia. Associar inibidor periférico de descarboxilase; duração contínua. [S1] Não somar massa de carbidopa/benserazida à dose de levodopa; off-label pediátrico.
Doença de Parkinson Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indicação adulta do original. Parkinsonismo juvenil requer diagnóstico etiológico; não copiar posologia adulta em criança. O esquema de distonia se aplica à distonia responsiva à dopa, não a qualquer Parkinson. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar discinesia, náusea, hipotensão e resposta funcional. Não interromper subitamente; ajustar combinações pela proporção do produto.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)

Tratamento da doença de Parkinson (uso adulto); distonia responsiva à dopa / síndrome de Segawa (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] GeneReviews - GTPCH 1: distonia responsiva à dopa (ncbi.nlm.nih.gov)

271. Levodropropizina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tosse seca/irritativa >2 anos	1 mg/kg/dose VO até 3 vezes/dia (máximo 3 mg/kg/dia); intervalo mínimo 6 h. >12 anos 60 mg/dose até 3 vezes/dia, máximo 180 mg/dia. Suspende quando cessar tosse; reavaliar se persistente após 4-5 dias. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em tosse produtiva com hipersecreção, depuração mucociliar reduzida e hepatopatia grave. Cautela renal grave/sedativos; contraindicado <2 anos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)

Alívio sintomático da tosse seca e irritativa em crianças acima de 2 anos e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Eurofarma - bula profissional Percof (uploads.consultaremedios.com.br)

272. Levofloxacino

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pneumonia, sinusite ou pielonefrite grave por agente suscetível	6 meses-<5 anos 10 mg/kg/dose VO/EV 12/12 h; ≥5 anos 10 mg/kg/dose 24/24 h; máximo 750 mg/dia. Duração 7-14 dias, dirigida ao foco, cultura e resposta. [S1]
>6 meses, uso selecionado/off-label	Alternativa quando resistência/alergia impede opções preferenciais; não usar rotineiramente em sinusite viral.
Tuberculose drogarresistente	15-20 mg/kg/dose VO 24/24 h (máximo 1000 mg/dia), em associação a esquema antituberculose definido por suscetibilidade. Duração corresponde ao regime de TB resistente, não 7-14 dias. [S1]
Crianças	Não usar monoterapia; esquema total exige classificação da resistência.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar em insuficiência renal. Monitorar QT, tendão, neuropatia, glicemia e SNC. Separar VO de ferro/cálcio/antiácidos; não misturar EV com bicarbonato/heparina.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)

Infecções bacterianas graves por agentes suscetíveis (pneumonia, sinusite, pielonefrite); tuberculose drogarresistente (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - levofloxacino (aeped.es)

273. Levomepromazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Agitação psicomotora em psicose >3 anos	0,5-2 mg/kg/DIA VO, divididos em 2-3 tomadas; máximo 40 mg/dia. Iniciar baixo e titular à resposta. Tratamento contínuo somente enquanto indicação persistir. [S1]
Cuidados paliativos - delirium, dor e sedação refratários 1-11 anos; ≥12 anos	1-11 anos: 350 mcg/kg/DIA (0,35 mg/kg/dia), máximo inicial 12,5 mg/dia; titular até 3 mg/kg/dia. ≥12 anos: 12,5 mg/dia inicial, até 200 mg/dia. Infusão contínua EV/SC por 24 h; alternativamente dividir total em 1-2 bolus EV/SC. Reavaliar diariamente. [S2] Insônia no original refere-se à sedação paliativa refratária; não a insônia comum. Corrigida faixa de 1m para 1 ANO e retirada extrapolaçãoVO.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sedação, FR, PA, QT e sintomas extrapiramidais. Começar menor e 1 vez/dia na insuficiência renal grave; risco de hipotensão e anticolinergia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 36)
Agitação psicomotora em quadros psicóticos; adjuvante em cuidados paliativos para delírio, dor e insônia refratária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - levomepromazina (aeped.es)

[S2] APPM 2024 - levomepromazina (appm.org.uk)

274. Levosimendana

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência cardíaca descompensada grave; baixo débito pós-cirurgia cardíaca	EV contínua 0,1 mcg/kg/min; avaliar em 30-60 min: reduzir para 0,05 se hipotensão/taquicardia ou subir até 0,2 se necessário/tolerado. Usual 24 h, sem bolus de rotina. Diluir em SG 5% para 50-100 mcg/mL. mL/h = dose × peso × 60 ÷ concentração final. [S1, S2]
Pediatria em UTI; off-label	Ensaios pediátricos estudaram 0,05 mcg/kg/min por 48 h; benefício e seleção dependem do contexto. Não usar automaticamente duração de ensaio em todo paciente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Corrigir hipovolemia/hipocalemia; ECG/PA invasiva/diurese. Não usar se CrCl <30, hepatopatia grave, obstrução mecânica ventricular ou torsades prévia. Metabólitos prolongam efeito por dias.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Insuficiência cardíaca descompensada grave com necessidade de inotrópico; baixo débito pós-cirurgia cardíaca pediátrica (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - levosimendan (aeped.es)

[S2] Wang et al. - ensaio pediátrico de levosimendana (doi.org)

275. Levotiroxina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipotireoidismo congênito neonatal RN, iniciar idealmente até 14 dias de vida	Levotiroxina VO 1 vez/dia: forma grave(T4L <5 pmol/L) 10-15 mcg/kg/dia; leve(T4L >10 pmol/L) aproximadamente 10 mcg/kg/dia; se T4L normal,5-10 mcg/kg/dia. Reavaliar T4L/TSH em 1-2 semanas e ajustar. Tratamento contínuo. [S3] Não aguardar titulação lenta do adulto; investigar insuficiência adrenal quando pertinente.
Hipotireoidismo congênito/adquirido Lactentes, crianças, adolescentes	Levotiroxina VO 24/24 h: 1-3 meses 10-15 mcg/kg/dia; 3-6 meses 8-10; 6-12 meses 6-8; 1-5 anos 5-6; 6-12 anos 4-5; >12 anos 2-3; puberdade/crescimento completos 1,7 mcg/kg/dia. Ajustar por T4L/TSH, sem teto universal. Tratamento contínuo. [S1, S2]
Supressão de TSH no câncer diferenciado da tireoide Crianças sob endocrinologia/oncologia	Titular levotiroxina VO 24/24 h pela TSH: risco baixo 0,5-1 mUI/L; intermediário 0,1-0,5; alto <0,1. Não há dose ponderal única de supressão. Duração contínua e metas flexibilizadas com resposta/remissão. [S4] Evitar tireotoxicose clínica; monitorar crescimento, coração e saúde óssea.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Administrar consistentemente em jejum; separar ferro/cálcio. Corrigir insuficiência adrenal antes. Hipotireoidismo congênito não deve aguardar titulação lenta de adulto; seguir faixa neonatal acima.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Tratamento do hipotireoidismo congênito e adquirido; supressão de TSH no câncer diferenciado da tireoide.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - levothyroxine (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - levotiroxina-sodica (aeped.es)

[S3] ENDO-ERN 2020-2021 - hipotireoidismo congênito (seep.es)

[S4] NCI - câncer de tireoide pediátrico (cancer.gov)

276. Lidocaína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anestesia local infiltrativa/regional Crianças; dose total somada de todos os sítios	Infiltrar a menor dose eficaz. Sem vasoconstritor: teto 4,5 mg/kg, máximo 300 mg por procedimento. Com adrenalina: teto 7 mg/kg, máximo 500 mg por procedimento. Não repetir antes de 2 h; bloqueios específicos exigem concentração/volume próprios. [S1] Os limites são tetos, não doses-alvo; reduzir em lactentes, hepatopatia, baixo débito e áreas muito vascularizadas.
Anestesia tópica de mucosas Crianças com reflexos protetores preservados RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Aplicar localmente a menor quantidade necessária, sem exceder dose sistêmica cumulativa 4,5 mg/kg (máximo 300 mg). Geleia 2%=20 mg/g; spray 10%=100 mg/mL, mas mg por jato dependem do dispositivo. Uma aplicação por procedimento, reavaliando absorção. [S1] Não usar lidocaína viscosa para dentição; mucosa inflamada aumenta absorção. Não comer até recuperar deglutição.
Arritmia ventricular maligna/PCR por FV ou TV sem pulso Pediatria; monitorização contínua	Lidocaína SEM adrenalina: 1 mg/kg EV/IO na PCR. Para arritmia ventricular monitorada, IWK permite repetir 1 mg/kg a cada 10-15 min por até 2 doses adicionais, respeitando teto cumulativo 100 mg ou 5 mg/kg, o menor. Se indicada manutenção: EV 20-50 mcg/kg/min, titulado ao ECG; reavaliar continuamente. [S1] Usar apresentação adequada à via EV antiarrítmica, sem conservantes inadequados. Não administrar formulação com vasoconstritor por via EV/IO.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Errata do original: “vasoespasmo” deve ser “vasoconstritor”. Toxicidade: convulsão, depressão cardíaca e arritmia; somar anestésicos locais. Não usar apresentação de depósito, spray ou geleia EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Anestesia local infiltrativa e regional; anestesia tópica de mucosas; tratamento de arritmias ventriculares malignas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - lidocaine (dir.iwk.nshealth.ca)

277. Linezolida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por MRSA; enterococos resistentes à vancomicina RN, crianças e adolescentes	VO/EV: nascimento-11 anos 10 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 600 mg/dose; ≥12 anos 600 mg 12/12 h. Exceção: prematuro <34 semanas de gestação com <7 dias de vida, iniciar 10 mg/kg/dose 12/12 h; considerar 8/8 h se resposta insuficiente; a partir do 7º dia, 8/8 h. Pneumonia/pele complicada: 10-14 dias; VRE: 14-28 dias, ajustados ao foco/complicações. EV: 2 mg/mL em 30-120 min. [S3] RN a termo não recebem automaticamente o intervalo de 12 h do prematuro.
Tuberculose drogarresistente ≥3 kg; em <5 kg especialista em TB pediátrica	Linezolida VO 24/24 h. Doses da suspensão 20 mg/mL na tabela OMS: 3-<5 kg 40 mg; 5-<7 kg 80 mg; 7-<10 kg 120 mg; 10-<16 kg 160 mg; 16-<24 kg 220 mg; 24-<30 kg 280 mg; 30-<36 kg 300 mg; 36-<46 kg 400 mg; ≥46 kg 600 mg. Associar ao regime completo MDR/RR; duração de 6 ou 9 meses ou mais depende do regime e tolerância, sem presumir linezolida por todo período. [S2] A tabela inclui arredondamentos diferentes para comprimido dispersível; não somar alternativas nem aplicar esquema 8/8 h de infecção piogênica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma semanal; neuropatia óptica/periférica, acidose láctica e toxicidade cumulativa em tratamento prolongado. Interações serotoninérgicas/IMAO. Não cobre Gram-negativos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Infecções graves por Gram-positivos multirresistentes (MRSA, enterococos resistentes à vancomicina); tuberculose drogarresistente (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - linezolid (aeped.es)

[S2] OMS 2025 - doses de fármacos para TB (tbksp.who.int)

[S3] DailyMed - linezolida (dailymed.nlm.nih.gov)

278. Lisdexanfetamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
TDAH ≥6 anos	Dimesilato de lisdexanfetamina 30 mg VO pela manhã; aumentar 10 ou 20 mg/dia a cada semana; faixa 30-70 mg/dia, teto 70 mg/dia. Uso contínuo, com reavaliação de benefício, crescimento, sono e função escolar. [S1]
Transtorno de compulsão alimentar Menores de 18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A eficácia/segurança pediátrica não estão estabelecidas. Indicação adulta do original preservada; não extrapolar esquema adulto para adolescente. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose em mg do DIMEsilato, como rotulado, não em dexanfetamina. TFG 15-<30: teto 50 mg/dia; TFG <15: teto 30 mg/dia. Monitorar PA/FC, peso/altura e sintomas psiquiátricos; contraindicado com IMAO ou nos 14 dias seguintes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)
Tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) a partir de 6 anos; transtorno de compulsão alimentar (adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - lisdexanfetamina, bula regulatória (dailymed.nlm.nih.gov)

279. Lítio (Carbonato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno bipolar I - mania/episódio misto 7-17 anos e ≥ 20 kg; autorização internacional, off-label conforme bula BR	Carbonato VO: 20-30 kg iniciar 300 mg 12/12 h, subir 300 mg/DIA semanalmente; usual 600-1500 mg/dia dividido. >30 kg iniciar 300 mg 8/8 h, subir 300 mg/DIA a cada 3 dias; usual 600 mg 2-3 vezes/dia. Titular a litemia 0,8-1,2 mEq/L, colhida 12 h após dose; faixa de dose não é teto seguro independente da litemia. [S1]
Profilaxia/manutenção do transtorno bipolar I 7-17 anos e ≥ 20 kg	Após estabilizar: 20-30 kg usual 600-1200 mg/DIA dividido; >30 kg 300-600 mg 2-3 vezes/dia. Meta de bula 0,8-1 mEq/L; manutenção contínua, reavaliada regularmente. [S1]
Potencialização de antidepressivo na depressão grave População pediátrica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há regime pediátrico estabelecido na bula para essa indicação. Não transferir alvo/dose de mania automaticamente para depressão unipolar. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dosar litemia após 3 dias e após mudanças; monitorar creatinina, Na⁺, TSH e cálcio. Evitar se CrCl <30 ; iniciar menor/titular lentamente se 30-89. Desidratação, AINE, tiazídico, IECA/BRA elevam toxicidade. Formulações convencionais/prolongadas exigem ajuste.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Tratamento do transtorno bipolar (manias e profilaxia); potencializador de antidepressivos na depressão grave (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - carbonato de lítio: bula pediátrica (dailymed.nlm.nih.gov)

280. Loperamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diarreia aguda inespecífica não infecciosa Adolescentes >12 anos; respeitar bula BR adulta RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Quando causa infecciosa/inflamatória excluída: 4 mg VO inicialmente; depois 2 mg após cada evacuação líquida, máximo 16 mg/dia. Suspende se obstipação/distensão ou sem melhora em 48 h; uso pediátrico depende de indicação excepcional e registro. [S1] O original restringe a adultos; esta alternativa internacional >12 anos não muda a bula brasileira.
Diarreia infecciosa aguda infantil - contra-indicação original Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não administrar como tratamento de gastroenterite; priorizar reidratação. Contraindicado em disenteria, enterocolite invasiva, colite por C. difficile e risco de íleo/megacólon. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não ultrapassar teto: overdose causa prolongamento QT, torsades e depressão do SNC. Evitar em hepatopatia grave e íleo; não tratar perda hídrica apenas reduzindo evacuações.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)

Tratamento sintomático da diarreia aguda inespecífica não infecciosa em adultos (contraindicada na diarreia infecciosa aguda infantil).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - loperamida (aeped.es)

281. Loratadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica; urticária crônica	2-12 anos ≤30 kg: 5 mg VO 24/24 h; >30 kg: 10 mg 24/24 h. >12 anos: 10 mg 24/24 h. Manter enquanto sintomas/exposição persistirem; reavaliar necessidade em uso prolongado. [S1]
≥2 anos	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hepatopatia grave: mesma dose em dias alternados. Não exige ajuste renal pela monografia. Evitar duplicar anti-histamínicos e confirmar que não se trata de associação com descongestionante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)
Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica em crianças e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP/Pediamécum - loratadina (aeped.es)

282. Lorazepam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno de ansiedade Crianças; uso excepcional/off-label	<12 anos: 0,02-0,1 mg/kg/dose VO 4/4-8/8 h, dose usual 0,05 mg/kg, máximo 2 mg/dose. ≥12 anos: iniciar 0,5-3 mg/DIA dividido 2-3 vezes; manutenção 1-2 mg 2-3 vezes/dia. Menor dose e menor tempo possível; reavaliar em dias e retirar gradualmente se uso prolongado. [S1] Iniciar pela menor dose e maior intervalo; doses do extremo superior e intervalos curtos exigem supervisão especializada, sem associar automaticamente ambos. Não é esquema domiciliar universal.
Pré-medicação anestésica Crianças/adolescentes	0,02-0,09 mg/kg VO, usual 0,05 mg/kg, dose única antes do procedimento; não superar teto adulto 4 mg. Monitorar sedação e ventilação. [S1]
Catatonia Pediatria hospitalar	Teste: 0,05 mg/kg EV lento 2-5 min, máximo 2 mg; alternativa IM/VO 0,1 mg/kg, máximo 2 mg. Reavaliar em 30 min com escala de catatonia/RASS. Protocolo VUMC permite doses adicionais 1 mg a cada 30-60 min conforme resposta e sedação, com equipe à beira-leito. Após resposta, individualizar manutenção e desmame; não há teto pediátrico universal validado. [S2] Não converter sequência do teste em receita domiciliar; tratar causa e considerar ECT em casos refratários.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Disponibilidade brasileira do original é VO. Risco de depressão respiratória com opioides e acúmulo em disfunção hepática/renal. Catatonia requer avaliação psiquiátrica/neurológica; não interromper benzodiazepínico crônico abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 37)
Tratamento de distúrbios de ansiedade; pré-medicação anestésica; controle da catatonia (uso oral adulto na bula).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] AEP/Pediamécum - lorazepam (aeped.es)
[S2] Vanderbilt Children’s - catatonia, novembro 2025 (vumc.org)

283. Losartana Potássica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial 6-16 anos	0,7 mg/kg VO 24/24 h, máximo inicial 50 mg; titular até 1,4 mg/kg/dia, máximo 100 mg/dia, em 1 tomada ou dividido 12/12 h. Alternativa por peso: 20-50 kg 25 mg/dia (até 50 mg); >50 kg 50 mg/dia (até 100 mg). Contínuo, titulado pela PA. [S1]
Proteção renal/nefropatia diabética com proteinúria ≥4 anos; uso off-label por nefrologia RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Evidência pediátrica de proteinúria em DRC: iniciar 0,4-0,8 mg/kg/DIA VO; aumentar lentamente até 1 mg/kg/dia, máximo 50 mg/dia, segundo PA/proteinúria/tolerância. Tratamento contínuo. [S1] A evidência é de DRC proteinúrica; não prova benefício em criança diabética normotensa sem albuminúria.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar K+, creatinina e PA após início/ajuste. Evitar gestação, estenose renal bilateral, hepatopatia grave; dados limitados se TFG <30. Corrigir hipovolemia; não associar rotineiramente IECA.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Hipertensão arterial e proteção renal na nefropatia diabética (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - losartan (aeped.es)

284. Macrogol 3350 / 4000 (PEG)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação funcional - manutenção Crianças; maior base de dados ≥6 meses	PEG 3350/4000 VO 0,4 g/kg/DIA inicialmente; titular dentro de 0,2-0,8 g/kg/dia em 1-2 tomadas. Manter pelo menos 2 meses e até ≥1 mês sem sintomas antes de retirada gradual; atravessar treinamento esfincteriano se necessário. [S1] Dose expressa em gramas de PEG, não peso total do sachê com eletrólitos.
Desimpactação fecal Crianças	PEG VO 1-1,5 g/kg/DIA por 3-6 dias, máximo 6 dias consecutivos; depois iniciar manutenção. Dividir volume para tolerância; descartar obstrução. [S1]
Preparo para colonoscopia Crianças; solução própria com eletrólitos	Solução de PEG 4000+sais reconstituída exatamente como rotulada: 25-40 mL/kg/HORA VO/sonda até efluente claro, geralmente 4-10 h; ajustar tolerância e horário de anestesia. [S2] Não aplicar mL/kg/h a PEG concentrado sem eletrólitos; risco de aspiração e distúrbio hidroeletrólítico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em obstrução, perfuração ou íleo. Conferir formulação/reconstituição; supervisão no preparo, especialmente se sonda, cardiopatia ou doença renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Tratamento da constipação intestinal funcional crônica, desimpactação fecal e preparo intestinal para colonoscopia.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ESPGHAN/NASPGHAN - constipação funcional (naspghan.org)

[S2] AEP/Pediamécum - macrogol-4000-sodio-sulfato (aeped.es)

285. Manitol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão intracraniana/edema cerebral Crianças em emergência/UTI	0,5-1 g/kg EV em 20-30 min; solução 20%=200 mg/mL: 2,5-5 mL/kg. Reavaliar PIC, perfusão e osmolaridade antes de repetir; monografia limita a 1,5 g/kg/DIA. Não usar infusão contínua. [S1]
Hipertensão intraocular aguda Crianças	1-2 g/kg EV em 30-60 min; solução 20%: 5-10 mL/kg. Dose única inicial; se pré-operatório, administrar 1-1,5 h antes da cirurgia. Repetição depende de resposta e avaliação osmótica/renal. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, volemia, diurese, Na⁺/K⁺, osmolaridade e função renal. Não administrar se anúria, edema pulmonar/congestão grave. Usar filtro e solução sem cristais. O teto de 1,5 g/kg/dia acima refere-se ao esquema de PIC, não à dose ocular.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Redução da pressão intracraniana e edema cerebral; controle de hipertensão intraocular aguda.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - manitol (aeped.es)

286. Mebendazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Enterobíase/oxiúros ≥2 anos; <2 somente avaliação especializada	100 mg VO em dose única; repetir 100 mg após 2 semanas (AEP admite 2-3 semanas). Tratar contatos elegíveis e medidas de higiene. [S1]
Ascaridíase; tricuríase; ancilostomíase ≥2 anos	100 mg VO 12/12 h por 3 dias. Alternativa para ascaridíase/ancilostomíase: 500 mg VO em dose única; para tricuríase preferir esquema 3 dias. [S1, S2] Se persistência parasitológica, reavaliar reinfeção/resistência antes de novo curso.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não associar metronidazol: risco de Stevens-Johnson/NET. Crianças pequenas têm relato de convulsão; uso <2 anos exige benefício justificado. Cursos prolongados: hemograma e função hepática.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Tratamento de parasitoses intestinais por oxiúros (*Enterobius vermicularis*), ascaridíase, tricuríase e ancilostomíase.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - mebendazol (aeped.es)

[S2] CDC - tratamento de helmintos transmitidos pelo solo (cdc.gov)

287. Mebeverina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor/espasmos na síndrome do intestino irritável Pediatria off-label; indicação/formulação original adulta RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Mebeverina convencional VO 20 min antes de refeições: 3 anos 25 mg 8/8 h; 4-8 anos 50 mg 8/8 h; 9-10 anos 100 mg 8/8 h; 11-18 anos 135 mg 8/8 h. Reavaliar após cerca de 1 mês, suspendendo se ineficaz. [S1] Esquema AEP é de liberação convencional: NÃO fracionar cápsula de liberação prolongada 200 mg nem tratá-la como equivalente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Excluir causa orgânica/alarmes. Evitar em íleo paralítico e cautela em insuficiência renal/hepática; registro BR e disponibilidade de formulação pediátrica devem ser confirmados.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Tratamento de dor e espasmos abdominais associados à síndrome do intestino irritável (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - mebeverina (aeped.es)

288. Meloxicam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Artrite idiopática juvenil Crianças; off-label segundo bula BR citada	0,125 mg/kg VO 24/24 h, máximo 7,5 mg/dia. Uso continuado conforme atividade da doença e reavaliação de toxicidade. [S1]
Osteoartrite/artrite reumatoide Adolescentes ≥16 anos e porte adulto; não extrapolar a >12 automaticamente RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	7,5 mg VO 24/24 h; se necessário até 15 mg/dia. Menor dose pelo menor período eficaz, com reavaliação. [S1] Original menciona “acima de 12 anos”; fonte pediátrica aberta sustenta regime adulto a partir de 16 anos. Em 13-15 anos não presumir teto 15 mg.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não associar outros AINEs. Vigiar sangramento GI, PA e rim; contraindicado na insuficiência renal grave sem diálise e hepática grave. Evitar desidratação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)
Tratamento da osteoartrite e artrite reumatoide (uso oral adulto acima de 12 anos; AIJ em pediatria, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - meloxicam (aeped.es)

289. Meropenem

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Meningite bacteriana ≥3 meses	40 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose. Infundir em 15-30 min. Referência RCH para duração total por agente: meningococo 7 dias; pneumococo e H. influenzae 10 dias; bacilos Gram-negativos 21 dias, ampliando se complicações. Meropenem somente quando indicado por suscetibilidade/cenário. [S1, S2] A duração refere-se ao tratamento antimicrobiano total; descalonar quando possível, sem manter meropenem apenas para completar prazo.
Sepse grave ≥3 meses	20 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 1 g/dose; infecção excepcionalmente grave por agente menos sensível pode exigir 40 mg/kg/dose, máximo 2 g. Reavaliar em 48-72 h e direcionar/descalonar; não há duração única de sepsis sem foco definido. [S1]
Infecção intra-abdominal complicada ≥3 meses	10-20 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 1 g/dose; preferir 20 mg/kg nos quadros graves. Duração guiada por controle do foco e resposta; abscesso não drenado exige reavaliação do controle de foco. [S1]
Exacerbação broncopulmonar na fibrose cística ≥3 meses	40 mg/kg/dose EV 8/8 h, máximo 2 g/dose; duração individual segundo recuperação respiratória e microbiologia. Não existe um número único de dias de meropenem para toda exacerbação. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar se TFG <50; TFG 30-50 manter dose por administração 12/12 h; 10-29 metade 12/12 h; <10 metade 24/24 h. Risco de convulsão e queda importante do valproato. Via EV; evitar bolus rápido da dose 40 mg/kg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Meningite bacteriana, sepsis grave, infecções intra-abdominais complicadas, exacerbações em fibrose cística (aprovado a partir de 3 meses).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - meropenem (aeped.es)

[S2] RCH - meningite e encefalite (rch.org.au)

290. Mesalazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Retocolite ulcerativa - indução oral Crianças; apresentação apropriada	≤40 kg: 30-50 mg/kg/DIA VO em 1-3 tomadas; faixa superior até 75 mg/kg/dia, máximo 4 g/dia. >40 kg: esquemas por formulação 1,5-4,8 g/dia. Avaliar resposta em semanas e associar/escalar se refratária; não intercambiar liberação de marcas. [S1]
Retocolite ulcerativa - manutenção Crianças	≤40 kg: 15-30 mg/kg/DIA VO em 1-3 tomadas; pode chegar 60 mg/kg/dia, máximo 2,4 g/dia. >40 kg: 0,8-2,4 g/dia por formulação. Contínuo, mantendo remissão. [S1]
Retocolite distal/proctite - via retal Crianças maiores/adolescentes; dose individualizada	Supositório 1 g retal à noite; alternativa 500 mg 3 vezes/dia. Enema em >40 kg: 4 g ao dia; formas 1 g à noite por 2-3 semanas ou espuma 1-2 g/dia por 4-6 semanas conforme extensão. [S1] A dose retal e registro etário variam; usar apenas formulação correspondente.
Doença de Crohn colônica - indução/manutenção Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indicação documental preservada. AEP antiga descreve os mesmos esquemas orais, mas benefício na doença de Crohn é limitado; não considerar mesalazina terapia suficiente para Crohn ativa moderada/grave. Seleção excepcional por gastroenterologia. [S1, S2] DiretrizECCO-ESPGHAN orienta indução nutricional/corticoide ou terapia biológica e manutenção imunomoduladora conforme risco; mesalazina não deve atrasar terapia eficaz.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Creatinina/urina, hemograma e enzimas hepáticas; suspender se suspeita de nefrite, pancreatite ou intolerância aguda. Contraindicado em insuficiência renal/hepática grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)

Retocolite ulcerativa e doença de Crohn colônica: indução e manutenção da remissão clínica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - mesalazina (aeped.es)

[S2] ECCO-ESPGHAN 2021 - Crohn pediátrica (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

291. Metadona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor crônica intensa refratária - faixa especializada Crianças; equipe de dor/paliativos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: ≤6 meses 0,025-0,05 mg/kg/dose 4/4-8/8 h; >6 meses e <50 kg 0,1-0,2 mg/kg/dose 4/4-8/8 h, máximo 5 mg/dose inicial. São faixas de monografia especializada: iniciar no limite inferior, usualmente intervalo 8 h, e titular lentamente pela sedação/dor. Uso contínuo com reavaliação diária no início. [S1] A faixa ampla da AEP não deve ser usada como início automático em paciente sem tolerância. Rotação depende do opioide/dose prévios; conversão não é linear.
Prevenção/tratamento da abstinência iatrogênica e desmame em UTI Crianças expostas a opioide por período prolongado	0,05-0,1 mg/kg/dose VO 6/6-8/8 h, máximo 5 mg/dose; alta exposição/tolerância pode exigir 0,15-0,2 mg/kg/dose 6/6 h, máximo 5 mg. Sobrepor à infusão opioide nas primeiras 24 h e reduzi-la com avaliação WAT-1; após estabilização reduzir metadona gradualmente, não interromper de forma brusca. [S2] Fonte UW descreve protocolos por duração da exposição; reavaliação clínica determina velocidade, sem duração fixa segura para todos.
Dor refratária - paciente sem tolerância opioide ≥1 ano; off-label, equipe experiente RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	1-<12 anos: 0,05-0,1 mg/kg/dose VO 8/8-12/12 h, máximo INICIAL 2,5 mg/dose. ≥12 anos: 2,5 mg/dose VO 8/8-12/12 h. Titular lentamente; reavaliar diariamente no início. [S3] Dose inicial apenas; acúmulo tardio exige vigilância. Não extrapolar para <1 ano.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG/QTc, K+/Mg 2+, sedação e FR; meia-vida longa e variável causa acúmulo tardio. Interações CYP e serotoninérgicas. Doses altas de paciente tolerante podem matar paciente sem tolerância.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 38)
Dor crônica e intensa refratária; desmame e prevenção de abstinência de opioides em UTI pediátrica (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] AEP/Pediamécum - metadona (aeped.es)
- [S2] UW Health - analgesia e desmame iatrogênico pediátrico (nicu.pediatrics.wisc.edu)
- [S3] APPM 2024 - metadona (appm.org.uk)

292. Metformina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diabetes mellitus tipo 2 ≥10 anos; formulação convencional	500-850 mg VO 1 vez/dia com alimento; após 10-15 dias ajustar por glicemia/tolerância. Aumentar progressivamente até máximo 2 g/DIA, dividido em 2-3 tomadas. Tratamento contínuo associado a medidas de estilo de vida; avaliar HbA 1c. [S1]
Síndrome dos ovários policísticos Adolescentes pós-menarca; off-label	Iniciar 500-850 mg VO 24/24 h com alimento; titular lentamente para 850 mg 12/12 h conforme tolerância/metabolismo, máximo 2 g/dia. Duração individual; reavaliar ciclos e risco metabólico. [S1] Não usar como tratamento único de todo sintoma de SOP; XR tem restrições próprias.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar função renal e vitamina B₁₂ no uso prolongado. Suspende em desidratação, hipóxia, sepse grave ou acidose; contraindicado TFG <30. Não iniciar se TFG 30-45 sem avaliação especializada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (a partir de 10 anos na forma convencional); síndrome dos ovários policísticos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - metformina (aeped.es)

293. Metilergometrina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorragia pós-parto/atonía uterina - prevenção e tratamento Uso obstétrico; não existe dose pediátrica por peso RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Para paciente obstétrica elegível, dose de bula: 0,2 mg IM; alternativa emergencial 0,1-0,2 mg EV LENTO, durante ≥60 s. Na atonia/hemorragia pode repetir a cada 2-4 h, máximo 5 doses/24 h. Na prevenção administrar somente após nascimento conforme manejo obstétrico. [S1] Em adolescente puérpera a decisão é obstétrica; NÃO administrar ao recém-nascido. Esquema adulto documentado, sem extrapolação para criança.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em gestação antes do parto, hipertensão, pré-eclâmpsia/eclâmpsia e sepse. Risco de hipertensão grave/vasoespasmó, sobretudo EV rápido; monitorar PA. Preferir IM.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)
Prevenção e tratamento de hemorragia uterina pós-parto e atonia uterina (uso obstétrico adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Novartis - Methergin, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

294. Metilfenidato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
TDAH - liberação imediata ≥6 anos	5 mg VO 1-2 vezes/dia no café/almoço; titular 5-10 mg/DIA por semana. Dividir total em 2-3 tomadas; máximo 60 mg/dia. Contínuo com reavaliação de benefício/necessidade. [S1]
TDAH - liberação prolongada ≥6 anos	Cápsula de microgrânulos: 10 mg pela manhã, titular semanalmente até 60 mg/dia. Sistema OROS: 18 mg pela manhã, aumentar 18 mg/semana; teto 54 mg/dia em crianças, 72 mg/dia em adolescentes, sem exceder 2 mg/kg/dia, conforme produto. [S2] Não converter todas as formulações mg a mg sem avaliar perfil de liberação.
Narcolepsia ≥6 anos; uso especializado/off-label conforme registro RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Liberação imediata: iniciar 5 mg VO 2 vezes/dia, manhã/almoço; aumentar 5-10 mg/DIA por semana, máximo 60 mg/dia em 2-3 tomadas. Tratamento contínuo titulado à vigília e efeitos adversos. [S3] Dose pediátrica geral da bula de produto que inclui narcolepsia; estudos pediátricos são sobretudo TDAH, portanto não representa prova equivalente de eficácia/regulamentação para narcolepsia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FC/PA, peso/altura, apetite, sono, tics e humor. Evitar IMAO e doença cardíaca relevante. Reavaliar após titulação e regularmente; não triturar OROS.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)
Tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) a partir de 6 anos de idade; narcolepsia.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] Bula regulatória Ritalin 10 mg (medicines.org.uk)
- [S2] AEP/Pediamécum - metilfenidato (aeped.es)
- [S3] DailyMed - metilfenidato solução (dailymed.nlm.nih.gov)

295. Metilprednisolona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Nefrite lúpica - pulsoterapia Crianças	Metilprednisolona SUCCINATO 30 mg/kg/dose EV 24/24 h por 3 dias, máximo 1 g/dose; alternativa 600-1000 mg/m ² /dose 24/24 h por 3 dias, máximo 1 g. Infundir lentamente, usualmente ≥60 min em pulsos. Seguir com imunossupressão/manutenção conforme classe histológica. [S1]
Rejeição aguda de transplante Crianças; tipo de rejeição confirmado RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Pulsoterapia imunossupressora 15-30 mg/kg/dose EV 24/24 h por 3 dias, máximo 1 g/dose; escolher dose segundo órgão, biópsia e equipe transplantadora. Rejeição humoral pode exigir terapias adicionais. [S1] Não confundir rejeição com dose de indução ou doença enxerto-contra-hospedeiro.
Exacerbação asmática grave Crianças	<12 anos: 1-2 mg/kg/DIA VO ou EV dividido 12/12 h, máximo 60 mg/dia, por 3-10 dias. ≥12 anos: VO 40-60 mg/dia ou EV 40-80 mg/dia em 1-2 tomadas, com transição precoce VO. [S1]
Estado de mal asmático em UTI Crianças monitoradas	Sem corticoide prévio: carga EV 2 mg/kg, máximo 60 mg; depois 1 mg/kg/dose EV 6/6 h, máximo 30 mg/dose. Se recebeu prednisona/metilprednisolona/dexametasona, iniciar manutenção 6 h após última dose, sem repetir carga. Após estabilização, reduzir ao esquema convencional. [S3, S1] AEP descreve manutenção 0,5-1 mg/kg/dose 6/6 h; o teto 30 mg/dose provém do protocolo CHOP.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES EV somente succinato: acetato de depósito e aceponato tópico NÃO são intercambiáveis. Monitorar PA, glicose, K+, infecção e bradicardia durante pulsos. Curso prolongado exige retirada gradual.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Corticoterapia sistêmica de alta potência em nefrites lúpicas, rejeição de transplante, exacerbações asmáticas graves.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - metilprednisolona (aeped.es)

[S2] IWK - methylprednisolone sodium succinate (dir.iwk.nshealth.ca)

[S3] CHOP - asma na UTI, dose por exposição prévia (chop.edu)

296. Metoclopramida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Náuseas/vômitos tardios da quimioterapia - segunda linha 1-18 anos	0,1-0,15 mg/kg/dose VO/EV até 3 vezes/dia, intervalo mínimo 6 h, máximo 0,5 mg/kg/DIA e 10 mg/dose. Usar até 5 dias; EV ≥3 min. [S1]
Náuseas/vômitos pós-operatórios - segunda linha 1-18 anos	0,1-0,15 mg/kg/dose EV até 3 vezes/dia, intervalo ≥6 h; teto 0,5 mg/kg/dia e 10 mg/dose. Duração máxima 48 h; administrar ≥3 min. [S1]
Distúrbios de motilidade gastrointestinal; outras náuseas/vômitos População pediátrica	Não recomendar uso crônico como procinético; restrição regulatória pediátrica limita indicações e duração. Contraindicado <1 ano. Outras causas exigem alternativa/avaliação específica. [S1]
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de distonia aguda, acatisia e discinesia tardia. Não repetir após vômito antes de 6 h. Reduzir na disfunção renal/hepática; evitar em obstrução, perfuração, hemorragia GI e epilepsia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Distúrbios da motilidade gastrointestinal e náuseas/vômitos (contraindicada abaixo de 1 ano e restrita em crianças de 1 a 18 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - metoclopramida (aeped.es)

297. Metoprolol (Tartarato / Succinato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão - tartarato convencional 1-17 anos	0,5-1 mg/kg/dose VO 12/12 h; titular pela PA/FC, máximo 6 mg/kg/DIA ou 200 mg/dia, o menor. Uso contínuo. [S1]
Hipertensão - succinato de liberação prolongada ≥6 anos	1 mg/kg VO 24/24 h (máximo inicial 50 mg); titular até 2 mg/kg/dia, máximo 200 mg/dia. Não triturar liberação prolongada. [S2]
Insuficiência cardíaca crônica estável Crianças; off-label	Iniciar 0,1 mg/kg/dose VO 12/12 h, titular lentamente conforme estabilidade até 0,9 mg/kg/DIA. Não iniciar/aumentar em choque ou descompensação aguda. Contínuo. [S2]
Taquicardia supraventricular refratária 1 mês-18 anos; terceira linha, evidência limitada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Teste 0,02 mg/kg EV; depois 0,1 mg/kg EV, máximo 5 mg/dose, em 2-5 min(velocidade ≤1-2 mg/min). Pode repetir após 5 min, máximo 3 doses. [S3] Cardiopediatra/UTI; ECG, PA e FC contínuos. Não usar como substituto automático de adenosina ou cardioversão.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar bradicardia, bloqueio AV, PA, broncoespasmo e hipoglicemia mascarada. Não retirar abruptamente. Confirmar sal e equivalência rotulada de succinato/tartarato.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)
Hipertensão arterial, taquicardias supraventriculares, insuficiência cardíaca crônica estável.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] IWK - metoprolol (dir.iwk.nshealth.ca)
- [S2] AEP/Pediamécum - metoprolol (aeped.es)
- [S3] ePed 2024 - metoprolol EV pediátrico (eped.se)

298. Metronidazol / Benzoilmetronidazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Amebíase intestinal/invasiva ≥4 semanas	Metronidazol BASE 15 mg/kg/dose VO 8/8 h, máximo 800 mg/dose, por 10 dias; alternativa 40-50 mg/kg/DIA dividido 6/6-8/8 h por 10 dias. Seguir com amebicida luminal. [S1, S2]
Giardíase ≥4 semanas	Alternativas VO: 30 mg/kg/dose 24/24 h, máximo 2 g, por 3 dias; OU 10 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 400 mg/dose, por 5-7 dias; AEP: 15 mg/kg/DIA dividido 8/8 h por 5-7 dias, máximo 500 mg/dia. Escolher UM esquema. [S1, S2]
Anaeróbios - infecção intra-abdominal/pélvica ≥4 semanas	EV 12,5 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 500 mg/dose; grave 8/8 h. VO 10 mg/kg/dose 12/12 h, máximo 400 mg/dose; grave 8/8 h. Associar cobertura de demais agentes e controle de foco; duração depende de drenagem e resposta. [S1]
Abscesso cerebral/infecção anaeróbia do SNC ≥4 semanas	PCH (≥4 semanas): 12,5 mg/kg/dose EV 8/8 h; alternativa UCSF (>3 meses): 10 mg/kg/dose EV 8/8 h. Máximo 500 mg/dose em ambos; associar antimicrobianos para demais agentes. Duração usual 4-8 semanas, conforme drenagem, evolução e imagem. [S1, S4]
Colite por C. difficile Crianças com doença sintomática, não colonização	Não grave, quando selecionado: 10 mg/kg/dose VO 8/8 h, máximo 400 mg/dose, por 10 dias. Grave/fulminante: não monoterapia; adicionar EV 12,5 mg/kg/dose 8/8 h, máximo 500 mg, ao tratamento enteral indicado. [S1, S3] <2 anos: discutir diagnóstico com infectologia; positividade isolada frequentemente é colonização.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Expressar dose em metronidazol BASE: benzoilmetronidazol pode declarar massa do éster/equivalente; conferir rótulo antes de converter mL. Hepatopatia grave reduz depuração. Monitorar neuropatia em curso prolongado; evitar mebendazol concomitante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Amebíase, giardíase, infecções por bactérias anaeróbias estritas (intra-abdominais, pélvicas, abscesso cerebral), colite por *C. difficile*.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH ChAMP - metronidazol, revisão 2024 (pch.health.wa.gov.au)

[S2] AEP/Pediamécum - metronidazol (aeped.es)

[S3] PCH ChAMP - infecções entéricas (pch.health.wa.gov.au)

[S4] UCSF - abscesso intracraniano pediátrico (idmp.ucsf.edu)

299. Micafungina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase invasiva/candidemia ≥4 meses	≤40 kg: 2 mg/kg/dose EV 24/24 h; >40 kg: 100 mg 24/24 h. Se resposta inadequada, até 4 mg/kg/dia ou 200 mg/dia, respectivamente. Candidemia sem complicação: ao menos 14 dias APÓS negativação documentada das hemoculturas e resolução dos sintomas; focos profundos exigem curso maior. [S1, S2, S3]
Candidíase invasiva neonatal <4 meses, incluindo RN	4 mg/kg/dose EV 24/24 h; suspeita de SNC requer dose de até 10 mg/kg/dia, e avaliação especializada. Segurança/eficácia no SNC não plenamente estabelecidas; escolher conforme susceptibilidade e foco. [S1, S2] 10 mg/kg/dia é dose especializada estudada para suspeita de acometimento do SNC; não escalonar automaticamente todos os RN. Duração da candidemia conforme critérios acima; SNC exige curso próprio.
Profilaxia de Candida no transplante de medula/alto risco neutropênico ≥4 meses	≤40 kg: 1 mg/kg EV 24/24 h; >40 kg: 50 mg 24/24 h. Manter até pelo menos 1 semana após recuperação dos neutrófilos. [S2] Não generalizar como profilaxia de qualquer fungo; atividade e risco do paciente orientam escolha.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reconstituir com 5 mL SF/SG 5%; diluir para 0,5-1,5 mg/mL e infundir 1 h, protegido da luz. Não exige ajuste renal. Monitorar função hepática, hemograma e reação infusional.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Tratamento de candidíase invasiva e candidemia; profilaxia de infecções fúngicas em transplante de medula óssea.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - micafungina (aeped.es)

[S2] EMA - Mycamine: informação do produto (ema.europa.eu)

[S3] IDSA - candidíase, diretriz 2016 (idsociety.org)

300. Miconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase oral ≥6 meses segundo original; deglutição adequada	Gel oral 20 mg/g: 6-23 meses 25 mg por aplicação, 4 vezes/dia após refeições; ≥2 anos 50 mg por aplicação, 4 vezes/dia. Dividir em pequenas porções na mucosa afetada; continuar ≥7 dias após resolução. [S1]
Dermatomicoses/candidíase cutânea superficial Crianças	Creme dermatológico: camada fina 1 vez/dia por 2-4 semanas; infecção mais intensa pode exigir 12/12 h. Pó: 1 aplicação/dia em área propensa à maceração. Reavaliar se persistente. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não colocar gel na garganta ou mamilo para lactente: risco de asfixia. Interação importante com varfarina mesmo por gel oral; formulação cutânea não deve ser ingerida. Não usar gel se deglutição imatura.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 39)

Tratamento da candidíase oral (gel a partir de 6 meses); dermatofitoses superficiais e candidíase cutânea.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - miconazol (aeped.es)

301. Midazolam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Sedação pré-procedimento Crianças/adolescentes	VO 0,25-0,75 mg/kg dose única (máximo 20 mg) 20-30 min antes; IN 0,2-0,5 mg/kg (máximo 10 mg, 5 mg/narina) 10-20 min antes; IM 0,1-0,15 mg/kg (máximo 10 mg) 30-60 min antes. EV 6 meses-5 anos 0,05-0,1 mg/kg, titular lentamente até total 0,6 mg/kg ou 6 mg; 6-12 anos 0,025-0,05 mg/kg, até 0,4 mg/kg ou 10 mg; ≥12 anos 0,5-2,5 mg, até 10 mg total. [S1, S2]
Sedação contínua em UTI/ventilação mecânica >1 mês; RN exigem esquema específico	EV carga 0,05-0,1 mg/kg, seguida 0,05-0,1 mg/kg/HORA; titular em incrementos 0,05-0,1 mg/kg/h, faixa usual 0,05-0,5 mg/kg/h. Reavaliar diariamente; retirar gradualmente após exposição prolongada. [S1]
Crise convulsiva prolongada Crianças; resgate	IN/bucal 0,2-0,3 mg/kg, máximo 10 mg; alternativa bucal por idade: 3 meses-<1 ano 2,5 mg; 1-<5 anos 5 mg; 5-<10 anos 7,5 mg; ≥10 anos 10 mg. Dose única de resgate; contar benzodiazepínicos prévios e reavaliar em 5 min. [S2] 3-6 meses: apenas ambiente hospitalar; não repetir indefinidamente.
Indução anestésica Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indução requer plano anestésico individual. A bula relata indução inconsistente mesmo em estudo pediátrico com 0,6 mg/kg EV após opioide; não recomenda usar esse número como dose de indução. Não há regime pediátrico universal respaldado nesta fonte. [S3]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ventilação/capnografia, PA e sedação; suporte de via aérea disponível. Opioides aumentam depressão respiratória. Evitar bolus em prematuro; acúmulo de metabólitos na disfunção renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Sedação pré-procedimento, indução anestésica, sedação contínua em UTI; crises convulsivas prolongadas (vias intranasal e bucal, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - midazolam (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - midazolam (aeped.es)

[S3] DailyMed - midazolam injetável (dailymed.nlm.nih.gov)

302. Mikania Glomerata (Guaco)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tosse com expectoração; adjuvância em rouquidão	Exemplo verificável: Xarope de Guaco Herbarium, 0,175 mg de cumarinas/5 mL. 2-5 anos: 2,5 mL VO 12/12 h; >5 anos: 2,5 mL VO 8/8 h. Afecção aguda: 7 dias; crônica: até 14 dias e reavaliar. Equivale 0,0875 mg de cumarinas por dose pediátrica. [S1]
≥2 anos; produto padronizado	Não extrapolar volume entre extratos; a bula sustenta tosse/expectorante, sem esquema específico comprovado para rouquidão isolada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <2 anos. Formulação contém açúcar e 1% de álcool; evitar em diabéticos conforme bula. Cautela em hepatopatia e uso com anticoagulante. Não substitui tratamento de asma, pneumonia ou obstrução respiratória.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Xarope fitoterápico adjuvante para alívio da tosse produtiva e rouquidão em vias aéreas (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Herbarium - bula de xarope de guaco (herbarium.com.br)

303. Milrinona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Insuficiência cardíaca grave/baixo débito pós-operatório	Milrinona EV contínua 0,25-0,75 mcg/kg/MIN; usual iniciar 0,5 e titular 0,25 conforme hemodinâmica. IWK admite teto 1 mcg/kg/min em casos selecionados. Sem bolus se hipotensão/instabilidade; usar pelo menor período necessário. [S1]
Crianças em UTI	
Prevenção/tratamento de baixo débito após cirurgia cardíaca - esquema estudado	Carga 75 mcg/kg EV em 60 MINUTOS, seguida 0,75 mcg/kg/min por 35 h; alternativa carga 50-75 mcg/kg em 30-60 min e infusão 0,25-0,75 mcg/kg/min. Manutenção dessa alternativa por até 35 h, conforme resposta. [S3]
Crianças selecionadas	Errata de fonte secundária: não administrar carga em 30-60 segundos. Decidir carga conforme PA/volemia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ECG, PA, perfusão, diurese e plaquetas. Depuração renal: reduzir/titular na insuficiência renal; risco de acúmulo e hipotensão. Não é dose em mg/kg/min.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Tratamento inotrópico e vasodilatador (inodilatador) de curto prazo na insuficiência cardíaca grave e baixo débito pós-cirurgia cardíaca.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - milrinone (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - milrinona (aeped.es)

[S3] SmPC - milrinona, atualização 2023 (medicines.org.uk)

304. Minociclina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acne inflamatória ≥12 anos; formulação convencional ou MR conforme registro	MR 100 mg VO 24/24 h; reavaliar após 6 semanas e limitar em geral a ≤6 meses. Se não responder, trocar estratégia; tratamentos >6 meses exigem investigação laboratorial/autoimune a cada 3 meses. [S1]
Infecções por agentes sensíveis >8 anos; uso selecionado	VO 4 mg/kg na primeira dose (máximo 200 mg), depois 2 mg/kg/dose 12/12 h (máximo 100 mg/dose). Duração depende do foco/agente; não há curso único para “infecções sensíveis”. [S2] Em 8-11 anos, aprovação e risco dentário dependem da formulação; MR para acne não é equivalente ao regime antimicrobiano convencional.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar gestação, menores de 8 anos, hepatopatia importante e isotretinoína concomitante. Riscos: vertigem, hepatite, lúpus, hiperpigmentação e hipertensão intracraniana. Tomar com água, sem deitar em seguida.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)
Tratamento da acne inflamatória moderada a grave e infecções por patógenos sensíveis (acima de 8 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Bula regulatória Minocin MR (medicines.org.uk)
[S2] DailyMed - minociclina convencional (dailymed.nlm.nih.gov)

305. Misoprostol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Maturação cervical/indução de trabalho de parto Paciente obstétrica, inclusive adolescente; uso hospitalar RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Misoprostol 25 mcg VO a cada 2 h OU 25 mcg vaginal a cada 6 h, conforme seleção obstétrica e monitorização materno-fetal. Suspende com trabalho de parto estabelecido, hiperestimulação ou alteração fetal; não há dose pediátrica por kg. [S1] Esquemas da OMS para indução a termo, não intercambiáveis com esquemas para outras idades gestacionais/indicações.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose em MICROGRAMAS. Não usar para indução em útero com cesárea prévia sem protocolo específico; vigilância de contrações/FC fetal. Não administrar ao RN nem em ambiente sem assistência obstétrica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Maturação cervical e indução do trabalho de parto em obstetrícia hospitalar.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] OMS - recomendações para indução do parto (iris.who.int)

306. Mometasona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica - tratamento/profilaxia ≥3 anos na fonte regulatória consultada	Spray 50 mcg/jato: 3-11 anos 1 jato/narina 24/24 h (100 mcg/dia). ≥12 anos 2 jatos/narina 24/24 h (200 mcg/dia); após controle 1 jato/narina/dia; refratária até 4 jatos/narina/dia (400 mcg/dia). Uso diário durante exposição; em sazonalidade previsível iniciar antes da exposição. [S1]
Dermatite atópica/outras dermatoses inflamatórias ≥2 anos	Mometasona creme 0,1%: camada fina na área afetada 1 vez/dia; em crianças, limitar a 5 dias pela bula consultada e reavaliar. Não há dose sistêmica por kg para aplicação tópica. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar corticoide cutâneo em micose/impetigo não tratados nem sob fralda/oclusão. Vigiar atrofia e supressão adrenal em área extensa. Nasal: epistaxe, técnica afastada do septo e crescimento no uso longo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Tratamento e profilaxia da rinite alérgica; dermatites atópicas e eczema cutâneo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bula regulatória Nasonex (medicines.org.uk)

[S2] Bula regulatória Elocon creme (medicines.org.uk)

307. Montelucaste de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma - manutenção ≥12 meses na bula norte-americana; registros internacionais diferem	VO 1 vez/noite: 12 meses-5 anos 4 mg; 6-14 anos 5 mg; ≥15 anos 10 mg. Manter conforme controle e reavaliar benefício; não substitui corticoide inalatório quando indicado. [S1, S2]
Broncoespasmo induzido por exercício Crianças ≥6 anos	Dose etária VO: 6-14 anos 5 mg; ≥15 anos 10 mg, pelo menos 2 h antes do exercício. Não repetir em 24 h; se já toma diariamente, não administrar dose extra pré-exercício. [S2] Não é medicamento de resgate.
Rinite alérgica Rinite perene ≥6 meses; sazonal ≥2 anos	VO 1 vez/dia: 6 meses-5 anos 4 mg; 6-14 anos 5 mg; ≥15 anos 10 mg. Reservar para falha/intolerância de alternativas; manter conforme benefício e exposição. Não somar doses de rinite e asma. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Alertar e monitorar alterações do sono, humor, comportamento e ideação suicida; suspender e avaliar se surgirem. Não tratar crise asmática aguda com montelucaste.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Tratamento de manutenção e controle adjuvante da asma persistente; prevenção de broncoconstrição por exercício; rinite alérgica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - montelukast (aeped.es)

[S2] DailyMed - montelucaste (dailymed.nlm.nih.gov)

308. Morfina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor aguda intensa - trauma, queimadura, crise falciforme Crianças sem tolerância prévia a opioide	VO: <6 meses 0,1 mg/kg/dose 4/4 h; ≥6 meses 0,2 mg/kg/dose 3/3-4/4 h, titular na faixa 0,2-0,5 mg/kg, máximo inicial 10 mg/dose. EV: <6 meses 0,05 mg/kg 4/4 h; ≥6 meses 0,05-0,1 mg/kg 3/3-4/4 h, faixa até 0,2 mg/kg, máximo inicial 2 mg/dose. Reavaliar após cada dose; reduzir/suspender conforme dor. [S1]
Dor intensa - infusão contínua em UTI >1 mês, equipe de dor/UTI	Após dose de carga apropriada, iniciar 0,02 mg/kg/HORA EV; titular 0,01 mg/kg/h a cada 2-4 h, faixa usual 0,01-0,04 mg/kg/h. Doses maiores requerem tolerância/indicação específica. Revisão diária e desmame após uso prolongado. [S1]
Dor oncológica/cuidados paliativos Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Titular morfina de liberação imediata à analgesia e efeitos adversos; pacientes tolerantes podem precisar doses maiores que iniciais acima. Após dose diária estável, formulação prolongada pode usar 0,2-0,8 mg/kg/dose 12/12 h como faixa inicial descrita, com ajustes 30-50%; não há teto universal em paciente tolerante. [S2] Não iniciar automaticamente dose alta de liberação prolongada em criança sem tolerância; plano de resgate individual.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FR, sedação, PA, náuseas/constipação; suporte e naloxona disponíveis. Insuficiência renal acumula metabólitos ativos: reduzir/espaciar ou escolher alternativa. Não confundir mg com mcg nem EV com VO.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Analgesia opioide para dor intensa aguda (trauma, queimaduras, crise falciforme), dor oncológica e cuidados paliativos pediátricos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - morphine (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - morfina (aeped.es)

309. Moxifloxacino

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Conjuntivite bacteriana ≥1 ano na bula aberta; neonatal exige avaliação específica	Colírio 0,5%: 1 gota no(s) olho(s) afetado(s), 3 vezes/dia por 7 dias. Não injetar e não usar formulação sistêmica como colírio. [S1]
Infecções respiratórias por agentes resistentes ≥3 meses-18 anos; excepcional/off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	10 mg/kg/dose VO/EV 24/24 h, máximo 400 mg/dia. EV: solução pronta infundida em 60 min. Duração vinculada ao foco, patógeno e resposta; uso protegido por infectologia. [S3] Reserva para resistência/intolerância sem alternativa; não cobre <i>Pseudomonas</i> .
Tuberculose drogaresistente ≥3 meses; equipe de TB pediátrica	10-15 mg/kg/dose VO 24/24 h, máximo 400 mg/dia, pelo período definido no regime combinado MDR/RR. Não usar monoterapia; verificar elegibilidade para regimes 6 ou 9 meses ou esquema longo. [S3] Dose PCH 2025; OMS dispõe de tabela por peso/formulação com arredondamentos específicos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sistema: QT, interação com outros prolongadores QT, hepatotoxicidade e tendinopatia. Colírio: higiene de ponta/sem lentes de contato durante infecção.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 40)

Tratamento de conjuntivite bacteriana (colírio); infecções respiratórias em adultos e tuberculose multirresistente (off-label sistêmico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - moxifloxacino oftálmico (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] AEP/Pediamécum - moxifloxacino (aeped.es)

[S3] PCH ChAMP 2025 - moxifloxacino (pch.health.wa.gov.au)

310. Mupirocina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Impetigo; foliculite; infecções cutâneas superficiais	Mupirocina 2%: camada fina na lesão limpa/seca 2-3 vezes/dia por 5-10 dias. Reavaliar se não houver melhora em 3-5 dias. Infecção extensa/sistêmica exige tratamento sistêmico. [S1]
Crianças	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Pomada cutânea não serve para olho, nariz ou cateter; formulação nasal é distinta. Evitar grande área de ferida, sobretudo em insuficiência renal, pela absorção de macrogol da base.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Tratamento tópico de impetigo, foliculite e infecções bacterianas superficiais da pele.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - mupirocina (aeped.es)

311. Naloxona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Depressão respiratória/coma por intoxicação opioide Crianças	Naloxona 0,1 mg/kg EV/IO, máximo 2 mg/dose; repetir a cada 2-3 min até ventilação adequada. Alternativa titulada: 0,01 mg/kg inicialmente, escalando para 0,1 mg/kg se resposta insuficiente. IM se sem acesso. Se sem resposta após total 10 mg, reavaliar causa/coingestões. [S1] Ventilar imediatamente; não aguardar efeito da naloxona.
Depressão respiratória em paciente dependente/tolerante ou analgesia terapêutica Crianças monitoradas	Reversão parcial: 0,001 mg/kg EV (1 mcg/kg) a cada 2-3 min, titulando à respiração; se quadro grave, escalar. Observar por tempo compatível com opioide causal e repetir se ressedação. [S2] Infusão contínua pode ser necessária em opioide de longa ação; calcular segundo bolus eficaz e toxicologia.
Intoxicação opioide com recorrência após bolus Crianças monitoradas	Infusão EV inicial: 2/3 da dose cumulativa de bolus que restaurou a ventilação, em mg, POR HORA; titular à ventilação. Diluir 2 mg em SF 0,9% q.s.p. 20 mL = 0,1 mg/mL. Taxa mL/h = dose mg/h ÷ 0,1. Manter enquanto houver risco de recorrência; reduzir gradualmente conforme resposta. [S3] Pode exigir bolus adicional. Observar 4-6 h após suspensão, prolongando conforme opioide e avaliação toxicológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Antagonismo dura menos que muitos opioides. Risco de abstinência abrupta e dor intensa. Não usar de rotina na reanimação neonatal nem em RN de mãe dependente; prioridade é ventilação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Reversão da depressão respiratória aguda e coma por superdose ou intoxicação exógena por opioides.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - naloxona (aeped.es)

[S2] IWK - naloxone (dir.iwk.nshealth.ca)

[S3] Atlantic Canada Poison Centre - naloxona pediátrica (atlanticcanadapoisoncentre.ca)

312. Naproxeno (Sódico)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Artrite idiopática juvenil >2 anos; off-label conforme bula BR	Naproxeno BASE 5 mg/kg/dose VO 12/12 h; titular conforme atividade, faixa total 7-20 mg/kg/DIA, máximo 1000 mg/dia. Uso continuado com monitorização. [S1]
Dor musculoesquelética/inflamatória >2 anos; uso selecionado	5-7 mg/kg/dose VO 8/8-12/12 h; respeitar total ≤20 mg/kg/dia e 1000 mg/dia. Menor dose por menor tempo; reavaliar se dor persistente. [S1]
Dismenorreia Adolescentes pós-menarca	Esquema de analgesia por peso acima; em >12 anos, alternativa de dose fixa 400 mg BASE inicial, depois 200 mg 8/8-12/12 h, máximo 600 mg/dia. Usar apenas durante dias sintomáticos. [S1] 220 mg de sal sódico equivalem 200 mg de naproxeno base; não somar apresentações.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sangramento GI, rim e PA; evitar desidratação, doença renal e associação com outro AINE. Dose diária depende da indicação; teto 1000 mg não autoriza dose sem peso.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Analgésico e anti-inflamatório em dor musculoesquelética, dismenorreia e processos inflamatórios (uso adulto na bula; AIJ off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - naproxeno (aeped.es)

313. Neomicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção de infecção em pequenos cortes/escoriações/queimaduras ≥2 anos; formulação isolada específica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Neomicina BASE 3,5 mg/g: pequena camada na área limpa 1-3 vezes/dia; não ultrapassar 7 dias sem reavaliação. [S2] Rótulo OTC internacional de 2013; não comprova disponibilidade/aprovação brasileira atual.
Infecção bacteriana superficial estabelecida Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	O rótulo localizado sustenta primeiros socorros/prevenção em pequenas lesões. Não extrapolar para impetigo extenso, abscesso ou infecção sistêmica; escolher tratamento conforme sítio/cultura. [S2] Indicação do documento preservada; benefício de neomicina isolada não estabelecido para toda infecção cutânea.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Neomicina pode causar sensibilização, nefrotoxicidade e ototoxicidade se absorvida por pele extensa/queimada. Evitar uso em RN, grande área e mucosa lesada sem indicação especializada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Tratamento tópico de infecções bacterianas superficiais da pele e prevenção de infecção em feridas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cosmed - Nebacetin: fonte de associação, não monofármaco (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] DailyMed - neomicina isolada tópica (dailymed.nlm.nih.gov)

314. Neomicina + Bacitracina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Impetigo/infecções superficiais; pequenas queimaduras e escoriações	Pomada: sulfato de neomicina 5 mg/g (equivale a 3,5 mg/g de neomicina base) + bacitracina zíncica 250 UI/g. Aplicar camada fina 2-5 vezes/dia após limpeza/secagem. Manter 2-3 dias após desaparecerem sintomas. Em queimaduras/área maior, limitar a 8-10 dias, evitando áreas extensas. [S1, S2]
Crianças; não RN/prematuros	A dose é camada suficiente sobre a lesão, não mg/kg/dia. Infecção extensa/febre pode exigir antibiótico sistêmico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em RN/prematuros, insuficiência renal grave e alergia a aminoglicosídeo. Evitar olho, ouvido com tímpano perfurado e grande área; risco de dermatite, oto/nefrotoxicidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Prevenção e tratamento de infecções bacterianas cutâneas superficiais, impetigo, pequenas queimaduras e escoriações.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cosmed - Nebacetin: bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] Nebacetin - bula do fabricante: composição e equivalência sal/base

315. Neostigmina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão de bloqueio neuromuscular não despolarizante RN/crianças/adolescentes	Neostigmina 0,03-0,07 mg/kg EV lenta, máximo total 0,07 mg/kg OU 5 mg, o menor. Administrar apenas com recuperação espontânea apropriada e monitorização de bloqueio; associar atropina 0,02 mg/kg ou glicopirrolato em dose correspondente. Dose única de reversão. [S1, S2]
Miastenia gravis - tratamento sintomático Crianças	0,01-0,04 mg/kg/dose EV/IM/SC a cada 2-4 h segundo força muscular/respiração; EV em ≥ 1 min. Tratamento continuado titulado, com avaliação de anticolinérgico para efeitos muscarínicos. [S2] Não usar dose de reversão como manutenção; distinguir crise miastênica de colinérgica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FC, secreções, FR e força. Evitar obstrução intestinal/urinária, bradicardia importante; depuração prolongada na insuficiência renal. Reversão inadequada pode causar fraqueza/paralisia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Reversão do bloqueio neuromuscular não despolarizante; tratamento sintomático da miastenia gravis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - neostigmine (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - neostigmina (aeped.es)

316. Nifedipino

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial crônica Crianças; off-label	Nifedipino de LIBERAÇÃO PROLONGADA 0,25-0,5 mg/kg/DIA VO, em 1-2 tomadas conforme produto. Titular geralmente a cada 7-14 dias; máximo 3 mg/kg/dia ou 120 mg/dia, o menor. Contínuo. [S1] Dose total por dia; não mg/kg por tomada. Só usar forma que possa ser administrada sem destruir liberação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não triturar/mastigar formulação prolongada. Evitar administração sublingual para queda rápida da PA; risco de hipotensão imprevisível. Cautela hepática; monitorar PA/FC, edema e gengiva.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Tratamento da hipertensão arterial crônica (uso adulto na bula; uso pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - nifedipino (aeped.es)

317. Nimesulida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor aguda de origem inflamatória >12 anos; segunda linha	Nimesulida 50-100 mg VO 12/12 h após refeições. Adotar teto conservador 200 mg/dia e máximo 15 dias; preferir período menor. [S1, S2] Bula BR consultada cita excepcionalmente 400 mg/dia, mas restrição EMA é 200 mg/dia; não reproduzir teto maior como faixa segura pediátrica.
Febre <12 anos contraindicado; adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não usar como antitérmico pediátrico de rotina; indicação original preservada com restrição. Considerar alternativas com melhor perfil de segurança, sobretudo em doença febril viral. [S1, S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hepatotoxicidade potencialmente grave: evitar doença hepática, outros hepatotóxicos e álcool. Contraindicado insuficiência renal grave/úlcera ou sangramento; suspender com anorexia, vômito persistente, urina escura/icterícia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Tratamento de dor inflamatória aguda e febre (contraindicado estritamente abaixo de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Aché - Nisulid: bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] EMA - revisão de segurança da nimesulida (ema.europa.eu)

318. Nistatina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Candidíase oral RN, lactentes e crianças	Suspensão: RN prematuro 100000 UI 6/6 h; RN termo 200000 UI 6/6 h; após período neonatal até <1 ano 250000 UI 6/6 h; ≥1 ano 250000-500000 UI 6/6-12/12 h. Aplicar metade em cada lado da boca, mantendo contato antes de engolir. Tratar até 48 h após resolução; reavaliar se persiste 14 dias. [S1]
Candidíase intestinal Lactentes, crianças/adolescentes	Lactentes 100000-300000 UI VO 6/6 h; crianças/adolescentes 250000-750000 UI VO 6/6 h. Continuar ≥48 h após resolução; reavaliar diagnóstico se persistente. [S1] Não tratar Candida em fezes isoladamente como doença; nistatina não trata candidemia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES UI não são mg. Agitar suspensão e conferir concentração antes de converter volume. Absorção sistêmica mínima; não usar EV. Candidíase persistente exige avaliar técnica, imunodeficiência e diagnóstico.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 41)

Tratamento local da candidíase oral (sapinho) e candidíase intestinal.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - nistatina (aeped.es)

319. Nistatina + Óxido de Zinco

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatite de fralda com Candida - tratamento/proteção da pele	Pomada nistatina 100000 UI/g+óxido de zinco 200 mg/g: camada fina após banho e a cada troca de fralda, após limpeza e secagem suaves. Manter até resolução clínica, reavaliando se não houver melhora. [S1]
Lactentes/crianças	A associação contém antifúngico; prevenção rotineira sem candidíase pode usar barreira simples, sem expor ao antifúngico desnecessariamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso cutâneo, evitar olho. Não esfregar pele; trocar fraldas frequentemente. Suspende se dermatite de contato/irritação. Não existe dose fixa em g/kg nem duração universal na bula.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento e prevenção da dermatite de fraldas complicada por infecção fúngica (*Candida albicans*).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Dermodex Tratamento - bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

320. Nitazoxanida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Giardíase; criptosporidiose em imunocompetente; helmintíases sensíveis ≥1 ano	VO com alimento por 3 dias: 1-3 anos 100 mg 12/12 h; 4-11 anos 200 mg 12/12 h; ≥12 anos 500 mg 12/12 h. Helmintos documentados na monografia: Ascaris e Hymenolepis nana. Fasciola hepatica exige 7 dias. [S1] Não generalizar 3 dias para qualquer helminto; imunodeficiência pode alterar resposta.
Gastroenterite por rotavírus ou norovírus ≥1 ano; indicação da bula brasileira RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO com alimentos: 1-11 anos 7,5 mg/kg/dose 12/12 h por 3 dias; ≥12 anos 500 mg 12/12 h por 3 dias. Não generalizar para todos os vírus nem tratar todo quadro de diarreia com nitazoxanida. [S2] Registro da bula brasileira; evidência limitada para benefício rotineiro. Reidratação continua essencial.
Giardíase, helmintíases sensíveis e criptosporidiose - alternativa brasileira ≥1 ano RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: 1-11 anos 7,5 mg/kg/dose 12/12 h; ≥12 anos 500 mg 12/12 h. Usualmente 3 dias. Na criptosporidiose com imunodepressão: bula indica 14 dias se CD 4 >50 células/mm ³ ; se <50, ao menos 8 semanas ou até resolução/negativação, sob infectologia. Em ≥12 anos com imunodepressão, bula admite 500-1000 mg 12/12 h. [S2] Bula cita Enterobius, Ascaris, Strongyloides, ancilostomídeos, Trichuris, Taenia e Hymenolepis; não é primeira escolha universal. Imunodepressão: eficácia depende de recuperação imune; CD 4 =50 exige decisão especializada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES <1 ano: contraindicado na bula brasileira; doença renal/hepática também contraindica esse produto. Usar suspensão e peso correto em <12 anos. Esquema ponderal brasileiro e faixas etárias internacionais são alternativas; não somar. Pode alterar a cor da urina.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento de parasitoses intestinais por protozoários (*Giardia lamblia*, *Cryptosporidium*) e helmintos, além de gastroenterites virais.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - nitazoxanida (aeped.es)

[S2] Farmoquímica - bula profissional Annita, aprovada em 2021 (cópia pública) (uploads.consultaremedios.com.br)

321. Nitrofurantoína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Cistite/infecção urinária baixa ≥1 mês; confirmar restrição etária local	0,75-1,75 mg/kg/dose VO 6/6 h, máximo 100 mg/dose. Alternativa 5-7 mg/kg/DIA dividido em 4 tomadas, por 5-7 dias. Administrar com alimento. [S1, S2] Não usar para pielonefrite, bacteremia ou febre com suspeita de foco renal.
Profilaxia de recorrência de ITU Crianças selecionadas	1-2 mg/kg/dose VO ao deitar, máximo 100 mg/dia. Manutenção somente enquanto benefício superar risco, com reavaliação urológica e laboratorial periódica. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado <1 mês; fonte europeia restringe <3 meses. Evitar deficiência G 6PD e função renal reduzida: em geral TFG <45, exceção 30-44 apenas avaliação especializada. Vigiar toxicidade pulmonar/hepática e neuropatia no uso prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento e profilaxia de infecções do trato urinário baixo por bactérias sensíveis (contraindicado em menores de 1 mês e na pielonefrite).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PCH ChAMP - nitrofurantoína (pch.health.wa.gov.au)

[S2] AEP/Pediamécum - nitrofurantoina (aeped.es)

322. Nitroglicerina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Edema pulmonar hipertensivo; IC descompensada; controle hemodinâmico cirúrgico	EV contínua 0,25-0,5 mcg/kg/MIN; titular à PA/perfusão, faixa usual 1-5 mcg/kg/min. IWK admite máximo 20 mcg/kg/min em ambiente especializado; RN máximo 5 mcg/kg/min pela AEP. Adolescente: alternativa 5-10 mcg/min, titulando até 200 mcg/min. Sem bolus EV; menor duração necessária. [S1, S2]

Crianças; UTI/anestesia

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Diluir SF/SG 5% para 50-100 mcg/mL; usar sistema de baixa adsorção, evitando PVC. Monitorar PA, FC e metemoglobina se doses altas. Contraindicado com PDE 5/riociguat; tolerância após 24-48 h. $\text{mL/h} = \text{dose} \times \text{peso} \times 60 / \text{concentração}$.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento de edema agudo de pulmão hipertensivo, insuficiência cardíaca descompensada e controle hemodinâmico cirúrgico.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - nitroglycerin (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - nitroglicerina (aeped.es)

323. Nitroprussiato de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Emergência hipertensiva/encefalopatia hipertensiva Crianças em UTI	Nitroprussiato EV contínuo 0,3-0,5 mcg/kg/MIN; subir 0,25-0,5 a cada 5-10 min, usual 0,5-4. Máximo 10 mcg/kg/min por ≤10 min; se não controlar, suspender/trocar. Se >24 h, não exceder 4 mcg/kg/min. Redução de PA controlada, sem bolus. [S1]
Dissecção aguda de aorta Pediatria; cenário excepcional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	EV contínuo: iniciar 0,3-0,5 mcg/kg/min, titular conforme PA; faixa usual 0,5-4 mcg/kg/min. Teto 10 mcg/kg/min por ≤10 min; se >24 h, teto 4 mcg/kg/min. Usar APÓS/COM betabloqueador para controlar frequência/contratilidade. Manter até estratégia definitiva. [S1, S2] Indicação documental preservada; metas dependem de perfusão e equipe cardiovascular.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Diluição em SG 5% e fotoproteção conforme produto. Monitorar PA invasiva, lactato, equilíbrio ácido-base e função renal/hepática; risco de cianeto/tiocianato, maior com dose alta, tempo prolongado e disfunção orgânica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento de emergências hipertensivas graves, encefalopatia hipertensiva e dissecção aórtica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - nitroprusside (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - nitroprusiato-sodico (aeped.es)

324. Noradrenalina (Norepinefrina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Choque séptico vaso plégico/hipotensão refratária >28 dias; UTI/emergência	Noradrenalina BASE EV/IO contínua: iniciar 0,05-0,1 mcg/kg/MIN (IWK também início 0,02); titular à perfusão/PA. Faixa usual 0,02-1 mcg/kg/min; teto usual institucional 2 mcg/kg/min. Na emergência séptica, 0,05-0,3 é faixa inicial. Não há duração fixa: reduzir gradualmente após reversão do choque. [S1]
Hipotensão/choque neonatal RN	Iniciar 0,05 mcg/kg/min de BASE EV, titular até 1 mcg/kg/min na monografia neonatal. Preparo: 300 mcg/kg de base em SG 5% até volume FINAL 50 mL; 0,5 mL/h entrega 0,05 mcg/kg/min. [S2] Teto neonatal não é teto universal de todas as crianças.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Bitartarato pode conter 2 mg de sal por 1 mg de base: conferir equivalência no rótulo. Sem bolus; bomba e monitorização contínua. Acesso central preferido; acesso periférico/IO inicial exige vigilância de extravasamento sem atrasar suporte.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento do choque séptico vasoplégico e hipotensão arterial refratária em adultos e pediatria.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - norepinephrine (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] Queensland NeoMedQ 2026 - noradrenalina (health.qld.gov.au)

325. Nortriptilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Depressão maior Menores de 18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Uso pediátrico não estabelecido na bula regulatória consultada; não aplicar dose adulta. Avaliar alternativa com evidência em depressão pediátrica. [S1]
Profilaxia de migrânea Crianças/adolescentes; off-label	VO à noite: iniciar 10 mg(5 mg se <20 kg); aumentar 10-20 mg a cada 2-6 semanas até efeito ou máximo 75 mg/dia OU 1 mg/kg/dia, o menor. Pode levar 6 semanas para avaliar efeito; manutenção enquanto benefício, com retirada gradual. [S2] Monitorar humor, ECG conforme risco, PA e efeitos anticolinérgicos. Não usar dose antidepressiva adulta.
Dor neuropática Crianças/adolescentes; off-label, equipe de dor RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Iniciar 0,1 mg/kg VO à noite; titular lentamente até 0,5 mg/kg à noite, máximo usual 20-25 mg/dia conforme tolerabilidade. Manutenção conforme resposta; retirada gradual. [S3] Tabela de revisão clínica pediátrica, sem intervalo único de titulação ou duração fixa; monitorar ECG, sedação, anticolinergia e humor.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Tricíclico com risco de arritmia, anticolinergia e toxicidade grave em overdose; ECG e avaliação de interações/risco suicida antes de uso especializado. Retirar gradualmente após uso prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento de depressão em adultos; dor neuropática crônica e profilaxia de migrânea (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEMPS - nortriptilina, ficha técnica (cima.aemps.es)

[S2] SSM Health - cefaleia pediátrica (ssmhealth.com)

[S3] Friedrichsdorf e Goubert, Pain Reports 2020 - tabela 5 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

326. Octreotida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorragia digestiva por varizes Crianças	EV 1-2 mcg/kg na carga, depois 1-2 mcg/kg/HORA, máximo 50 mcg/h. Após ≥ 24 h sem sangramento, reduzir 50% a cada 12 h e suspender; tratar fonte hemorrágica/endoscopia. [S1]
Quilotórax refratário Crianças; off-label	Infusão EV 0,5-4 mcg/kg/HORA; titular ao débito. Alternativa intermitente: 5 mcg/kg/dose EV 8/8 h por 5 dias, aumentar 5 mcg/kg/dose a cada 24 h até máximo 40 mcg/kg/DIA. Se infusão, AEP descreve aumento até 10 mcg/kg/h em casos selecionados; reduzir gradualmente 2-7 dias após resposta. [S1, S2] Faixa alta exige equipe especializada; dose ideal/duração não universais.
Hiperinsulinismo congênito/persistente Lactentes/crianças; off-label, após falha de diazóxido	Iniciar 5 mcg/kg/DIA SC dividido 6/6-8/8 h OU em infusão SC contínua 24 h. Titular progressivamente à glicemia, faixa 5-25 mcg/kg/dia; AEP descreve teto 35 mcg/kg/dia. Tratamento contínuo com endocrinologia. [S2] Risco de enterocolite necrosante sobretudo RN/pré-termo; teto não elimina risco.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar glicemia, função hepática/tireoide, vesícula, crescimento e perfusão intestinal. Distinguir mcg/kg/HORA de mcg/kg/DIA. Formulação de depósito não equivale a solução de ação curta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento de hemorragia digestiva por varizes esofágicas; hiperinsulinismo congênito e quilotórax refratário (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] IWK - octreotide (dir.iwk.nshealth.ca)

[S2] AEP/Pediamécum - octreotida (aeped.es)

327. Olanzapina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Esquizofrenia; episódio maníaco/misto do transtorno bipolar I	Olanzapina VO 2,5-5 mg 24/24 h inicialmente; titular em passos 2,5-5 mg, alvo 10 mg/dia, faixa 2,5-20 mg/dia, máximo 20 mg/dia estudado. Reavaliar eficácia e necessidade de manutenção; tratamento contínuo quando indicado. [S1]
13-17 anos, registro internacional	Registro brasileiro/indicação etária podem diferir; não extrapolar <13 anos.
Náuseas/vômitos refratários associados à quimioterapia	0,1 mg/kg/dose VO 1-2 vezes/dia, máximo 10 mg/dose, segundo emetogenicidade/resposta. Usar durante período de risco/resgate, com reavaliação diária. [S2]
≥3 anos; off-label	Não aplicar a qualquer vômito infantil; dose 2 vezes/dia exige supervisão oncológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar peso, glicemia, lipídios, sedação e sintomas extrapiramidais. Adolescente tem maior risco metabólico. Evitar olanzapina IM concomitante a benzodiazepínico parenteral; não converter esquema VO em IM.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 42)

Tratamento da esquizofrenia e transtorno bipolar em adultos (adolescentes a partir de 13 anos para esquizofrenia); náuseas refratárias (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - olanzapina: bula regulatória (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] IWK - olanzapine (dir.iwk.nshealth.ca)

328. Óleo Mineral (Petrolato Líquido)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação - óleo mineral oral ≥6 anos, sem disfagia/risco de aspiração	Óleo mineral/parafina líquida medicinal: 6-12 anos 15 mL VO 1 vez/dia, máximo 15 mL/dia; >12 anos 15-45 mL/dia, máximo 45 mL. Emulsões têm doses distintas: 6-12 anos 5 mL 1-2 vezes/dia, máximo 10 mL; >12 anos 15 mL 1-2 vezes/dia, máximo 30 mL. Reavaliar se >6 dias. [S1] Conferir formulação; não aplicar dose de emulsão ao óleo puro.
Hidratação/proteção cutânea Crianças, conforme rótulo cutâneo; exemplo consultado: 6-18 meses RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Aplicar pequena quantidade do produto cutâneo na mão e massagear suavemente a pele íntegra. Não há dose em g/kg nem intervalo ou duração fixos; seguir necessidade de hidratação e rótulo. [S2] Fonte descreve produto cosmético à base de óleo mineral com outros componentes; não valida ingestão nem aplicação em pele irritada/lesada. Evitar olhos e mucosas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não administrar deitado, em paciente com disfagia ou via sonda sem avaliação: pneumonia lipóidica. Evitar <6 anos na fonte consultada; interfere na absorção de vitaminas/lipofílicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento e lubrificação para constipação intestinal (uso oral); hidratação cutânea (uso tópico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - parafina-liquida (aeped.es)

[S2] Fabricante Johnson's - óleo cutâneo à base de óleo mineral (johnsonsbaby.com.br)

329. Olopatadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Conjuntivite alérgica ≥3 anos	Olopatadina colírio 0,1%: 1 gota em cada olho afetado 2 vezes/dia, intervalo aproximado 8 h. Pode manter até 4 meses se necessário, reavaliando. [S1] Concentrações 0,2%/0,7% têm posologias próprias; não usar mesma frequência sem bula.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não tocar ponta; retirar lentes de contato e respeitar intervalo de reinserção da bula. Se dor ocular, fotofobia ou perda visual, reavaliar diagnóstico.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento e profilaxia de sinais e sintomas da conjuntivite alérgica (uso ocular a partir de 3 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - olopatadina (aeped.es)

330. Omalizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma alérgica grave ≥6 anos, elegível por sensibilização/IgE e peso	Omalizumabe SC: dose e intervalo definidos pela tabela abaixo, cruzando IgE total PRÉ-TRATAMENTO × peso. Doses 75-600 mg a cada 2 ou 4 semanas; máximo 600 mg a cada 2 semanas. Reavaliar benefício após 16 semanas. [S1] Tabela aplicável a ≥6 anos, com peso/IgE dentro das células autorizadas. Célula sem dose: não extrapolar. Não retitular pela IgE elevada durante o uso.
Urticária crônica espontânea refratária a anti-H1 ≥12 anos	300 mg SC a cada 4 semanas; independe de peso e IgE. Manutenção com reavaliação periódica da atividade/resposta. Não usar tabela de asma para urticária. [S1]

ASMA ALÉRGICA • DOSE SC POR IgE BASAL E PESO [S1]

≥6 anos; somente pacientes elegíveis na bula; tabela EMA não contempla <20 kg.

Cada célula informa a **dose em mg por administração** e, abaixo, o **intervalo em semanas**. “—” significa ausência de dose recomendada; não extrapolar. Este nomograma não se aplica à urticária.

IgE basal (UI/mL)	20-25 kg	>25-30 kg	>30-40 kg	>40-50 kg	>50-60 kg	>60-70 kg	>70-80 kg	>80-90 kg	>90-125 kg	>125-150 kg
30-100	75 mg 4 sem	75 mg 4 sem	75 mg 4 sem	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem
>100-200	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem
>200-300	150 mg 4 sem	150 mg 4 sem	225 mg 4 sem	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	450 mg 4 sem	450 mg 4 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem	375 mg 2 sem
>300-400	225 mg 4 sem	225 mg 4 sem	300 mg 4 sem	450 mg 4 sem	450 mg 4 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem	600 mg 4 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem
>400-500	225 mg 4 sem	300 mg 4 sem	450 mg 4 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem	600 mg 4 sem	375 mg 2 sem	375 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem
>500-600	300 mg 4 sem	300 mg 4 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem	600 mg 4 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	450 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—
>600-700	300 mg 4 sem	225 mg 2 sem	450 mg 4 sem	600 mg 4 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	—	—
>700-800	225 mg 2 sem	225 mg 2 sem	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—
>800-900	225 mg 2 sem	225 mg 2 sem	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—	—
>900-1000	225 mg 2 sem	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—	—	—
>1000-1100	225 mg 2 sem	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—	—	—	—
>1100-1200	300 mg 2 sem	300 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—	—	—	—
>1200-1300	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	450 mg 2 sem	525 mg 2 sem	—	—	—	—	—	—
>1300-1500	300 mg 2 sem	375 mg 2 sem	525 mg 2 sem	600 mg 2 sem	—	—	—	—	—	—

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de anafilaxia inclusive tardia; ambiente e plano de observação adequados. Não trata crise asmática aguda; não suspender corticoides abruptamente. IgE sobe durante tratamento: não retitular pela IgE medida em uso.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento complementar da asma alérgica grave persistente (a partir de 6 anos) e urticária crônica espontânea refratária (a partir de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Xolair: tabelas oficiais de dose (ema.europa.eu)

331. Omeprazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DRGE/esofagite erosiva ≥1 ano e ≥10 kg; lactentes off-label	VO 15-30 min antes do desjejum: 10-20 kg 10 mg 24/24 h, podendo 20 mg; >20 kg 20 mg 24/24 h, podendo 40 mg. Esofagite 4-8 semanas; DRGE sintomática 2-4 semanas e reavaliar. Em 5-<10 kg, fonte descreve 5 mg/dia; RN 0,5-1,5 mg/kg/dia e lactente 0,7 mg/kg/dia somente quando indicação comprovada. [S1]
Úlcera péptica Crianças	VO por peso: 5-<10 kg 5 mg/dia; 10-20 kg 10 mg/dia; >20 kg 20 mg/dia. Duração geralmente 4-8 semanas, reavaliando cicatrização e causa; pesquisar/tratar H. pylori quando indicado. [S1]
Erradicação de H.pylori Crianças ≥15 kg	Omeprazol VO 12/12 h por 14 dias: 15-24 kg 20 mg/dose; 25-34 kg 30 mg/dose; ≥35 kg 40 mg/dose. Associar antibióticos definidos por suscetibilidade; não usar monoterapia. [S2, S3] Maior dose para erradicação não equivale à dose de DRGE. FonteUCSF usa >35 kg, com fronteira 35 kg resolvida pela tabela ESPGHAN 35-49 kg.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não triturar grânulos gastro-resistentes; administração por sonda requer preparação adequada. Reavaliar uso prolongado; risco de hipomagnesemia e interações. Hepatopatia grave pode requerer metade da dose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)
DRGE com esofagite erosiva, úlcera péptica, erradicação de *H. pylori* (formulado a partir de 1 ano nas apresentações adequadas).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] AEP/Pediamécum - omeprazol (aeped.es)
- [S2] UCSF - IBP para H.pylori em pediatria (idmp.ucsf.edu)
- [S3] ESPGHAN/NASPGHAN 2024 - H.pylori (espghan.org)

332. Ondansetrona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Quimioterapia - prevenção de náuseas/vômitos ≥6 meses	Alternativas: 0,15 mg/kg/dose EV antes da quimioterapia, repetir 4 e 8 h depois (máximo 8 mg/dose); OU 5 mg/m ² EV uma vez, máximo 8 mg. Após 12 h: VO ≤10 kg 2 mg 12/12 h; >10 kg 4 mg 12/12 h, até 5 dias. Pela superfície: <0,6 m ² 2 mg 12/12 h; ≥0,6 m ² 4 mg 12/12 h. Não combinar cálculos de peso e superfície. [S1]
Náuseas/vômitos pós-operatórios ≥1 mês	0,1 mg/kg EV uma vez, máximo 4 mg, antes/durante/após indução; mesma dose única se sintomas estabelecidos. Administrar lentamente ≥30 s. Repetir rotineiramente após falha não mostra benefício. Alternativa VO off-label em ≥40 kg: 4 mg 1 h antes da anestesia e 4 mg após 12 h. [S1, S2]
Vômitos na gastroenterite aguda - facilitar reidratação ≥6 meses	VO dose única: 8-15 kg 2 mg; >15-30 kg 4 mg; >30 kg 8 mg. Alternativa EV 0,15 mg/kg uma vez, máximo 8 mg, em ambiente monitorado. Iniciar reidratação após controle do vômito. [S1, S2] Evitar uso rotineiro se diarreia predominante; não mascarar obstrução.
Náuseas/vômitos por radioterapia Pediatria DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	A fonte pediátrica não estabelece regime específico de radioterapia; individualizar por área irradiada e emetogenicidade com oncologia. Não transpor automaticamente sequência de quimioterapia. [S3] A bula HPRA explicita ausência de dados de ensaios controlados pediátricos para radioterapia; decisão por oncologia, sem copiar dose adulta.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco QT/torsades: corrigir K⁺/Mg 2+, avaliar ECG/interações e evitar QT longo congênito. Hepatopatia grave: teto 8 mg/DIA na bula adulta, aplicar cautela pediátrica. Não administrar 32 mg EV em dose única.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, radioterapia e no pós-operatório; vômitos na gastroenterite aguda (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] AEP/Pediamécum - ondansetron (aeped.es)

[S2] IWK - ondansetron (dir.iwk.nshealth.ca)

[S3] HPRA - ondansetrona, SmPC 2022 (assets.hpra.ie)

333. Oseltamivir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento de influenza A e B Crianças ≥1 ano	VO a cada 12 h por 5 dias: ≤15 kg, 30 mg/dose; >15-23 kg, 45 mg/dose; >23-40 kg, 60 mg/dose; >40 kg, 75 mg/dose. [S1] Iniciar precocemente; doença grave ou imunossupressão pode exigir extensão individualizada.
Tratamento de influenza A e B Lactentes e recém-nascidos	0-8 meses: 3 mg/kg/dose VO 12/12 h; 9-11 meses: 3,5 mg/kg/dose 12/12 h, por 5 dias. Prematuros: idade pós-menstrual <38 semanas, 1 mg/kg/dose; 38-40 semanas, 1,5 mg/kg/dose; >40 semanas, 3 mg/kg/dose; todos 12/12 h por 5 dias. [S1, S2] Uso <1 ano off-label na referência brasileira original; não aplicar dose do lactente a prematuro.
Quimioprofilaxia de influenza A e B Contatos pediátricos elegíveis	≥1 ano: mesma dose unitária das faixas de peso do tratamento, VO uma vez/dia por 10 dias (MS). 3-11 meses: 3 mg/kg VO uma vez/dia. <3 meses: reservar situação crítica; profilaxia em prematuro exige especialista, pois não se deve copiar a tabela de tratamento. [S1, S2] CDC usa 7 dias após última exposição. A dose de 3,5 mg/kg do lactente 9-11 meses pertence ao tratamento AAP, não é automaticamente dose profilática.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar na disfunção renal; os esquemas fixos adultos de depuração não podem ser transpostos automaticamente ao neonato. Vigiar vômitos e reações cutâneas graves.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento e quimioprofilaxia da infecção por vírus da influenza A e B (bula aprovada a partir de 1 ano; uso neonatal off-label respaldado pelo Ministério da Saúde).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - Guia de influenza 2023 (gov.br)

[S2] CDC - Antivirais para influenza (cdc.gov)

334. Oxacilina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por MSSA: celulite complicada e sepse Crianças <40 kg	Oxacilina 100-200 mg/kg/dia EV, divididos 6/6 h; máximo 12 g/dia na tabela pediátrica PIDS/IDSA. Na sepse por MSSA, usar extremidade superior se indicada. Bula brasileira: infecção estafilocócica grave ≥14 dias; duração efetiva guiada por foco, hemoculturas e resposta. [S1, S6] Faixa de dose sistêmica pediátrica combinada à indicação de infecção grave da bula. Celulite sem bacteremia ou foco profundo não exige automaticamente duração de sepse.
Endocardite por MSSA Crianças	200 mg/kg/dia EV, divididos 4/4-6/6 h; máximo 12 g/dia. Válvula nativa: 4-6 semanas; material protético: ≥6 semanas, com esquema combinado especializado. [S2] Não somar automaticamente gentamicina em toda endocardite nativa.
Osteomielite por MSSA Crianças, excluindo ajuste neonatal individual	Oxacilina 150-200 mg/kg/dia EV, divididos 6/6 h, máximo 2 g/dose. Osteomielite hematogênica não complicada com boa resposta: total 3-4 semanas, incluindo etapa oral; complicada necessita curso maior. [S4, S3] Consenso especializado define faixa superior que a bula genérica não delimitava.
Artrite séptica por MSSA Crianças	Oxacilina 100-200 mg/kg/dia EV, divididos 6/6 h, máximo 12 g/dia. Artrite primária sem osteomielite, resposta rápida/PCR em queda: 10-14 dias totais; resposta lenta ou controle inadequado: 21-28 dias. Com osteomielite, usar duração óssea. [S6] Diretriz específica de artrite fornece faixa e teto antes ausentes; drenagem conforme avaliação ortopédica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hemograma, transaminases, função renal e carga de sódio. Não aplicar esquema de criança maior ao neonato sem ajustar maturidade e função orgânica. MSSA deve ser confirmado; não cobre MRSA.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento de infecções graves por *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina (celulite, osteomielite, artrite séptica, endocardite, sepse).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Blau - Oxacilina sódica, bula profissional hospedada (cr-net-public-prod.s3.amazonaws.com)

[S2] AHA - Infective Endocarditis in Childhood (heartuniversity.org)

[S3] PIDS/IDSA - Osteomielite hematogênica pediátrica (idsociety.org)

[S4] Consenso italiano de osteomielite pediátrica, 2021 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S5] PIDS/IDSA - Artrite bacteriana pediátrica, 2023 (idsociety.org)

[S6] PIDS/IDSA - Artrite bacteriana, texto integral e tabela de doses (doi.org)

335. Oxcarbazepina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises epilépticas focais, com ou sem generalização secundária ≥1 mês; monoterapia ou adjuvante	VO: iniciar 8-10 mg/kg/dia divididos em 2 tomadas. Aumentar até 10 mg/kg/dia a intervalos aproximadamente semanais. Alvo adjuvante 30-46 mg/kg/dia; máximo 60 mg/kg/dia. Respeitar simultaneamente teto da apresentação: suspensão oral 1.200 mg/dia; comprimidos 2.400 mg/dia. Tratamento contínuo, reavaliando crises e tolerabilidade. [S1] Dose da bula brasileira de 2026; retirada gradual. Não converter mg/kg/dia em mg/kg/dose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sódio e reação cutânea; ClCr <30 mL/min: iniciar metade da dose e titular lentamente. Atenção interações com anticoncepcionais e antiepiléticos indutores.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento de crises epilépticas focais com ou sem generalização secundária (aprovado a partir de 1 mês de idade).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Novartis - Trileptal, bula profissional 2026 (pro.novartis.com)

336. Oxiconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatomicoses superficiais: tínea corporis e cruris	Creme 1%: camada fina na lesão e margem, uma ou duas vezes ao dia por 2 semanas. [S1]
Crianças; uso cutâneo	
Tínea pedis	Creme 1% uma ou duas vezes ao dia por 4 semanas. [S1]
Crianças	
Pitiríase versicolor	Creme 1% uma vez ao dia por 2 semanas. [S1]
Crianças	Persistência de discromia isolada não significa fungo viável.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso externo; evitar olhos, mucosas e ingestão. Suspender se irritação importante; reavaliar diagnóstico se ausência de melhora. Fonte internacional não estabelece registro brasileiro.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 43)

Tratamento tópico de dermatomicoses superficiais, tíneas e pitiríase versicolor.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Oxiconazole nitrate cream 1% (dailymed.nlm.nih.gov)

337. Oxigênio Medicinal

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipoxemia/hipóxia aguda; prevenção em anestesia e terapia intensiva Crianças sem cardiopatia cianótica ou alvo específico	Titular FiO ₂ /fluxo à SpO ₂ alvo 94-98%, salvo meta específica. Cânula SEM umidificação: até 1 L/min em neonatos, 2 L/min em <2 anos e 4 L/min nos maiores. Fluxos superiores exigem umidificação/dispositivo adequado. Máscara simples: mínimo 4 L/min para evitar reinalação de CO ₂ . [S1] Não existe dose em mg/kg nem duração fixa. Reduzir progressivamente e suspender quando sustentar alvo em ar ambiente. Hipóxia anêmica ou circulatória exige correção causal.
Hipoxemia em cenários com metas próprias Neonatos, cardiopatia cianótica e doença pulmonar crônica RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Neonatos: alvo usual 91-95%; bronquiolite: ≥90%. Cardiopatia cianótica: alvo individual próximo da saturação basal e fisiologia, sem impor 94-98%. Reduzir/suspender oxigênio quando mantiver alvo em ar ambiente e condição clínica estável. [S1] Fonte aberta reconhece metas específicas; alvo depende do diagnóstico e fase assistencial.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Oximetria contínua em instáveis; gasometria se retenção de CO₂, choque ou discordância. Evitar hiperóxia, lesão de pele e risco de combustão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)

Tratamento e prevenção da hipoxemia e hipóxia em quadros agudos, suporte anestésico e em terapia intensiva.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Royal Children's Hospital - Oxygen delivery (rch.org.au)

338. Oxitocina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução do trabalho de parto Adolescentes gestantes; contexto obstétrico	EV em bomba: 5 UI em volume final de 500 mL de solução eletrolítica (10 mUI/mL). Iniciar 1-4 mUI/min; aumentar 1-2 mUI/min a intervalos ≥ 20 min. Máximo recomendado perto do termo 20 mUI/min. Nessa concentração, mL/h = mUI/min $\times$ 6; início 6-24 mL/h, teto 120 mL/h. [S1] Suspender se hiperestimulação ou sofrimento fetal. Não administrar bolus para indução.
Prevenção da hemorragia pós-parto por atonia Adolescentes puérperas	5 UI EV diluídas em infusão de 5 min OU 5-10 UI IM após o parto. [S1] Esquema obstétrico, não destinado ao recém-nascido.
Tratamento da hemorragia pós-parto por atonia Adolescentes puérperas	5 UI EV diluídas em 5 min OU 5-10 UI IM; em hemorragia grave, continuar 5-20 UI em 500 mL de solução com eletrólitos, titulando à contratilidade e sangramento. [S1] A fonte não fixa velocidade universal para a infusão de resgate.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, frequência fetal e contrações; risco de ruptura uterina e hiponatremia com excesso de líquido hipotônico. 1 UI = 1.000 mUI. Não há dose pediátrica ponderal para indicações obstétricas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)

Prevenção e tratamento de hemorragia pós-parto por atonia uterina; indução do trabalho de parto (uso obstétrico adulto e adolescente).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Medsafe - Oxytocin, ficha técnica (medsafe.govt.nz)

339. Palivizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia de infecção grave por VSR em prematuros elegíveis, DBP e cardiopatia	15 mg/kg/dose IM a cada 30 dias durante sazonalidade, máximo 5 doses por estação; número efetivo 1-5 conforme início. Solução 100 mg/mL: volume = 0,15 mL/kg. Volumes >1 mL devem ser divididos entre locais. [S1]
Crianças dentro dos critérios de elegibilidade	Não trata bronquiolite instalada. Elegibilidade e transição para nirsevimabe em 2026 devem ser verificadas no programa regional; não repetir cinco doses fora da estação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Disponibilizar tratamento de anafilaxia; adiar em doença aguda moderada/grave quando adequado. Aplicar na face anterolateral da coxa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)
Profilaxia de infecções graves do trato respiratório inferior por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em prematuros elegíveis, DBP e cardiopatias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Ministério da Saúde - Protocolo de palivizumabe (antigo-conitec.saude.gov.br)

340. Pantoprazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
DRGE com esofagite erosiva	VO uma vez ao dia: 15-<40 kg, 20 mg; ≥40 kg, 40 mg. Curso de até 8 semanas. [S1]
≥5 anos e ≥15 kg	Não estabelecer uso prolongado ou em regurgitação fisiológica com esta recomendação.
Supressão ácida quando VO inviável	1-2 mg/kg/dose EV 12/12-24/24 h; máximo 40 mg/dose e 80 mg/dia. Manter enquanto indicada supressão e converter à VO assim que viável. [S2]
≥4 semanas	Uso pediátrico hospitalar off-label; não aplicar automaticamente esta faixa como profilaxia de úlcera de estresse.
Hemorragia digestiva alta	5-40 kg: ataque 2 mg/kg EV, seguido de 0,2 mg/kg/h por até 72 h. >40 kg: 80 mg EV, depois 8 mg/h por até 72 h. Teto da infusão 8 mg/h. mL/h = mg/kg/h × peso ÷ concentração final (mg/mL). [S3]
5-40 kg; >40 kg	Off-label; não extrapolar esse regime para <5 kg. Hemostasia endoscópica e ressuscitação não devem aguardar efeito do IBP.
Profilaxia de úlcera de estresse	Pantoprazol 1 mg/kg EV uma vez/dia, máximo 40 mg/dia. Suspender quando cessar risco. [S4]
Crianças em UTI com fatores de risco; off-label	Não indicar automaticamente para toda internação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar magnésio em uso prolongado; atenção interações com fármacos dependentes de acidez e metotrexato em alta dose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)
DRGE, esofagite erosiva (oral a partir de 5 anos); profilaxia de úlcera de estresse e hemorragia digestiva alta (IV adulto e pediátrico off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Pantoprazole delayed release (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] Perth Children’s Hospital - Pantoprazole (pch.health.wa.gov.au)
[S3] IWK Health - Pantoprazole pediatric dosing (dir.iwk.nshealth.ca)
[S4] Alberta Children’s Hospital - Profilaxia de úlcera de estresse,2024 (achpccg.com)

341. Paracetamol (Acetaminofeno)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Febre e dor leve a moderada; analgesia multimodal >1 mês a 18 anos	VO 15 mg/kg/dose (máx. 1.000 mg) 4/4-6/6 h se necessário; teto habitual 60 mg/kg/dia, máximo absoluto 4.000 mg/dia. Retal: 15-20 mg/kg/dose 6/6 h, respeitando o mesmo teto diário. EV: 15 mg/kg/dose (máx. 1.000 mg) 6/6 h; infundir em 15 min; teto 60 mg/kg/dia ou 4.000 mg/dia. [S1] A dose de 20 mg/kg retal não pode ser repetida quatro vezes se ultrapassar 60 mg/kg/dia.
Dor intensa em ambiente hospitalar - alternativa de curto prazo >1 mês	VO/retal: limite de até 90 mg/kg/dia (máx. 4.000 mg/dia) por no máximo 48 h, depois ≤60 mg/kg/dia. Ataque opcional perioperatório: até 30 mg/kg VO ou 40 mg/kg retal, máximo 1.000 mg, incluído no total diário. [S1] Não aplicar teto de 90 mg/kg/dia à via EV, uso domiciliar ou paciente com risco hepático.
Febre/dor neonatal Nascimento-<1 mês	VO 15 mg/kg/dose 6/6 h, teto 60 mg/kg/dia; EV 10 mg/kg/dose 6/6 h, teto 40 mg/kg/dia. [S2] Esquema institucional pediátrico; em prematuros, estabelecer idade gestacional e maturidade antes da prescrição.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Somar todas as apresentações e associações; reduzir exposição em hepatopatia, desnutrição e doença renal grave. Reavaliar diariamente a necessidade; tratar desconforto, não um número isolado de temperatura.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)

Alívio de febre e dor leve a moderada de diversas etiologias; suporte analgésico multimodal.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - Paracetamol (pch.health.wa.gov.au)

[S2] Royal Children's Hospital - Acute pain management (rch.org.au)

342. Penicilamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Wilson Crianças	20 mg/kg/dia VO, divididos em 2-4 tomadas, 1 h antes ou 2 h após refeições. Aumentar gradualmente sob controle clínico/bioquímico; tratamento contínuo. [S1] A fonte nacional usa arredondamento à cápsula de 250 mg; em criança pequena, avaliar formulação apropriada antes de arredondar. Dose de manutenção titulada à excreção de cobre, não à resposta clínica isolada.
Cistinúria grave com cálculos recorrentes Crianças	30 mg/kg/dia VO, divididos em quatro doses; iniciar baixo e aumentar gradualmente. Manter a dose noturna ao reduzir o esquema. Tratamento contínuo, ajustado à cistinúria e recorrência. [S2] Associar hidratação e alcalinização orientadas pela nefrologia. Fonte não define teto pediátrico absoluto distinto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, plaquetas, creatinina e urinálise seriados: risco de mielotoxicidade, proteinúria e síndrome nefrótica. Separar ferro, antiácidos e outros minerais. Não interromper abruptamente tratamento de Wilson sem substituição eficaz.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)
Tratamento da doença de Wilson e cistinúria grave com formação recorrente de cálculos renais.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] CONITEC - PCDT Doença de Wilson, documento 2023 (gov.br)
[S2] DailyMed - Penicillamine (dailymed.nlm.nih.gov)

343. Permetrina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Escabiose ≥2 meses	Permetrina 5%: cobrir pele corporal, pregas, espaços interdigitais e sob unhas; no lactente incluir couro cabeludo, nuca e têmporas, poupando olhos/boca. Remover após 8-14 h. Bula: uma aplicação; repetir se ácaros viáveis após 14 dias. [S1] Menores de 2 anos requerem prescrição médica. Tratar contatos simultaneamente; prurido residual pode durar 4 semanas.
Pediculose do couro cabeludo ≥2 anos na bula brasileira Prati-Donaduzzi consultada	Permetrina 1%: aplicar em cabelo lavado, úmido, saturar couro cabeludo/cabelo, aguardar 10 min, pentear e enxaguar. Repetir no 7º dia se persistirem piolhos/lêndeas. [S2] Restrição desta formulação: abaixo de 2 anos não aplicar; apresentação e excipientes importam.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não ingerir; evitar contato ocular. Não trocar concentração 1% por 5%. Conferir produto em menores de 2 anos; a aprovação de uma formulação não se estende às demais.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)

Tratamento tópico da escabiose (loção 5%) e pediculose do couro cabeludo (loção/emulsão capilar 1%).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Nativita - Permenati 5%, bula (nativita.ind.br)

[S2] Prati-Donaduzzi - Permetrina 10 mg/g, bula profissional (bulas.pratidonaduzzi.com.br)

344. Petidina (Meperidina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor aguda moderada a intensa	0,5-2 mg/kg/dose IM, intervalo mínimo de 4 h se necessário. Usar menor dose eficaz pelo menor tempo possível. [S1]
Crianças; uso excepcional hospitalar RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Fonte regulatória internacional; não apresenta teto pediátrico absoluto. Não extrapolar a mesma faixa à injeção EV rápida. Preferir opioide com perfil pediátrico melhor quando disponível.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sedação, FR, SpO₂, PA; normeperidina pode causar convulsões. Contraindicada em insuficiência renal/hepática grave, depressão respiratória e uso de IMAO nas últimas 2 semanas; cautela com serotoninérgicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)
Analgesia opioide para dor aguda moderada a intensa (uso adulto predominante na bula; uso pediátrico excepcional e restrito).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] ADVANZ / eMC - Pethidine Injection, atualização setembro/2026 (medicines.org.uk)

345. Picossulfato de Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Constipação intestinal funcional - curto prazo	VO à noite: <4 anos, 0,25 mg/kg/dia; 4-10 anos, 2,5-5 mg/dia; >10 anos, 5-10 mg/dia. Iniciar menor dose. Usar até restabelecer evacuação, sem uso diário prolongado sem investigar causa. [S1]
Crianças	Dose em mg de picossulfato de sódio da bula; não confundir sal monoidratado e base.
Esvaziamento intestinal para exames	Associação picossulfato 10 mg + óxido de magnésio + ácido cítrico por sachê: 1-<2 anos, ¼ sachê em cada uma das 2 doses; 2-<4 anos, ½ + ½; 4-<9 anos, 1 + ½; ≥9 anos, 1 + 1. Primeira dose 10-18 h e segunda 4-6 h antes do exame. [S2]
≥1 ano; apenas associação para preparo intestinal RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não substituir por igual fração de gotas de picossulfato isolado; formulações não equivalentes. Hidratação obrigatória ajustada ao tamanho, jejum e exame.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar na obstrução, abdome agudo e desidratação grave. Monitorar eletrólitos em preparo intestinal e doença renal; a associação com magnésio exige cautela renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 44)

Tratamento de curto prazo da constipação intestinal funcional e esvaziamento intestinal para exames.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Boehringer - Guttalax, bula profissional hospedada (saudedireta.com.br)

[S2] Ferring / eMC - Picolax, SmPC (medicines.org.uk)

346. Pilocarpina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Redução da pressão intraocular no glaucoma <2 anos; oftalmologia pediátrica	Pilocarpina colírio 1%:1 gota no (s) olho (s) afetado (s),3 vezes/dia. Titular pela pressão intraocular e resposta; tratamento contínuo enquanto indicado. [S1]
Redução da pressão intraocular no glaucoma ≥2 anos	1 gota de pilocarpina 1%,2% ou 4% no olho afetado, até 4 vezes/dia; iniciar 1% no paciente sem exposição anterior e ajustar pela resposta. [S1] Bula FDA distingue idade; a seleção de concentração depende do tipo de glaucoma. Não usar como prescrição empírica sem avaliação oftalmológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Oclusão nasolacrimal por 2 min reduz absorção sistêmica. Glaucoma congênito primário pode ter elevação paradoxal da pressão; não recomendado em glaucoma por uveíte anterior. Vigiar miopia transitória, broncoespasmo e efeitos colinérgicos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Redução da pressão intraocular no glaucoma (uso oftálmico adulto e pediátrico restrito).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Pilocarpine hydrochloride ophthalmic solution (dailymed.nlm.nih.gov)

347. Pimecrolimo

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatite atópica leve a moderada, inclusive face/pescoço	Pimecrolimo 1%: camada fina nas áreas afetadas duas vezes ao dia até desaparecerem sinais/sintomas. Interromper quando controlado; reiniciar no começo de recorrência. Se persistência após 6 semanas ou piora, suspender e reavaliar. [S1]
≥3 meses	Uso intermitente; não recomendar aplicação contínua indefinida. Não exige cálculo por peso.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar mucosas, oclusão e aplicação sobre infecção ativa. Fotoproteção; considerar absorção maior em defeito de barreira extenso. Fonte internacional, sem inferência automática de registro brasileiro.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)
Tratamento tópico anti-inflamatório da dermatite atópica leve a moderada em face e pescoço (a partir de 3 meses).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Medsafe - Elidel, ficha regulatória (medsafe.govt.nz)

348. Piperacilina + Tazobactam

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Neutropenia febril ≥2 anos, <50 kg, função renal normal	80 mg/kg/dose de piperacilina + 10 mg/kg/dose de tazobactam EV 6/6 h; teto 4 g + 0,5 g/dose. [S1] Bula combina com aminoglicosídeo; decisão atual de associação depende de instabilidade e microbiologia. Duração guiada por foco, culturas e recuperação clínica/hematológica.
Infecção intra-abdominal grave 2-12 anos, ≤40 kg	100 mg/kg/dose de piperacilina + 12,5 mg/kg/dose de tazobactam EV 8/8 h; teto 4 g + 0,5 g/dose. Bula: 5-14 dias e ≥48 h após resolução clínica. [S1] Reavaliar duração após controle efetivo de foco.
Infecção pulmonar grave e outras infecções graves suscetíveis ≥4 semanas; uso pediátrico hospitalar off-label fora da bula	100 mg/kg/dose de piperacilina EV 6/6 h, máximo 4 g/dose (=4,5 g da associação). Infundir em 30 min; alternativa farmacodinâmica: cada dose em 3-4 h. Reavaliar em 48-72 h e descalonar por cultura. [S2] Duração não é intercambiável entre pneumonia simples, abscesso e empiema; depende de foco definido.
Infecções suscetíveis - alternativas intermitente e contínua ≥4 semanas; especialista e programa hospitalar	Piperacilina 100 mg/kg/dose EV 8/8 h (máx. 4 g/dose) usual; grave 6/6 h. Alternativa BIC: 300 mg/kg/dia (máx. 12 g/dia), ou 400 mg/kg/dia (máx. 16 g/dia) na grave, em 24 h. Duração conforme foco, resposta e culturas. [S2] BIC requer estabilidade/concentração e dispositivo validados; não somar a doses intermitentes. Todas as doses expressam piperacilina.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar função renal; vigiar creatinina, hemograma e potássio. Administrar aminoglicosídeo separadamente salvo compatibilidade específica demonstrada. Não calcular por 112,5 mg/kg como se fossem 112,5 mg de piperacilina.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Tratamento da neutropenia febril, infecções intra-abdominais e pulmonares graves (aprovado a partir de 2 anos na bula pediátrica).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Pfizer - Tazocin, bula profissional (pfizer.com.br)

[S2] Perth Children's Hospital - Piperacillin/tazobactam (pch.health.wa.gov.au)

349. Pirazinamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tuberculose ativa pulmonar e extrapulmonar - fase intensiva Crianças <10 anos, sobretudo <25 kg	35 mg/kg/dia VO (faixa 30-40 mg/kg/dia), uma vez ao dia, em associação. Em esquema básico nacional, usar por 2 meses e retirar na manutenção. Não usar isoladamente. [S1] TB meningoencefálica/osteoarticular prolonga fase de manutenção de outros fármacos; não implica prolongar automaticamente pirazinamida.
Tuberculose ativa - dose por faixa de peso ≥25 kg; crianças/adolescentes em esquema apropriado	25-35 kg: 900-1.000 mg/dia; 36-45 kg: 1.500 mg/dia; >45 kg: 2.000 mg/dia VO, uma vez ao dia, fase intensiva de 2 meses. [S1] A idade ≥10 anos utiliza combinação adulta padronizada; registrar também doses dos outros componentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hepatotoxicidade e hiperuricemia sintomática; ajustar esquema em insuficiência renal importante. Confirmar sensibilidade e adesão; não tratar TB latente com este esquema.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Tratamento da tuberculose ativa pulmonar e extrapulmonar (fase intensiva do esquema combinado).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - Tratamento da tuberculose em crianças (gov.br)

350. Piridostigmina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Miastenia gravis juvenil Crianças	VO iniciar 0,5-1 mg/kg/dose, 3-4 vezes/dia; titular até 1,5 mg/kg/dose, 5 vezes/dia, máximo 450 mg/dia na recomendação especializada consultada. Administrar 30-60 min antes de atividades/refeições que exigem força. Uso contínuo com revisão frequente. [S1] Doses e horários individualizados pela flutuação. Falha em aproximadamente 1 mg/kg 4 vezes/dia deve motivar revisão da imunoterapia, não escalada indefinida.
Síndromes miastênicas congênitas Subtipos responsivos à inibição de acetilcolinesterase RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Subtipo CHAT: relato neonatal utilizou piridostigmina 1 mg/kg/dose VO 6/6 h; ocorreu toxicidade colinérgica e a dose precisou ser reduzida. Não existe regime uniforme para todas as síndromes; selecionar e titular por subtipo e resposta. [S2, S4] Evidência de relato não define dose segura universal. COLQ, DOK 7 e canal lento podem não responder ou piorar; neurologia/genética deve orientar escolha.
Miastenia gravis - alternativa BNFC Neonato-11 anos; 12-17 anos	Neonato-11 anos: 0,5-1 mg/kg/dose VO 4/4-6/6 h; titular a cada 3-4 dias até 1,2 mg/kg 4/4 h; em 1 mês-11 anos, máximo usual 60 mg 4/4 h. 12-17 anos: 30-90 mg 4/4-6/6 h; se >360 mg/dia, reavaliar imunossupressão; >450 mg/dia pode reduzir receptores. [S3] Não somar com regime anterior. Tratamento contínuo; ajustar rim e sinais colinérgicos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar deglutição, função respiratória, secreções, FC e diarreia. Diferenciar crise miastênica de crise colinérgica. Necessidade menor em disfunção renal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Tratamento sintomático da miastenia gravis e síndromes miastênicas congênitas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Management of Juvenile Myasthenia Gravis - recomendação especializada (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S2] GeneReviews - Congenital Myasthenic Syndromes (ncbi.nlm.nih.gov)

[S3] BNFC/NICE - Pyridostigmine bromide (bnfc.nice.org.uk)

[S4] Relato hospitalar - Síndrome miastênica congênita por CHAT (doi.org)

351. Piridoxina (Vitamina B6)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção de deficiência/neuropatia por isoniazida	VO uma vez ao dia: <5 kg, 5 mg; ≥5 kg, 10 mg. Manter durante isoniazida. Alternativa CHEO para deficiência induzida por drogas: 1-2 mg/kg/dia VO. [S1, S3]
Crianças em risco	Não somar alternativas.
Neuropatia por isoniazida	50 mg VO uma vez ao dia até resposta, em geral até 3 semanas; depois dose preventiva enquanto persistir isoniazida. [S1]
Crianças	
Convulsões dependentes de piridoxina - diagnóstico/tratamento	Ataque 100 mg EV, não mg/kg, lentamente em 5 min. Se <2 kg: 30 mg/kg EV; após 10 min sem resposta, completar até 100 mg totais. Manutenção 15-30 mg/kg/dia VO/EV, máximo 200 mg/dia. [S2]
Neonatos	EEG e suporte ventilatório disponíveis: pode causar apneia/colapso. Ajustar manutenção sob neurologia; tratamento contínuo se dependência confirmada.
Deficiência de vitamina B6 de outras causas	1 mês-12 anos: 5-25 mg VO/EV/IM uma vez/dia por 3 semanas; manutenção 2,5-5 mg VO/dia. >12 anos: 10-20 mg uma vez/dia por 3 semanas; manutenção 2-5 mg VO/dia. Manter reposição enquanto causa/risco persistirem. [S4]
1 mês-12 anos; >12 anos	Doses farmacológicas para epilepsia não substituem estas doses de reposição.
Alternativas de profilaxia da neuropatia por isoniazida e epilepsia dependente	Profilaxia: 1 mg/kg VO/dia (máx. 25 mg) em 1 mês-12 anos; >12 anos 25-50 mg/dia. Epilepsia dependente: teste 50-100 mg EV/IM uma vez; manutenção 50-100 mg VO/dia, máx. 200 mg/dia. [S4]
1 mês-12 anos; >12 anos	Teste com EEG e suporte ventilatório; neurologia define duração contínua se dependência confirmada. Não somar alternativas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose elevada crônica também causa neuropatia. Monitorar reflexos, sensibilidade e desenvolvimento; início parenteral com ECG/respiração contínuos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina B6; neuropatia por isoniazida e convulsões dependentes de piridoxina.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MSF - Pyridoxine oral (medicalguidelines.msf.org)

[S2] ANMF - Pyridoxine neonatal (anmfonline.org)

[S3] CHEO - Pyridoxine (outreach.cheo.on.ca)

[S4] IWK - Pyridoxine, doses pediátricas (dir.iwk.nshealth.ca)

352. Pirimetamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Toxoplasmose congênita Lactentes diagnosticados no primeiro ano	Pirimetamina 1 mg/kg VO uma vez ao dia por 6 meses; depois a mesma dose 3 vezes/semana até completar 12 meses. Alternativa para doença menos extensa: passar a 3 vezes/semana após 2 meses. Sempre associar sulfadiazina 50 mg/kg/dose VO 12/12 h e ácido fólico. [S1] Esquema SES-RS: ácido fólico 15 mg VO 3 vezes/semana, ajustável à mielotoxicidade.
Toxoplasmose congênita - alternativa com ataque Lactentes	Pirimetamina 1 mg/kg/dose VO 12/12 h por 2 dias; depois 1 mg/kg/dia por 2-6 meses; depois 1 mg/kg 3 vezes/semana, total 12 meses. Associar sulfadiazina e ácido fólico. [S2] Alternativa NIH; não somar com esquema sem ataque.
Toxoplasmose adquirida com acometimento ocular, SNC ou sistêmico Crianças, especialmente com HIV	Ataque 1 mg/kg/dose VO 12/12 h por 3 dias (máx. 50 mg/dose); depois 1 mg/kg/dia (máx. 25 mg/dia). Associar sulfadiazina e ácido fólico; indução ≥6 semanas, seguida de manutenção se imunossupressão persistente. [S2] Linfadenopatia isolada em imunocompetente não recebe automaticamente este esquema.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma/plaquetas seriados. Ácido fólico obrigatório e mantido por 1 semana após pirimetamina; ácido fólico não o substitui.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Tratamento da toxoplasmose congênita e adquirida em associação com sulfonamida e ácido fólico.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SES-RS - Toxoplasmose congênita (saude.rs.gov.br)

[S2] NIH - Toxoplasmosis, Pediatric OIs (clinicalinfo.hiv.gov)

353. Pirvínio (Pamoato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Oxiuríase/enterobíase	Pamoato de pirvínio 10 mg/kg VO em dose única, máximo 600 mg. Repetir a mesma dose após 2 semanas. Suspensão 10 mg/mL: 1 mL/kg, máximo 60 mL. [S1]
Crianças; suspensão oral	Dose expressa como pamoato, conforme bula brasileira; não confundir com dose de pirvínio base de outras referências. Drágea 100 mg: somente ≥12 anos na fonte.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Pode tingir fezes de vermelho. Higiene de mãos/unhas e manejo dos contatos reduzem reinfestação. Não requer laxante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)
Tratamento de oxiuríase (*Enterobius vermicularis*) em dose única.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] UCI-Farma - Pyr-Pam, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

354. Plasma Fresco Congelado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiências múltiplas de fatores com sangramento; sangramento ativo com coagulopatia Crianças e neonatos	Plasma fresco congelado 10-20 mL/kg EV por transfusão; velocidade usual 10-20 mL/kg/h. Reavaliar sangramento e coagulação antes de nova dose. [S1] Não usar somente para corrigir INR discretamente alterado em criança sem sangramento.
Reversão de cumarínicos em hemorragia grave Crianças	10-20 mL/kg EV quando plasma indicado, associado à vitamina K; concentrado de complexo protrombínico oferece reposição rápida quando apropriado. [S1] Não usar PFC como expansão volêmica de rotina; em hemorragia maciça, seguir ressuscitação hemostática com reavaliações seriadas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Confirmar compatibilidade ABO; monitorar reação transfusional, sobrecarga circulatória e hipocalcemia em grandes volumes. Usar equipo apropriado; não adicionar medicamentos à bolsa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)

Reposição de deficiências múltiplas de fatores da coagulação, sangramentos ativos e reversão de cumarínicos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Royal Children's Hospital - Blood product prescription (rch.org.au)

355. Poliestirenosulfonato de Cálcio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipercalcemia em DRC ou lesão renal aguda Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 1 g/kg/dia de resina em doses divididas; manutenção 0,5 g/kg/dia em doses divididas, titulada ao K. Suspender se K <5 mmol/L na bula. Se VO impossível, via retal com dose pelo menos equivalente e diluição 1 g: 5 mL, seguida de irrigação para remoção. [S1] Bula não define um intervalo pediátrico único; estabelecer fracionamento sob nefrologia. Não é resgate isolado de hipercalcemia com alterações no ECG.
Hipercalcemia neonatal Neonatos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não administrar VO. Via retal excepcional: menor dose eficaz entre 0,5 e 1 g/kg, diluída 1 g: 5 mL, com remoção adequada. [S1] Prematuros/baixo peso têm risco de hemorragia/necrose intestinal; avaliar alternativa antes de uso.
Hipercalcemia aguda - alternativa hospitalar Crianças, excluindo restrições neonatais RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	RCH: 0,5-1 g/kg/dose VO ou retal 6/6 h, máximo 30 g/dose; repetir somente conforme K e trânsito intestinal. [S2] Dose aguda difere substancialmente da manutenção da bula: não combinar esquemas. Efeito é lento e modesto; evitar íleo, cirurgia abdominal recente ou perfuração. Via oral não permitida no neonato.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar K, Ca, Mg e trânsito intestinal. Não combinar com sorbitol; evitar obstrução/íleo e separar outras medicações VO por ≥3 h (6 h se gastroparesia).

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 45)
Tratamento e controle da hipercalcemia em pacientes com doença renal crônica ou lesão renal aguda.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Medsafe - Calcium Resonium (medsafe.govt.nz)

[S2] RCH - Hyperkalaemia,2024 (rch.org.au)

356. Polimixina B

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções sistêmicas graves por Gram-negativos multirresistentes suscetíveis	15.000-25.000 UI/kg/dia EV, divididos 12/12 h; máximo 25.000 UI/kg/dia na bula. Lactentes: bula permite até 40.000 UI/kg/dia, sob especialista. Duração conforme foco, culturas e controle da infecção; reavaliar diariamente. [S1]
Crianças com função renal normal	1 mg de polimixina B base = 10.000 UI; não confundir massa do sulfato ou colistimetato. Doses acima do esquema habitual exigem justificativa específica. Bula antiga não resolve toda farmacocinética pediátrica moderna.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar creatinina/diurese, parestesias e bloqueio neuromuscular. Bula reduz dose em disfunção renal; protocolos farmacocinéticos modernos podem divergir: requer decisão infectológica, sem transposição automática de adulto. Evitar nefrotóxicos simultâneos quando possível.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)
Tratamento de infecções sistêmicas graves causadas por bacilos Gram-negativos multirresistentes.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Polymyxin B for injection (dailymed.nlm.nih.gov)

357. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona + Lidocaína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Otite externa bacteriana e inflamação associada, tímpano íntegro	Instilar 3-4 gotas no ouvido afetado, 2-4 vezes ao dia. Usar menor quantidade e menor período eficaz; reavaliar resposta em 48-72 h. [S1]
Crianças	Bula não especifica duração fixa em dias; não prescrever uso prolongado automático. Associação: fluocinolona 0,25 mg/mL + polimixina B 10.000 UI/mL + neomicina 3,5 mg/mL + lidocaína 20 mg/mL.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em perfuração timpânica e infecção viral/fúngica não tratada. Neomicina pode causar ototoxicidade e sensibilização; não usar em olhos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Tratamento de otite externa aguda bacteriana com membrana timpânica íntegra e processos inflamatórios associados.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Geolab - Otosylase, bula profissional (geolab.com.br)

358. Poractanto Alfa

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento da SDR/doença da membrana hialina Recém-nascidos prematuros	100-200 mg/kg intratraqueais em dose inicial; repetir 100 mg/kg a cada 12 h se SDR persistente. Máximo cumulativo 300-400 mg/kg, conforme dose inicial. Concentração 80 mg/mL: 1,25-2,5 mL/kg inicial e 1,25 mL/kg repetição. [S1] Não diluir. Administração por equipe neonatal com ventilação disponível.
Profilaxia da SDR Prematuros selecionados	100-200 mg/kg intratraqueais logo após nascimento, preferencialmente até 15 min. Se SDR persistir e dependência de VM: 100 mg/kg após 6-12 h e novamente 12 h depois; máximo total 300-400 mg/kg. [S1] Bula descreve profilaxia; elegibilidade contemporânea considera corticosteroide antenatal, CPAP e necessidade de intubação. Não intubar todo prematuro apenas para aplicar surfactante.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar bradicardia, dessaturação, obstrução do tubo e rápida melhora de complacência; reduzir prontamente FiO₂/pressões conforme resposta. Não administrar EV.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Tratamento e profilaxia da síndrome do desconforto respiratório (membrana hialina) em recém-nascidos prematuros.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Chiesi Brasil - Curosurf, bula profissional (chiesi.com.br)

359. Posaconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia de infecção fúngica invasiva Imunossuprimidos; comprimido de liberação modificada ≥2 anos	VO: 5-7 mg/kg/dose (máx. 300 mg) 12/12 h no dia 1; depois mesma dose uma vez/dia. Alternativa suspensão ≥6 meses: 4-6 mg/kg/dose (máx. 200 mg) 8/8 h. Manter durante período de risco. [S1]
Aspergilose/fusarios e invasiva refratária Uso especializado; comprimidos ≥2 anos	VO, dia 1 em duas doses, depois uma vez/dia: 10-<20 kg, 200 mg/dose e manutenção 200 mg/dia; 20-<30 kg, 300 mg/dose e manutenção 250 mg/dia; ≥30 kg, 300 mg/dose e manutenção 300 mg/dia. [S1] Duração guiada por doença, resposta radiológica/microbiológica e recuperação imune; não há curso fixo aplicável a todas micoses.
Tratamento - alternativa suspensão ou EV Suspensão ≥5 meses; EV ≥2 anos e ≥10 kg	Suspensão VO: <34 kg, 4,5-6 mg/kg/dose (máx. 200 mg) 6/6 h; ≥34 kg, 200 mg 6/6 h ou 400 mg 12/12 h com alimento gorduroso. EV: 6 mg/kg/dose (máx. 300 mg) 12/12 h dia 1, depois 24/24 h; diluir a 1-2 mg/mL e infundir em 90 min por acesso central. [S1] Doses off-label variam por formulação. Não substituir mg por mg entre suspensão e comprimido.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dosagem sérica obrigatória para ajustar exposição; revisar interações CYP 3A4, QT e hepatotoxicidade. Evitar apresentação EV se eGFR <50 mL/min/1,73 m² quando alternativa viável. Fusarium exige identificação/sensibilidade e avaliação especializada; susceptibilidade não é uniforme.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Profilaxia de infecções fúngicas invasivas em imunossuprimidos graves; tratamento de aspergilose e fusariose refratárias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - Posaconazole, 2026 (ahs.health.wa.gov.au)

360. Praziquantel

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Esquistossomose mansônica Crianças; ≥4 anos no documento original	Esquema brasileiro: 60 mg/kg VO, preferencialmente em dose única. Alternativa CDC para <i>S. mansoni</i> /haematobium/intercalatum: 40 mg/kg/dia VO em 2 doses, por 1 dia; japonicum/mekongi: 60 mg/kg/dia em 3 doses por 1 dia. [S1, S2] Não somar esquemas. Em <4 anos, avaliação individual e formulação adequada; programas OMS incluem crianças ≥2 anos.
Neurocisticercose Crianças; especialista	Regime convencional: 50 mg/kg/dia VO em 3 tomadas por 15 dias. Alternativa recomendada para >2 cistos parenquimatosos viáveis: praziquantel 50 mg/kg/dia em 3 tomadas + albendazol 15 mg/kg/dia em 2 tomadas (máximo 1.200 mg/dia de albendazol), por 10-14 dias. Corticosteroide antes do antiparasitário; manejo neurológico concomitante. [S3, S7] Não iniciar antiparasitário sem avaliar hipertensão intracraniana, localização ocular e necessidade de cirurgia; lesão calcificada isolada não se beneficia.
Cestodíases: teníase e himenolepíase Crianças	Teníase: 5-10 mg/kg VO dose única (10 mg/kg tem maior cura). Hymenolepis nana: 25 mg/kg VO dose única. [S4, S5] Teníase: exame de fezes após 1 e 3 meses; investigar sintomas de neurocisticercose antes de tratar.
Trematodíase: clonorchíase Crianças	25 mg/kg/dose VO 8/8 h por 2 dias (=75 mg/kg/dia). [S6] “Trematodíase” não define dose única para todas as espécies; praziquantel não é opção eficaz para Fasciola.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Interação importante com rifampicina e indutores enzimáticos; não tratar cisticercose ocular com esquema empírico. Dose total e duração dependem da espécie e localização.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Tratamento da esquistossomose, neurocisticercose e infestações por cestódeos e trematódeos (acima de 4 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - Esquistossomose: tratamento (gov.br)

[S2] CDC - Schistosomiasis treatment (cdc.gov)

[S3] CDC - Clinical care of cysticercosis (cdc.gov)

[S4] CDC - Clinical treatment of taeniasis (cdc.gov)

[S5] CDC - Hymenolepis clinical care (cdc.gov)

[S6] CDC - Clinical overview of Clonorchis (cdc.gov)

[S7] IDSA/ASTMH - Neurocisticercose, diretriz 2017 (idsociety.org)

361. Prednisolona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Exacerbação de asma 6-11 anos	Prednisolona VO 1-2 mg/kg/dia (máx. 40 mg/dia), tomada matinal única por 3-5 dias. [S1] Curso <2 semanas geralmente dispensa desmame; não usar este esquema para manutenção prolongada.
Síndrome nefrótica - episódio inicial Crianças	VO 2 mg/kg/dia ou 60 mg/m ² /dia (máx. 60 mg) por 4 semanas; depois 1,5 mg/kg/dose ou 40 mg/m ² /dose (máx. 40 mg) em dias alternados por 4 semanas. Alternativa: 6 semanas diárias + 6 semanas alternadas. [S2] Usar um método de cálculo; não somar mg/kg e mg/m ² .
Síndrome nefrótica - recidiva Crianças cortico-sensíveis	2 mg/kg/dia ou 60 mg/m ² /dia VO (máx. 60 mg) até remissão por ≥3 dias consecutivos; depois 1,5 mg/kg ou 40 mg/m ² (máx. 40 mg) em dias alternados por 4 semanas. [S2]
Crupe - alternativa Crianças com crupe leve/moderado	1 mg/kg VO em dose única na diretriz RCH. [S3] Dexametasona tem evidência mais consistente; crupe grave requer adrenalina nebulizada e suporte, não apenas prednisolona.
Doenças inflamatórias /autoimunes Crianças; diagnóstico definido RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Faixa inicial regulatória: 0,14-2 mg/kg/dia VO, divididos em 3-4 tomadas. Dose e duração dependem da doença/órgão e gravidade; titular à menor dose eficaz e planejar redução se prolongado. [S4] A indicação original é um grupo de doenças; esta faixa não substitui esquema específico de lúpus, vasculite ou doença intestinal.
Exacerbação asmática moderada/grave - crianças pequenas e adolescentes ≤5 anos; ≥12 anos	≤5 anos: 1-2 mg/kg/dia VO uma vez/dia, max 20 mg/dia se <2 anos ou 30 mg/dia se 2-5 anos, por 3-5 dias. Adolescentes: 40-50 mg VO uma vez/dia por 5-7 dias. [S5] Prednisona/prednisolona são alternativas equivalentes neste regime. Reavaliar antes de suspender; curso curto geralmente dispensa desmame.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Doses em prednisolona base. Vigiar PA, glicemia, crescimento e infecção; não suspender abruptamente exposição prolongada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Exacerbação de asma, síndrome nefrótica idiopática, crupe viral (alternativa oral), processos inflamatórios e autoimunes.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] GINA - Summary Guide 2025 (ginasthma.org)

[S2] KDIGO - Nephrotic syndrome in children, 2025 (kdigo.org)

[S3] RCH - Croup (rch.org.au)

[S4] DailyMed - Prednisolone sodium phosphate (dailymed.nlm.nih.gov)

[S5] GINA - Strategy Report 2026 (ginasthma.org)

362. Prednisona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Condições alérgicas graves, reumáticas e pulmonares que exigem ação anti-inflamatória/imunossupressora Crianças com diagnóstico definido RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Prednisona VO: dose inicial 0,14-2 mg/kg/dia ou 4-60 mg/m²/dia, preferencialmente pela manhã. Individualizar conforme doença e resposta; após controle, reduzir gradualmente à menor dose eficaz se tratamento prolongado. [S1] Faixa da bula, não um único esquema para todos os diagnósticos. Não há duração ou teto absoluto universal nesse grupo de indicações.
Exacerbação asmática dentro das indicações pulmonares 6-11 anos	1-2 mg/kg/dia VO (máx. 40 mg/dia), uma vez pela manhã, por 3-5 dias. [S1, S2] Equivalência anti-inflamatória oral prednisona: prednisolona 1:1; não aplicar esse curso a vasculite ou outra doença reumática.
Exacerbação asmática moderada/grave - crianças pequenas e adolescentes ≤5 anos; ≥12 anos	≤5 anos: 1-2 mg/kg/dia VO uma vez/dia, max 20 mg/dia se <2 anos ou 30 mg/dia se 2-5 anos, por 3-5 dias. Adolescentes: 40-50 mg VO uma vez/dia por 5-7 dias. [S3] Prednisona/prednisolona são alternativas equivalentes neste regime. Reavaliar antes de suspender; curso curto geralmente dispensa desmame.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, glicemia, crescimento, infecção e supressão adrenal. Definir retirada gradual após uso prolongado; comprimido não permite toda dose de lactente com precisão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Corticoterapia sistêmica anti-inflamatória e imunossupressora em doenças alérgicas graves, reumáticas e pulmonares.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Neo Química - Prednisona, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] GINA - Summary Guide 2025 (ginasthma.org)

[S3] GINA - Strategy Report 2026 (ginasthma.org)

363. Pregabalina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Adjuvante de crises focais ≥1 mês	VO: ≥30 kg, iniciar 2,5 mg/kg/dia, máximo 10 mg/kg/dia ou 600 mg/dia, em 2-3 doses. <30 kg, iniciar 3,5 mg/kg/dia e titular semanalmente até 14 mg/kg/dia: <4 anos em 3 doses; ≥4 anos em 2-3 doses. Tratamento contínuo. [S1] Dose pediátrica FDA; verificar registro brasileiro. Retirada gradual em pelo menos 1 semana.
Fibromialgia juvenil Crianças/adolescentes; uso off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ensaio em 12-17 anos estudou 75-450 mg/dia por 15 semanas, sem atingir desfecho primário; essa faixa não é recomendação de eficácia. [S1] Preservada indicação original; seleção e eventual titulação dependem de equipe de dor e evidência do diagnóstico específico.
Dor neuropática/dor crônica selecionada >4 anos; equipe de dor, off-label	<30 kg: iniciar 1,75 mg/kg/dose VO 12/12 h; titular até 14 mg/kg/dia. ≥30 kg: 1,25 mg/kg/dose ou 75 mg 12/12 h, o menor; teto 10 mg/kg/dia ou 600 mg/dia, o menor. Uso contínuo com reavaliação do benefício e titulação cautelosa. [S2] Ajustar rim; início menor se sedação. Não aplicar este esquema de dor automaticamente à fibromialgia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar sonolência, depressão respiratória com opioides, edema, peso e ideação suicida. Eliminação renal: ajuste pediátrico em insuficiência renal não foi estudado na bula; não usar automaticamente tabela Cockcroft-Gault adulta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)
Dor neuropática e crises focais adjuvantes (uso adulto na bula; fibromialgia juvenil e dor crônica off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Lyrica, revisão 2025 (accessdata.fda.gov)

[S2] IWK - Pediatric Drug Dosing Guidelines (dir.iwk.nshealth.ca)

364. Primidona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais e tônico-clônicas refratárias	VO: dias 1-3, 100-125 mg ao deitar; dias 4-6, mesma dose 12/12 h; dias 7-9, 8/8 h; dia 10 em diante, 250 mg 8/8 h. Manutenção 250 mg 3-4 vezes/dia; teto regulatório 500 mg 4 vezes/dia (2 g/dia). [S1]
≥8 anos na indicação brasileira	Titular mais lentamente conforme sedação e associação. Dose máxima não é dose inicial.
Alternativa pediátrica internacional	VO: dias 1-3, 50 mg à noite; dias 4-6, 50 mg 12/12 h; dias 7-9, 100 mg 12/12 h; depois 125-250 mg 8/8 h, ajustando manutenção a 10-25 mg/kg/dia em doses divididas. [S1]
<8 anos; off-label em relação à indicação original	Não iniciar comprimido inteiro em lactente nem usar teto adulto por padrão. Uso contínuo, retirada gradual.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar sedação, ataxia, hemograma, interações e níveis de primidona/fenobarbital quando indicado. Indução enzimática pode reduzir efeito de outros tratamentos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 46)

Tratamento de epilepsias focais e tônico-clônicas generalizadas refratárias (bula a partir de 8 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Primidone (dailymed.nlm.nih.gov)

365. Saccharomyces Boulardii

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diarreia aguda - adjuvante Crianças sem contraindicação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Saccharomyces boulardii VO 250-750 mg/dia por 5-7 dias; dividir conforme formulação. Sempre associar SRO e alimentação. [S1, S2] ESPGHAN admite esta opção, mas OMS 2024 sugere não usar probióticos na diarreia aquosa aguda; evidência e recomendações divergem. Não é componente obrigatório do tratamento.
Prevenção de diarreia associada a antibiótico Crianças sem contraindicação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Iniciar junto com antibiótico; selecionar preparação com dose alta estudada (≥5 bilhões de UFC/dia) de S. boulardii. Manter durante curso do antibiótico. [S1] Não converter UFC em mg sem relação comprovada do produto; massa não define viabilidade. A recomendação não fixa prolongamento universal após antibiótico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar em criticamente enfermos, imunossuprimidos e portadores de cateter venoso central pelo risco de fungemia. Não abrir sachê próximo a acesso vascular; antifúngico pode inativar o probiótico.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)
Adjuvante no tratamento da diarreia aguda e prevenção de diarreia associada a antibióticos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] ESPGHAN - Probiotics in pediatric gastrointestinal disorders, 2023 (espghan.org)
[S2] OMS - Pneumonia e diarreia pediátricas,2024 (iris.who.int)

366. Prometazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Alergia aguda e prurido ≥2 anos; uso sistêmico cauteloso RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: bula internacional descreve 6,25-12,5 mg 3 vezes/dia ou 25 mg ao deitar, ajustando à menor quantidade eficaz. Não aplicar automaticamente a maior dose à criança pequena. Usar por período curto, reavaliando sintomas. [S1] Anti-histamínico menos sedativo é preferível quando adequado. Não substitui adrenalina na anafilaxia.
Náusea e vômito de etiologia conhecida ≥2 anos; excepcional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula: cerca de 1,1 mg/kg/dose VO (=0,5 mg/libra), ajustado à idade/peso; esquema geral 12,5-25 mg, repetível 4/4-6/6 h. Usar a menor dose eficaz e não exceder 25 mg/dose no esquema aqui descrito. [S1] Não usar em vômito simples de gastroenterite, etiologia desconhecida ou suspeita de Reye; risco de depressão respiratória mesmo em doses ponderais.
Prurido localizado/picadas - creme ≥2 anos	Creme 20 mg/g: camada fina na área afetada 3-4 vezes/dia; suspender se irritação e reavaliar persistência. [S2] Não aplicar em pele infectada/lesada nem expor área ao sol.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada <2 anos; depressão respiratória fatal, sedação e distonia. Evitar associação com opioides/sedativos; formulação injetável não recebe dose extrapolada da oral.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Tratamento de reações alérgicas agudas, prurido, náuseas e vômitos; creme para picadas (injetável contraindicado abaixo de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Promethazine hydrochloride (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Opella - Cremefenergan, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

367. Propiltiouracila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Graves - uso excepcional Crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Diretriz japonesa: PTU 2-7,5 mg/kg/dia VO em 3 tomadas; máximo habitual 300 mg/dia, até 600 mg/dia em grave selecionado. Reduzir conforme T4/T3 e resposta. [S1, S2] Não é primeira escolha pediátrica: risco de hepatotoxicidade grave. Manter somente se benefício justificar ausência de alternativa adequada.
Graves - alternativa regulatória por idade 6-10 anos; >10 anos; neonatos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	SmPC: 6-10 anos 50-150 mg/dia VO; >10 anos 150-300 mg/dia ou 150 mg/m ² /dia. Neonatos 5-10 mg/kg/dia. Fracionamento em 3 tomadas respaldado pela diretriz; manutenção individualizada à resposta. [S1, S3] Limitar duração ao necessário, com endocrinologia e plano para alternativa mais segura.
Tempestade tireotóxica Crianças/adolescentes; UTI, uso excepcional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Diretriz pediátrica japonesa: PTU 15-30 mg/kg/dia VO, divididos em 3-4 tomadas; faixa adulta correspondente 800-1.200 mg/dia serve como limite de referência, não carga infantil. Titular/retirar regime intensivo após resolução da crise. [S1, S2] Não há carga separada indicada nessa fonte. Associar suporte, beta-bloqueador/corticosteroide quando apropriados; iodeto ≥1 h após antitireoidiano. Superioridade de PTU sobre metimazol não comprovada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar T4/T3, hemograma e fígado. Febre/odinofagia ou icterícia exigem suspensão e investigação imediata; testes periódicos não eliminam hepatotoxicidade imprevisível. Não somar regimes de Graves e tempestade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Tratamento da tempestade tireoidiana e hipertireoidismo (doença de Graves) em situações selecionadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sociedade Japonesa de Endocrinologia Pediátrica - Graves 2016 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S2] ATA - Hyperthyroidism 2016 (thermofisher.com)

[S3] eMC - Propylthiouracil 50 mg (medicines.org.uk)

368. Propofol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução e manutenção de anestesia geral ≥3 anos; anestesiologia	Indução EV lenta titulada: >8 anos geralmente 2,5 mg/kg; 3-8 anos podem exigir mais, sem teto numérico fixo na bula. Manutenção: 9-15 mg/kg/h EV, ajustando profundidade. Reduzir em ASA III-IV. Duração limitada ao ato anestésico. [S1] Solução 1% = 10 mg/mL. Não administrar 2% em bolus segundo esta bula; não extrapolar sistema TCI adulto.
Sedação contínua em UTI sob ventilação mecânica Crianças - indicação não recomendada na bula brasileira RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula não recomenda sedação em UTI pediátrica: segurança/eficácia não demonstradas e relatos de eventos fatais. A faixa anestésica de 9-15 mg/kg/h não é dose de sedação de UTIP. [S1] Preservada indicação documental; não constitui indicação pediátrica aprovada.
Sedação breve de UTIP - alternativa off-label selecionada, inclusive transição para extubação Crianças monitorizadas em terapia intensiva RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	PANDEM: infusão EV titulada em dose estritamente <4 mg/kg/HORA, por tempo estritamente <48 h. A diretriz não define dose inicial universal; titular à meta clínica e reduzir outros sedativos conforme avaliação. [S2] Recomendação condicional, evidência baixa; limites reduzem risco, não garantem ausência de síndrome da infusão de propofol.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar via aérea, ventilação, PA, ECG, lactato/acidose, CK e triglicerídeos conforme exposição; interromper diante de suspeita de PRIS. Assepsia rigorosa; não há analgesia intrínseca. $\text{mL/h} = \text{mg/kg/h} \times \text{peso} \div \text{concentração final mg/mL}$.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Indução e manutenção da anestesia geral; sedação de pacientes ventilados em UTI (emulsão aprovada a partir de 3 anos para indução).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Aspen - Diprivan, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] SCCM - PANDEM pediatric guidelines, 2022 (sccm.org)

369. Propranolol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Taquiarritmias; controle adrenérgico do hipertireoidismo Crianças	Propranolol VO 0,25-0,5 mg/kg/dose, 3-4 vezes/dia; titular à FC, sintomas e PA. Tratamento conforme persistência da indicação. [S1] Na tireotoxicose controla sintomas, sem substituir antitireoideano.
Profilaxia de enxaqueca Crianças selecionadas RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula internacional: <12 anos, 20 mg VO 2-3 vezes/dia; >12 anos, iniciar 40 mg 2-3 vezes/dia, faixa usual 80-160 mg/dia. Reavaliar frequência de crises e tolerância. [S1] Não usar dose fixa de 20 mg automaticamente em criança pequena; ponderar peso, PA e alternativa terapêutica.
Prevenção de crises hipóxicas na tetralogia de Fallot Crianças	VO até 1 mg/kg/dose, 3-4 vezes/dia, individualizado à resposta. [S1] Não substitui manejo imediato da crise grave nem correção cardíaca.
Hemangioma infantil proliferativo que exige terapia sistêmica Iniciar entre 5 semanas e 5 meses na bula EMA	Propranolol base VO: semana 1, 1 mg/kg/dia; semana 2, 2 mg/kg/dia; a partir da semana 3, 3 mg/kg/dia. Dividir em 2 tomadas com intervalo ≥9 h, durante/após alimentação. Curso de 6 meses, ajuste mensal pelo peso. [S2] Não converter automaticamente para cloridrato na mesma massa. Suspende temporariamente se jejum, alimentação insuficiente ou vômitos.
Crise hipoxêmica da tetralogia de Fallot - persistente Lactentes/crianças em ambiente de ressuscitação RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Propranolol 0,1 mg/kg EV lentamente, com FC/PA monitoradas, se crise persistir após medidas iniciais; fonte descreve diluição em 50 mL de SG 5%, cujo volume deve ser reavaliado em lactente pequeno. [S3] Revisão especializada não fixa minutos de infusão ou teto absoluto: cardiologia/anestesia devem definir antes da administração. Não substituir medidas de aumento do fluxo pulmonar e correção de hipovolemia/acidose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em broncoespasmo/asma, bradicardia importante, bloqueio AV significativo e choque. Vigiar FC, PA e hipoglicemia; dose de hemangioma possui base química específica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Profilaxia de migrânea, taquiarritmias, hipertireoidismo; tetralogia de Fallot (crises hipoxêmicas) e hemangioma infantil (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] eMC - Propranolol hydrochloride, SmPC (medicines.org.uk)

[S2] EMA - Hemangiol, informações do produto (ema.europa.eu)

[S3] Revisão especializada - Manejo de cardiopatias cianóticas (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

370. Protamina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão de heparina não fracionada: hemorragia grave ou pós-circulação extracorpórea	Para cada 100 UI de heparina recebida: se término da infusão <30 min, protamina 1 mg; 30-60 min, 0,5-0,75 mg; 61-120 min, 0,375-0,5 mg; >120 min, 0,25-0,375 mg. Considerar heparina das 2 h anteriores. Máximo 50 mg/dose EV em 10 min. [S1, S2]
Crianças/neonatos; dose baseada na heparina administrada	Os fatores temporais já ajustam a depuração: não reduzir primeiro a heparina por meia-vida e aplicar novamente a tabela. Após CEC, titular também por ACT/TTPa e método de heparina residual.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, FC e anafilaxia; excesso de protamina também anticoagula. Não misturar outros medicamentos na mesma linha. Heparina de baixo peso molecular tem reversão incompleta e esquema diferente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Reversão específica dos efeitos anticoagulantes da heparina não fracionada em hemorragias graves ou pós-circulação extracorpórea.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] West of Scotland NHS - Protamine sulfate neonatal monograph (perinatalnetwork.nhs.scot)

[S2] IWK - Pediatric Drug Dosing Guidelines (dir.iwk.nshealth.ca)

371. Quetiapina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Esquizofrenia 13-17 anos	Quetiapina XR VO uma vez/dia, preferencialmente à noite: dia 1, 50 mg; dia 2, 100 mg; dia 3, 200 mg; dia 4, 300 mg; dia 5, 400 mg. Faixa 400-800 mg/dia, máximo 800 mg/dia. Uso contínuo com revisão periódica. [S1]
Episódio maníaco do transtorno bipolar I 10-17 anos	Quetiapina XR VO uma vez/dia: 50, 100, 200, 300 e 400 mg nos dias 1-5, respectivamente; depois titular para 400-600 mg/dia, máximo 600 mg/dia. [S1] Esquema da formulação prolongada; não esmagar ou fracionar. Duração da fase aguda e manutenção dependem da evolução psiquiátrica.
Esquizofrenia ou mania - alternativa liberação imediata Esquizofrenia 13-17 anos; mania 10-17 anos	VO dia 1:25 mg 12/12 h. Totais diários nos dias 2-5:100,200,300 e 400 mg, divididos em 2 tomadas. Depois aumentar ≤100 mg/dia: esquizofrenia 400-800 mg/dia (máx. 800); mania 400-600 mg/dia (máx. 600). Pode fracionar em 3 tomadas por tolerabilidade. [S2] Não associar ao esquema XR. Manutenção contínua com revisão periódica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar peso/IMC, PA, glicemia, lipídios, sonolência e ideação suicida. Interações CYP 3A4 podem exigir grande ajuste; hepatopatia demanda titulação mais lenta. Não aplicar dose adulta de início 300 mg ao adolescente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Tratamento da esquizofrenia (adolescentes a partir de 13 anos) e episódios maníacos do transtorno bipolar (a partir de 10 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Seroquel XR, bula 2025 (accessdata.fda.gov)

[S2] FDA - Seroquel liberação imediata,2025 (accessdata.fda.gov)

372. Racecadotril

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diarreia aguda - adjuvante da reidratação ≥3 meses	Racecadotril 1,5 mg/kg/dose VO 8/8 h. Alternativa por faixas: <9 kg, 10 mg/dose; 9-13 kg, 20 mg; 14-27 kg, 30 mg; >27 kg, 60 mg; todos 8/8 h. Suspender após duas evacuações normais; máximo 7 dias. [S1] Não somar dose ponderal e faixa. Teto diário da bula aproximadamente 6 mg/kg/dia; regime usual ponderal =4,5 mg/kg/dia. As faixas da bula usam pesos inteiros; em peso intermediário, calcular 1,5 mg/kg/dose, sem criar faixa omitida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não substitui SRO; sangue nas fezes, febre importante ou vômitos persistentes exigem investigação. Cautela insuficiência hepática/renal; suspender se angioedema ou reação cutânea grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Tratamento adjuvante antissecretor da diarreia aguda aquosa em lactentes (a partir de 3 meses) e crianças.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bagó - Tiorfan, bula profissional (onepharma.com.br)

373. Rasburicase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção e tratamento da hiperuricemia na síndrome de lise tumoral	Rasburicase 0,2 mg/kg/dose EV uma vez ao dia, por 4-7 dias na bula brasileira; ajustar duração à uricemia e lise tumoral. Reconstituir com diluente próprio, retirar dose calculada e diluir em 50 mL de SF 0,9%; infundir em 30 min. [S1]
Crianças e adolescentes em risco	Não administrar em bolus nem misturar com quimioterápico. Volume em lactente requer avaliação farmacêutica para restrição hídrica, sem reduzir dose por frasco.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada na deficiência de G6PD, pelo risco de hemólise/metemoglobinemia. Colher ácido úrico em tubo pré-resfriado e transportar/manter em gelo, processando rapidamente: degradação ex vivo produz resultado falsamente baixo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 47)

Tratamento e profilaxia da hiperuricemia aguda severa para prevenção de insuficiência renal na síndrome da lise tumoral.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sanofi - Fasturtec, bula Anvisa hospedada (bula.gratis)

374. Remifentanila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Analgesia na manutenção da anestesia geral	Remifentanila EV: iniciar 0,25 mcg/kg/min com anestésico inalatório; titular 0,05-1,3 mcg/kg/min. Bolus suplementar 1 mcg/kg em 30-60 s quando necessário. [S1]
1-12 anos; ventilação controlada	Não usar como agente hipnótico único. Concentração pediátrica de 20-25 mcg/mL permite ajuste em bomba.
Analgesia na UTI com suporte ventilatório	Faixa publicada em pediatria: 0,05-1 mcg/kg/min EV em infusão contínua, titulada à escala de dor/sedação e estabilidade; iniciar na extremidade baixa quando clinicamente apropriado. [S2]
Lactentes/crianças; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Fonte hospitalar resume estudos pequenos; não há duração máxima universal comprovada. Reavaliar diariamente; dar analgésico de maior duração antes de suspender.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar apneia, rigidez torácica, bradicardia e hipotensão. 1 mg = 1.000 mcg; mL/h = mcg/kg/min × peso × 60 ÷ mcg/mL. Após interrupção efeito cessa em minutos; evitar bolus residual ao lavar linha.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Analgesia opioide de ação ultracurta na manutenção da anestesia geral (a partir de 1 ano) e ventilação mecânica em UTI (off-label pediátrico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Ultiva, revisão 2026 (accessdata.fda.gov)

[S2] University of Virginia Pediatrics - Remifentanil in infants and children (med.virginia.edu)

375. Retinol (Vitamina A)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção da deficiência de vitamina A	6-11 meses: 100.000 UI VO uma vez. 12-59 meses: 200.000 UI VO a cada 6 meses; conferir última dose e elegibilidade territorial/nutricional. [S3]
Crianças elegíveis ao PNSVA	Não duplicar megadose em criança contemplada pelo NutriSUS. Confirmar concentração da cápsula; não administrar EV/IM.
Deficiência de vitamina A com xeroftalmia/cegueira noturna	Retinol VO: <6 meses, 50.000 UI/dose; 6-11 meses, 100.000 UI/dose; ≥12 meses, 200.000 UI/dose. Administrar ao diagnóstico, repetir no dia seguinte e novamente após pelo menos 2 semanas. [S1]
Crianças; excluir gestação em adolescentes	Lesão corneana é emergência. Em adolescente com possibilidade de gestação e apenas cegueira noturna/mancha de Bitot, usar dose ≤10.000 UI/dia ou ≤25.000 UI/semana sob especialista; megadose requer indicação grave.
Sarampo suspeito/confirmado - reduzir complicações	VO duas doses, uma na suspeita e outra no dia seguinte: <6 meses, 50.000 UI; 6-11 meses, 100.000 UI; 12-59 meses, 200.000 UI. Se sinais de deficiência, considerar terceira dose após 2-4 semanas. [S2]
<5 anos; esquema nacional	Não fracionar cápsula de 100.000/200.000 UI para obter 50.000 UI; usar preparação que permita mensuração exata.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Somar suplementos e evitar megadoses repetidas fora dos intervalos. Hipervitaminose causa vômitos, hipertensão intracraniana e hepatotoxicidade; retinoides aumentam toxicidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Prevenção e tratamento da deficiência de vitamina A, xeroftalmia, cegueira noturna e terapia adjuvante do sarampo grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] OMS - Vitamin A supplements: prevenção e tratamento de xeroftalmia (iris.who.int)

[S2] Ministério da Saúde - Vitamina A para sarampo, nota técnica 2025 (gov.br)

[S3] Ministério da Saúde - Nota conjunta 134/2025, vitamina A (saude.sc.gov.br)

376. Ribavirina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hepatite C crônica em esquema combinado selecionado	Ribavirina VO 15 mg/kg/dia em 2 tomadas; <47 kg usar solução. Faixas de cápsulas: 47-59 kg, 800 mg/dia; 60-73 kg, 1.000 mg/dia; >73 kg, 1.200 mg/dia, divididos manhã/noite. [S1]
3-17 anos	Esquema da bula com interferon é histórico: genótipo 1, 48 semanas; 2/3, 24 semanas. Não escolher interferon/ribavirina automaticamente quando antivirais de ação direta estão disponíveis.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar monoterapia. Hemograma basal e em 2/4 semanas; anemia pode exigir redução para 12 e depois 8 mg/kg/dia. Teratogenicidade: evitar gravidez durante e pelo período pós-tratamento da bula; contraindicação renal relevante (ClCr <50 mL/min na formulação citada).

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Tratamento da hepatite C crônica em esquemas combinados selecionados (uso adulto e pediátrico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Ribavirin capsules (dailymed.nlm.nih.gov)

377. Rifampicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tuberculose ativa Crianças	Rifampicina 15 mg/kg/dia VO (faixa 10-20 mg/kg/dia), máximo 600 mg/dia, uma tomada diária em associação. Esquema básico usual: 2 meses intensivos +4 meses manutenção; formas meníngea/osteoarticular exigem maior duração. [S1, S2] Não usar isoladamente em doença ativa.
Quimioprofilaxia de meningococo Contatos elegíveis	<4 semanas a termo: 5 mg/kg/dose VO 12/12 h por 2 dias. ≥4 semanas: 10 mg/kg/dose VO 12/12 h (máx. 600 mg/dose) por 2 dias, total 4 doses. [S1]
Infecção estafilocócica associada a biofilme ≥4 semanas; adjuvante	10-20 mg/kg/dia VO ou EV (máx. 600 mg/dia), dividido em 1-2 doses, sempre com outro antimicrobiano ativo. EV: diluir a ≤6 mg/mL e infundir em 30 min. [S1] Duração depende de prótese, retenção/remoção, sítio e bacteremia; resistência emerge rapidamente em monoterapia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Revisar interações por forte indução enzimática; monitorar fígado e hemograma. Secreções alaranjadas são esperadas. Rifampicina reduz eficácia de anticoncepcionais e diversos antiepilépticos/antivirais.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Tratamento da tuberculose ativa (esquema combinado), quimioprofilaxia de doença meningocócica e infecções estafilocócicas associadas a biofilme.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - Rifampicin (pch.health.wa.gov.au)

[S2] Ministério da Saúde - TB em crianças (gov.br)

378. Risperidona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Irritabilidade associada ao autismo 5-17 anos	VO: <20 kg, 0,25 mg/dia nos dias 1-3, depois 0,5 mg/dia até pelo menos dia 14; aumentar 0,25 mg a intervalos ≥ 2 semanas, máximo 1,5 mg/dia. ≥ 20 kg: 0,5 mg/dia inicialmente, depois 1 mg/dia; aumentar 0,5 mg a intervalos ≥ 2 semanas, máximo 2,5 mg/dia; >45 kg, até 3,5 mg/dia. Uma ou duas tomadas. [S1]
Esquizofrenia 13-17 anos	VO iniciar 0,5 mg/dia; titular 0,5-1 mg a intervalos ≥ 24 h até alvo 3 mg/dia. Faixa estudada 1-6 mg/dia; máximo estudado 6 mg/dia. [S1] Uso contínuo com revisão; sonolência pode melhorar dividindo em 2 doses.
Mania bipolar 10-17 anos	VO iniciar 0,5 mg uma vez/dia; aumentar 0,5-1 mg a intervalos ≥ 24 h conforme tolerado até alvo 2,5 mg/dia. Faixa eficaz estudada 0,5-6 mg/dia; não exceder 6 mg/dia. [S1] Reavaliar justificativa do uso continuado; dose do autismo não deve ser transposta automaticamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar peso, glicemia, lipídios, sintomas extrapiramidais e hiperprolactinemia. Insuficiência renal/hepática: reduzir doses inicial/manutenção pela metade e titular lentamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Tratamento da irritabilidade e agressividade associadas ao transtorno do espectro autista (a partir de 5 anos); esquizofrenia e mania.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Janssen - Risperdal, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

379. Rufinamida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Síndrome de Lennox-Gastaut - adjuvante ≥4 anos, <30 kg (original: >18 kg)	VO em 2 tomadas com alimento: iniciar 200 mg/dia. Sem valproato: aumentar 200 mg a cada 3 dias, máximo 1.000 mg/dia. Com valproato: aumentar 200 mg a intervalos ≥2 dias, máximo 600 mg/dia. [S1] Regime EMA; a faixa original >18 kg não é requisito ponderal desta fonte internacional. Tratamento contínuo com avaliação de crises.
Síndrome de Lennox-Gastaut - adjuvante ≥4 anos, ≥30 kg	Iniciar 400 mg/dia VO em 2 tomadas; aumentar 400 mg a cada 2 dias. Máximos sem valproato: 30-50 kg, 1.800 mg/dia; >50-70 kg, 2.400; >70 kg, 3.200. Com valproato: respectivos tetos 1.200, 1.600 e 2.200 mg/dia. [S1] Tratamento contínuo. Os valores de manutenção são tetos, não doses obrigatórias.
Alternativa por aprovação internacional 1-<4 anos; fora da faixa da indicação original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO iniciar 10 mg/kg/dia em 2 tomadas; aumentar até 10 mg/kg/dia a cada 3 dias. Máximo 45 mg/kg/dia sem valproato ou 30 mg/kg/dia com valproato. [S1] Uso contínuo; não extrapolar para <1 ano. EMA não comprova registro no Brasil.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Valproato eleva exposição; atenção DRESS, sonolência e encurtamento de QT. Retirada gradual, aproximadamente 25% a cada 2 dias na bula, individualizando controle de crises.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Terapia adjuvante para crises epiléticas associadas à síndrome de Lennox-Gastaut (a partir de 4 anos e peso superior a 18 kg).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Inovelon, informações do produto (ema.europa.eu)

380. Sais de Reidratação Oral (SRO)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção da desidratação e reposição de perdas por diarreia/vômitos - plano A	SRO VO após cada evacuação: <1 ano, 50-100 mL; 1-10 anos, 100-200 mL; >10 anos, volume aceito. Ofertar em pequenas quantidades frequentes; se vomitar, reiniciar mais lentamente. Manter enquanto houver perdas. [S1]
Crianças	
Tratamento da desidratação sem choque - plano B	SRO VO 50-100 mL/kg ao longo de 4-6 h como orientação inicial, titulando à sede/perdas e reavaliando continuamente. Se corrigido, retornar ao plano A; persistência pode exigir sonda nasogástrica. Piora para desidratação grave exige plano EV. [S1]
Crianças capazes de receber via enteral	Não fixar o volume como teto se perdas continuam; contabilizar entradas e saídas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Reconstituir sachê no volume EXATO indicado no produto, sem adicionar açúcar/sal. Não usar refrigerante como equivalente; manter aleitamento. Choque, íleo ou alteração de consciência contraindicam forçar VO.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)

Prevenção e tratamento da desidratação aguda decorrente de diarreia ou vômitos e reposição de perdas hidroeletrólíticas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - Manejo do paciente com diarreia (bvsmis.saude.gov.br)

381. Salbutamol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crise asmática e broncoespasmo/sibilância aguda 6-11 anos; aerossol com espaçador	Salbutamol 100 mcg/jato: 4-10 jatos por administração, a cada 20 min por até 3 administrações na primeira hora; depois espaçar conforme resposta. Necessidade persistente exige reavaliação da gravidade, não repetição domiciliar indefinida. [S1] GINA 2025. Sibilância de bronquiolite não constitui indicação automática de broncodilatador.
Crise asmática - esquema por idade e nebulização Crianças com asma/sibilância responsiva	Referência histórica RCH (1999): <6 anos, 6 jatos de 100 mcg; ≥6 anos, 12 jatos, a cada 20 min inicialmente. Nebulização: 0,05-0,15 mg/kg/dose. [S2] Esquema preservado para rastreabilidade; não representa atualização de 2026. Priorizar a avaliação atual e o esquema GINA 2026 abaixo. Não somar automaticamente jatos e nebulizações; crise crítica exige monitorização e tratamento intensivo.
Hipercalemia aguda - adjuvante nebulizado 1 mês-18 anos; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	<25 kg: 2,5 mg por nebulização; ≥25 kg: 5 mg por nebulização. Repetir se necessário pela resposta do potássio, ECG e tolerância; a fonte não determina intervalo fixo. [S3] Não é tratamento isolado de hipercalemia com alterações eletrocardiográficas; resposta é variável e transitória.
Hipercalemia aguda - alternativa RCH com intervalo definido Crianças; off-label, ambiente monitorado	≤25 kg: 2,5 mg nebulizados a cada 1-2 h; >25 kg: 5 mg a cada 1-2 h. RCH admite máximo 10-20 mg em maiores, exclusivamente por decisão especializada e monitorização. Suspender repetições ao corrigir K ou ocorrer toxicidade. [S4] O limiar 25 kg difere do PCH.10-20 mg não é dose inicial padrão nem meta obrigatória.
Crise asmática - alternativa atualizada GINA 2026 Crianças e adolescentes	≥6 anos, apresentação leve: 4 jatos de 100 mcg por espaçador, um por vez; repetir na primeira hora se necessário. ≤5 anos: leve 4 jatos, repetir após 30-60 min; moderada/grave 4-6 jatos ou 2,5 mg nebulizados a cada 20-30 min até 3 vezes, depois reavaliar. [S5] Titular resposta; dose histórica maior não é meta obrigatória. Após primeira hora, sem repetição programada se resposta sustentada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FC, K, lactato e glicemia em doses repetidas; acidose láctica por beta-agonista pode simular piora da crise. Não confundir mcg por jato com mg por nebulização.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)
Alívio rápido do broncoespasmo na crise asmática e sibilância aguda; hipercalemia aguda (nebulização, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] GINA - Summary Guide 2025 (ginasthma.org)
[S2] RCH - Best practice acute asthma, outubro de 1999 (referência histórica)
[S3] Perth Children’s Hospital - Hyperkalaemia (pch.health.wa.gov.au)
[S4] RCH - Hyperkalaemia,2024 (rch.org.au)
[S5] GINA - Strategy Report 2026 (ginasthma.org)

382. Salmeterol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção da asma, sempre associado a corticosteroide inalatório ≥4 anos	Salmeterol inalatório 50 mcg/dose 12/12 h; máximo 100 mcg/dia. Uso contínuo, com revisão regular e redução quando controle sustentado permitir. [S1] Nunca usar isolado na asma. Não é resgate; técnica deve ser compatível com dispositivo e capacidade inspiratória.
Manutenção da DPOC Indicação adulta original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico estabelecido para DPOC. Não extrapolar doença de adulto para displasia broncopulmonar ou bronquiolite obliterante. [S1] Posologia infantil para asma não valida DPOC pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar taquicardia, tremor e hipocalemia; evitar outro LABA concomitante e inibidores fortes de CYP 3A4. Pó com lactose pode conter proteína do leite.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 48)
Manutenção prolongada da asma persistente e DPOC, sempre associado a corticosteroides inalatórios.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] GSK - Serevent Diskus, monografia (ca.gsk.com)

383. Secnidazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Giardíase 2-11 anos; estudo pediátrico, uso conforme formulação/registro	Secnidazol 30 mg/kg VO em dose única; não exceder 2 g, dose adulta. [S1, S3] Ensaio pediátrico aberto sustenta dose ponderal; teto de 2 g é limite conservador da dose adulta, não máximo estudado em criança.
Amebíase intestinal Crianças; evidência antiga, diagnóstico etiológico necessário RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	30 mg/kg VO em dose única; limite conservador de 2 g. Ensaio incluiu 10 meses-7 anos; nos menores, decisão especializada conforme formulação e autorização local. [S2, S3] Microscopia isolada não distingue <i>E. histolytica</i> de <i>E. dispar</i> . Estudo antigo não estabelece erradicação luminal moderna nem trata automaticamente amebíase invasiva/hepática.
Tricomoniase ≥12 anos, autorização FDA	2 g VO em dose única. Tratar parceiros concomitantemente. [S4] Aprovação internacional não demonstra registro pediátrico brasileiro. Em <12 anos, não há esquema validado nesta bula; investigar contexto de exposição e proteção da criança.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar álcool durante e por 48 h após tratamento conforme bula FDA; conferir restrição mais longa da apresentação brasileira. Reavaliar persistência, reinfecção e necessidade de agente luminal na amebíase.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Tratamento em dose única de giardíase, amebíase intestinal e tricomoniase.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ensaio pediátrico - Secnidazole versus metronidazole for giardiasis (produccioncientifica.luz.edu.ve)

[S2] BVS/OMS - Comparative study of secnidazole and metronidazole in intestinal amoebiasis (search.bvsalud.org)

[S3] Vitamedic - Secnidazol, bula profissional (vitamedic.ind.br)

[S4] DailyMed - Solosec (dailymed.nlm.nih.gov)

384. Sertralina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Transtorno obsessivo-compulsivo 6-17 anos	Sertralina VO uma vez/dia: 6-12 anos iniciar 25 mg; 13-17 anos iniciar 50 mg. Aumentar 25-50 mg/dia em intervalos de pelo menos 1 semana, conforme resposta; máximo 200 mg/dia. Tratamento contínuo, com reavaliação periódica e retirada gradual. [S1]
Transtornos de ansiedade de separação, generalizada ou social 7-17 anos; off-label	Ensaio CAMS: titular sertralina até 200 mg/dia VO, ao longo de 12 semanas. Início conservador de 25 mg/dia e incrementos semanais de 25-50 mg seguem titulação pediátrica da bula de TOC; essa aplicação à ansiedade é off-label. [S1, S2] A combinação com terapia cognitivo-comportamental teve benefício. As 12 semanas são período do estudo, não duração obrigatória de todo tratamento.
Depressão maior 6-17 anos; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ensaios pediátricos estudaram 50-200 mg/dia VO durante 10 semanas, em dose flexível. A escolha de dose inicial e incrementos em criança pequena requer psiquiatria; não iniciar diretamente na faixa alta. [S1, S3] A indicação original é adulta; não há aprovação pediátrica regulatória para depressão nesta bula. Dez semanas descrevem ensaio, não curso curativo fixo.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar ideação suicida, ativação/manias, síndrome serotoninérgica e hiponatremia. Doença hepática leve: metade das doses; moderada/grave: não recomendada pela bula. Não combinar com IMAO nem suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)
Tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) a partir de 6 anos; depressão e transtornos de ansiedade em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DailyMed - Zoloft (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] CAMS - Sertraline, CBT or combination in childhood anxiety (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
[S3] Wagner et al. - Sertraline in pediatric major depressive disorder (doi.org)

385. Sevoflurano

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução da anestesia geral Crianças; anestesiologista	Sevoflurano inalatório: concentrações inspiradas até 7% podem produzir anestesia cirúrgica em <2 min; titular ao plano e à idade em vaporizador calibrado, com O ₂ ou mistura O ₂ /N ₂ O. [S2] Concentração máxima descrita para indução, não para manutenção. Não administrar EV nem dosar em mL/kg.
Manutenção da anestesia geral Crianças	Concentração inspirada usual 0,5-3%, com ou sem óxido nitroso, ajustada à idade, estímulo e agentes associados. CAM em O ₂ : termo <1 mês 3,3%; 1-<6 meses 3,0%; 6 meses-<3 anos 2,8%; 3-12 anos 2,5%. [S1] CAM é referência populacional de potência, não concentração obrigatória individual. Duração: ato anestésico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar ventilação, capnografia, pressão e temperatura; contraindicado em suscetibilidade à hipertermia maligna. CAM de prematuros não estabelecida. Evitar absorvente de CO₂ ressecado e respeitar limites de baixo fluxo do equipamento/bula.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Indução e manutenção de anestesia geral inalatória em procedimentos cirúrgicos pediátricos e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Ultane (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Medsafe - Sevoflurane (medsafe.govt.nz)

386. Sildenafil

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertensão arterial pulmonar 1-17 anos; esquema EMA, off-label na bula brasileira original	Sildenafil VO: ≤20 kg, 10 mg 3 vezes/dia; >20 kg, 20 mg 3 vezes/dia. Não superar esses tetos pediátricos da EMA. Tratamento contínuo com equipe de HAP. [S1] Não aplicar doses adultas elevadas a crianças.
Hipertensão pulmonar persistente neonatal ou pulmonar crônica neonatal Neonatos selecionados; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	VO: iniciar 0,5-1 mg/kg/dose 6/6-8/8 h; titular até 2 mg/kg/dose conforme resposta. EV: ataque 0,4 mg/kg em 3 h; depois 1,6 mg/kg/dia em infusão contínua (=aprox. 66,7 mcg/kg/h) por até 7 dias na monografia. [S2] VO e EV são alternativas, não doses intercambiáveis. Reservar PPHN refratária/retirada difícil de NO ou indisponibilidade de NO conforme avaliação. A equivalência 66,7 mcg/kg é POR HORA, não por minuto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicar nitratos e riociguat; monitorar PA, oxigenação e ecocardiograma. Interações CYP 3A4. Na infusão neonatal, mcg/kg/HORA não mcg/kg/min; titulação em UTI.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)
Tratamento da hipertensão arterial pulmonar (uso adulto na bula; uso pediátrico em HAP e hipertensão pulmonar persistente neonatal, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Revatio (ema.europa.eu)
[S2] ANMF - Sildenafil, 2026 (anmfonline.org)

387. Simeticona (Dimeticona)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Meteorismo, distensão e desconforto por gases	Simeticona VO, 3 vezes/dia: lactentes, aproximadamente 8,3-13,9 mg/dose; demais crianças até 12 anos, 13,9-27,8 mg/dose; >12 anos, aproximadamente 36,1 mg/dose. Usar enquanto sintomático, reavaliando persistência. [S1]
Crianças	Conversão da bula Cimed 75 mg/mL, 27 gotas/mL; 1 gota ≈ 2,78 mg. Não transpor gotas para frasco de outra concentração. Teto geral da bula 500 mg/dia não é alvo de lactente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dor intensa, vômito bilioso, distensão progressiva ou suspeita de obstrução exigem diagnóstico. Não tratar cólica infantil como doença necessariamente responsiva à simeticona.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Alívio do meteorismo, distensão e desconforto abdominal por excesso de gases intestinais.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cimed - Simeticona, bula profissional hospedada (uploads.consultaremedios.com.br)

388. Sinvastatina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipercolesterolemia primária - forma familiar heterozigótica	Sinvastatina 10-40 mg VO uma vez à noite; iniciar na menor dose apropriada e ajustar após avaliação de LDL, a partir de 4 semanas. Máximo 40 mg/dia; tratamento contínuo com dieta e seguimento. [S1]
≥10 anos	A aprovação internacional pediátrica é específica para hipercolesterolemia familiar; não se estende a toda dislipidemia.
Redução de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco	Não existe dose pediátrica validada para prevenção de eventos cardiovasculares como desfecho. Tratar dislipidemia infantil conforme etiologia/risco e indicação específica acima. [S1]
Indicação adulta original	Não usar 80 mg/dia em criança/adolescente.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar inibidores fortes CYP 3A4, ciclosporina e gemfibrozila; revisar tetos com amiodarona/verapamil/amlodipina. Investigar mialgia/CK e hepatopatia; reavaliar uso se gravidez.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)
Tratamento de hipercolesterolemia primária e redução de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Zocor, revisão 2023 (accessdata.fda.gov)

389. Solução de Ringer com Lactato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Ressuscitação volêmica no choque Crianças; recursos de terapia intensiva disponíveis	Ringer lactato 10-20 mL/kg EV/IO por bolus, reavaliando perfusão e congestão após cada. Na primeira hora, até 40-60 mL/kg se necessário e tolerado; interromper bolus se choque resolvido ou sobrecarga. [S1] Não é volume obrigatório. Sem UTI e sem hipotensão, diretriz recomenda evitar bolus na sepse.
Reidratação e reposição extracelular Crianças sem choque ou após estabilização RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Calcular déficit: mL = peso (kg) × percentual de desidratação ×10; repor gradualmente, geralmente em 24 h, somando manutenção e perdas medidas, com reavaliação de sódio e diurese. [S2] Hipernatremia exige correção mais lenta; Ringer sem glicose não supre sozinho toda necessidade de manutenção de lactente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar congestão, eletrólitos e balanço. Contém cálcio: incompatibilidade com ceftriaxona EV em neonatos; não misturar com sangue ou fármacos sem checar compatibilidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Ressuscitação volêmica, reidratação e reposição de água e eletrólitos no espaço extracelular.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Surviving Sepsis Campaign - Pediatria 2026 (doi.org)

[S2] RCH - Intravenous fluids (rch.org.au)

390. Somatropina (Hormônio do Crescimento)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência de GH Crianças com epífises abertas	Somatropina SC 0,025-0,035 mg/kg/dia. Alternativa de bula: 0,16-0,24 mg/kg/semana, dividida em 6-7 aplicações. Uso contínuo, ajustando crescimento e IGF-1. [S1, S2] Não somar esquemas diário e semanal.
Síndrome de Turner Crianças	SC 0,045-0,050 mg/kg/dia; alternativa 0,33 mg/kg/semana em 6-7 aplicações. [S1, S2]
Síndrome de Prader-Willi Crianças elegíveis	SC 0,035 mg/kg/dia, máximo 2,7 mg/dia; alternativa 0,24 mg/kg/semana em 6-7 aplicações. [S1, S2] Excluir apneia/obstrução respiratória e obesidade grave antes de iniciar.
Insuficiência renal crônica com falha de crescimento Crianças	SC 0,045-0,050 mg/kg/dia, após otimizar nutrição, acidose e metabolismo mineral. Reavaliar resposta em 6 meses; interromper por ocasião de transplante renal. [S1]
PIG sem recuperação estatural ≥4 anos na EMA; ≥2 anos na FDA	EMA: 0,035 mg/kg/dia SC até altura final. FDA: até 0,48 mg/kg/semana em 6-7 aplicações, podendo iniciar 0,24 mg/kg/semana nos menores e titular. [S1, S2] Critérios etários e dose diferem por produto/regulador. Suspender se epífises fechadas ou ausência de benefício.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar IGF-1, glicemia, tireoide, crescimento e sinais de hipertensão intracraniana/epifisiólise. Contraindicado em neoplasia ativa e estado crítico agudo; não usar para crescimento após fechamento epifisário.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Tratamento de baixa estatura por deficiência de GH, síndrome de Turner, Prader-Willi, insuficiência renal crônica e PIG sem recuperação estatural.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Omnitrope (ema.europa.eu)

[S2] DailyMed - Genotropin (dailymed.nlm.nih.gov)

391. Soro Antiaracnídico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Envenenamento por Phoneutria - moderado Crianças; dose independente do peso	Soro antiaracnídico 2-4 frascos-ampola EV, em administração única precoce. [S1]
Envenenamento por Phoneutria - grave Crianças	5-10 frascos-ampola EV em administração única. [S1]
Envenenamento por Loxosceles - moderado Crianças	5 frascos-ampola EV em administração única, conforme critérios clínicos e tempo do acidente. [S1]
Envenenamento por Loxosceles - grave/hemolítico Crianças	10 frascos-ampola EV em administração única. [S1] Não reduzir número de frascos por idade; quantidade neutraliza veneno. Preparação/velocidade requer bula do lote e volume compatível com criança.
Escorpionismo por Tityus - alternativa SAEsc indisponível ou dúvida Phoneutria-Tityus	Moderado: 3 frascos-ampola EV. Grave: 6 frascos-ampola EV; máximo total 6 no escorpionismo. Infundir em 20-60 min. Diluir em SF 0,9%/SG 5% na proporção 1:2-1:5 (PCDT admite 1:1), considerando sobrecarga hídrica. Observar ≥24 h após soroterapia e monitorar sinais vitais/hipersensibilidade. [S2] Esses limites são do escorpionismo; não transferir aos outros venenos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar reação imediata/anafilaxia e, no loxoscelismo, hemólise, hemoglobínúria e função renal. Não fazer teste cutâneo nem infiltrar no local da picada. Não atrasar soro para teste ou pré-medicação. Instabilidade exige suporte intensivo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Tratamento de envenenamento moderado ou grave por Phoneutria (armadeira) e Loxosceles (aranha-marrom). A indicação alternativa de escorpionismo acima foi acrescentada nesta revisão.

FONTES DO ESQUEMA - CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Escola de Saúde Pública do Ceará - Guia de animais peçonhentos

[S2] Ministério da Saúde - PCDT Acidentes Escorpiônicos, 2026, quadros 1/3/4

Revisão corretiva de 13/09/2026: alterações e novas referências conferidas nesta ficha.

392. Soro Antibotrópico (Pentavalente)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acidente botrópico leve Crianças e adultos	Soro antibotrópico 3 frascos-ampola EV, dose única inicial. Critério: dor/edema até um segmento, sangramento discreto/ausente, coagulopatia pode ocorrer. [S1]
Acidente botrópico moderado Crianças e adultos	6 frascos-ampola EV, dose única inicial; dor/edema de dois segmentos, sem complicações graves. [S1]
Acidente botrópico grave Crianças e adultos	12 frascos-ampola EV, dose única inicial; edema de três segmentos ou hemorragia grave, choque ou injúria renal. [S1] PCDT atual substitui antigas faixas variáveis por 3/6/12. Administrar total de uma vez, diluído em SF 0,9% ou SG 5%; ajustar volume/velocidade à tolerância pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Mesma quantidade de frascos no adulto/criança. Monitorar sangramento, coagulação, função renal, perfusão e reação ao soro; redose depende de persistência de envenenamento, não de peso.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 49)

Tratamento específico de envenenamento ofídico botrópico (*jararaca*, *jararacuçu*, *caiçara*) leve, moderado ou grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - PCDT Acidentes Ofídicos, resumido (gov.br)

393. Soro Antibotulínico AB Bivalente

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Botulismo alimentar ou de ferimentos por toxinas A/B	Soro antibotulínico AB: 1 frasco de 20 mL (7.500 UI anti-A + 5.500 UI anti-B) EV, diluído 1:10 em SF 0,9%, em 30-60 min. Dose inicial única; adicional somente por evolução avaliada por especialista. [S1]
Crianças; suspeita clínica fundamentada	Não aguardar confirmação laboratorial. Não cobre outros tipos de toxina.
Botulismo intestinal, inclusive lactente	A bula admite a mesma dose neutralizante de 1 frasco EV, mas botulismo do lactente requer avaliação de imunoglobulina humana específica e central de referência; não considerar o soro equino intercambiável ao produto humano. [S1, S2]
Crianças; decisão especializada	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Antitoxina neutraliza toxina circulante e não reverte paralisia já estabelecida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES UTI e suporte ventilatório conforme necessidade. Prever anafilaxia/doença do soro; não usar teste de sensibilidade. Conferir volume final da diluição com farmácia antes de infusão em lactente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)

Tratamento neutralizante do botulismo alimentar, de ferimentos ou intestinal causado pelas toxinas botulínicas tipos A ou B.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Butantan - Soro antibotulínico AB, bula profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] CDC - Infant botulism clinical overview (cdc.gov)

394. Soro Anticrotálico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acidente crotálico leve Crianças e adultos	Soro anticrotálico 5 frascos-ampola EV em administração única; neurotoxicidade discreta, sem mialgia, urina escura ou oligúria. [S1]
Acidente crotálico moderado Crianças e adultos	10 frascos-ampola EV em administração única; neurotoxicidade evidente, mialgia e mioglobínúria discretas. [S1]
Acidente crotálico grave Crianças e adultos	20 frascos-ampola EV em administração única; neurotoxicidade, mialgia/mioglobínúria intensas e oligúria. [S1] Diluir em SF 0,9% ou SG 5%, ajustando volume/velocidade à criança; não fracionar a dose em dias.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar ventilação, CK, K, creatinina e diurese. Dose depende de veneno/gravidade, não de peso. C. d. ruruima pode exigir avaliação do soro combinado por manifestações hemorrágicas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)

Tratamento específico do envenenamento ofídico crotálico (*cascavel*) leve, moderado ou grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - PCDT Acidentes Ofídicos (gov.br)

395. Soro Antidiftérico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Difteria respiratória/cutânea leve suspeita ou confirmada Crianças; dose não ponderal	Soro antidiftérico 20.000-40.000 UI EV em dose única, precocemente. [S1]
Difteria laringoamigdaliana ou mista Crianças	40.000-60.000 UI EV em dose única. [S1]
Difteria grave ou apresentação tardia Crianças	80.000-100.000 UI EV em dose única. [S1] Dose definida pela extensão/tempo de doença, não pelo peso. Conferir potência do frasco; antibiótico concomitante e manejo de via aérea são necessários.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES A antitoxina não neutraliza toxina já ligada ao tecido. Monitorar miocardite, neuropatia e anafilaxia; manter precauções/isolamento e notificar suspeita imediatamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)
Imunoterapia passiva no tratamento da difteria respiratória ou cutânea suspeita ou confirmada.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] SES-MG - Diretrizes para soro antidiftérico (saude.mg.gov.br)

396. Soro Antielapídico (Bivalente)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Acidente elapídico moderado por <i>Micrurus</i> Crianças e adultos	Soro antielapídico 5 frascos-ampola EV, administração única; miastenia/ptose e redução objetiva da força sem paralisia. [S1]
Acidente elapídico grave Crianças e adultos	10 frascos-ampola EV, administração única; fraqueza/paralisia, disfagia ou comprometimento respiratório. [S1]
Acidente elapídico leve: apenas manifestações locais Crianças e adultos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	PCDT atual: sem soro inicialmente; observar pelo menos 24 h e administrar se evoluir miastenia. [S1] Para soro indicado, diluir em SF 0,9% ou SG 5% na proporção 1:2 a 1:5, com volume adaptado. Não usar regra antiga de 10 frascos para todos os acidentes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ventilação não deve esperar efeito do soro. Monitorar força bulbar/respiratória e anafilaxia; dose igual para criança/adulto. Anticolinesterásico depende de espécie/resposta e não substitui soro.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)

Tratamento específico do envenenamento ofídico elapídico por serpentes do gênero **Micrurus** (coral-verdadeira).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - PCDT Acidentes Ofídicos (gov.br)

397. Soro Antiescorpiônico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Escorpionismo moderado por Tityus Crianças; dose não ponderal	3 frascos-ampola EV, imediatamente. [S2] Manifestações sistêmicas de pequena intensidade, associadas ao quadro local. Náusea/vômito isolado atribuível à dor não define, sozinho, gravidade moderada. Casos leves não recebem soro automaticamente.
Escorpionismo grave por Tityus Crianças; dose não ponderal	6 frascos-ampola EV, imediatamente. Máximo total: 6 frascos no escorpionismo. [S2] Toxicidade sistêmica intensa: vômitos repetidos, sudorese/sialorreia intensas, alterações neurológicas, insuficiência cardíaca, edema pulmonar ou choque. Se já recebeu 3 e evoluiu para grave, complementar até o total de 6.

ADMINISTRAÇÃO Diluir em SF 0,9% ou SG 5% (proporção 1:2-1:5; o PCDT admite 1:1). Infundir em 10-15 minutos, avaliando sobrecarga hídrica. Sem acesso venoso, admite-se via IO. A dose neutraliza veneno e não deve ser reduzida pelo peso. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Observar por pelo menos 24 horas após soroterapia; acompanhar PA, FC, FR, SpO₂, temperatura, perfusão e hipersensibilidade. Reclassificar se persistirem manifestações; complementação respeita o máximo total. Instabilidade exige suporte intensivo. Ter tratamento de anafilaxia disponível; não fazer teste cutâneo. [S2]

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)
Tratamento específico de envenenamento escorpiônico moderado ou grave por escorpiões do gênero Tityus.

Atualização: as faixas 2-3/4-6 frascos da bula anteriormente citada foram substituídas pelo esquema 3/6 frascos do PCDT nacional de 2026.

FONTES DO ESQUEMA - CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] Butantan - bula profissional anteriormente citada (registro histórico)
- [S2] Ministério da Saúde - PCDT Acidentes Escorpiônicos, 2026, quadros 1/3/4

398. Soro Antitetânico

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia pós-exposição em ferimento de risco, IG humana indisponível	Soro antitetânico 5.000 UI IM em dose única; se volume exigir, dividir entre duas massas musculares. Aplicar vacina indicada em outro local e completar esquema. [S1]
Crianças com indicação conforme ferida/vacinação	Dose fixa, não UI/kg. Não indicado em toda ferida limpa nem em todo vacinado; analisar histórico e imunossupressão.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Soro heterólogo exige estrutura para anafilaxia; não realizar teste cutâneo. Limpar/desbridar ferida. Não confundir 5.000 UI do soro equino com 250 UI da imunoglobulina humana profilática.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)
Profilaxia pós-exposição ao tétano em ferimentos de risco (quando a imunoglobulina humana específica estiver indisponível).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ministério da Saúde - Guia de Vigilância: tétano acidental (sjp.pr.gov.br)

399. Soro Polieletrólítico Balanceado

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Ressuscitação volêmica Crianças com choque	Cristaloide balanceado 10-20 mL/kg EV/IO por bolus; reavaliar após cada. Com UTI disponível, até 40-60 mL/kg na primeira hora quando persiste hipoperfusão sem congestão. [S1] Sem hipotensão e sem disponibilidade de UTI, evitar bolus na sepse. Volume não é meta obrigatória.
Reposição de déficits hidroeletrólíticos Crianças após avaliação de sódio, glicose e função renal RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Déficit estimado (mL)=peso (kg)×desidratação (%)×10. Repor em geral ao longo de 24 h, acrescentando perdas medidas e manutenção individualizada. [S2] Não considerar todo soro balanceado equivalente: concentração de Na/K/Ca/Mg e tampão variam. Hipernatremia ou cardiopatia exigem plano específico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar eletrólitos, glicemia, peso e congestão. Solução sem glicose não satisfaz por si só manutenção neonatal; potássio e cálcio da formulação determinam incompatibilidades.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)

Ressuscitação volêmica e reposição de déficits hidroeletrólíticos com menor risco de acidose hiperclorêmica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Surviving Sepsis Campaign - Pediatria 2026 (doi.org)

[S2] RCH - Intravenous fluids (rch.org.au)

400. Succinilcolina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intubação de emergência ou sequência rápida Lactentes e crianças pequenas	Succinilcolina 2 mg/kg EV em dose única após indução anestésica adequada. Crianças maiores/adolescentes: 1 mg/kg EV em dose única. Efeito ultracurto; redose exige reavaliação do bloqueio e risco de bradicardia. [S1] Bula não define corte etário exato entre pequena e maior; selecionar pela maturidade e resposta, sem inventar limiar de peso.
Intubação emergencial sem acesso venoso Crianças	3-4 mg/kg IM, dose única; máximo 150 mg. Início mais lento que EV. [S1] Reservar a emergência de via aérea; não é via equivalente em velocidade à EV.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Bloqueia sem sedar nem analgesiar. Risco de hipercalemia fatal em miopatia oculta; evitar em denervação, doença neuromuscular, queimadura após fase aguda e suscetibilidade à hipertermia maligna. Ventilação, ECG e ressuscitação devem estar disponíveis; deficiência de pseudocolinesterase prolonga apneia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)

Bloqueio neuromuscular despolarizante de ação ultracurta para intubação endotraqueal de emergência ou sequência rápida.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Succinylcholine chloride injection (dailymed.nlm.nih.gov)

401. Sucralfato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Úlcera gástrica ou duodenal benigna 15-17 anos	Sucralfato VO 2 g 12/12 h ou 1 g 6/6 h, por 4-6 semanas; refratária pode exigir até 12 semanas. Esquemas usuais totalizam 4 g/dia; limite de bula citado pelo formulário: 8 g/dia, apenas por decisão especializada. [S1] Fonte complementar BNFC e regime ponderal BCCH nas linhas seguintes ampliam a cobertura para crianças menores.
Profilaxia de úlcera de estresse Crianças em UTI com indicação específica; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	20 mg/kg/dose por sonda nasogástrica 6/6 h; manter apenas enquanto persistir risco de sangramento. O protocolo pediátrico não informa teto absoluto: confirmar teto local antes de prescrever a crianças de maior peso. [S2] Não administrar pela sonda nasojejunal; regime específico para profilaxia, não dose comprovada para cicatrização de gastrite.
Gastrite erosiva Crianças DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	As fontes abertas não estabeleceram um esquema pediátrico específico de sucralfato para esta indicação. Avaliar causa, sangramento e opção de supressão ácida; não reutilizar automaticamente dose profilática de UTI. [S1, S2] Indicação documental preservada; lacuna de esquema terapêutico pediátrico específico.
Úlcera gástrica/duodenal - alternativa por idade 1 mês-14 anos; off-label	VO: 1 mês-<2 anos 250 mg/dose; 2-11 anos 500 mg/dose; 12-14 anos 1 g/dose; 4-6 vezes/dia em intervalos regulares. Duração guiada por cicatrização e avaliação de gastroenterologia; fonte não fixa curso em menores de 15 anos. [S3] Administrar 1 h antes da alimentação. Não somar ao regime ponderal alternativo.
Profilaxia de úlcera de estresse - alternativa BNFC 1 mês-17 anos em UTI, quando indicada	VO: 1 mês-<2 anos 250 mg/dose; 2-11 anos 500 mg/dose; 12-14 anos 1 g/dose; 4-6 vezes/dia. 15-17 anos 1 g 6 vezes/dia, máximo 8 g/dia. Manter só durante risco. [S3] Escolher uma alternativa; não combinar com 20 mg/kg 6/6 h do protocolo Calgary.
Proteção/cicatrização de úlcera gastrointestinal - alternativa ponderal Crianças; >12 anos	15 mg/kg/dose VO 4 vezes/dia; >12 anos 1 g 4 vezes/dia. Reavaliar cicatrização e duração por gastroenterologia. [S4] Formulário reflete prática BCCH; não constitui regime específico validado para toda gastrite erosiva.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contém alumínio: cautela importante na insuficiência renal. Separar outros medicamentos enterais devido à ligação/adsorção; risco de bezoar em pacientes críticos. Não usar como proteção automática de toda criança internada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 50)
Tratamento de úlceras gástricas e duodenais, gastrites erosivas e profilaxia de úlcera de estresse.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] NHS Somerset - Ulcer healing drugs (somersetformulary.nhs.uk)
[S2] Alberta Children’s Hospital - Stress ulcer prophylaxis, 2024 (achpccg.com)
[S3] BNFC/NICE - Sucralfate (bnfc.nice.org.uk)
[S4] PubMed - formulário com prática do BC Children’s Hospital (pedmed.org)

402. Sufentanila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução da anestesia geral balanceada >1 mês	Sufentanila 0,2-0,5 mcg/kg EV em pelo menos 30 segundos, associada a hipnótico. Para cirurgia cardíaca: dose de até 1 mcg/kg na indução. [S1] Não confundir mcg com mg. Doses de indução adulta de outra faixa não se aplicam automaticamente.
Manutenção anestésica, incluindo cirurgia cardíaca >1 mês, sob ventilação controlada	Dose inicial 0,3-2 mcg/kg EV em pelo menos 30 segundos; reforços de 0,1-1 mcg/kg conforme estímulo e resposta. Em cirurgia cardíaca, máximo total 5 mcg/kg. Duração: procedimento e necessidade anestésica. [S1] Não há intervalo fixo para reforço. Em neonatos ≤1 mês, a bula não estabelece recomendação posológica confiável.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Opioide de alta potência; anestesiológista, capnografia, suporte ventilatório e antagonista disponíveis. Vigiar rigidez torácica, bradicardia, hipotensão e depressão respiratória tardia; reduzir exposição com depressores do SNC.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Analgesia opioide de alta potência na indução e manutenção da anestesia geral balanceada e cirurgia cardíaca.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Sufenta - Bula profissional, seção de posologia (bula.com.br)

403. Sugamadex

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Reversão de bloqueio moderado por rocurônio ou vecurônio ≥2 anos; peso corporal real	Sugamadex 2 mg/kg EV em dose única quando reaparecer T2 no TOF. Administrar em bolus de aproximadamente 10 segundos. [S1] Esquema regulatório dos EUA para rocurônio/vecurônio; a fonte internacional não comprova a mesma indicação no registro brasileiro.
Reversão de bloqueio profundo por rocurônio ou vecurônio ≥2 anos	4 mg/kg EV em dose única quando há 1-2 respostas na contagem pós-tetânica e nenhuma no TOF, em aproximadamente 10 segundos. [S1] Diluição pediátrica: solução 100 mg/mL pode ser diluída em SF 0,9% a 10 mg/mL. Reversão imediata com 16 mg/kg não foi estudada em pediatria nesta bula; não extrapolar.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorização quantitativa do bloqueio; manter ventilação até recuperação adequada, usualmente TOF ≥0,9. Vigiar anafilaxia e bradicardia grave. Não recomendado se ClCr <30 mL/min. Aconselhar contracepção adicional por 7 dias após uso em paciente que toma hormonal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Reversão específica do bloqueio neuromuscular induzido por rocurônio ou vecurônio (aprovado a partir de 2 anos de idade).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] [DailyMed - Sugammadex injection](https://dailymed.nlm.nih.gov) (dailymed.nlm.nih.gov)

404. Sulfadiazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Toxoplasmose congênita	Sulfadiazina 50 mg/kg/dose VO 12/12 h, durante 12 meses; associar pirimetamina e ácido folínico. [S1, S2]
Lactentes, incluindo recém-nascidos afetados	Dose em sulfadiazina, não no total da combinação. Monitorização pediátrica especializada durante todo tratamento.
Toxoplasmose adquirida: SNC, ocular ou sistêmica com indicação de tratamento	25-50 mg/kg/dose VO 6/6 h, por pelo menos 6 semanas; associar pirimetamina e ácido folínico. NIH informa teto de 1-1,5 g/dose, selecionado pela gravidade/peso sob infectologia. Extender se resposta clínica/radiológica incompleta. [S2]
Crianças, especialmente com HIV	Linfadenopatia isolada em imunocompetente não exige automaticamente este regime; imunossupressão pode exigir manutenção após indução.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hidratação, hemograma, função renal/hepática e sinais de reação cutânea grave. Risco de cristalúria e hemólise em deficiência G6PD; ajustar disfunção renal. Uso neonatal congênito é indicação especializada, não permissão geral para sulfonamidas no recém-nascido.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Tratamento da toxoplasmose congênita e adquirida, em associação com pirimetamina e ácido folínico.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SES-RS - Toxoplasmose congênita (saude.rs.gov.br)

[S2] NIH - Toxoplasmosis, Pediatric OIs (clinicalinfo.hiv.gov)

405. Sulfadiazina de Prata

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção/tratamento de infecção em queimaduras de 2º/3º graus e úlceras cutâneas	Sulfadiazina de prata creme 1%: aplicar camada fina cobrindo a lesão limpa, uma vez/dia; em lesão muito exsudativa pode ser necessário duas vezes/dia. Reaplicar no curativo e manter até cicatrização ou decisão da equipe de feridas. [S1]
≥2 meses	Não há dose fixa em mg/kg: quantidade depende da área tratada. Não estender automaticamente por semanas sem avaliar evolução e necessidade de desbridamento.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar <2 meses e proximidade do parto pelo risco de kernicterus. Em áreas extensas há absorção sistêmica: monitorar hemograma e função renal/hepática. Cautela em deficiência G6PD e alergia a sulfonamidas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Prevenção e tratamento tópico de infecções em queimaduras de 2º e 3º graus e úlceras cutâneas (a partir de 2 meses).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cristália - Dermazine, bula profissional (cristalia.com.br)

406. Sulfametoxazol + Trimetoprima (Co-Trimoxazol)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Pneumonia por Pneumocystis jirovecii - tratamento Crianças; dose calculada pelo componente trimetoprima (TMP) RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	TMP 15-20 mg/kg/dia EV ou VO, divididos 6/6-8/8 h, por 21 dias; iniciar EV na doença grave e converter à VO após melhora/absorção adequada. Depois instituir profilaxia secundária se indicada. [S1] Não usar 15-20 mg/kg por DOSE. Teto absoluto de tratamento não é especificado na tabela NIH; individualizar no adolescente de grande peso.
Pneumocystis - profilaxia primária/secundária Crianças com HIV ou imunossupressão; critérios específicos	TMP 5-10 mg/kg/dia VO: dividir 12/12 h em 3 dias/semana, consecutivos ou alternados; alternativa mesma dose diária em tomada única todos os dias. Máximo NIH 160 mg por tomada. Em oncologia, 2 dias/semana em 2 tomadas/dia também foram estudados. Manter durante risco ou até recuperação imune que permita suspender. [S1] Em HIV, iniciar no lactente elegível com 4-6 semanas; não suspender antes de 1 ano somente porque CD 4 recuperou.
Pneumocystis - alternativas do protocolo ChAMP ≥4 semanas; off-label nas idades abaixo da bula brasileira	Oncologia: TMP 2,5 mg/kg/dose (máx. 160 mg) VO 12/12 h em 3 dias consecutivos/semana, ou 75 mg/m²/dose (máx. 160 mg) no mesmo intervalo. Não oncologia: 5 mg/kg (máx. 320 mg) VO uma vez/dia em 3 dias/semana. [S2] Tetos diferentes refletem protocolos distintos; escolher um regime completo. Não somar cálculo por kg e m².
Infecção urinária: cistite e pielonefrite não grave Cistite ≥4 semanas; pielonefrite ≥3 meses, estável	TMP 4 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 160 mg/dose. Cistite afebril: 3 dias; pielonefrite não grave: 7-10 dias. [S3] Cultura e susceptibilidade orientam escolha. <3 meses com febre ou doença sistêmica exige esquema parenteral inicial adequado, não este curso de cistite.
Infecção comunitária por MRSA de pele/tecidos moles ≥4 semanas; suscetibilidade demonstrada	TMP 4 mg/kg/dose VO 12/12 h, máximo 160 mg/dose. Abscesso recorrente drenado com indicação de antibiótico: 5-10 dias. Doença invasiva não recebe automaticamente este regime oral curto. [S2, S4] Drenagem e cobertura de estreptococo, quando necessária, são avaliadas separadamente.
Isosporíase/cistoisoporíase - tratamento Crianças com HIV	TMP 5 mg/kg/dose VO 12/12 h (máx. 160 mg/dose), por 10 dias. Se persistente: mesma dose 3-4 vezes/dia e/ou prolongar por 3-4 semanas sob infectologia. [S5]
Isosporíase - prevenção secundária Crianças com imunossupressão persistente	TMP 2,5 mg/kg/dose VO 12/12 h (máx. 80 mg/dose), em 3 dias da semana; manter enquanto houver risco de recidiva. [S5]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Todas as doses expressam TMP; SMX acompanha na proporção 5:1. EV: infundir em 60-90 min após diluição compatível, nunca bolus. Monitorar K, creatinina, hemograma e pele; ajustar rim. Sulfonamida em <2 meses requer indicação especializada. Evitar associação inadvertida com metotrexato em alta dose.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)
Tratamento e profilaxia da pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, infecções urinárias, infecções por MRSA comunitário e isosporíase.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] NIH - Pneumocystis pediatric OIs, dezembro 2025 (clinicalinfo.hiv.gov)
[S2] Perth Children’s Hospital - Co-trimoxazole (pch.health.wa.gov.au)
[S3] PCH - Urinary tract infection, 2026 (pch.health.wa.gov.au)
[S4] IDSA - Skin and soft tissue infections (idsociety.org)
[S5] NIH - Isosporiasis pediatric OIs (clinicalinfo.hiv.gov)

407. Sulfassalazina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Retocolite ulcerativa ≥6 anos, bula Azulfín consultada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Sulfassalazina VO 40-60 mg/kg/dia, divididos em 3-6 tomadas para fase ativa; manutenção 30 mg/kg/dia em 4 tomadas. Duração contínua conforme remissão e acompanhamento. [S1] A bula não informa teto pediátrico absoluto específico para colite; não usar a faixa ponderal sem validar dose máxima no adolescente de grande peso. Não triturar revestimento gastrorresistente.
Artrite idiopática juvenil ≥6 anos	30-50 mg/kg/dia VO em 2 tomadas, máximo 2 g/dia. Iniciar com ¼-½ da dose alvo e aumentar semanalmente até alvo em cerca de 1 mês. Tratamento contínuo; resposta não é imediata. [S1] A bula aberta inclui indicação pediátrica; corrige anotação do documento original que classificava todo uso como adulto/off-label.
Doença de Crohn Crianças/adolescentes RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Consenso GEDIIB não recomenda 5-ASA/sulfassalazina para induzir remissão em Crohn pediátrico ativo de baixo ou médio risco. Não há esquema recomendado para reproduzir aqui como tratamento de rotina. [S2] Preserva a indicação original sem transferir a posologia de retocolite para Crohn.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, enzimas hepáticas, função renal e folato; suspender se exantema grave, febre, odinofagia ou citopenia. Cautela com sulfonamidas/salicilatos e G6PD.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Retocolite ulcerativa e doença de Crohn (uso adulto na bula; AIJ e DII pediátrica off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Apsen - Azulfín, bula hospedada (devstatic.visaogrupos.com.br)

[S2] GEDIIB - Consenso brasileiro de DII pediátrica 2023 (gediib.org.br)

408. Sulfato de Magnésio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipomagnesemia grave/sintomática Crianças	Sulfato de magnésio 25-50 mg/kg/dose EV, máximo 2 g/dose, usualmente em 2-4 h. Repetição pode ser necessária a cada 4-6 h, guiada por magnésio, sintomas e função renal. Alternativa RCH expressa Mg: 0,1-0,2 mmol/kg, podendo chegar a 0,4 mmol/kg (máx. 8 mmol), em 2-4 h. [S1, S2] mg referem-se ao sal MgSO ₄ hepta-hidratado; mmol ao íon Mg. Não somar as duas formas de expressar reposição. 1 mmol de Mg corresponde a aproximadamente 246,5 mg de MgSO ₄ hepta-hidratado; a massa do sal não equivale ao magnésio elementar.
Asma grave refratária Crianças; off-label	25-50 mg/kg de MgSO ₄ EV, máximo 2 g, dose única; esquema BCEHS 50 mg/kg em 15 min. Reavaliar após infusão. [S1, S3] Adjuvante após broncodilatadores/corticosteroide; não substitui suporte ventilatório.
Torsades de pointes Crianças; off-label	50 mg/kg de MgSO ₄ EV/IO, máximo 2 g. Com pulso: infundir em 15 min; parada cardíaca: administrar em 1-2 min durante ressuscitação. [S3] Não atrasar desfibrilação quando indicada; corrigir K e retirar agentes que prolongam QT.
Eclâmpsia - esquema Zuspan Gestantes/adolescentes gestantes	4 g de MgSO ₄ EV em 15-20 min; depois 1 g/h, podendo aumentar para 2 g/h se sintomas persistirem. Manter 24 h após parto ou última convulsão, o que ocorrer por último. Carga: 8 mL a 50% + 12 mL de SF 0,9% = 20 mL finais. Manutenção: 10 mL a 50% + 490 mL de SF = 10 mg/mL; 100 mL/h fornece 1 g/h. Para 2 g/h: 20 mL a 50% + 480 mL de SF = 20 mg/mL; 100 mL/h. [S4] Dose materna. Contabilizar volume total: ajustar concentração pela farmácia se houver restrição hídrica, mantendo a dose prescrita.
Eclâmpsia - alternativa Pritchard Gestantes/adolescentes gestantes	4 g EV em 15-20 min + 10 g IM (5 g/nádega); depois 5 g IM profunda a cada 4 h. Manter 24 h após parto/última convulsão. [S4] Escolher Zuspan OU Pritchard; não acumular manutenções.
Neuroproteção fetal no parto prematuro iminente Administrado à gestante; idade gestacional de 24 a 32 semanas	4 g MgSO ₄ EV em 20 min; depois 1 g/h EV até o parto, com reavaliação obstétrica se parto deixa de ser iminente. [S5] Protocolo DF; não significa dose ao feto/neonato. Evitar prolongamento indefinido se não houver parto iminente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar reflexos, FR, PA, ECG, diurese e Mg. No regime obstétrico: reflexo patelar presente, FR ≥16/min e diurese ≥25 mL/h; alteração exige suspender/reduzir e investigar toxicidade. Creatinina materna ≥1 mg/dL: reduzir manutenção à metade. Cálcio EV disponível para toxicidade. Solução 50% = 500 mg/mL; 10% = 100 mg/mL. Esses limiares maternos não são metas neonatais.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)
Tratamento de hipomagnesemia grave e crises de eclampsia; asma grave refratária e *torsades de pointes* (off-label); neuroproteção fetal (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] IWK - Pediatric Drug Dosing Guidelines (dir.iwk.nshealth.ca)
[S2] RCH - Hypomagnesaemia (rch.org.au)
[S3] BCEHS - Magnesium sulfate (handbook.bcehs.ca)
[S4] RBEHG - Pré-eclâmpsia, protocolo 2023 (cofen.gov.br)
[S5] SES-DF - Rotura prematura de membranas (saude.df.gov.br)

409. Zinco (Sulfato)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diarreia aquosa aguda ou persistente - recomendação OMS 2024 Crianças ≤10 anos	Zinco ELEMENTAR 5 mg VO uma vez/dia por até 14 dias, associado à reidratação e alimentação. [S1] Recomendação condicional, certeza baixa para a dose; atualização difere do material brasileiro tradicional.
Diarreia - esquema do Ministério da Saúde brasileiro Crianças, especialmente menores de 5 anos	<6 meses: zinco elementar 10 mg VO uma vez/dia; ≥6 meses: 20 mg uma vez/dia; manter 10-14 dias. [S2] Escolher a diretriz adotada no serviço; não somar aos 5 mg/dia da OMS.
Prevenção/reposição neonatal em grupos de risco Prematuros e neonatos selecionados	Zinco elementar 2-3 mg/kg/dia VO; doses até 6 mg/kg/dia apenas em deficiência/necessidade especial sob neonatologia. Prematuros <32 semanas ou <1.800 g: iniciar após 7 dias quando tolerarem ≥50% da oferta enteral, mantendo até alta ou 3-6 meses conforme risco. [S3] Considerar zinco da dieta/fortificantes; não aplicar dose de prematuro a toda criança saudável.
Correção de deficiência adquirida; acrodermatite enteropática Crianças com diagnóstico definido RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Deficiência adquirida/transitória: 0,5-1 mg/kg/dia de zinco elementar VO, com reavaliação clínica/laboratorial; casos relacionados à lactação podem necessitar 3-4 meses ou até desmame. Acrodermatite enteropática hereditária: 1-3 mg/kg/dia VO, tratamento contínuo. [S4] Evidência de deficiência adquirida inclui relato clínico e revisão; duração depende da causa e da recuperação, não curso universal.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Expressar sempre zinco elementar; massa do sulfato varia com hidratação e apresentação. Doses elevadas prolongadas podem causar deficiência de cobre; monitorar Zn/Cu e hemograma. Separar de tetraciclina/quinolonas e ferro quando interação reduzir absorção.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Tratamento adjuvante da diarreia aguda e persistente em pediatria; prevenção e correção de deficiência nutricional.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] OMS - Pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years,2024 (iris.who.int)

[S2] Ministério da Saúde - Manejo do paciente com diarreia (bvsmms.saude.gov.br)

[S3] ANMF - Zinc,2024 (anmfonline.org)

[S4] Transient symptomatic zinc deficiency in an infant - relato/revisão 2024 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

410. Sulfato Ferroso

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia na infância: termo saudável com peso adequado 6-24 meses	Ferro ELEMENTAR 10-12,5 mg VO uma vez/dia, em dois ciclos de 3 meses, iniciados preferencialmente aos 6 e 12 meses; pausa de 3 meses entre ciclos. [S1, S2] SBP 2026/MS 2025: substituir regra indiscriminada de dose ponderal diária para todo lactente saudável.
Profilaxia em prematuro/baixo peso Desde 30 dias; dose diária pelo peso atual	Peso ao nascer de 1.500 a 2.500 g: 2 mg/kg/dia; 1.000-<1.500 g: 3 mg/kg/dia; <1.000 g: 4 mg/kg/dia de ferro elementar VO, até 1 ano. Depois, dos 12 aos 24 meses: 1 mg/kg/dia continuamente. [S1] Tabela SBP sobrepõe o ponto 1.500 g; aqui foi alocado à faixa ≥1.500 g para evitar dupla dose. Considerar aporte da fórmula, transfusões e estoque.
Deficiência de ferro e anemia ferropriva infantil Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ferro elementar 3-6 mg/kg/dia VO, em dose única ou fracionada, por 3-6 meses ou até normalizar hemoglobina e repor estoques. Hemograma em 30-45 dias. Desnutrição grave: iniciar 3 mg/kg/dia na reabilitação. [S1] Corrigir causa; não aumentar indefinidamente se ausência de resposta. A fonte não define teto absoluto pediátrico único.
Profilaxia na gestação e pós-parto Gestantes, inclusive adolescentes	Ferro elementar 40 mg VO uma vez/dia desde confirmação da gravidez até o parto; continuar 40 mg/dia por 3 meses após parto ou aborto. [S2] Dose de prevenção; anemia estabelecida exige esquema terapêutico. Avaliar ácido fólico separadamente.
Tratamento da anemia ferropriva na gestação Gestantes, inclusive adolescentes; deficiência comprovada	Ferro elementar 60-200 mg/dia VO, associado a ácido fólico 400 mcg/dia; escolher menor dose tolerada que produza resposta. Manter até corrigir anemia e estoques, frequentemente por meses, com hemograma de acompanhamento. [S3] PCDT brasileiro consultado; anemia grave, intolerância/falha oral ou necessidade rápida pode exigir alternativa EV sob obstetrícia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Todas as doses são de ferro elementar, não sulfato ferroso. Evitar duplicidade com polivitamínico/fortificação. Guardar fora do alcance: superdose pode ser fatal. Náusea/constipação afetam adesão; investigar sangramento, inflamação e má absorção se resposta insuficiente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 51)

Prevenção e tratamento da deficiência de ferro e anemia ferropriva na infância e gestação.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] SBP - Deficiência de ferro e anemia ferropriva, 2026 (sbp.com.br)

[S2] Ministério da Saúde - Micronutrientes, 2ª edição 2025 (bvsms.saude.gov.br)

[S3] Ministério da Saúde - PCDT anemia por deficiência de ferro (gov.br)

411. Tacrolimo

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção da rejeição: transplante hepático	Início VO 0,15-0,20 mg/kg/dia, dividido 12/12 h; se VO inviável, EV 0,03-0,05 mg/kg/dia em infusão contínua. Ajustar por nível de vale e resposta. Tratamento contínuo. [S1]
Crianças; tacrolimo de liberação imediata	Não converter formulações de liberação prolongada mg por mg por conta própria.
Prevenção da rejeição: transplante renal ou cardíaco	Renal: iniciar 0,3 mg/kg/dia VO em 2 tomadas. Cardíaco: 0,3 mg/kg/dia em 2 tomadas; com indução por anticorpos, 0,1 mg/kg/dia em 2 tomadas. Titular pela concentração de vale, função do enxerto e toxicidade. [S1]
Crianças	Bula usa faixa ampla de vale 5-20 ng/mL nos primeiros 12 meses; alvo exato depende de órgão, tempo, associação e centro. Não é teto de dose em mg/kg.
Dermatite atópica moderada/grave - crise	2-15 anos: pomada 0,03% em camada fina 2 vezes/dia. ≥16 anos: 0,03% ou 0,1% 2 vezes/dia. Suspender quando resolvida; reavaliar se não melhorar em 6 semanas. [S2, S3]
≥2 anos; uso tópico	EMA apresenta alternativa infantil: 2 vezes/dia até 3 semanas, depois 1 vez/dia até controle. Não aplicar em mucosa ou sob oclusão.
Dermatite atópica - manutenção preventiva	Após controle, aplicar concentração permitida pela idade uma vez/dia em 2 dias da semana nas áreas habitualmente afetadas; manter intervalos sem aplicação. Reavaliar em 12 meses, incluindo interrupção na criança para verificar necessidade. [S3]
≥2 anos, crises frequentes e resposta inicial	Estratégia proativa EMA para quem tem ≥4 exacerbações/ano; recidiva volta temporariamente ao esquema de crise.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Sistêmico: monitorar vale, creatinina, K, glicemia, PA e neurotoxicidade; interações CYP 3A4 são relevantes e toranja deve ser evitada. EV exige diluição segundo apresentação e vigilância de anafilaxia. Tópico: limitar exposição solar, não usar sobre infecção não controlada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Prevenção da rejeição de transplantes de órgãos sólidos (sistêmico); dermatite atópica moderada a grave (pomada 0,03% a partir de 2 anos; 0,1% a partir de 16 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Prograf (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] DailyMed - Tacrolimus ointment (dailymed.nlm.nih.gov)

[S3] EMA - Protopic (ema.europa.eu)

412. Tadalafila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Disfunção erétil Indicação adulta masculina do documento original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não existe indicação nem posologia pediátrica estabelecida para esta finalidade na bula consultada. Não aplicar doses adultas a crianças. [S1]
Hiperplasia prostática benigna Indicação adulta RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico estabelecido. A doença/indicação é adulta; manter a ficha como restrição documental, sem prescrição em mg/kg. [S1] Doses usadas em hipertensão pulmonar pertencem a outra indicação e não justificam tratar estas condições pediátricas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não combinar com nitratos ou riociguat; hipotensão pode ser grave. Esta ficha não estabelece esquema para hipertensão arterial pulmonar.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento da disfunção erétil e hiperplasia prostática benigna (uso adulto masculino).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - Cialis (dailymed.nlm.nih.gov)

413. Teicoplanina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções graves por Gram-positivos/MRSA: sepse, osteomielite e endocardite Neonatos e lactentes <2 meses	16 mg/kg EV no primeiro dia; depois 8 mg/kg EV uma vez/dia, em 30 min. Ajustar por função renal e níveis séricos; duração pelo foco e resposta. [S1] Neonatos: somente infusão, não bolus.
Infecções graves por Gram-positivos/MRSA: sepse, osteomielite e endocardite 2 meses-12 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ataque: 10 mg/kg/dose EV a cada 12 h por 3 doses; depois 6-10 mg/kg uma vez/dia, em 30 min. Infecção grave: extremidade superior, com níveis séricos. [S1] Bula sem teto pediátrico absoluto; duração pelo foco e resposta.
Endocardite e infecção osteoarticular >12 anos	12 mg/kg/dose EV a cada 12 h por 3-5 doses; depois 12 mg/kg EV/IM uma vez/dia. Infusão EV em 30 min. Endocardite: mínimo 21 dias na bula; agente/válvula podem exigir mais. [S1] A bula limita tratamento a 4 meses; não é duração obrigatória.
Colite por C. difficile >12 anos; opção de bula, uso restrito RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	100-200 mg VO a cada 12 h por 7-14 dias. Dose oral em ≤12 anos não estabelecida nas fontes. [S1, S2] NICE não recomenda uso habitual pela evidência insuficiente. Preparo oral exige farmácia; EV não substitui tratamento luminal.
Sepse/bacteremia associada a foco cutâneo, pulmonar ou urinário por Gram-positivo suscetível >12 anos	6 mg/kg/dose EV a cada 12 h por 3 doses; depois 6 mg/kg uma vez/dia, em 30 min. Ajustar gravidade/níveis séricos; duração pelo foco e resposta. [S1] Foco ósseo ou endocárdico: utilizar regime correspondente, sem somar doses.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar creatinina, hemograma, audição quando risco e níveis de vale; metas dependem do ensaio e foco. Ajustar manutenção na disfunção renal, sem omitir carga automaticamente. Não administrar intraventricular. Gram-negativos não são cobertos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Infecções graves por bactérias Gram-positivas sensíveis (MRSA, endocardite, sepse, osteomielite); colite por *C. difficile* (via oral).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] eMC - Teicoplanin, SmPC (medicines.org.uk)

[S2] NICE - C. difficile antimicrobial prescribing (nice.org.uk)

414. Tenecteplase

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infarto agudo com supra de ST Uso adulto na indicação original RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Tenecteplase não possui esquema pediátrico estabelecido nesta bula. IAM pediátrico exige etiologia e estratégia de reperfusão individualizadas por cardiologia; não aplicar as faixas fixas adultas de peso a crianças. [S1]
AVC isquêmico agudo elegível Uso adulto; bula TNKase 2025 RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há posologia pediátrica estabelecida para tenecteplase. Uso excepcional off-label não pode ser convertido em esquema rotineiro sem equipe de AVC pediátrico e critérios especializados. [S1] Não confundir dose do IAM com dose do AVC nem transpor automaticamente 0,25 mg/kg do protocolo adulto.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Trombolítico com risco de hemorragia intracraniana; exige avaliação de contraindicações e tempo de sintomas. Esta ficha não autoriza trombólise pediátrica empírica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Trombolítico no infarto agudo do miocárdio com supra de ST e no AVC isquêmico agudo elegível (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] DailyMed - TNKase, bula 2025 (dailymed.nlm.nih.gov)

415. Teofilina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção do broncoespasmo na asma de difícil controle	Teofilina VO: manutenção total de 11-13 mg/kg/dia, calculada pelo peso corporal ideal; distribuir em tomadas regulares ao longo de 24 h. Ajustar pela resposta e teofilinemia, alvo regulatório 8-20 mcg/mL. Tratamento contínuo, com reavaliação de benefício/toxicidade. [S1]
≥16 anos na formulação Teolong RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A bula desta formulação não fixa número único de tomadas; liberação total descrita de 5 h não autoriza presumir intervalo de 12 ou 24 h. Prescrição deve definir frequência conforme formulação dispensada e nível sérico.
Manutenção da asma - alternativa ER com intervalo validado	Formulação ER 12 h: iniciar 300 mg/dia VO em 2 tomadas; após 3 dias, se tolerado, 400 mg/dia; após outros 3 dias, 600 mg/dia em 2 tomadas. Acima disso, somente por teofilinemia. Se depuração reduzida ou níveis indisponíveis, não exceder 400 mg/dia. [S2]
≥16 anos, sem fatores de redução de depuração	Esta titulação pertence ao comprimido ER da fonte, não automaticamente ao Teolong. Metabolizador rápido pode exigir fracionar total 8/8 h sob TDM. Manter continuamente só se benefício justificar risco.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Janela terapêutica estreita: náuseas, arritmia e convulsões podem indicar toxicidade. Febre persistente, infecção viral, disfunção hepática/cardíaca e interações reduzem depuração. Não usar para resgate da crise nem combinar com aminofilina sem contabilizar equivalência/exposição.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento de manutenção do broncoespasmo na asma de difícil controle (uso oral restrito a maiores de 16 anos na forma de liberação prolongada).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Abbott - Teolong, bula profissional (dam.abbott.com)

[S2] DailyMed - Theophylline extended-release 12 h (dailymed.nlm.nih.gov)

416. Terbinafina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Onicomicose ≥12 meses e ≥10 kg	VO a cada 24 h: 10-<20 kg: 62,5 mg; 20-<40 kg: 125 mg; ≥40 kg: 250 mg. Manter até resposta clínica; reavaliar obrigatoriamente aos 3 meses. Crescimento de unha sadia pode levar 9-12 meses. [S1] Uso pediátrico oral off-label em bulas brasileiras; confirmar micologia antes de tratamento prolongado.
Dermatomicoses superficiais extensas ≥12 meses e ≥10 kg	VO nas mesmas faixas: 62,5 /125 /250 mg a cada 24 h. Pele: 2 semanas; áreas pilosas/hiperqueratóticas podem exigir extensão. Tinea capitis: 4-6 semanas. [S1]
Dermatomicoses superficiais - tratamento tópico ≥12 meses na referência hospitalar	Creme 1% em camada fina 1-2 vezes/dia: tinea pedis 2-6 semanas; corporis 4 semanas; cruris 2-4 semanas. [S1] Não aplicar creme em unhas/couro cabeludo como substituto do tratamento sistêmico quando este é indicado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicada por via oral em hepatopatia ativa/crônica; verificar transaminases e sinais de hepatotoxicidade. Evitar extrapolar a dose para <10 kg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento de onicomicoses e dermatomicoses superficiais extensas (creme tópico e comprimidos orais).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Perth Children's Hospital - Terbinafine (pch.health.wa.gov.au)

417. Terbutalina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Broncoespasmo agudo grave/crise asmática refratária - resgate	10 mcg/kg/dose (=0,01 mg/kg/dose) SC OU EV em 5 min; máximo 250 mcg/dose. Repetir a cada 15-30 min conforme resposta, máximo 3 doses. [S1]
Crianças, emergência monitorizada	
Crise asmática refratária - infusão contínua	CHOP: ataque EV 10 mcg/kg, máximo 400 mcg; iniciar 0,4 mcg/kg/min, titular até 3 mcg/kg/min. Alternativa institucional Children's Mercy: ataque 10 mcg/kg, infusão 0,1-10 mcg/kg/min. Manter somente até controle do broncoespasmo, com desmame pela resposta. [S1, S2]
UTI pediátrica	
	A faixa até 10 mcg/kg/min é de UTI e não teto universal; não combinar limites de protocolos distintos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG e pressão contínuos; monitorar potássio, glicose, lactato e isquemia. Converter bomba: mL/h = mcg/kg/min × peso × 60 ÷ concentração final em mcg/mL; preparo padronizado pela farmácia.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento de resgate do broncoespasmo agudo grave e crise asmática refratária.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHOP - crise asmática (chop.edu)

[S2] 14. Asthma Management in the PICU (childrensmercy.org)

418. Terlipressina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemorragia digestiva por varizes esofágicas; síndrome hepatorenal tipo 1	Não existe esquema pediátrico padronizado na bula consultada. As indicações originais são adultas; não converter esquemas adultos em mg/kg. [S1, S2]
População pediátrica	APASL 2025 confirma ausência de dose/segurança pediátrica estabelecida para sangramento varicoso; não é apenas ausência de bula. Relatos não definem faixa universal.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de insuficiência respiratória e isquemia; a quantidade pode ser expressa como terlipressina base ou acetato, que não são numericamente idênticos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)
Tratamento de hemorragia digestiva por varizes esofágicas e síndrome hepatorenal tipo 1 (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FDA/Daily Med - Terlipressin (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] APASL 2025 - sangramento varicoso pediátrico (doi.org)

419. Tetraciclina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções por agentes sensíveis >8 anos	25-50 mg/kg/dia VO, divididos em 4 doses a cada 6 h (=6,25-12,5 mg/kg/dose). Não ultrapassar 2 g/dia. Continuar por pelo menos 24-48 h após resolução dos sintomas/febre; duração adicional exige identificar o foco e o agente. [S1] “Infecções por agentes sensíveis” não identifica síndrome suficiente para estabelecer uma duração única.
Acne vulgar Adolescentes >8 anos; bula original assinala uso adulto RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A bula consultada descreve 1 g/dia VO dividido em 2-4 tomadas inicialmente; após melhora, 125-500 mg/dia. Não é um esquema ponderal pediátrico validado e não deve ser aplicado automaticamente a crianças. [S1] Preferir terapias de acne com dose adolescente especificamente estabelecida; duração reavaliada por dermatologia.
Infecções oculares superficiais - conjuntivite bacteriana Crianças	Pomada oftálmica 1%: aplicar nos dois olhos 2 vezes/dia por 7 dias. Traçar pequena quantidade no saco conjuntival inferior, sem tocar o olho. [S2] Não usar pomada dermatológica; conjuntivite neonatal instalada exige antibiótico sistêmico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Via oral contraindicada <8 anos por alterações dentárias/ósseas; separar de ferro, cálcio e antiácidos. Ajustar na insuficiência renal e evitar hepatopatia importante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento de infecções por agentes sensíveis, acne vulgar (uso adulto na bula); pomada oftálmica para infecções oculares.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Tetracycline (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] MSF - tetraciclina oftálmica (medicalguidelines.msf.org)

420. Tiabendazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Larva migrans cutânea	Tiabendazol creme 5%: aplicar camada na lesão e adjacências 2-3 vezes/dia por 3-5 dias. [S1]
Uso tópico pediátrico	Formas extensas ou múltiplas podem necessitar tratamento sistêmico com outro agente.
Micoses superficiais selecionadas/dermatomicoses	Creme 5%: friccionar suavemente nas áreas afetadas 2 vezes/dia até desaparecimento das lesões; se persistência, reavaliar diagnóstico micológico. [S1]
Uso tópico pediátrico	A bula não define duração fixa nem máximo em gramas/área pediátrica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Somente pele; não usar nos olhos/mucosas. Irritação ou sensibilização exigem suspensão.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 52)

Tratamento tópico de larva migrans cutânea e micoses superficiais selecionadas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FOLDAN (tiabendazol) (uploads.consultaremedios.com.br)

421. Tiamazol (Metimazol)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipertireoidismo/doença de Graves; preparo para tireoidectomia	Inicial: 0,4 mg/kg/dia VO dividido em 3 tomadas a cada 8 h. Após controle bioquímico, manutenção aproximada de 0,2 mg/kg/dia, ajustada a T4 livre/T3. Tratamento contínuo; no preparo cirúrgico, manter até eutireoidismo e cirurgia. [S1]
Crianças e adolescentes	A bula não fixa máximo absoluto pediátrico nem duração única para remissão; não adotar o máximo adulto como teto infantil.
Graves - alternativa de titulação em dose diária única	Tiamazol 0,15-0,3 mg/kg VO a cada 24 h; doença grave: até 0,5 mg/kg/dia. Após 4-6 semanas e controle de T4/T3, reduzir 25-50% conforme exames. Manter ≥3 anos; considerar ≥5 anos se baixa probabilidade de remissão; retirar somente com anticorpos TSHR baixos por meses. [S2]
Crianças/adolescentes	Dose alta persistente ≥1 mg/kg/dia é sinal para discutir terapia definitiva, não teto recomendado. No preparo cirúrgico, manter até eutireoidismo/cirurgia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma/transaminases basais; febre ou odinofagia: suspender e dosar neutrófilos imediatamente. Evitar no primeiro trimestre da gestação; controlar T4 livre, pois TSH pode permanecer suprimido.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Tratamento do hipertireoidismo e preparo para tireoidectomia (doença de Graves).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Methimazole (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] ETA 2022 - Graves pediátrico (doi.org)

422. Tiamina (Vitamina B1)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência leve/crônica de tiamina Crianças	10-25 mg VO a cada 24 h, até recuperação e correção do aporte alimentar; reavaliar após algumas semanas. [S2]
Beribéri infantil agudo Lactentes	25 mg EV lentamente em 30 min; depois 25 mg IM 1-2 vezes/dia. Assim que melhorar, 10 mg VO a cada 24 h até recuperação completa, usual 3-4 semanas. [S1, S2]
Beribéri infantil cardiopulmonar grave - alternativa estudada Lactentes em UTI; estudo observacional RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	100 mg EV diluídos em 10 mL de SF 0,9%, infundidos em 1 h, a cada 24 h por 3 dias. Reavaliar lactato, perfusão e função cardíaca; depois reposição oral individualizada. [S4] Regime específico de estudo de hipertensão pulmonar responsiva à tiamina, não teto seguro universal.
Prevenção da deficiência na realimentação Crianças de alto risco	2 mg/kg VO/enteral a cada 24 h, máximo 100-200 mg/dia conforme risco, antes de iniciar alimentação/SG. Manter 5-7 dias ou mais se deficiência/desnutrição persistente. Se via enteral inviável, usar EV com mesmo objetivo. [S3] BAPEN também publica esquema EV por idade: <6 anos 100 mg/dia; 6-<10 anos 150 mg/dia; ≥10 anos 200-300 mg/dia por 3 dias, até 5 em alto risco. Não somar os esquemas.
Encefalopatia de Wernicke Crianças/adolescentes - emergência, off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há esquema pediátrico universal validado. Relato em criança de 13 anos: 100 mg EV/dia por 5 dias foi insuficiente; houve melhora após 500 mg EV a cada 8 h (1.500 mg/dia), com curso parenteral prolongado ≈20 dias. Dose/duração precisam ser individualizadas imediatamente por neurologia. [S5] Regime de relato clínico não é prescrição universal nem faixa máxima de segurança; não substituir tratamento agudo EV por dose preventiva.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Administrar EV lentamente e monitorar anafilaxia/pressão. Corrigir magnésio. Oferecer tiamina antes/junto a carboidratos em risco, sem atrasar correção de hipoglicemia. Selecionar apresentação sem álcool benzílico para neonatos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Tratamento e prevenção da deficiência de tiamina, beribéri e encefalopatia de Wernicke.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] MSF - Tiamina injetável (medicalguidelines.msf.org)

[S2] MSF - Tiamina oral (medicalguidelines.msf.org)

[S3] BAPEN/ASPEN - realimentação pediátrica (bapen.org.uk)

[S4] Estudo primário - beribéri cardiopulmonar infantil (doi.org)

[S5] Relato primário - Wernicke pediátrico (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

423. Ticagrelor

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção trombotica aterosclerótica na síndrome coronariana aguda; pós-AVC isquêmico	Sem dose pediátrica estabelecida para estas indicações adultas. Não fornecer ataque/manutenção adulto como prescrição pediátrica. [S1]
<18 anos	Segurança/eficácia pediátrica não estabelecidas; estudo em doença falciforme não demonstrou eficácia.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de hemorragia; contraindicado em sangramento ativo e antecedente de hemorragia intracraniana.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)
Prevenção de eventos tromboticos ateroscleróticos na síndrome coronariana aguda e pós-AVC isquêmico (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Ticagrelor (dailymed.nlm.nih.gov)

424. Tigeciclina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecções intra-abdominais complicadas; infecções complicadas de partes moles por organismos suscetíveis multirresistentes	8-11 anos: 1,2 mg/kg/dose EV a cada 12 h, máximo 50 mg/dose. 12-17 anos: 50 mg EV a cada 12 h. Infundir em 30-60 minutos. Duração referencial 5-14 dias, ajustada a foco, drenagem e resposta; não acrescentar automaticamente ataque adulto. [S1] Uso excepcional quando alternativas não são adequadas; os regimes pediátricos foram propostos por farmacocinética, sem comprovação equivalente de eficácia. Não indicada <8 anos.
8-11 anos; 12-17 anos	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Mortalidade maior em estudos adultos; evitar para bacteremia isolada e pneumonia hospitalar. Monitorar fibrinogênio/coagulação, função hepática e pancreatite; não cobre Pseudomonas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)
Infecções intra-abdominais e de partes moles complicadas por microrganismos multirresistentes em adultos (uso pediátrico excepcional, off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] FDA - Tigecycline, 2025 (accessdata.fda.gov)

425. Timolol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Glaucoma - redução da pressão intraocular ≥2 anos	Colírio 0,25%: 1 gota no(s) olho(s) acometido(s) a cada 12 h. Se insuficiente, 0,5%: 1 gota a cada 12 h. Após controle, pode reduzir a 1 gota a cada 24 h. Uso contínuo, guiado pela pressão intraocular. [S2] Esquema de solução, não automaticamente do gel.
Hemangioma infantil superficial pequeno Lactentes; off-label cutâneo	Gel/solução 0,5%: 1 gota na lesão 2 vezes/dia (ensaio por 24 semanas). Alternativa institucional descrita pelo NICE: 1 gota 3 vezes/dia. Reavaliar regressão e necessidade de continuidade. [S1] Não há dose máxima segura por área validada; evitar lesões extensas, ulceradas, mucosas ou lactentes de baixo peso sem supervisão especializada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ocluir ponto lacrimal por 1-2 min no uso ocular. Absorção sistêmica pode causar broncoespasmo, bradicardia e hipoglicemia; contraindicado em asma/ bloqueio cardíaco relevante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Redução da pressão intraocular no glaucoma (colírio a partir de 2 anos na bula formulação oftálmica de referência); hemangiomas infantis superficiais (off-label cutâneo).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Infantile haemangioma: topical timolol | Advice (nice.org.uk)

[S2] Daily Med - Timolol solução oftálmica (dailymed.nlm.nih.gov)

426. Tinidazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Giardíase >3 anos	50 mg/kg VO em dose única, máximo 2 g; administrar com alimento. [S1] Dose pediátrica de bula dos EUA; não implica aprovação brasileira.
Amebíase intestinal >3 anos	50 mg/kg/dose VO a cada 24 h por 3 dias; máximo 2 g/dia. [S1] Avaliar complemento luminal para erradicação intestinal.
Amebíase hepática >3 anos	50 mg/kg/dose VO a cada 24 h por 3-5 dias; máximo 2 g/dia. [S1] Dados pediátricos além de 3 dias são limitados; acompanhar evolução/drenagem quando indicada.
Tricomoníase - alternativa Adolescentes pós-púberes, conforme diretriz de IST	2 g VO em dose única. Falha após metronidazol 500 mg a cada 12 h por 7 dias, sem reexposição: tinidazol 2 g VO a cada 24 h por 7 dias, sob avaliação especializada. [S2] Não transferir este regime a crianças pré-púberes. Tratar parceiros e excluir reinfeção; evitar tinidazol na gestação.
Infecções por anaeróbios Crianças	A indicação do original é adulta. A bula consultada não estabelece regime pediátrico específico por foco; selecionar antibiótico com esquema pediátrico documentado. [S1]
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar álcool durante o curso e por 72 h depois; monitorar neurotoxicidade, interações com varfarina e doença hepática grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Tratamento de giardíase, amebíase intestinal e hepática, tricomoníase e infecções por anaeróbios (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Tinidazole (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] CDC - tricomoníase (cdc.gov)

427. Tioconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Micoses superficiais; candidíase cutânea Crianças conforme formulação dermatológica e avaliação médica	Tioconazol creme 1%: aplicar camada fina na área e adjacências 1-2 vezes/dia. Duração usual 2-4 semanas; reavaliar cura clínica e etiologia se persistência. [S1] Fontes portuguesas; não comprovam faixa etária ou disponibilidade de cada produto no Brasil.
Onicomicose Crianças: evidência pediátrica limitada RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Solução ungueal 28%: aplicar na unha e pele adjacente 2 vezes/dia; pode exigir 6 meses e, em casos extensos, até 12 meses. [S2] Esquema da formulação; uso pediátrico individualizado sem teto de área corporal validado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso exclusivamente externo; evitar olhos, mucosas e pele macerada; confirmar etiologia fúngica antes de tratamento ungueal prolongado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Tratamento tópico de micoses superficiais, candidíase cutânea e onicomicose (solução para unhas).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Pfizer - Trosyd creme (labeling.pfizer.com)

[S2] Pfizer - Trosyd solução ungueal (labeling.pfizer.com)

428. Tiopental

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Indução anestésica para intubação em estado de mal refratário Crianças; anestesiologia/UTI	Tiopental 3-5 mg/kg EV em dose de indução, titulada ao efeito; reduzir se choque/baixo débito. Dose única para indução, não repetição programada. [S1]
Estado de mal epiléptico refratário - infusão contínua Crianças em UTI sob ventilação e EEG RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime pediátrico descrito: ataque 5 mg/kg EV, depois 1-5 mg/kg/h EV contínuo, titulado à supressão de crises clínicas/eletrográficas. Manter controle por 24-48 h antes de desmame lento, conforme neurointensivista. [S2] Diretriz descreve uso tradicional; sem vantagem comprovada sobre outros barbitúricos e com maior risco de efeitos adversos.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de apneia, hipotensão, acúmulo e parada; suporte ventilatório/vasopressor e EEG são necessários. Evitar porfiria e extravasamento; solução alcalina não deve compartilhar via com fármacos ácidos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Indução anestésica e controle de estado de mal epiléptico refratário em ambiente hospitalar especializado.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] NWTS/NHS - estado de mal convulsivo pediátrico (nwts.nhs.uk)

[S2] Alberta Children's Hospital - estado de mal refratário (achpccg.com)

429. Tobramicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecção crônica por <i>Pseudomonas</i> na fibrose cística - inalação	Solução inalatória: 300 mg por nebulização a cada 12 h por 28 dias, seguidos de 28 dias sem tratamento, em ciclos. Alternativa pó inalatório: 112 mg a cada 12 h no mesmo ciclo 28 dias com/28 sem. [S1]
≥6 anos	Não usar solução EV em nebulização sem preparação apropriada; não deglutir cápsulas do pó.
Infecções sistêmicas graves por agentes sensíveis	4 semanas-<10 anos: 7,5 mg/kg/dose EV a cada 24 h, máximo 320 mg/dose. 10-<18 anos: 6-7 mg/kg/dose a cada 24 h, máximo 560 mg/dose; faixa alta para choque/UTI. Infundir em 20-60 min. Individualizar por função renal/AUC. Duração conforme foco, sensibilidade e resposta. [S2]
≥4 semanas; função renal normal	Não confundir dose EV com dose inalatória.
Exacerbação infecciosa da fibrose cística - tratamento EV	10 mg/kg/dose EV a cada 24 h, máximo inicial 660 mg; até 15 mg/kg/dose (máximo 750 mg) somente por farmacocinética e monitorização. Duração conforme exacerbação e equipe de FC. [S2]
≥4 semanas na referência hospitalar	
Infecções oculares externas	Colírio 0,3%: 1-2 gotas no(s) olho(s) acometido(s) a cada 4 h; infecção grave: 2 gotas a cada hora até melhora, depois reduzir. Suspende conforme resolução; bula não fixa curso único. [S3]
≥2 meses na bula consultada	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar função renal, audição e níveis séricos na via sistêmica. Neonatos <4 semanas exigem esquema por idade gestacional/pós-natal, não incluído na dose a cada 24 h.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 53)

Tratamento inalatório crônico da infecção por **Pseudomonas** na fibrose cística (a partir de 6 anos); infecções oculares externas e infecções sistêmicas graves.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Product Information for Aus Par Tobramycin inhalation powder (tga.gov.au)

[S2] PCH - Tobramycin EV (pch.health.wa.gov.au)

[S3] Daily Med - Tobramycin oftálmica (dailymed.nlm.nih.gov)

430. Tocilizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
AIJ poliarticular ≥2 anos	EV a cada 4 semanas, em 60 min: <30 kg 10 mg/kg/dose; ≥30 kg 8 mg/kg/dose. Alternativa SC: <30 kg 162 mg a cada 3 semanas; ≥30 kg 162 mg a cada 2 semanas. Tratamento contínuo. [S1]
AIJ sistêmica ≥2 anos	EV a cada 2 semanas, em 60 min: <30 kg 12 mg/kg/dose; ≥30 kg 8 mg/kg/dose. Alternativa SC: <30 kg 162 mg a cada 2 semanas; ≥30 kg 162 mg semanal. Tratamento contínuo. [S1]
Síndrome de liberação de citocinas pós-CAR-T ≥2 anos	<30 kg: 12 mg/kg EV; ≥30 kg: 8 mg/kg EV; máximo 800 mg/dose, em 60 min. Se resposta insuficiente, até 3 doses adicionais, intervalo mínimo 8 h; máximo 4 doses. [S1]
Covid-19 grave ≥2 anos na bula FDA; internação, corticoide sistêmico e necessidade de oxigênio/suporte ventilatório	<30 kg: 12 mg/kg EV; ≥30 kg: 8 mg/kg EV; máximo 800 mg, em 60 min. Se piora/ausência de melhora, considerar somente 1 dose adicional após ≥8 h. [S1] Autorização internacional não prova aprovação pediátrica brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Rastrear tuberculose, hemograma, plaquetas e transaminases. Evitar vacinas vivas e outro biológico; suspender em infecção grave. Doses EV de AIJ não devem ser substituídas por dose SC de mesma massa.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Artrite idiopática juvenil poliarticular ou sistêmica (a partir de 2 anos); síndrome de liberação de citocinas pós CAR-T; Covid-19 grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Tocilizumab (dailymed.nlm.nih.gov)

431. Tocoferol (Vitamina E)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência/prevenção de deficiência de vitamina E na fibrose cística Lactentes <12 meses; crianças e adolescentes	VO diariamente: <12 meses 50 UI de alfa-tocoferol; ≥12 meses 100-400 UI/dia. Ajustar níveis; uso contínuo enquanto persistir má absorção. [S1] Equivalência de alfa-tocoferol natural: 1 mg=1,49 UI; não transferir automaticamente a outros ésteres.
Colestase crônica congênita/hereditária com má absorção RN a termo até 18 anos; formulação hidrossolúvel EMA	17 mg/kg/dia de d-alfa-tocoferol na forma de tocofersolano VO (=0,34 mL/kg/dia somente da solução 50 mg/mL). Ajustar pelos níveis mensais inicialmente; manutenção contínua enquanto deficiência/má absorção. [S2]
Anemia hemolítica; deficiência de vitamina E fora da FC/colestase Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Vitamina E só tem papel quando a hemólise decorre de deficiência comprovada. As fontes consultadas não estabelecem dose universal para todas as anemias hemolíticas; selecionar reposição pela etiologia, níveis e absorção. [S1] Não tratar hemólise de outra causa com o regime de colestase.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar alfa-tocoferol/lipídios; na FC razão alfa-tocoferol: colesterol alvo >5,4 mg/g. Doses altas aumentam risco hemorrágico, sobretudo na deficiência de vitamina K; Vedrop não é indicado a prematuros.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Tratamento e prevenção da deficiência de vitamina E, anemias hemolíticas e suplementação na colestase e fibrose cística.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ESPEN/ESPGHAN/ECFS - nutrição na fibrose cística (espen.org)

[S2] EMA - Vedrop/tocofersolano (ema.europa.eu)

432. Topiramato

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais; crises generalizadas tônico-clônicas; síndrome de Lennox-Gastaut - adjuvante 2-16 anos	Iniciar 1-3 mg/kg/dia VO à noite (usual até 25 mg/dia) na primeira semana. Aumentar 1-3 mg/kg/dia a cada 1-2 semanas até 5-9 mg/kg/dia, dividido em 2 doses a cada 12 h; máximo diário da referência 400 mg. Tratamento contínuo, com retirada gradual. [S1]
Profilaxia de enxaqueca ≥12 anos	VO: semana 1: 25 mg à noite; semana 2: 25 mg a cada 12 h; semana 3: 25 mg pela manhã +50 mg à noite; semana 4: 50 mg a cada 12 h (100 mg/dia). Titulação mais lenta se intolerância; tratamento preventivo contínuo, reavaliar benefício. [S1] Sem benefício pediátrico demonstrado para <12 anos na fonte; não prescrever para abortar crise.
Crises focais/Lennox-Gastaut; tônico-clônicas generalizadas - adjuvante 17 anos	Iniciar 25-50 mg/dia VO; aumentar 25-50 mg/dia a cada semana. Manutenção: focais/Lennox-Gastaut, 200-400 mg/dia; tônico-clônicas generalizadas, 400 mg/dia, sempre divididos a cada 12 h. Máximo 400 mg/dia; uso contínuo. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Controlar bicarbonato, crescimento, peso, hidratação e sintomas oculares. Reduzir dose em insuficiência renal; riscos de acidose, cálculos, oligohidrose e teratogenicidade. Evitar retirada abrupta.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Tratamento adjuvante de crises focais e generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut; profilaxia de enxaqueca.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Topiramate (dailymed.nlm.nih.gov)

433. Tramadol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dor moderada/intensa - liberação imediata Adolescentes >12 anos elegíveis	50-100 mg VO a cada 4-6 h, usando a menor dose efetiva; máximo 400 mg/dia. Duração: menor tempo necessário, com reavaliação clínica, sem curso fixo. [S1]
Dor moderada/intensa - parenteral Adolescentes >12 anos elegíveis; monitorizados	50-100 mg EV lenta, IM ou SC a cada 4-6 h; máximo 400 mg/dia. Via EV: administrar lentamente, 1 mL/min da solução 50 mg/mL (=50 mg/min). [S1] Usar pelo menor tempo necessário, com reavaliação clínica e transição de via quando possível; não há duração fixa para toda dor.
Dor persistente - liberação prolongada Adolescentes >12 anos elegíveis	100 mg VO a cada 12 h inicialmente; se necessário 150-200 mg a cada 12 h, máximo 400 mg/dia. Engolir inteiro; duração individualizada com reavaliação. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar <12 anos segundo restrição FDA; contraindicado <18 anos após tonsilectomia/adenoidectomia. Evitar 12-18 anos com obesidade, apneia ou doença respiratória importante. Risco de depressão respiratória/CYP 2D6 ultrarrápido, síndrome serotoninérgica e convulsões; ajustar rim/fígado.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Tratamento de dor moderada a intensa em adolescentes elegíveis (acima de 12 anos) e adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Cristália - Tramadon (cristalia.com.br)

[S2] FDA - Tramadol, advertências pediátricas (accessdata.fda.gov)

434. Triancinolona Acetonida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Lesões inflamatórias/úlceras traumáticas da mucosa oral Crianças; aplicação localizada sob prescrição	Pasta bucal 0,1%: pequena quantidade suficiente para película sobre a lesão 2-3 vezes/dia, preferencialmente após refeições e ao deitar. Reavaliar se não cicatrizar em 7 dias. [S1] Não friccionar; evitar infecção oral não tratada. Quantidade em mg varia com extensão, sem teto pediátrico validado.
Uveíte associada à AIJ refratária com edema macular, hipotonia ou vitrite Crianças; uso excepcional por oftalmologista RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Triancinolona acetonida: 2-4 mg por injeção intravítrea, OU 20-40 mg em injeção no assoalho orbitário/periocular. Efeito pode durar 1-2 meses; não há intervalo de repetição pediátrico fixo. [S2] Diretriz admite casos selecionados, não tratamento ocular de rotina; suspensão estéril específica para a via.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco ocular de catarata, glaucoma e endoftalmite; evitar injeção em quem apresenta elevação da pressão por corticoide. Pasta bucal nunca é injetável/oftálmica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Tratamento de lesões inflamatórias e úlceras traumáticas da mucosa oral (pasta bucal); uveítes (suspensão ocular).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - Triamcinolone dental paste (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Diretriz interdisciplinar de uveíte associada à AIJ (augenlinik.charite.de)

435. Trimebutina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Síndrome do intestino irritável; espasmos intestinais	Maleato de trimebutina 200 mg VO 2-3 vezes/dia (a cada 12 ou 8 h), preferencialmente antes das refeições; máximo 600 mg/dia. Duração individualizada pela resposta, sem curso fixo em bula. [S1]
>12 anos	Dose em maleato: 200 mg correspondem a 154 mg de trimebutina base. Cápsula inteira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Investigar sinais de alarme gastrointestinais antes de terapia sintomática contínua; formulação contraindicada <12 anos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)
Tratamento dos sintomas da síndrome do intestino irritável e espasmos intestinais (bula a partir de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Eurofarma - Trimeb bula profissional (eurofarma.com.br)

436. Ureia

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Xerose/hiperqueratose de pele íntegra; hidratação/queratólise	Ureia creme 10%: aplicar camada fina 2 vezes/dia; manutenção enquanto necessário, reavaliando tolerância e integridade cutânea. [S1]
Crianças, pequenas áreas de pele íntegra	Concentrações mais altas não são equivalentes; não há dose universal em g/kg ou máximo de superfície na bula.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar pele ferida, inflamada, olhos e mucosas; absorção/irritação aumentam sob oclusão e em grandes áreas. Suspender se dermatite local.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)
Hidratação intensiva, queratólise e tratamento de peles hiperqueratóticas e xeróticas íntegras.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] [Summary of Product Characteristics \(assets.hpra.ie\)](#)

437. Valaciclovir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Herpes labial ≥12 anos	2 g VO a cada 12 h por 1 dia (2 doses); iniciar ao primeiro pródromo. Máximo 4 g no curso de 24 h. [S1]
Varicela não complicada 2-<18 anos, imunocompetentes - FDA	20 mg/kg/dose VO a cada 8 h por 5 dias; máximo 1 g/dose. Iniciar precocemente, idealmente ≤24 h do exantema. [S1]
Herpes-zóster não complicado; varicela leve no HIV sem imunossupressão grave ≥3 meses - diretriz NIH	20 mg/kg/dose VO a cada 8 h, máximo 1 g/dose; zóster 7-14 dias, varicela 7-14 dias. Formas graves/disseminadas ou imunossupressão grave exigem aciclovir EV inicialmente. [S2] Uso pediátrico especializado fora da bula brasileira; não transferir o curso de 5 dias da criança imunocompetente.
Herpes genital - primeiro episódio/recidiva/supressão Adolescentes elegíveis a regimes de IST; não pré-púberes	Primeiro episódio: 1 g VO a cada 12 h por 7-10 dias (estender se cicatrização incompleta). Recidiva: 500 mg a cada 12 h por 3 dias OU 1 g a cada 24 h por 5 dias. Supressão: 500 mg ou 1 g a cada 24 h, contínuo, reavaliação anual. [S3] 500 mg/dia pode ser insuficiente se ≥10 recidivas/ano; CDC não fornece dose ponderal para criança pequena.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Ajustar função renal e hidratação; risco de neurotoxicidade por acúmulo. Idades da FDA/NIH não significam aprovação brasileira. Doença ocular, visceral ou SNC requer manejo específico.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Tratamento de herpes-zóster, herpes simples genital/labial e varicela (a partir de 12 anos na bula brasileira).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the information needed to use VALTREX saf (gskpro.com)

[S2] NIH - VZV pediátrico (clinicalinfo.hiv.gov)

[S3] CDC - Herpes genital (cdc.gov)

438. Valganciclovir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia de CMV após transplante renal 4 meses-16 anos	VO a cada 24 h com alimento: dose em $\text{mg} = 7 \times \text{SC}(\text{m}^2) \times \text{ClCr}(\text{mL}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2)$. Limitar ClCr a 150 e dose a 900 mg/dia; arredondar ao múltiplo de 25 mg. Iniciar até 10 dias após transplante e manter até dia 200. [S1]
Profilaxia após transplante cardíaco 1 mês-16 anos na FDA; original ≥ 4 meses	Mesma fórmula $7 \times \text{SC} \times \text{ClCr}$, máximo 900 mg VO a cada 24 h. Iniciar até 10 dias e manter até dia 100. [S1] Outros órgãos: bula não estabelece o mesmo regime/duração.
Retinite por CMV - doença leve em criança maior Crianças maiores/adolescentes com SC que permita dose adulta RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	900 mg VO a cada 12 h por 14-21 dias; depois 900 mg a cada 24 h como supressão. Suspensão da manutenção depende de inatividade da retinite e recuperação imune sustentada, com oftalmologia. [S2] NIH: opção somente quando dose adulta é adequada à SC; dados para indução em criança pequena são insuficientes. Não extrapolar 16 mg/kg do CMV congênito para retinite.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Superfície corporal (SC)= $\sqrt{(\text{altura cm} \times \text{peso kg}/3600)}$. $\text{ClCr} = k \times \text{altura}(\text{cm})/\text{creatinina}(\text{mg}/\text{dL})$: k 0,33 lactente <1 ano pequeno para idade gestacional; 0,45 demais <2 anos; 0,55 meninos 2- <13 e meninas 2- <16 ; 0,70 meninos 13-16. Coeficientes de Jaffé: ajustar ao método do laboratório. Monitorar rim, neutrófilos e plaquetas; dose máxima 900 mg.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 54)

Profilaxia de CMV pós-transplante de órgãos sólidos (a partir de 4 meses) e retinite por CMV em imunossuprimidos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Label: VALCYTE- valganciclovir tablet, film coated VALCYTE- valganciclovir hydrochloride powder, for solution (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] NIH - tabela pediátrica de CMV (clinicalinfo.hiv.gov)

439. Vancomicina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Infecção sistêmica grave por Gram-positivos/MRSA ≥4 semanas; função renal normal	15 mg/kg/dose EV a cada 6 h (60 mg/kg/dia), máximo inicial 750 mg/dose; titular por níveis/exposição e função renal. Infundir por ≥60 min e ≤10 mg/min; usar o maior tempo. Duração conforme foco, culturas e controle da fonte. Se nível baixo e rim normal, PCH admite 20 mg/kg/dose a cada 6 h, máximo 80 mg/kg/dia OU 3 g/dia, o menor, após avaliação farmacocinética. [S1]
Colite por C. difficile grave/recorrente ≥2 anos	10 mg/kg/dose VO a cada 6 h por 10 dias; máximo 125 mg/dose. Forma ameaçadora à vida/refratária: mesmo mg/kg, máximo 500 mg/dose, sob infectologia. [S2] Vancomicina EV não trata adequadamente a luz intestinal.
C. difficile - segunda ou posteriores recidivas, desmame/pulsos ≥2 anos	10 mg/kg/dose VO, máximo 125 mg: a cada 6 h por 14 dias; depois a cada 12 h por 7 dias; a cada 24 h por 7 dias; depois a cada 48 h por 2-8 semanas. [S2]
MRSA invasivo - alternativa de infusão contínua Crianças; conversão supervisionada	Administrar a quantidade total recebida nas 24 h anteriores em infusão EV contínua por 24 h, inicialmente sem aumento automático. Concentração final 5 mg/mL; taxa mL/h=dose total diária (mg)÷120. Ajustar por níveis em 24/48 h, alvo 17-25 mg/L na referência PCH. [S1] Necessita linha/preparo apropriados; níveis alvo e AUC dependem do contexto clínico. Duração conforme foco.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar creatinina e níveis sistêmicos; evitar associação nefrotóxica desnecessária. Neonatos exigem intervalos por idade/TFG. C. difficile <2 anos frequentemente é colonização e não deve ser tratado automaticamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Tratamento de infecções sistêmicas graves por Gram-positivos multirresistentes (MRSA); colite por *C. difficile* (via oral).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Vancomycin (intravenous) Monograph - Paediatric (pch.health.wa.gov.au)

[S2] PCH - Vancomycin oral (pch.health.wa.gov.au)

440. Varfarina Sódica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento/prevenção de tromboembolismo venoso Crianças	Dia 1: administrar 0,2 mg/kg VO em dose única à noite, máximo 5 mg/dose; hepatopatia, insuficiência renal grave, pós-operatório ou coagulopatia: 0,1 mg/kg, máximo 5 mg. Ajustar diariamente pelo INR inicialmente; alvo usual 2-3. Sobrepor anticoagulante parenteral até anticoagulação terapêutica estável. [S1] Não há dose de manutenção ponderal fixa. Duração depende de evento provocado/não provocado, persistência do fator de risco e recorrência.
Prótese valvar mecânica Crianças	Mesma estratégia de início/titulação VO; alvo INR definido pelo tipo e posição da válvula, frequentemente 2,5-3,5. Tratamento contínuo enquanto prótese mecânica. [S1] Confirmar alvo específico com cardiologia; não aplicar INR 2-3 a toda prótese.
Titulação inicial - dias 2-4 Crianças, após primeira dose	Dose noturna pelo INR: 1,1-1,3 repetir dose inicial; 1,4-3,0 usar 50% da dose inicial; 3,1-3,5 usar 25%; >3,5 suspender até INR <3,5 e reiniciar 50% abaixo da dose anterior. Depois, individualizar manutenção pelo INR-alvo. [S1] Não repetir automaticamente a dose de ataque todos os dias.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES INR frequente, dieta e vitamina K consistentes; numerosas interações, inclusive antibióticos/antiepilépticos. Evitar em gestação salvo decisão especializada; não usar dose fixa sem INR.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Anticoagulante oral para prevenção e tratamento de tromboembolismo venoso e próteses valvares mecânicas.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Clinical Haematology : Warfarin Guidelines for Clinicians (rch.org.au)

441. Vasopressina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Choque vasodilatado refratário a catecolaminas UTI pediátrica; adjuvante	Infusão EV contínua 0,0003-0,002 UI/kg/min (=0,3-2 mili UI/kg/min); titular à perfusão/pressão. Duração apenas enquanto choque refratário, com redução guiada pela resposta. Sem bolus. [S1]
Diabetes insípido central agudo UTI pediátrica	Iniciar 0,0005 UI/kg/h (=0,5 mili UI/kg/h) EV contínua; titular à diurese/sódio, máximo 0,01 UI/kg/h (=10 mili UI/kg/h). Reavaliar a cada 30 min na titulação; duração até controle e possibilidade de estratégia de manutenção. [S1, S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Choque usa UI/kg/MINUTO; DI usa UI/kg/HORA: erro equivale a 60 vezes. CHEO concentrações finais 0,02/0,4/1 UI/mL; para DI <0,001 UI/kg/h usar 0,02 UI/mL. Bomba: choque=dose × peso × 60/concentração; DI=dose × peso/concentração. Monitorar Na, diurese, isquemia e débito cardíaco.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Tratamento do choque vasodilatado refratário a catecolaminas; diabetes insípido central agudo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CHEO - Vasopressina (outreach.cheo.on.ca)

[S2] Central Diabetes Insipidus (DI)/Arginine Vasopressin Deficiency ... (chop.edu)

442. Verapamil

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Taquiarritmia supraventricular - reversão 1-16 anos	0,1-0,3 mg/kg EV lento em ≥ 2 min; máximo 5 mg na primeira dose. Se necessário repetir após 30 min, máximo 10 mg na repetição; ECG/pressão contínuos. [S1]
Taquiarritmia supraventricular - manutenção Crianças selecionadas por cardiologia	2-8 mg/kg/dia VO divididos a cada 8 h; tratamento contínuo enquanto indicado, com reavaliação do ritmo e condução. [S2] Não é adequado para FA pré-excitada/WPW nem para TSV indiferenciada. Fonte não fixa teto absoluto pediátrico.
Hipertensão arterial; angina Pediatria DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Indicações preservadas; fontes abertas não estabelecem esquema pediátrico específico para estes dois cenários. Não transferir a dose antiarrítmica indiscriminadamente. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar EV em <1 ano por risco de colapso cardiovascular. Contraindicado em disfunção ventricular importante, bloqueio AV sem marca-passo e FA com via acessória. Associação com betabloqueador EV pode causar parada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Tratamento de taquiarritmias supraventriculares, hipertensão arterial e angina do peito.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Verapamil HC I (outreach.cheo.on.ca)

[S2] Consenso italiano - taquicardia/WPW pediátrico (doi.org)

443. Vigabatrina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Espasmos infantis/síndrome de West 1 mês-2 anos	Iniciar 50 mg/kg/dia VO divididos a cada 12 h; aumentar 25-50 mg/kg/dia a cada 3 dias até máximo 150 mg/kg/dia (75 mg/kg/dose). Suspende-se se resposta insuficiente em 2-4 semanas; se eficaz, curso individualizado com neurologia. [S1]
Epilepsia focal refratária - adjuvante 2-16 anos e ≥10 kg	Dose diária VO dividida em 2: 10-15 kg iniciar 350 mg/dia→1.050 mg/dia; >15-20 kg 450→1.300; >20-25 kg 500→1.500; >25-60 kg 500→2.000; >60 kg 1.000→3.000. Aumentar semanalmente até manutenção indicada; máximo 3.000 mg/dia. Suspende-se sem benefício relevante em 3 meses. [S1] Os valores são mg/DIA, não por dose; cada tomada é metade.
Epilepsia focal refratária - adjuvante 17 anos; ou 2-16 anos com >60 kg	Iniciar 500 mg VO a cada 12 h; aumentar a dose diária total em 500 mg a cada semana até 1.500 mg a cada 12 h (máximo 3.000 mg/dia). Suspende-se gradualmente se sem benefício relevante em 3 meses. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Perda irreversível de campo visual: exame basal e periódico; a menor dose/tempo eficaz. Ajustar rim; vigiar alterações de RM em lactentes e retirar gradualmente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Tratamento de espasmos infantis (síndrome de West) e epilepsias focais refratárias.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Label: VIGADRON- vigabatrin tablet (dailymed.nlm.nih.gov)

444. Vitamina A + D (Associação)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção concomitante de deficiência A e D; profilaxia do raquitismo Crianças conforme bula da associação	Formulação de referência: 2.500 UI de vitamina A +500 UI de vitamina D VO a cada 24 h (2 gotas somente no produto 50.000/10.000 UI/mL, 40 gotas/mL). Duração conforme necessidade nutricional e acompanhamento. [S1] A proporção varia entre marcas; nunca converter número de gotas sem concentração.
Tratamento concomitante de deficiência A e D Deficiências laboratoriais/clínicas confirmadas RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não há razão fixa A: D apropriada a toda deficiência. A dose preventiva acima não é um regime validado para tratar raquitismo/deficiência grave. Repor cada vitamina separadamente em dose terapêutica específica e depois reavaliar a associação. [S1] A indicação documental é preservada, porém escalonar gotas para corrigir D pode causar hipervitaminose A.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contabilizar vitaminas em dieta e outros suplementos; toxicidade por A/D pode causar hipercalcemia e lesão hepática. Não aumentar dose da associação para acompanhar esquema de vitamina D isolada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Prevenção e tratamento concomitante da deficiência de vitaminas A e D e profilaxia de raquitismo.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Bula Prof (uploads.consultaremedios.com.br)

445. Voriconazol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Aspergilose invasiva; infecção grave por <i>Scedosporium</i>/Fusarium 2-<12 anos OU 12-14 anos <50 kg	EV: ataque 9 mg/kg/dose a cada 12 h nas primeiras 24 h; manutenção 8 mg/kg/dose a cada 12 h. Alternativa VO 9 mg/kg/dose a cada 12 h, máximo 350 mg/dose. Infusão EV em 1-3 h, ≤3 mg/kg/h. Aspergilose: mínimo 6-12 semanas; fungos raros: duração pela resposta e recuperação imune, sem curso universal. [S1]
Mesmas micoses invasivas - adolescente de peso/faixa adulta 12-14 anos ≥50 kg OU ≥15 anos	EV: ataque 6 mg/kg a cada 12 h por 24 h; manutenção 4 mg/kg a cada 12 h. VO manutenção 200 mg a cada 12 h se ≥40 kg; 100 mg a cada 12 h se <40 kg. Ajustar por níveis/ resposta. [S1] Em infecção invasiva, início EV preferível; conversão VO depende da evolução.
Candidíase esofágica ≥2 anos	VO nas faixas pediátricas acima (9 mg/kg/dose a cada 12 h, máximo 350 mg; faixa adulta 200 mg a cada 12 h se ≥40 kg/100 mg se <40 kg). Duração pelo menos 14 dias e ≥7 dias após desaparecimento dos sintomas. [S1] Confirmar suscetibilidade e necessidade deste azólico; não usar a duração de aspergilose.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar níveis, fígado, QT, visão e fototoxicidade; interações extensas. EV contém excipiente que se acumula na insuficiência renal; doses orais e EV pediátricas não são numericamente equivalentes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)

Tratamento de aspergilose invasiva, candidíase esofágica e infecções graves por **Scedosporium** e **Fusarium** (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Voriconazole Monograph - Paediatric (pch.health.wa.gov.au)

[S2] IDSA - aspergilose (idsociety.org)

446. Duloxetina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Ansiedade generalizada 7-17 anos	Iniciar 30 mg VO a cada 24 h por 2 semanas; aumentar a 60 mg/dia se necessário. Usual 30-60 mg/dia; aumentos posteriores de 30 mg/dia, máximo estudado 120 mg/dia. Tratamento contínuo, reavaliando eficácia/risco. [S1] Esquema pediátrico FDA; bula original brasileira adulta.
Fibromialgia 13-17 anos	30 mg VO a cada 24 h; aumentar a 60 mg/dia conforme resposta/tolerância. Máximo recomendado 60 mg/dia; tratamento contínuo. [S1] Esquema pediátrico FDA.
Transtorno depressivo maior; dor neuropática periférica diabética <18 anos	Segurança e eficácia pediátricas não estabelecidas para estas indicações. Não transferir os regimes de ansiedade/fibromialgia a elas. [S1]
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar suicidabilidade, pressão, peso e crescimento; evitar hepatopatia e TFG <30 mL/min. Não associar a IMAO; retirada gradual.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)
Transtorno depressivo maior, ansiedade generalizada, dor neuropática periférica diabética e fibromialgia (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Duloxetine capsule, delayed release - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

447. Desvenlafaxina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento do transtorno depressivo maior em adultos.	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos	Dois ensaios de depressão em 7-17 anos não demonstraram eficácia.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Psicofármacos: monitorar ideação suicida, ativação e interações; não suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)
Tratamento do transtorno depressivo maior em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] DESVENLAFAXINE tablet, extended release (dailymed.nlm.nih.gov)

448. Vortioxetina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento do transtorno depressivo maior em pacientes adultos.	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos	Ensaio em 7-17 anos não demonstraram superioridade ao placebo.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Psicofármacos: monitorar ideação suicida, ativação e interações; não suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 55)
Tratamento do transtorno depressivo maior em pacientes adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] These highlights do not include all the information needed to use TRINTELLIX ®safely and effectively. See full prescribing information (dailymed.nlm.nih.gov)

449. Trazodona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento da depressão maior com ou sem ansiedade; dor na neuropatia diabética (uso adulto).	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos	
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A bula não estabelece posologia para depressão ou neuropatia diabética em crianças.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Psicofármacos: monitorar ideação suicida, ativação e interações; não suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)

Tratamento da depressão maior com ou sem ansiedade; dor na neuropatia diabética (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Trazodone Hydrochloride tablet - Daily Med - NIH (dailymed.nlm.nih.gov)

450. Venlafaxina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Depressão resistente a ISRS - uso off-label 12-18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Venlafaxina ER VO diária: semanas 1/2/3/4: 37,5/75/112,5/150 mg/dia. Na semana 6, pode aumentar até 225 mg/dia se necessário. Ensaio de 12 semanas; manutenção posterior individualizada e retirada gradual. [S2] Não mostrou superioridade à troca para outro ISRS; maior efeito sobre pressão/pulso.
Ansiedade generalizada - uso off-label 6-17 anos e ≥50 kg para o teto aqui documentado RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Iniciar 37,5 mg de ER VO a cada 24 h; titular por resposta/tolerância, máximo 225 mg/dia no subgrupo ≥50 kg. Curso estudado 8 semanas, depois reavaliar. [S3] Ensaio incluiu ≥25 kg, mas a tabela com tetos de 25-<50 kg não foi recuperada integralmente; não aplicar 225 mg a eles.
Ansiedade social - uso off-label 8-17 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	ER VO: iniciar 37,5 mg/dia e titular conforme resposta/tolerância até máximo estudado 225 mg/dia; ensaio 16 semanas. Reavaliar continuidade, sintomas suicidas e pressão. [S4] Resumo primário não detalha todos passos de titulação; máximo estudado não é dose-alvo de toda criança.
Transtorno do pânico <18 anos DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Não foi identificado regime pediátrico estabelecido para esta indicação; não transferir doses dos ensaios de outras condições. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Vigiar suicidabilidade, ativação, pressão/pulso, peso/crescimento; ajustar função renal/hepática. Retirada gradual; evitar IMAO e combinações serotoninérgicas.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)

Tratamento da depressão, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social e pânico (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EFFEXOR- venlafaxine tablet - Daily Med - NIH (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] TORDIA - depressão resistente 12-18 anos (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S3] Ensaio primário - ansiedade generalizada 6-17 anos (psychiatryonline.org)

[S4] Ensaio primário - ansiedade social 8-17 anos (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

451. Mirtazapina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento de episódios de depressão maior em adultos.	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Ensaios pediátricos não sustentaram indicação; ganho ponderal significativo foi observado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Psicofármacos: monitorar ideação suicida, ativação e interações; não suspender abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)
Tratamento de episódios de depressão maior em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] MIRTAZAPINE tablet, film coated (dailymed.nlm.nih.gov)

452. Memantina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave e outras demências com prejuízo cognitivo (uso adulto).	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos	Alzheimer e outras demências do adulto não constituem indicação pediátrica estabelecida.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de efeitos neurológicos e cardiovasculares; demência adulta não justifica uso automático para dificuldade cognitiva infantil.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)

Tratamento da doença de Alzheimer moderada a grave e outras demências com prejuízo cognitivo (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - MEMANTINE HYDROCHLORIDE- memantine hydrochloride kit (dailymed.nlm.nih.gov)

453. Rivastigmina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve a moderadamente grave e demência associada à doença de Parkinson.	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1] Não recomendado <18 anos; não converter dose de adesivo adulto para criança.
<18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de efeitos neurológicos e cardiovasculares; demência adulta não justifica uso automático para dificuldade cognitiva infantil.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)

Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve a moderadamente grave e demência associada à doença de Parkinson.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] These highlights do not include all the information needed to use RIVASTIGMINE TRANSDERMAL SYSTEM safely and effectively (dailymed.nlm.nih.gov)

454. Donepezila

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve, moderadamente grave ou grave (uso adulto).	Não existe regime pediátrico aprovado/estabelecido na bula consultada para a indicação documental. Dose, intervalo e duração adultos não são apresentados como posologia infantil. [S1]
<18 anos	Não há condição pediátrica aprovada na bula consultada.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Risco de efeitos neurológicos e cardiovasculares; demência adulta não justifica uso automático para dificuldade cognitiva infantil.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)
Tratamento sintomático da demência de Alzheimer leve, moderadamente grave ou grave (uso adulto).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] ARICEPT- donepezil hydrochloride tablet, film coated ARICEPT ODT- donepezil hydrochloride tablet, orally disintegrating (dailymed.nlm.nih.gov)

455. Tezepelumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma grave - manutenção complementar	210 mg SC a cada 4 semanas; tratamento contínuo, reavaliar exacerbações e controle. [S1]
≥12 anos	
Rinossinusite crônica com pólipos nasais	210 mg SC a cada 4 semanas; tratamento contínuo. [S1]
≥12 anos na bula FDA atual; original cita adultos	Faixa adolescente confirmada em fonte internacional; não equivale à aprovação brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não trata broncoespasmo agudo. Avaliar helmintíase e hipersensibilidade; não retirar corticoide abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)
Tratamento complementar de manutenção da asma grave (a partir de 12 anos); rinossinusite crônica grave com pólipos nasais em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Daily Med - TEZSPIRE- tezepelumab-ekko injection, solution (dailymed.nlm.nih.gov)

456. Dupilumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Dermatite atópica 6 meses-5 anos	SC, sem ataque: 5-<15 kg: 200 mg a cada 4 semanas; 15-<30 kg: 300 mg a cada 4 semanas. Manutenção contínua. [S1] EMA e FDA: mesma dose inicial e de manutenção nesta faixa.
Dermatite atópica 6-17 anos	SC: 15-<30 kg: ataque 600 mg, depois 300 mg a cada 4 semanas; 30-<60 kg: ataque 400 mg, depois 200 mg a cada 2 semanas; ≥60 kg: ataque 600 mg, depois 300 mg a cada 2 semanas. [S1, S2] Esquema FDA; alternativa EMA 6-11 anos e 15-<60 kg: 300 mg SC nos dias 1 e 15; depois 300 mg a cada 4 semanas, iniciando 4 semanas após dia 15; pode ajustar para 200 mg a cada 2 semanas.
Asma tipo 2 6-11 anos; ≥15 kg	SC sem ataque: 15-<30 kg: 300 mg a cada 4 semanas; ≥30 kg: 200 mg a cada 2 semanas. Se dermatite moderada/grave concomitante, usar esquema de dermatite com ataque. [S2] Alternativa EMA para 30-<60 kg: 300 mg SC a cada 4 semanas. Sem ataque na asma isolada.
Asma tipo 2 ≥12 anos	SC: ataque 400 mg →200 mg a cada 2 semanas; alternativa ataque 600 mg →300 mg a cada 2 semanas. Usar este último se dependência de corticoide oral ou dermatite moderada/grave concomitante. [S1]
Rinossinusite com pólipos ≥12 anos na FDA	300 mg SC a cada 2 semanas. [S1]
Esofagite eosinofílica ≥1 ano e ≥15 kg	SC: 15-<30 kg: 200 mg a cada 2 semanas; 30-<40 kg: 300 mg a cada 2 semanas; ≥40 kg: 300 mg semanal. [S1]
Urticária crônica espontânea 2-17 anos - EMA; inadequadamente controlada por anti-H1 e sem anti-IgE prévio	2-5 anos: 5-<15 kg 200 mg SC a cada 4 semanas; 15-<30 kg 300 mg a cada 4 semanas. 6-17 anos: 5-<15 kg 200 mg a cada 4 semanas; 15-<30 kg 300 mg dias 1 e 15, depois a cada 4 semanas desde 4 semanas após dia 15; 30-<60 kg ataque 400 mg→200 mg a cada 2 semanas; ≥60 kg 600 mg→300 mg a cada 2 semanas. [S2] Avaliar resposta em 24 semanas; considerar suspensão sem resposta. Aprovação EMA não estabelece aprovação Anvisa.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar conjuntivite/ceratite e eosinofilia sintomática; tratar helmintíase antes; evitar vacinas vivas. Idades FDA explicitadas: não presumem aprovação BR. Regimes de manutenção são contínuos enquanto eficazes e indicados, com reavaliação periódica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)

Dermatite atópica grave (a partir de 6 meses); asma grave tipo 2 (a partir de 6 anos); rinossinusite com pólipos; esofagite eosinofílica (a partir de 1 ano e 15 kg); urticária crônica espontânea (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Approval Label (accessdata.fda.gov)

[S2] EMA - Dupixent: regimes pediátricos e UCE ≥2 anos (ema.europa.eu)

457. Mepolizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma eosinofílica grave	6-11 anos: 40 mg SC a cada 4 semanas. ≥12 anos: 100 mg SC a cada 4 semanas. Manutenção contínua. [S1]
6-11 anos; ≥12 anos	
Síndrome hipereosinofílica	300 mg SC a cada 4 semanas (3 injeções de 100 mg em locais separados). Manutenção contínua. [S1]
≥12 anos; duração ≥6 meses, sem causa secundária não hematológica	
Granulomatose eosinofílica com poliangiite	6-11 anos <40 kg: 100 mg SC a cada 4 semanas; 6-11 anos ≥40 kg: 200 mg a cada 4 semanas; ≥12 anos: 300 mg a cada 4 semanas. Manutenção contínua, reavaliar pelo menos anualmente. [S2]
≥6 anos - EMA	Bula FDA consultada limita a adultos; esquema pediátrico vem da EMA e não comprova aprovação BR.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não trata crise aguda de asma. Avaliar helmintíases, herpes-zóster e reações alérgicas; reduzir corticoide gradualmente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 56)
Asma eosinofílica grave (a partir de 6 anos); granulomatose eosinofílica com poliangiite e síndrome hipereosinofílica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - NUCALA- mepolizumab injection, powder, for solution (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] EMA - Nucala/EGPA pediátrica (ema.europa.eu)

458. Benralizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma eosinofílica grave 6-11 anos na FDA	<35 kg: 10 mg SC; ≥35 kg: 30 mg SC. A cada 4 semanas nas primeiras 3 doses, depois a cada 8 semanas. Manutenção contínua. [S1] Original cita adultos; ampliação pediátrica aqui é da FDA.
Asma eosinofílica grave ≥12 anos	30 mg SC a cada 4 semanas nas primeiras 3 doses, depois a cada 8 semanas; contínuo. [S1]
Granulomatose eosinofílica com poliangiite - off-label Adolescente de 16 anos em relato publicado RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Regime de resgate descrito: 30 mg SC a cada 4 semanas, associado inicialmente a corticoide; manutenção contínua após controle. O paciente havia recebido 30 mg a cada 8 semanas, com recidiva cutânea. [S2] Evidência de relato; não define faixa pediátrica universal nem valida uso para vasculite com órgão ameaçado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não usar para resgate asmático; rastrear helmintíase e hipersensibilidade. Não suspender corticoides abruptamente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)
Manutenção complementar da asma eosinofílica grave e granulomatose eosinofílica com poliangiite em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Daily Med - FASENRA- benralizumab injection, solution (dailymed.nlm.nih.gov)
[S2] Relato primário - benralizumabe em EGPA pediátrica (doi.org)

459. Roflumilaste

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tratamento complementar da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave com bronquite crônica em adultos.	Não há esquema pediátrico estabelecido para manutenção de DPOC. Indicação adulta preservada; não converter dose inalatória ou oral adulta para criança. [S1] Outras apresentações do mesmo princípio ativo não tornam o produto para DPOC intercambiável.
<18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não indicado para alívio imediato de broncoespasmo. Roflumilaste oral pode provocar perda ponderal e efeitos psiquiátricos.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)

Tratamento complementar da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave com bronquite crônica em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - DALIRESP- roflumilast tablet (dailymed.nlm.nih.gov)

460. Indacaterol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção broncodilatadora na DPOC moderada a grave em adultos.	Não há esquema pediátrico estabelecido para manutenção de DPOC. Indicação adulta preservada; não converter dose inalatória ou oral adulta para criança. [S1]
<18 anos	Outras apresentações do mesmo princípio ativo não tornam o produto para DPOC intercambiável.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não indicado para alívio imediato de broncoespasmo. Conferir dispositivo, sal e dose liberada versus dose nominal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)
Manutenção broncodilatadora na DPOC moderada a grave em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] 3194912 This label may not be the latest approved by FDA ... (accessdata.fda.gov)

461. Glicopirrônio (Brometo)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção broncodilatadora de longa duração na DPOC em adultos.	Não há esquema pediátrico estabelecido para manutenção de DPOC. Indicação adulta preservada; não converter dose inalatória ou oral adulta para criança. [S1]
<18 anos	Outras apresentações do mesmo princípio ativo não tornam o produto para DPOC intercambiável.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não indicado para alívio imediato de broncoespasmo. Conferir dispositivo, sal e dose liberada versus dose nominal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)
Manutenção broncodilatadora de longa duração na DPOC em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Seebri Breezhaler | European Medicines Agency (EMA) (ema.europa.eu)

462. Umeclidínio (Brometo)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Manutenção broncodilatadora anticolinérgica na DPOC em adultos.	Não há esquema pediátrico estabelecido para manutenção de DPOC. Indicação adulta preservada; não converter dose inalatória ou oral adulta para criança. [S1]
<18 anos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Outras apresentações do mesmo princípio ativo não tornam o produto para DPOC intercambiável.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não indicado para alívio imediato de broncoespasmo. Conferir dispositivo, sal e dose liberada versus dose nominal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (p. 57; redação corrigida)

Manutenção broncodilatadora anticolinérgica na DPOC em adultos.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] INCRUSE ELLIPTA- umeclidinium aerosol, powder - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

463. Abatacepte

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
AIJ poliarticular EV ≥6 anos	<75 kg: 10 mg/kg EV em 30 min. 75-100 kg: 750 mg; >100 kg: 1.000 mg (máximo). Administrar semanas 0,2,4; depois a cada 4 semanas, continuamente. [S1]
AIJ poliarticular; artrite psoriásica juvenil SC ≥2 anos e ≥10 kg	SC semanal: 10-<25 kg: 50 mg; 25-<50 kg: 87,5 mg; ≥50 kg: 125 mg. Sem ataque EV; manutenção contínua. [S1] Artrite psoriásica pediátrica documentada na FDA, embora original cite adultos.
Artrite reumatoide Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indicação adulta; na infância enquadrar doença como AIJ e usar seu regime específico. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Rastrear TB/hepatites, atualizar vacinas antes; evitar vacina viva e associação a anti-TNF. Interromper em infecção grave; reconstituição EV exige seringa sem silicone.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)

Artrite reumatoide e artrite psoriásica em adultos; artrite idiopática juvenil poliarticular (IV a partir de 6 anos; SC conforme peso).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ORENCIA (dailymed.nlm.nih.gov)

464. Adalimumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
AIJ; uveíte não infecciosa ≥2 anos e ≥10 kg	SC a cada 2 semanas: 10-<15 kg: 10 mg; 15-<30 kg: 20 mg; ≥30 kg: 40 mg. [S1]
Crohn ≥6 anos e ≥17 kg	SC: 17-<40 kg: dia 1 80 mg, dia 15 40 mg, depois 20 mg a cada 2 semanas desde dia 29. ≥40 kg: 160/80 mg nos dias 1/15, depois 40 mg a cada 2 semanas. [S1]
Retocolite ulcerativa ≥6 anos no escopo original; ≥20 kg	SC: 20-<40 kg: dias 1/8/15: 80/40/40 mg; desde dia 29: 40 mg a cada 2 semanas OU 20 mg semanal. ≥40 kg: 160/80/80 mg; depois 80 mg a cada 2 semanas OU 40 mg semanal. [S1]
Hidradenite supurativa ≥12 anos e ≥30 kg	SC: 30-<60 kg: 80 mg dia 1, depois 40 mg a cada 2 semanas desde dia 8. ≥60 kg: 160 mg dia 1, 80 mg dia 15, depois 40 mg semanal OU 80 mg a cada 2 semanas desde dia 29. [S1]
Espondilite anquilosante de início juvenil 12-17 anos e ≥30 kg; off-label	40 mg SC a cada 2 semanas. Ensaio controlado por 12 semanas, seguido de extensão até 24 semanas; continuidade conforme resposta e reumatologia. [S2]
Artrite reumatoide Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Na infância, classificar a artrite e utilizar o regime de AIJ correspondente; o regime de artrite reumatoide adulta não é uma indicação pediátrica adicional. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Manutenção contínua, condicionada à resposta. Rastrear TB/HBV; risco de infecção grave e malignidade; evitar vacinas vivas. Doses deste quadro são da FDA; apresentações brasileiras podem diferir.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)

Artrite reumatoide, espondilite anquilosante; doença de Crohn e retocolite ulcerativa (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil e uveíte (a partir de 2 anos); hidradenite supurativa.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] HUMIRA- adalimumab kit (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Ensaio primário - espondilite anquilosante juvenil (doi.org)

465. Etanercepte

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
AIJ poliarticular; artrite psoriásica juvenil ≥2 anos	0,8 mg/kg SC 1 vez/semana; máximo 50 mg/semana. Manutenção contínua. Alternativa para AIJ: 0,4 mg/kg SC 2 vezes/semana, máximo 25 mg/dose, intervalo 3-4 dias. Considerar suspensão se sem resposta em 4 meses. [S1, S2]
Psoríase em placas grave ≥6 anos no escopo original	0,8 mg/kg SC 1 vez/semana, máximo 50 mg/dose, por até 24 semanas na bula BR. Suspender se sem resposta após 12 semanas; retratamento pode repetir esse esquema. [S2]
Artrite reumatoide Pediatria RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Indicação adulta; o diagnóstico pediátrico AIJ tem esquema próprio acima. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Rastrear TB/hepatite B e infecções; evitar vacinas vivas. Não associar outro biológico; suspender em infecção grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)

Artrite reumatoide, artrite psoriásica; psoríase em placas grave (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil poliarticular (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] etanercept solution - ENBREL - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Pfizer BR - Enbrel (pfizer.com.br)

466. Secuquinumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Psoríase em placas moderada/grave ≥6 anos	SC nas semanas 0,1,2,3,4; depois a cada 4 semanas: <50 kg 75 mg/dose; ≥50 kg 150 mg/dose. Manutenção contínua. [S1]
Artrite psoriásica juvenil ≥2 anos e ≥15 kg	SC nas semanas 0,1,2,3,4; depois a cada 4 semanas: 15-<50 kg 75 mg/dose; ≥50 kg 150 mg/dose. [S1]
Espondilite anquilosante juvenil ≥12 anos na FDA atual	SC nas semanas 0,1,2,3,4; depois a cada 4 semanas: <50 kg 75 mg/dose; ≥50 kg 150 mg/dose. [S2] Ampliação internacional; confirmar correspondência da bula brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Rastrear TB e candidíase; pode agravar doença inflamatória intestinal. Evitar vacinas vivas e interromper em infecção grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 57)

Psoríase em placas moderada a grave (a partir de 6 anos); artrite psoriásica e espondilite anquilosante; artrite psoriásica juvenil (acima de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - COSENTYX- secukinumab injection (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Novartis - Cosentyx 2026 (novartis.com)

467. Albumina Humana

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Choque/hipovolemia com indicação de coloide	0,5-1 g/kg EV; equivale a 10-20 mL/kg de albumina 5% OU 2-4 mL/kg de albumina 25%. Reavaliar circulação após 15-30 min antes de repetir; teto da bula 2 g/kg/dia. [S1]
Crianças	Concentrações não são intercambiáveis em volume. Cristaloide é normalmente a expansão inicial.
Hipoalbuminemia grave	A albumina sérica isolada não define dose. Se há indicação clínica de reposição, individualizar em gramas e resposta volêmica; a bula não estabelece esquema pediátrico específico distinto da reposição acima. [S1]
Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não normalizar albumina laboratorial sem objetivo clínico demonstrado.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar perfusão, pressão, diurese e edema pulmonar; reduzir/interromper se sobrecarga. Não diluir em água estéril pura por risco de hemólise; usar solução isotônica compatível.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Restauração e manutenção do volume sanguíneo circulante em estados de choque, hipovolemia e hipoalbuminemia grave.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ALBUMIN (HUMAN)- albumin human solution - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

468. Romiplostim

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Trombocitopenia imune refratária ≥1 ano; PTI ≥6 meses	Iniciar 1 mcg/kg SC semanal. Aumentar 1 mcg/kg/semana se plaquetas <50.000/mm ³ ; máximo 10 mcg/kg/semana. Alvo ≥50.000/mm ³ para reduzir sangramento, sem normalizar contagem. Se >200.000 por 2 semanas, reduzir 1 mcg/kg; se >400.000, suspender até <200.000 e reiniciar 1 mcg/kg abaixo. [S1] Suspender se após 4 semanas em 10 mcg/kg não alcançar resposta suficiente. Reavaliar peso a cada 12 semanas.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma semanal na titulação; depois mensal. Risco trombótico e reticulina medular. Usar mcg, nunca mg; volumes pequenos exigem diluição específica confirmada.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)
Trombocitopenia imune primária crônica refratária (adultos; crianças a partir de 1 ano).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] Daily Med - NPLATE- romiplostim injection, powder, lyophilized, for solution (dailymed.nlm.nih.gov)

469. Eltrombopague

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
PTI persistente/crônica refratária ≥6 anos no escopo original	50 mg VO a cada 24 h. Ajustar em passos de 25 mg, com intervalo ≥2 semanas; máximo 75 mg/dia. Meta ≥50.000 plaquetas/mm ³ . Ascendência leste/sudeste asiática ou hepatopatia: iniciar 25 mg/dia; se ambas, considerar 12,5 mg/dia. [S1] FDA também aprova 1-5 anos: 25 mg/dia; distinção regulatória brasileira deve ser mantida.
Anemia aplástica severa - primeira linha associada a ATG equina e ciclosporina ≥2 anos na FDA	VO por 6 meses: 2-5 anos: 2,5 mg/kg a cada 24 h; 6-11 anos: 75 mg/dia; ≥12 anos: 150 mg/dia. Reduzir dose inicial 50% em ascendência leste/sudeste asiática ou hepatopatia. [S1]
Anemia aplástica severa recidivada/refratária - regime estudado 1-17 anos; associado à ciclosporina, com/sem ATG, off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	1-<6 anos: iniciar 25 mg VO a cada 24 h; 6-17 anos: 50 mg a cada 24 h. Titular em intervalos de 2 semanas a partir da semana 3, segundo plaquetas/toxicidade; máximo estudado 150 mg/dia, alvo 50.000-200.000/mm ³ . Curso 26 semanas, extensível se benefício. [S2] Estudo fase 2 sem grupo-controle; titulação e vigilância hepática/medular devem seguir protocolo de hematologia.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hemograma e fígado. Separar cálcio/ferro/antiácidos: tomar ≥2 h antes ou ≥4 h depois. Interromper por trombose, toxicidade hepática ou resposta plaquetária excessiva.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Trombocitopenia imune crônica refratária (adultos e crianças acima de 6 anos); anemia aplástica severa.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] PROMACTA- eltrombopag olamine tablet, film coated PROMACTA- eltrombopag olamine powder, for suspension (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] ESCALATE 2025 - anemia aplástica pediátrica recidivada/refratária (doi.org)

470. Emicizumabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia de hemorragias na hemofilia A, com ou sem inibidores	Ataque: 3 mg/kg SC semanal por 4 semanas. Manutenção: 1,5 mg/kg semanal OU 3 mg/kg a cada 2 semanas OU 6 mg/kg a cada 4 semanas. Tratamento contínuo; escolher um único esquema. [S1]
Pediatria, inclusive lactentes	Não é tratamento isolado de hemorragia aguda. Não administrar EV.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar complexo protrombínico ativado em doses cumulativas >100 U/kg/24 h por ≥24 h: risco de microangiopatia/trombose. Interfere com TTPa e ensaios de FVIII baseados em coagulação; usar testes adequados.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)
Profilaxia de rotina para prevenir ou reduzir episódios hemorrágicos em pacientes com hemofilia A (com ou sem inibidores).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026
[S1] HEMLIBRA- emicizumab injection, solution (dailymed.nlm.nih.gov)

471. Fator XIII da Coagulação Humana

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Deficiência congênita de fator XIII - profilaxia	40 UI/kg EV a cada 28 dias; velocidade ≤ 4 mL/min. Ajustar ± 5 UI/kg para manter atividade mínima de FXIII 5-20%. Uso contínuo. [S1]
Crianças	
Deficiência congênita - cobertura perioperatória	Dose conforme FXIII e tempo desde profilaxia: ≤ 7 dias, pode dispensar reforço; 8-21 dias, dose parcial/completa conforme atividade; 21-28 dias, dose profilática completa de 40 UI/kg. Monitorar durante e após cirurgia. [S1]
Crianças	A tabela da bula sobrepõe o dia 21: nesse limite, decidir pela atividade de FXIII e risco cirúrgico, sem redose automática.
Deficiência adquirida de fator XIII com sangramento	15-20 UI/kg EV a cada 24 h, ajustados à atividade de FXIII e resposta; manter até melhora dos sintomas e recuperação espontânea de níveis normais. Velocidade ≤ 4 mL/min. [S2]
Crianças/adolescentes - bula de Israel	A bula descreve pelo menos 15-20 UI/kg; não estabelece teto fixo. Doses maiores exigem atividade mensurada e hematologia. Não implica registro brasileiro; investigar inibidor adquirido.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar atividade de FXIII e inibidores se baixa recuperação; risco de trombose/hipersensibilidade. UI de FXIII não são UI de FVIII ou FIX.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Profilaxia e controle perioperatório de sangramentos por deficiência congênita ou adquirida do fator XIII.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the information needed to use CORIFACT safely (labeling.cslbehring.com)

[S2] Ministério da Saúde de Israel - Fibrogammin (mohpublic.z6.web.core.windows.net)

472. Fator VIII + Fator de von Willebrand

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de von Willebrand - sangramento Crianças, não neonatos estudados	EV, em UI de VWF:RCo. Sangramento menor: tipos 2/3 ou tipo 1 com VWF basal <30%, 40-50 UI/kg, 1-2 doses. Sangramento grave: tipo 1 com basal >30%, ataque 40-60, depois 40-50 UI/kg; tipo 1 com basal <30%, ataque 50-75, depois 40-60 UI/kg; tipos 2/3, ataque 60-80, depois 40-60 UI/kg. Manutenção a cada 8-12 h por 3 dias, depois diária por até 7 dias, guiada pelos níveis. [S1] Tipo 1 leve: considerar desmopressina quando apropriada; se inadequada, esquema de ataque 40-60 UI/kg. Não trocar UI de VWF por UI de FVIII.
Doença de von Willebrand - prevenção perioperatória Crianças	Dose EV (UI VWF:RCo)=peso × (alvo-basal)/recuperação; se recuperação desconhecida, usar 2 UI/dL por UI/kg. Alvo grande cirurgia: VWF 100 UI/dL e FVIII 80-100 UI/dL. Emergência: 50-60 UI/kg; manutenção inicial metade do ataque a cada 8-12 h. Mínimo 72 h em grande cirurgia; duração pela cicatrização. [S1]
Hemofilia A - controle de sangramento Crianças	Dose EV em UI de FVIII=peso × elevação desejada(UI/dL) × 0,5. Hemartrose/muscular/oral menor: alvo 20-40%, repetir a cada 12-24 h por ≥1 dia até resolução; hemorragia muscular extensa: 30-60%, a cada 12-24 h por 3-4 dias; risco de vida: 60-100%, a cada 8-24 h até resolução. [S2] Recalcular por recuperação/atividade mensurada; não usar UI de VWF como FVIII.
Hemofilia A - profilaxia Crianças	20-40 UI de FVIII/kg EV a cada 2-3 dias, continuamente; crianças pequenas podem exigir doses maiores/intervalos menores segundo farmacocinética e hemorragias. [S2]
Hemofilia A - cobertura cirúrgica Crianças	Mesma fórmula de FVIII. Cirurgia menor: alvo 30-60%, redosar a cada 24 h por ≥1 dia até cicatrização. Grande: alvo 80-100% pré/pós-operatório, redosar a cada 8-24 h até cicatrização adequada; depois ≥7 dias mantendo 30-60%. [S2]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FVIII/VWF diariamente em doses repetidas; evitar acúmulo e trombose. O produto consultado não indica profilaxia espontânea rotineira de VWD.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Tratamento e profilaxia de sangramentos na doença de von Willebrand e hemofilia A.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] HUMATE-P (antihemophilic factor/von willebrand factor complex- human kit (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Haemate P - bula profissional BR (uploads.consultaremedios.com.br)

473. Fenoximetilpenicilina Potássica (Penicilina V)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Faringoamigdalite estreptocócica Crianças/adolescentes	Crianças: 250 mg VO a cada 12 h OU a cada 8 h por 10 dias. Adolescentes: 250 mg a cada 6 h OU 500 mg a cada 12 h por 10 dias. [S1]
Profilaxia secundária da febre reumática Crianças/adolescentes quando opção oral apropriada	250 mg VO a cada 12 h, continuamente. Duração depende da presença/gravidade de cardite e valvopatia, idade e tempo desde o último episódio; não suspender por desaparecimento dos sintomas. [S2] Penicilina benzatina costuma ser preferida quando adesão oral é incerta.
Profilaxia pneumocócica na asplenia/hiposplenia Pediatria - esquema PCH	<1 ano: 62,5 mg VO a cada 12 h; 1-5 anos: 125 mg a cada 12 h; >5 anos: 250 mg a cada 12 h. Manutenção prolongada, individualizada pelo risco; PCH recomenda profilaxia ao longo da infância e avalia continuidade na vida adulta. [S3] Faixas desta diretriz diferem das de outros países; não misturar idade de corte com dose de fonte diferente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Checar alergia imediata a penicilina. Profilaxia não substitui vacinação nem avaliação urgente de febre na asplenia; ajustar insuficiência renal grave.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Faringoamigdalite estreptocócica aguda (primeira linha oral); profilaxia secundária da febre reumática e de infecção pneumocócica na asplenia.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] CDC - faringite estreptocócica (cdc.gov)

[S2] CONCENSO SOBRE O USO RACIONAL D. PDF (bvsm.s.saude.gov.br)

[S3] PCH - asplenia e profilaxia (pch.health.wa.gov.au)

474. Nirsevimabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Prevenção de doença respiratória inferior por VSR - primeira temporada	<5 kg: 50 mg IM em dose única. ≥5 kg: 100 mg IM em dose única. Administrar antes/durante entrada na primeira temporada; se nascer durante a temporada, desde o nascimento. [S1]
RN/lactentes	
Segunda temporada - crianças que permanecem vulneráveis	200 mg IM em dose única, como duas injeções de 100 mg em locais diferentes; independentemente do peso. [S1]
Até 24 meses, critérios de alto risco	
Reposição após circulação extracorpórea	Se cirurgia ≤90 dias da dose: primeira temporada repetir 50 mg se <5 kg/100 mg se ≥5 kg; segunda 200 mg. Se cirurgia >90 dias: primeira 50 mg, segunda 100 mg, independentemente do peso. [S1]
Primeira/segunda temporada; assim que estável após cirurgia	Esta é dose adicional por perda na circulação extracorpórea; não redose rotineira por outra internação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Não é vacina nem tratamento da infecção ativa. Via exclusivamente IM, preferir coxa; contraindicação por hipersensibilidade grave. Elegibilidade do programa brasileiro depende da norma vigente.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Prevenção de infecção grave do trato respiratório inferior por VSR em recém-nascidos e lactentes na primeira temporada viral e grupos de risco até 24 meses.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Beyfortus/nirsevimabe (accessdata.fda.gov)

475. Atomoxetina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
TDAH ≥6 anos e ≤70 kg	Iniciar 0,5 mg/kg/dia VO; após ≥3 dias, aumentar para 1,2 mg/kg/dia. Máximo 1,4 mg/kg/dia OU 100 mg/dia, o menor. Administrar dose diária pela manhã OU dividir em 2 tomadas manhã/fim da tarde. Tratamento contínuo, com reavaliação periódica. [S1]
TDAH >70 kg	Iniciar 40 mg/dia VO; após ≥3 dias, 80 mg/dia. Se resposta insuficiente após 2-4 semanas, aumentar até 100 mg/dia. Dose única pela manhã OU dividida em 2 tomadas. [S1]
TDAH - inibidor forte CYP 2D6 ou metabolizador lento ≥6 anos	Usar a mesma dose inicial (0,5 mg/kg/dia se ≤70 kg; 40 mg/dia se >70 kg), mas aguardar 4 semanas antes de aumentar para 1,2 mg/kg/dia ou 80 mg/dia, respectivamente, se necessário/tolerado. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar PA, pulso, peso, crescimento, suicidabilidade e fígado. Insuficiência hepática Child-Pugh B: 50% da dose; C: 25%. Não associar IMAO; não abrir cápsula.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 58)

Tratamento do TDAH em crianças a partir de 6 anos e adolescentes, como opção não estimulante.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] STRATTERA- atomoxetine hydrochloride capsule - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

476. Cloreto de Cálcio 10%

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
PCR atribuível a hipocalcemia; hipercalemia com instabilidade miocárdica; hipermagnesemia sintomática	Cloreto de cálcio 10%: 20 mg/kg/dose do SAL EV/IO (=0,2 mL/kg; máximo 1 g/10 mL). Em paciente com circulação, administrar em 5-10 min; na PCR, 10-20 s. Repetir somente por persistência da indicação, ECG e cálcio ionizado. [S1]
Crianças; emergência monitorizada	Não usar rotineiramente em toda PCR. A via central é preferível; IO é opção em ressuscitação, corrigindo “central exclusiva” do original.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES 10%=100 mg/mL de sal, cerca 27 mg/mL de cálcio elementar. Não intercambiar com gluconato por volume. Evitar extravasamento e mesma linha de bicarbonato/fosfato; cautela em intoxicação digitálica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

PCR associada a hipocalcemia, hipercalemia com instabilidade miocárdica e hipermagnesemia sintomática (via central exclusiva).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ped Med (pedmed.org)

[S2] ANMF/NSW - cloreto de cálcio neonatal (seslhd.health.nsw.gov.au)

477. Fosfato de Potássio Injetável

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hipofosfatemia grave - esquema da bula brasileira VMG	0,15-0,33 mmol/kg de FÓSFORO EV em 6 h; máximo 9 mmol/ciclo. Repetir conforme exames e condição clínica; taxa $\leq 0,2$ mmol/kg/h. Dose não é em mEq de potássio. [S2]
Crianças	Ampola VMG: 1,1 mmol de fósforo/mL e 2 mEq de K ⁺ /mL. Volume do concentrado=mmol prescritos ÷ 1,1; K ⁺ fornecido=volume × 2.
Hipofosfatemia grave - alternativa RCH	0,36 mmol/kg EV em 6 h; repetir se necessário, máximo 2 mmol/kg/dia OU 70 mmol/dia, o menor. Velocidade $\leq 0,2$ mmol/kg/h e ≤ 10 mmol/h. Diluir: periférica $\leq 0,05$ mmol/mL; central $\leq 0,12$ mmol/mL. [S1]
Crianças, reposição monitorizada	Alternativa institucional com teto diferente da bula VMG; escolher um regime completo. RCH permite SF 0,9% ou SG 5%.
Fósforo em nutrição parenteral	0,5-2 mmol/kg/dia de fósforo, incorporados à nutrição parenteral individualizada; ajustar a idade, aporte de cálcio, crescimento e exames. Infusão por ≥ 4 h, usualmente ao longo do ciclo de NPT. [S3]
Crianças	Estabilidade cálcio-fosfato precisa ser calculada pela farmácia; não usar a receita de reposição intermitente para NPT.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar fósforo, potássio, cálcio, magnésio e rim antes/depois (RCH ≈ 2 h após término). Se hipercalemia, usar fonte sem K. Não infundir concentrado puro ou junto a cálcio/magnésio. Composição varia entre fabricantes; Isofarma declara 1,12 mmol de P/mL, não é a ampola VMG.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

Correção de hipofosfatemia grave em pediatria e UTI; suporte em nutrição parenteral total.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Clinical Practice Guidelines : Hypophosphataemia (rch.org.au)

[S2] VMG - fosfato de potássio bula 2023 (vmgfarmaceutica.com.br)

[S3] Isofarma/Halex Istar - NPT pediátrica (halexistar.com.br)

478. Infliximabe

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Doença de Crohn; colite ulcerativa refratária	5 mg/kg EV nas semanas 0,2,6; depois 5 mg/kg a cada 8 semanas. Infundir em ≥2 h. Manutenção contínua enquanto eficaz; avaliar resposta após indução. [S1]
≥6 anos	
Colite ulcerativa - regime intensificado	10 mg/kg EV semanas 0,2,6; depois 10 mg/kg a cada 4-8 semanas, guiados por atividade e concentração mínima. Reduzir dose quando remissão e níveis permitirem. [S2]
Pediatria em centro de DII; off-label de intensificação	Diretriz 2025 recomenda frequentemente maior exposição; não é dose da bula padrão.
AIJ poliarticular - regime investigado, off-label	Ensaio: 3 mg/kg EV semanas 0,2,6,14,20 e depois a cada 8 semanas até 44. Outro braço: 6 mg/kg EV semanas 14,16,20 após fase placebo, depois a cada 8 semanas até 44. [S3]
4-17 anos, associado a MTX	É descrição dos braços do estudo, não esquema universal recomendado; benefício primário não estabelecido e imunogenicidade relevantes. Uso atual exige decisão reumatológica, usualmente associado a MTX.
RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Rastrear TB/hepatites, hemograma e infecção; evitar vacinas vivas. Insuficiência cardíaca moderada/grave contraindica >5 mg/kg. Reconstituição 100 mg/10 mL; solução final 0,4-4 mg/mL em SF 0,9%, filtro 0,2-1,2 micra conforme bula.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)
Doença de Crohn e colite ulcerativa moderada a grave refratária (a partir de 6 anos); artrite idiopática juvenil poliarticular.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] REMICADE® (infliximab) for injection, for intravenous use (accessdata.fda.gov)
[S2] ECCO/ESPGHAN 2025 - colite ulcerativa pediátrica (doi.org)
[S3] Ensaio pediátrico de infliximabe na AIJ (doi.org)

479. Micofenolato de Mofetila / Sódio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia de rejeição de transplante renal - mofetila ≥3 meses - FDA atual	600 mg/m ² /dose VO a cada 12 h, máximo 1 g/dose (2 g/dia). Uso contínuo, associado ao regime antirrejeição. [S1]
Profilaxia de rejeição cardíaca/hepática - mofetila ≥3 meses - FDA atual	Iniciar 600 mg/m ² /dose VO a cada 12 h; se tolerado, aumentar até 900 mg/m ² /dose a cada 12 h, máximo 1,5 g/dose (3 g/dia). Uso contínuo. [S1] Indicação/dose da FDA não comprova registro pediátrico brasileiro.
Nefrite lúpica proliferativa - indução Crianças/adolescentes; off-label	Mofetila: 600 mg/m ² /dose VO a cada 12 h, máximo 1,5 g/dose; pode iniciar menor e atingir alvo em ≤4 semanas. Alternativa micofenolato sódico: 400 mg/m ² /dose a cada 12 h, máximo 1.080 mg/dose. Indução 6 meses; manutenção e retirada condicionadas à resposta renal. [S3] Associar ao regime de corticoide/imunossupressão apropriado; não são equivalentes mg a mg.
Síndrome nefrótica corticorresistente - manutenção selecionada Crianças; off-label	Mofetila 1.200 mg/m ² /dia VO, dividido a cada 12 h (600 mg/m ² /dose); exposição pode ser guiada por AUC de ácido micofenólico, alvo >50 mg·h/L. Usar em casos selecionados em remissão/necessidade de reduzir inibidor da calcineurina. [S2] Não é substituição indiscriminada da primeira linha de indução; duração individual, pelo menos enquanto necessidade de manutenção. Não há dose equivalente do sal sódico validada pela diretriz de síndrome nefrótica consultada.
Micofenolato sódico - profilaxia de rejeição renal, conversão ≥5 anos; ≥6 meses após transplante renal	400 mg/m ² /dose VO a cada 12 h, máximo 720 mg/dose. Superfície corporal 1,19-1,58 m ² : 540 mg a cada 12 h; Superfície corporal >1,58 m ² : 720 mg a cada 12 h. Manutenção contínua. [S4] Bula FDA: comprimidos disponíveis não permitem dose precisa se superfície corporal <1,19 m ² . Não mastigar/triturar; não é regime de indução imediatamente após transplante.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Hemograma, creatinina e fígado; mielotoxicidade, diarreia, infecções e teratogenicidade. Não triturar comprimidos nem abrir cápsulas; não administrar SC/IM. Reavaliar se neutrófilos <1.300/mm³.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

Profilaxia de rejeição em transplantes; nefrite lúpica e síndrome nefrótica cortico-resistente (off-label pediátrico).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA - Cell Cept (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-resistant nephroti (theipna.org)

[S3] CARRA - nefrite lúpica proliferativa juvenil (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S4] FDA/Daily Med - Myfortic (dailymed.nlm.nih.gov)

480. Metotrexato (Uso Imunossupressor)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
AIJ poliarticular; artrite persistente da AIJ sistêmica	10-15 mg/m ² VO, SC ou IM UMA VEZ POR SEMANA; se necessário até 25 mg/m ² /semana sob especialista. Tratamento contínuo, com reavaliação da resposta e toxicidade. [S1]
Crianças, incluindo ≥2 anos sob reumatologia	Não trata adequadamente síndrome de ativação macrofágica nem manifestação sistêmica grave isolada.
Uveíte associada à AIJ	10-15 mg/m ² VO, SC ou IM UMA VEZ POR SEMANA; se necessário até 25 mg/m ² /semana. Preferência de via/titulação conforme controle ocular. Manutenção prolongada; redução apenas após inatividade sustentada. [S1]
Crianças	
Morfeia/esclerodermia localizada juvenil	15 mg/m ² VO ou SC UMA VEZ POR SEMANA. Continuar ≥12 meses após remissão clínica antes de reduzir gradualmente. [S3]
Crianças	Na doença ativa, frequentemente associado inicialmente a corticoide como ponte; não usar diariamente.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ERRO FATAL: não administrar diariamente. Prescrever um dia fixo da semana e suplementação de folato separada. Monitorar hemograma, transaminases e rim; evitar TMP-SMX e gravidez; reavaliar em infecção ou desidratação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)
Tratamento da artrite idiopática juvenil (AIJ) poliarticular e sistêmica, uveíte associada à AIJ e morfeia (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] BNF for Children - Methotrexate (bnfc.nice.org.uk)
- [S2] 2026 American College of Rheumatology (ACR) Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) Guidelines (assets.contentstack.io)
- [S3] NHSS cotland 2025 - morfeia juvenil (nn.nhs.scot)

481. Toxina Botulínica Tipo A

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Espasticidade focal de membro superior na paralisia cerebral ≥2 anos - onabotulinumtoxina A (BOTOX)	3-6 unidades/kg IM por sessão, distribuídas nos músculos-alvo; máximo 200 unidades por membro superior tratado. Repetir conforme resposta, intervalo ≥12 semanas. [S1]
Espasticidade focal de membro inferior na paralisia cerebral ≥2 anos - onabotulinumtoxina A	4-8 unidades/kg IM por sessão; máximo 300 unidades por membro inferior tratado. Se tratar vários membros: total ≤10 unidades/kg OU 340 unidades por 3 meses, o menor. Intervalo ≥12 semanas. [S1]
Sialorreia crônica ≥2 anos e ≥12 kg - incobotulinumtoxina A (XEOMIN)	Dose total intraglandular: 12-<15 kg 20 U; 15-<19 kg 30 U; 19-<23 kg 40 U; 23-<27 kg 50 U; 27-<30 kg 60 U; ≥30 kg 75 U. Dividir 30% da dose em cada parótida e 20% em cada submandibular; intervalo ≥16 semanas. [S2] Guiar por ultrassom. É dose específica de incobotulinumtoxina A/FDA, não conversão de Botox nem aprovação brasileira.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Unidades de preparações distintas NÃO são intercambiáveis. Risco de fraqueza distante, disfagia, aspiração e insuficiência respiratória; dosar por músculos/glândulas e peso, sem ultrapassar teto global.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)
Tratamento da espasticidade focal em membros na paralisia cerebral pediátrica (a partir de 2 anos); sialorreia crônica refratária (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Botox Therapeutic - VHB - master-uspi-mg-onabotulinumtoxin A-2024 oct 18 (rxabbvie.com)

[S2] FDA 2026 - Xeomin (accessdata.fda.gov)

482. Ropivacaína

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Bloqueio caudal único - analgesia cirúrgica RN a termo-12 anos, ≤25 kg	Ropivacaína 0,2% (2 mg/mL): 2 mg/kg em dose caudal única (=1 mL/kg), máximo 25 mL/50 mg. [S1]
Peridural - bolus e analgesia pós-operatória contínua RN a termo-12 anos	Bolus: <12 meses 1-2 mg/kg; 1-12 anos 2 mg/kg, máximo 25 mL da solução 2 mg/mL. Infusão: <6 meses 0,2 mg/kg/h; 6 meses-12 anos 0,4 mg/kg/h; por até 72 h. [S1] 2 mg/mL: taxas 0,1 ou 0,2 mL/kg/h, respectivamente.
Bloqueio periférico único/contínuo 1-12 anos	Bloqueio periférico único: 1-1,5 mg/kg (SmPC Aspen), escolhendo a menor dose eficaz conforme técnica. O limite de 2,5-3 mg/kg da SmPC Sandoz é teto, não dose inicial universal. Infusão: 0,2-0,6 mg/kg/h por até 72 h; somar outros bloqueios/anestésicos. [S1, S2] Concentração 2 mg/mL: 0,1-0,3 mL/kg/h. Prematuros e <1 ano para bloqueio periférico: dados insuficientes.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Administrar por anestesista, com aspiração e doses fracionadas; nunca EV/IO. Monitorar toxicidade sistêmica e ter emulsão lipídica disponível. Hepatopatia/infusão prolongada aumentam acúmulo; peso ideal em obesidade.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

Anestesia locorregional cirúrgica e analgesia pós-operatória por bloqueio peridural, caudal e periférico em pediatria.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ropivacaine 2 mg / ml solution for infusion - Summary of Product Characteristics (Sm PC) - (emc) | 100394 (medicines.org.uk)

[S2] SmPC Aspen - ropivacaína 2 mg/mL: tabela pediátrica de bloqueios

483. Carboximaltose Férrica

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anemia ferropriva com falha/intolerância ao ferro oral	<50 kg: 15 mg de FERRO/kg EV por dose, em 2 doses separadas por ≥7 dias. ≥50 kg: 750 mg de ferro EV por dose, em 2 doses separadas por ≥7 dias (curso 1.500 mg). [S2]
≥1 ano - aprovação FDA; bula BR consultada só adultos	O regime de 1.000 mg em dose única é adulto; não aplicar automaticamente a adolescentes.
Preparo/infusão do curso pediátrico	Diluir apenas em SF 0,9%, concentração final ≥2 mg de ferro/mL; infundir em ≥15 min. Reavaliar Hb/estoques e necessidade de novo curso após reposição. [S2]
Mesmas faixas	No Brasil, prescrição pediátrica deste produto é off-label na bula consultada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar reação de infusão e observar ≥30 min; dosar fósforo em risco ou cursos repetidos: hipofosfatemia pode ser grave/prolongada. Evitar sobrecarga de ferro e extravasamento pigmentante.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

Tratamento intravenoso da anemia por deficiência de ferro em crianças a partir de 1 ano e adolescentes quando o ferro oral é ineficaz ou inviável.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Ferinject - Bula Profissional de saúde (assets-dam.takeda.com)

[S2] FDA 2026 - Injectafer (accessdata.fda.gov)

484. Azul de Metileno (Cloreto de Metiltionínio)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Metemoglobinemia tóxica sintomática Crianças, inclusive lactentes - FDA	1 mg/kg EV em 5-30 min. Se methHb >30% ou sintomas persistirem, repetir 1 mg/kg após 1 h. Máximo 2 doses no esquema FDA; se refratário, considerar terapias alternativas. [S1] Dose em cloreto de metiltionínio; confirmar concentração do produto. Não repetir indefinidamente.
Vasoplegia refratária após circulação extracorpórea Crianças; off-label e resgate especializado RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	1,5 mg/kg EV em 20 min, dose única no ensaio pediátrico; avaliar resposta hemodinâmica e necessidade de vasopressores. [S2] Estudo pequeno, sem faixa segura validada para infusão contínua ou repetição; não estender automaticamente a choque séptico.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Contraindicado em deficiência G6PD; risco hemólise e síndrome serotoninérgica com antidepressivos/opioides. Se diluir, usar SG 5%; SF pode reduzir solubilidade. Se TFG 15-59 mL/min/1,73 m², limitar a 1 dose conforme bula.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 59)

Antídoto específico para tratamento de urgência da metemoglobinemia tóxica sintomática; choque vasoplégico refratário (off-label).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Label: PROVAYBLUE- methylene blue injection - Daily Med (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Ensaio pediátrico de vasoplegia pós-CEC (doi.org)

485. Pralidoxima

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Intoxicação por organofosforado - ataque e infusão contínua Crianças; associado à atropina e suporte respiratório	CLORETO de pralidoxima 20-50 mg/kg EV em 15-30 min, máximo 2 g/dose; depois 10-20 mg/kg/h EV contínuo. Duração por força muscular, ventilação e recorrência colinérgica; reavaliar continuamente. [S1]
Alternativa EV intermitente Crianças	20-50 mg/kg EV em 15-30 min, máximo 2 g/dose; repetir após ≈1 h se fraqueza persistir; depois repetir a cada 10-12 h se necessário. Se infusão inviável, dose EV lenta em ≥5 min, solução 50 mg/mL. [S1]
Alternativa IM - ausência de acesso EV Crianças	<40 kg: 15 mg/kg IM por injeção; ≥40 kg: 600 mg/injeção. Sintomas leves: até 3 injeções com observação 15 min entre elas; sintomas graves: 3 injeções em sequência rápida. Curso total 45 mg/kg (<40 kg) OU 1.800 mg (≥40 kg); cursos adicionais podem iniciar 1 h após última injeção. [S1] Regime IM específico da bula Protopam; não administrar concentração EV por engano.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Dose é do sal CLORETO; mesilato/iodeto não são equivalentes mg a mg. Diluir para EV em SF 0,9% conforme produto; monitorar pressão/ECG/rim, reduzir em insuficiência renal. Atropina deve acompanhar; pralidoxima não substitui atropinização.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Antídoto reativador colinesterásico no tratamento da intoxicação aguda por inseticidas organofosforados, em associação à atropina.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - Protopam cloreto (dailymed.nlm.nih.gov)

486. Ciclesonida

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Asma persistente - manutenção 4-11 anos na bula BRA lvesco	80-160 mcg por inalação oral a cada 24 h; máximo 160 mcg/dia. Uso contínuo, reduzindo à menor dose que controle a asma. [S1] Bula BR aberta permite ≥4 anos; original cita 6/12.
Asma persistente - adolescente ≥12 anos	80-640 mcg/dia por inalação oral. Usual leve 160 mcg/dia; moderada 160-320 mcg/dia; grave 320-640 mcg/dia, em 1 tomada OU 320 mcg a cada 12 h. Máximo 640 mcg/dia; contínuo. [S1]
Rinite alérgica sazonal/perene Sazonal ≥6 anos; perene ≥12 anos conforme bula BR	100 mcg por narina a cada 24 h (=2 jatos de 50 mcg em cada narina; total 200 mcg/dia). Máximo 200 mcg/dia; manter pelo período sintomático, reavaliando resposta. [S2] Idade ≥2 anos do original não confirmada nesta bula; ensaio em 2-5 anos não equivale a aprovação.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Inalador oral e spray nasal não são intercambiáveis. Não serve para crise asmática; monitorar crescimento, candidíase e eixo adrenal em doses altas. Enxaguar boca após inalação.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Manutenção e controle da asma persistente (a partir de 6/12 anos); tratamento da rinite alérgica (a partir de 2 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] ALVESCO Bula Profissional (uploads.consultaremedios.com.br)

[S2] Omnaris - bula profissional brasileira (uploads.consultaremedios.com.br)

487. Rupatadina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Rinite alérgica; urticária crônica espontânea	10-<25 kg: 2,5 mg VO a cada 24 h; ≥25 kg: 5 mg a cada 24 h. Manter enquanto sintomas/indicação, com reavaliação periódica. [S1]
2-11 anos e ≥10 kg	Sem dose estabelecida <10 kg ou <2 anos na bula.
Mesmas indicações ≥12 anos	10 mg VO a cada 24 h. Tratamento conforme período sintomático; não aumentar para regime adulto off-label de altas doses sem avaliação especializada. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar inibidores fortes CYP 3A4 e toranja; cautela com QT e sedação. Não recomendada em insuficiência renal/hepática sem dados suficientes.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)
Tratamento sintomático da rinite alérgica e urticária crônica espontânea (solução oral de 2 a 11 anos; comprimidos a partir de 12 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Rupatadine 1 mg/ml oral solution (medicines.org.uk)

488. Propafenona

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Taquicardia supraventricular - reversão e prevenção Crianças selecionadas por eletrofisiologia	Ataque 0,5 mg/kg EV em 10 min. Manutenção 10-15 mg/kg/dia VO dividido a cada 8 h (=3,33-5 mg/kg/dose). Uso contínuo enquanto risco de recorrência. [S2] Fonte pediátrica WPW/TSV; não fixa teto absoluto.
Taquiarritmias ventriculares Crianças RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	A seleção depende do mecanismo e da presença de cardiopatia; o regime de TSV não valida tratamento de toda arritmia ventricular. Diretriz consultada não oferece esquema pediátrico universal seguro. [S1] Pode ser pró-arrítmica; uso somente em indicação eletrofisiológica específica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES ECG, QRS, função ventricular, rim/fígado e interações. Evitar cardiopatia estrutural significativa/disfunção ventricular e síndrome de Brugada; reduzir/suspender se alargamento QRS >25% do basal.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Profilaxia e tratamento de taquiarritmias supraventriculares paroxísticas e ventriculares na infância (cardiologia pediátrica).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Pharmacological and non-pharmacological therapy for arrhythmias in the pediatric population: EHRA and AEPC-Arrhythm (heartuniversity.org)

[S2] Consenso italiano - WPW/TSV na infância (doi.org)

489. Sotalol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Arritmias ventriculares/supraventriculares complexas - manutenção	Iniciar 1,2 mg/kg/dose VO a cada 8 h (=3,6 mg/kg/dia). Aumentar com intervalo ≥ 36 h entre etapas; máximo 2,4 mg/kg/dose a cada 8 h (=7,2 mg/kg/dia). Tratamento contínuo, titulado pelo QTc/frequência e resposta. [S1]
≥ 2 anos; rim normal	
Mesmas indicações em menores de 2 anos	Multiplicar a dose de ≥ 2 anos pelo fator etário da curva específica da bula. Exemplos da bula: 1 mês fator 0,7; 1 semana fator 0,3. Não interpolar idade gestacional/pós-natal sem farmacologia clínica. [S1]
Lactentes/neonatos RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Não aplicar 1,2 mg/kg a cada 8 h integral ao neonato; fonte não fornece equação contínua para todas idades.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Iniciar/reiniciar em hospital com ECG e eletrólitos corrigidos; QT ≥ 500 ms exige redução/aumento do intervalo/suspensão. Eliminação renal: intervalo e dose devem ser ajustados à depuração. Risco torsades/broncoespasmo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Manutenção do ritmo sinusal e prevenção de arritmias ventriculares e supraventriculares complexas na infância.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - SOTALOL HYDROCHLORIDE tablet (dailymed.nlm.nih.gov)

490. Insulina Detemir

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Diabetes tipo 1 - insulina basal ≥1 ano	Detemir SC 1-2 vezes/dia; dose basal geralmente 30-50% da dose TOTAL diária de insulina. Pré-púber fora da remissão: total usual 0,7-1 UI/kg/dia; puberdade 1-2 UI/kg/dia, por vezes mais. Logo, basal é apenas a fração desse total, individualizada por glicemia. [S1, S2] Associar insulina prandial. Na remissão parcial, necessidade total costuma ser <0,5 UI/kg/dia; não há teto universal.
Diabetes tipo 2 - necessidade inicial de insulina Crianças/adolescentes com HbA 1c ≥8,5%, sem acidose/cetose	Iniciar insulina basal SC 0,25-0,5 UI/kg/dia; para detemir, 1-2 administrações/dia conforme perfil. Associar tratamento apropriado e titular pela glicemia. Reavaliar redução após controle metabólico. [S3] Regime ISPAD para jovens, não dose adulta fixa de 10 U; T2 em criança muito pequena exige investigação etiológica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Uso contínuo conforme diabetes; nunca EV/IM ou em bomba. Não diluir/misturar. Hipoglicemia exige ajuste, não suspensão de toda insulina no T1. Cetoacidose exige protocolo EV de insulina apropriada; detemir isolada não a trata.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)
Controle glicêmico basal no diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 em pediatria a partir de 1 ano de idade.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

- [S1] [insulina detemir](#) (novonordisk.com.br)
[S2] ISPAD 2024 - [insulina na infância](#) (ispad.org)
[S3] ISPAD 2024 - [diabetes tipo 2 pediátrico](#) (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

491. Fator IX da Coagulação Humana

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hemofilia B - sangramento menor Crianças, concentrado FIX humano padrão	20-30 UI/kg EV inicialmente para alvo 15-25 UI/dL; repetir após 24 h se necessário. Dose e duração pelo sangramento/recuperação medida. [S1]
Hemorragia importante/trauma/cirurgia - referência Mononine Crianças	Até 75 UI/kg EV de ataque; depois repetir a cada 18-30 h conforme meia-vida/níveis, por até 10 dias conforme situação. Alvos de bula 25-50 UI/dL são referenciais e podem ser insuficientes para sítios críticos; hematologia deve definir alvo do procedimento. [S1] Dose necessária (UI)=peso × elevação desejada UI/dL ÷ recuperação individual (UI/dL por UI/kg).
Profilaxia contínua - FIX de meia-vida padrão Crianças	Regime intermediário: 20-40 UI/kg EV 2 vezes/semana. Regime intensivo: 40-60 UI/kg EV 2 vezes/semana. Individualizar por hemorragias e níveis mínimos; tratamento prolongado. [S2] Doses WFH; não converter para FIX de meia-vida estendida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar FIX/inibidores, anafilaxia e trombose. Infusão Mononine até 225 UI/min usualmente tolerada; produto específico pode ter limite diverso. Crianças podem ter menor recuperação e exigir ajuste.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Tratamento e profilaxia de episódios hemorrágicos em pacientes pediátricos com hemofilia B.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Coagulation Factor IX (Human) MONONINE (labeling.cslbehring.com)

[S2] WFH 3ª edição - profilaxia hemofilia (www.1.wfh.org)

492. Imunoglobulina Humana Antivaricela-Zóster (VZIG)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Profilaxia pós-exposição à varicela	IM em dose única, idealmente ≤96 h e até 10 dias da exposição: ≤2 kg 62,5 UI; >2-10 kg 125 UI; >10-20 kg 250 UI; >20-30 kg 375 UI; >30-40 kg 500 UI; >40 kg 625 UI(máximo). [S1]
RN de risco e crianças imunocomprometidas suscetíveis	Se nova exposição ≥3 semanas após dose, considerar nova dose. Não é tratamento de varicela estabelecida.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Distribuir volume >3 mL em locais IM diferentes conforme produto; concentração varia entre fabricantes. Adiar vacina viva de varicela por 5 meses. Vigiar doença por 28 dias após exposição; profilaxia não elimina risco.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)
Profilaxia pós-exposição à varicela em recém-nascidos de risco e crianças imunocomprometidas suscetíveis.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Label: VARIZIG- human varicella-zoster immune globulin solution (dailymed.nlm.nih.gov)

493. Epoetina Alfa (Eritropoietina)

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Anemia da doença renal crônica ≥1 mês	Iniciar se Hb <10 g/dL: 50 UI/kg SC ou EV 3 vezes/semana. Se Hb não subir >1 g/dL após 4 semanas, aumentar ≈25%; se subir >1 g/dL em 2 semanas, reduzir ≥25%. Reduzir/suspender se Hb >12 g/dL; usar menor dose para evitar transfusões. Tratamento contínuo com avaliação da causa de hiporresposta. [S1]
Anemia da prematuridade - esquema estudado Prematuros ≤1.500 g e ≥7 dias; off-label RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	400 UI/kg SC 3 vezes/semana por 4 semanas. Alternativa estudada no mesmo ensaio: 1.200 UI/kg SC 1 vez/semana por 4 semanas. Associar reposição adequada de ferro e monitorar Hb/reticulócitos/ferritina. [S2] Ensaio pequeno; não é recomendação de rotina nem substitui transfusão indicada. Não generalizar neuroproteção.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Controlar pressão e trombose; corrigir deficiência de ferro/B12/folato. Neonatos/lactentes devem receber apresentação sem álcool benzílico. Não usar para correção imediata de anemia crítica.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 60)

Anemia da doença renal crônica em pediatria; prevenção e tratamento da anemia da prematuridade (off-label neonatal).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Daily Med - EPOGEN- epoetin alfa solution (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] Ensaio primário - epoetina em prematuros (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

494. Baloxavir Marboxil

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Influenza A/B aguda não complicada, ≤48 h de sintomas	VO em DOSE ÚNICA: <20 kg 2 mg/kg; 20-<80 kg 40 mg; ≥80 kg 80 mg. Usar suspensão apropriada se dose <40 mg. Não repetir diariamente. [S1]
≥1 ano no escopo original - esquema EMA	FDA consultada limita a ≥5 anos; EMA tem população mais ampla. Faixa ≥1 ano do PDF não prova aprovação Anvisa.
Influenza - alternativas por apresentação FDA	Se usar suspensão reconstituída: mesmo esquema ponderal acima. Formulação sachê FDA: 15-<20 kg 30 mg em dose única; demais faixas usar a dose/formulação validada. [S2]
≥5 anos	Não arredondar arbitrariamente 2 mg/kg para 30 mg fora da faixa aprovada.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Evitar administração junto a leite/bebidas enriquecidas com cálcio, antiácidos e suplementos com cátions. Não é regime estabelecido para influenza grave hospitalizada ou imunossupressão importante; acompanhar resistência/recaída.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 61)

Tratamento em dose única oral da influenza aguda (A e B) até 48 h de sintomas em crianças a partir de 1 ano.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] EMA - Xofluza (ema.europa.eu)

[S2] FDA 2025 - Xofluza (accessdata.fda.gov)

495. Griseofulvina

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Tinea capitis ≥4 semanas-12 anos	Griseofulvina micronizada 10-20 mg/kg VO a cada 24 h, máximo 1 g/dia, por 6-8 semanas; ajustar por espécie e resposta micológica. Tomar com refeição gordurosa. [S1]
Dermatofitose cutânea/corporis/cruris/pedis ≥4 semanas-12 anos	Mesma dose 10-20 mg/kg/dia VO, máximo 1 g. Pele usual 2-4 semanas. Duração pela resolução clínica/micológica. [S1]
Onicomicose por dermatófitos Crianças	Mesma dose 10-20 mg/kg/dia VO, máximo 1 g; unhas das mãos ≥4 meses, pés ≥6 meses, até crescimento sadio/cura micológica. [S1] Confirmar fungo; outras opções podem ser preferidas.
Mesmas dermatofitoses - adolescentes >12 anos	500 mg VO a cada 24 h; infecção grave pode exigir 1.000 mg/dia, com redução após resposta. Máximo 1 g/dia; duração pelo sítio conforme linhas acima. [S1]

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Micronizada e ultramicronizada não são equivalentes mg a mg. Não cobre Candida. Evitar hepatopatia grave, porfiria e gravidez; monitorar fígado/hemograma em cursos prolongados.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 61)

Tratamento oral de micoses superficiais e dermatofitoses, sendo primeira escolha para *tinea capitis* em pediatria.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Griseofulvin Monograph - Paediatric (pch.health.wa.gov.au)

496. Acetato de Cálcio

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Hiperfosfatemia na DRC - quelante intestinal Crianças; off-label, nefrologia DOSE NÃO VALIDADA NESTA PESQUISA	Administrar VO junto às refeições, com quantidade individualizada pelo fósforo ingerido, fosfatemia e carga total de cálcio. A diretriz atual não fixa dose pediátrica universal em mg/kg; o valor de 50 mg/kg/dia do consenso antigo não explicita inequivocamente sal versus elemento e não é convertido aqui em prescrição. [S1, S2] Se a nefrologia definir a quantidade de cálcio elementar permitida no quelante, calcular a massa de acetato pela fração real do produto (aproximadamente 25% de cálcio). Reavaliar exames e manter enquanto necessário ao controle da hiperfosfatemia.
Limite de carga cálcica e ajuste Crianças com DRC	Acetato contém ≈25% de cálcio elementar. Somar cálcio da dieta+suplementos+quelante: manter dentro da ingestão sugerida para idade e, em geral, ≤2 vezes essa referência. Reduzir/suspender se hipercalcemia; rever estratégia de quelante. [S2] Fórmula de carga: mg Ca do acetato=mg de acetato × 0,25; não confundir sal com elementar.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar cálcio, fósforo, PTH, fosfatase alcalina e 25-OHD. Separar ferro/antibióticos que quelam; excesso de cálcio favorece calcificação vascular. Não usar para suplementar fósforo.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 61)

Agente quelante de fósforo intestinal para controle da hiperfosfatemia em crianças com doença renal crônica.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] Consenso ESPN - osteodistrofia renal pediátrica 2006 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

[S2] Pediatric Renal Nutrition Taskforce 2019 (doi.org)

497. Cloranfenicol

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Meningite bacteriana quando alternativas adequadas não podem ser usadas Crianças além do período neonatal	50-100 mg/kg/dia EV dividido a cada 6 h (=12,5-25 mg/kg/dose); usar faixa alta inicialmente quando necessário para LCR e reduzir a 50 mg/kg/dia assim que possível. Duração exige agente/culturas, não é única para toda meningite. [S1] Uso excepcional por toxicidade; dose de cloranfenicol base equivalente, não massa de succinato.
Infecção grave em neonatos/prematuros Neonatos/prematuros RESTRIÇÃO / CONTEXTO ESPECÍFICO	Bula: 25 mg/kg/dia EV, com ajuste obrigatório por concentração sérica, maturidade e função hepatorenal; não transferir 100 mg/kg/dia da criança maior. [S1] A bula não fixa intervalo para toda idade gestacional; precisa de farmacocinética neonatal.
Febre maculosa grave - alternativa Crianças, quando doxiciclina não pode ser usada	50-100 mg/kg/dia VO/EV dividido a cada 6 h, máximo 2 g/dia. Usual 7 dias e manter ≥3 dias após desaparecer febre; via EV no caso grave até melhora/recuperação da consciência. [S2] Doxiciclina é preferida em todas as idades; cloranfenicol associa-se a maior risco de morte.
Infecção ocular superficial - conjuntivite bacteriana aguda ≥2 anos	Colírio 0,5%: 1 gota no(s) olho(s) acometido(s) a cada 2 h nas primeiras 48 h; depois a cada 4 h, somente durante vigília. Total 5 dias; reavaliar se sem melhora em 48 h. [S3] Não aplicar a meningite; curso/produto desta referência britânica.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar hemograma frequente e concentração sérica; risco de aplasia medular idiossincrática e síndrome do bebê cinzento. Insuficiência hepática/renal exige ajuste. Não usar preventivamente ou em infecção trivial.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 61)

Meningite bacteriana em alérgicos graves a betalactâmicos; febre maculosa grave; infecções oculares superficiais.

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] FDA/Daily Med - cloranfenicol EV (dailymed.nlm.nih.gov)

[S2] MS/COSEMS-SP 2023 - febre maculosa (cosemssp.org.br)

[S3] Sm PC - cloranfenicol colírio 0,5% (medicines.org.uk)

498. Perampanel

ESQUEMAS POR INDICAÇÃO • POPULAÇÃO PEDIÁTRICA

INDICAÇÃO / POPULAÇÃO	DOSE, INTERVALO E DURAÇÃO
Crises focais - adjuvante ≥12 anos - bula BR consultada	Iniciar 2 mg VO à noite a cada 24 h; aumentar 2 mg por etapa (intervalo ≥1 semana, frequentemente 2 conforme interações) até 4-8 mg/dia; máximo 12 mg/dia. Contínuo; retirada gradual. [S1]
Crises tônico-clônicas generalizadas primárias ≥12 anos - bula BR	Iniciar 2 mg VO à noite; aumentar 2 mg por etapa até 8 mg/dia; se necessário/tolerado, máximo 12 mg/dia. Intervalo ≥1-2 semanas conforme depuração. [S1]
Crises focais ≥4 anos; tônico-clônicas primárias ≥7 anos - crianças <12 EMA; uso abaixo de 12 não autorizado na bula BR consultada	VO à noite: ≥30 kg iniciar 2 mg, titular+2 mg/etapa; manutenção 4-8 mg, máximo 12 mg/dia. 20-<30 kg iniciar 1 mg, titular+1 mg; manutenção 4-6 mg, máximo 8 mg/dia. <20 kg iniciar 1 mg, titular+1 mg até 2-4 mg; acima disso+0,5 mg/etapa, máximo 6 mg/dia. Intervalo ≥1-2 semanas. [S2] Faixas por peso da EMA; solução oral 0,5 mg/mL pode permitir frações. Não partir comprimidos para essas doses.

MONITORIZAÇÃO E PRECAUÇÕES Monitorar agressividade, suicidabilidade, quedas e sedação. Interações CYP 3A4 alteram titulação. Hepatopatia exige limites menores próprios por idade/peso; doença grave/diálise não recomendadas. O PDF original usava idades europeias sem identificar jurisdição.

INDICAÇÕES DO PDF-BASE (registro documental, p. 61)

Terapia adjuvante para crises epilépticas focais (a partir de 4 anos) e crises tônico-clônicas generalizadas (a partir de 7 anos).

FONTES DO ESQUEMA • CONSULTA EM 13/09/2026

[S1] 2.0 Bula Profissional_Fycompa - changes v.05.2026_CLEAN (knighttx.com.br)

[S2] EMA - Fycompa suspensão e comprimidos (ema.europa.eu)